中 南 大 学

CENTRAL SOUTH UNIVERSITY

系统分析与设计

课 程 项 目 报 告

SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN REPORT

题　目 ADC 牙科连锁运营管理系统分析与设计

学生姓名 张加良

学　　号 8210241102

指导教师 毕文杰教授

学　　院 商学院

专业班级 信管 T2401

2026 年 11 月 1 日

ADC 牙科连锁运营管理系统分析与设计

摘 要

连锁牙科诊所的选诊、预约、检查治疗、费用结算和设备使用相互关联，资料分散容易造成患者等待、承诺冲突与费用争议。本文以 Andrew’s Dental Chain（ADC）为背景，面向一家约 5 至 20 家诊所的连锁机构，分析七类岗位的责任、业务交接及可观察规则，建立需求、用例、领域关系、状态与验收之间的追踪关系。

系统围绕患者服务过程，整合匿名找店选医、网站与微信小程序访问、本人及代约关系核验、电话接待和统一资源预约。医师本人提交画像，各门店主管审核采用版本，前台负责出诊与调班。检查记录、跨次方案、实际治疗和复诊加工分别保留责任与完成依据；版本化账单、独立收退款、资金凭据、逐笔对账及医保模拟清算形成财务衔接。月度经营核算区分诊疗产值、资金回款和已确认成本，按出诊分钟分摊公共费用，保留缺失、零值和修订历史。 患者以小程序为主要入口，网站保持同等业务规则。门店基础服务、医师专业方向与实际接诊服务分别核对，登录后保留选诊意向并重新校验就诊人与资源。轻量索引支持完整门店筛选与客户端距离排序，本人结算单显示已发布版本及当前收退款余额，代约权限不扩展到临床和账单。 初复诊完整文书引用准确检查、病史、方案与实际处置来源，医师在接诊结束后确认完整版本。诊断、离诊医嘱和复诊安排与资金事实分离；追加更正、历史对比及责任期限保留办理依据。 具体医疗告知绑定准确检查与方案步骤，本人决定、问题答复和撤回追加保留；预约代办与医疗代签权限分离。 医疗代理经材料核验与医师适用性确认后限定到具体步骤，开治依据与真实执行相连，已发生治疗缺口独立复核并保留历史。 病历完成后提交准确归档清单，由另一名获委任医师独立核对；固定文件与来源摘要保留。归档后的文书和检查更正先审批准确内容，再追加临床版本与补充归档包；缺项资料保全不冒充完整归档。

研究采用用例驱动与信息隐藏原则，基于模块化单体、事务约束及追加历史实现可追溯办理。八城二十店的课程合成场景用于核对多渠道流程、岗位隔离、并发、界面与恢复；统计指标明确时间、分母及完整性。验证结果只支持实际执行范围，不能替代真实专业资格、平台联调、临床有效性和独立商用运营评价。

关键词 系统分析与设计；连锁诊所；预约流程；患者服务；财务管理；设备维护

Analysis and Design of the ADC Dental Chain Operations Management System

ABSTRACT

Dental chains coordinate patient access, clinical care, shared resources and financial review across clinics. This study examines a single chain of approximately five to twenty clinics. It connects business problems to actor responsibilities, observable rules, use cases, domain relationships, state transitions and acceptance criteria. A modular monolith assigns ownership of business facts while preserving transactions.

The patient website and native WeChat client share discovery, identity and booking rules. Front-desk staff coordinate schedules and resources; managers review public profiles. Verified patient relationships remain separate from authentication and clinical authority. Clinical workflows connect reported history, structured examinations, treatment plans, actual procedures and follow-up. Initial and follow-up documents retain exact sources and author confirmation. Medical representation, plan acceptance, specific consent and treatment preflight are distinct responsibilities. Independently reviewed archives preserve fixed files and source snapshots. Post-archive corrections require approval of specific proposed content before the responsible clinician appends a version. Financial workflows distinguish production, posted receipts and refunds, payment evidence, reconciliation and reviewed costs.

Synthetic scenarios across twenty clinics support workflow, permission, concurrency, interface and encrypted-recovery evaluation. Metrics identify periods, denominators and missing information. The results establish tested software behavior within the observed scope. Institutional clinical and archive policies require qualified professional review; reliable signatures, physical devices and independent hosting require separate acceptance. Course confirmation is not presented as a qualified signature or approval for real clinical use.

Key words systems analysis and design; dental chain; appointments; patient service; finance; equipment maintenance

目 录

第 1 章 绪论.....1
1.1 项目背景与业务问题.....1
1.2 研究目标与实践意义.....1
1.3 分析依据与研究方法.....1
1.4 系统范围与报告结构.....2
第 2 章 相关方法与技术.....3
2.1 用例驱动与业务流程建模.....3
2.2 多渠道访问与模块化结构.....3
2.3 信息隐藏与职责分离.....3
2.4 数据一致性与历史保留.....4
2.5 场景验证与管理指标.....4
第 3 章 系统需求分析.....5
3.1 业务范围与现状分析.....5
3.2 系统总体目标与改进业务流程.....8
3.3 用户需求分析.....12
3.4 需求清单与优先级.....12
3.5 系统用例分析.....13
3.6 用例清单与业务完整性.....17
3.7 业务规则与非功能性需求.....18
3.8 电话预约与患者自助预约.....20
3.9 取消时段分析与业务改进.....23
3.10 财务收退款与费用核对.....25
3.11 设备维护与诊疗安排衔接.....26
3.12 患者关系核验与代约办理.....26
3.13 专业范围与跨店诊疗协作.....26
3.14 健康自述与实际检查记录.....27
3.15 连续诊疗与后续责任.....27
3.16 加工件送返、验收与原约保护.....28
3.17 公开找店与按需登录.....28
3.18 患者账号与本人建档核验.....28
3.19 医保资料核对与结算准备.....29
3.20 医保结算与基金清算.....29
3.21 医师与门店画像及连续选诊.....30
3.22 月度经营成本与利润完整性.....30
3.23 以小程序为主的完整患者办理.....31
3.24 服务连续性与上线交付要求.....31
3.25 初复诊完整文书与医师责任.....31
3.26 具体医疗告知与本人决定.....32
3.27 医疗代理材料与责任核验.....32
3.28 治疗前核对与真实补记.....33

3.29 病历归档与追加补正.....33
第 4 章 系统设计.....35
4.1 领域关系与状态模型.....35
4.2 模块职责与接口合同.....42
4.3 结果核对与只读模式.....43
4.4 账号安全封禁与业务退役.....43
4.5 设计原则在本项目中的应用.....44
4.6 协调与通知的数据责任.....45
4.7 任务状态与独立复核.....46
4.8 多渠道预约与接待记录设计.....47
4.9 科室和诊疗资源设计.....47
4.10 资金与设备的协作合同.....48
4.11 取消分析的数据与查询设计.....48
4.12 权限、审计与服务连续性.....50
4.13 数据库实体关系设计.....51
4.14 前台排班的职责与数据设计.....83
4.15 实际操作人与就诊人的分离设计.....83
4.16 专业权限与限定披露设计.....84
4.17 检查记录的版本与状态设计.....84
4.18 方案、执行与唯一收费来源.....86
4.19 随访完成与加工就绪状态.....88
4.20 门店资料版本与患者入口.....90
4.21 账号身份与建档决定设计.....90
4.22 医保资料的版本与独立核对.....91
4.23 结算责任与资金清算模型.....92
4.24 画像版本、门店采用与任职退出.....92
4.25 月度核算、分摊与报告版本.....93
4.26 两端选诊与查询边界.....95
4.27 多端共享投影与患者只读结算.....95
4.28 版本发布与异地恢复设计.....96
4.29 完整文书版本与责任待办设计.....96
4.30 本人医疗决定的版本与沟通设计.....100
4.31 医疗代理依据与限定访问设计.....104
4.32 开治依据执行与缺口复核设计.....107
4.33 归档、独立审核与准确补正设计.....111
第 5 章 系统实现与测试.....117
5.1 功能范围与完成状态.....117
5.2 预约与接诊的界面组织.....119
5.3 财务与设备的操作衔接.....120
5.4 典型业务场景与测试设计.....121
5.5 业务测试结果与质量评价.....123
5.6 预约指标的独立核算示例.....124
5.7 需求、用例与验收追踪.....124
5.8 专业协作的实施与适用边界.....126

5.9 检查业务的应用与限制.....126
5.10 连续诊疗业务的跨岗位核对.....126
5.11 门店发现与登录延续核对.....127
5.12 本人申请与跨渠道办理核对.....127
5.13 医保资料基础的业务核对.....128
5.14 模拟结算和基金资金核对.....128
5.15 微信登录和短信核验的验证.....129
5.16 医师与门店选诊的跨岗位核对.....129
5.17 经营核算的独立业务校验.....130
5.18 二十店能力矩阵与患者渠道验证.....130
5.19 初始化与运行交付验证.....131
5.20 初复诊文书与更正的业务核对.....131
5.21 本人医疗决定与沟通闭环核对.....132
5.22 医疗代理及开治业务场景核对.....132
5.23 归档、独立审核与追加补正核对.....133
第 6 章 总结与展望.....134
6.1 设计成果与业务价值.....134
6.2 下一阶段业务完善计划.....134
6.3 研究限制与进一步评价.....135
参考文献.....136
附录 A 基础系统用例规约.....139
附录 B 维护 协调与通知用例规约.....156
附录 C 扩展业务用例规约.....173

第 1 章 绪论

1.1 项目背景与业务问题

ADC 案例描述广东地区 15 家牙科诊所及三年内数量翻倍的扩张计划。管理者希望掌握各店服务质量、患者取消情况、牙医技能组合与经营表现，并以标准化业务资料支持管理决策。[1] 本项目据此选择一家拥有约 5 至 20 家诊所的连锁作为系统服务对象。

业务问题集中在五个方面：预约咨询与正式预约的界限不清，电话接待需要多次人工核对；患者对可用时段及变更结果不易掌握；接诊与实际治疗、账单和实收之间容易脱节；设备维护影响诊疗安排但缺少统一协调视图；经营报表能显示取消总量，却不足以解释哪些时间段、哪些原因需要优先改进。

1.2 研究目标与实践意义

系统以患者服务过程为主线，连接预约前咨询、预约确认、到诊交接、治疗记录、结算收退款及后续服务。业务人员应能知道下一步由谁办理、需要什么资料、成功后得到什么结果，以及失败时如何继续处理。

管理目标包括提高预约可解释性、减少重复录入与错误交接、保留资金和设备责任记录，并提供可核查的经营指标。业务价值以完整场景和可观察结果评估，不预设取消率已经下降、收入已经增长或系统已达到大型商业运营水平。

1.3 分析依据与研究方法

以课程案例和 note 讲义为理论依据。note 3 强调需求应说明系统提供的服务、可被用户理解并具备可测试性；因此每项主要业务均描述参与者、触发、正常与异常路径及结果。note 5 强调关注点分离、简单性与受限可见性；因此预约、临床、财务、设备各自管理本模块的业务规则，通过明确操作衔接。[3,5]

分析顺序为业务问题识别、现状流程建模、改进流程设计、用例和数据设计、场景验证。财务和统计部分同时运用会计核对与管理分析方法，将账单金额、实际资金、缺失资料和比例分母分别表达。流程设计中的岗位分工与资源规则属于课程方案，需要结合真实机构访谈进一步确认。

1.4 系统范围与报告结构

系统当前范围为患者服务、服务说明发布、电话及网站与小程序预约、到诊治疗、版本化结算、资金核对、候补排班、设备维护和经营分析。后续目标为同一连锁独立部署的完整门诊平台；临床监护同意、连续诊疗、临床签署及处方药事作为后续需求分别设计与专业验收。

第 2 章介绍方法与技术，第 3 章说明业务需求和流程，第 4 章给出系统设计，第 5 章讨论功能实现与业务测试，第 6 章总结设计并安排后续工作。附录提供 63 项编号业务用例和 1 项共享核验规约。演示采用合成资料，真实支付、保险申报及临床自动决策不在课程系统范围内。

表 1-1 项目目标与可观察结果

目标	预期结果	主要核验对象
G1 资料一致	跨店复用患者编号，分别记录多过敏与多资格	档案关系与跨店查询
G2 业务闭环	预约、到诊、实际治疗、结算及更正可以关联核对	状态、账单与历史版本
G3 操作可理解	身份入口分离，唯一身份直达，手动引导不扩权	工作上下文与任务路径
G4 结果可解释	缺失不等于零，指标带分母，收入只计当前版本	统计粒度与季度核对
G5 协作可控	承诺、接收控制、任务与消息分开；已有安排不会被隐式撤销	候补、权限与异常响应

思维导图 业务背景 → {患者服务、岗位协作、经营核对} → 研究目标 → 范围与方法 → 六章分析设计。

第 2 章 相关方法与技术

2.1 用例驱动与业务流程建模

用例从执行者希望达到的业务结果出发，回答谁发起、为何办理、如何交互、何时成功和失败后保留什么。电话预约的咨询登记与正式预约分别建模，避免把一次询问误认为已有时间承诺；系统用例通过需求与测试追踪，连接用户可见行为和设计责任。[3]

业务序列说明不同岗位如何交接；活动流程突出选择与异常；领域模型表达患者、就诊、治疗、账单和资源之间的关系；状态机约束允许的业务变化。图示与文字规约相互补充，不能用页面清单代替完整业务流程。

2.2 多渠道访问与模块化结构

员工通过网站办理诊所业务，患者通过网站或原生微信小程序查询时段、预约、改期及候补。患者服务中心集中展示下一次就诊、待确认邀约和候补进展；两个渠道共用患者授权、排班资源、明确确认和保存结果。 门店主管明确发布患者服务说明；前台维护出诊，患者在选择时段前先了解服务范围与费用，服务介绍不等于治疗或收费。

系统采用 Django、PostgreSQL 和独立通知处理组件。模块化单体在同一事务边界中处理预约占用、治疗结算和资金审核，适合课程系统对一致性、可维护性和实施成本的要求。

2.3 信息隐藏与职责分离

接待模块管理沟通、责任及成约关联；排班模块管理服务目录、资源日历、方案与占用；临床模块管理实际治疗；财务模块管理结算、资金及审核；设备模块管理资产状态和维护。其他模块通过明确业务操作取得结果，不直接改写对方数据。[4-5]

职责分离也适用于岗位。经办人与独立审核人不能为同一账号；技术管理员维护账号和基础目录，不因此取得患者病历和财务审核权。

2.4 数据一致性与历史保留

通过事务、版本检查和资源锁保持关联结果的一致性。查询空闲不占用时段，提交预约时重新核对；改期失败保留原预约，成功后保留原记录及后继关系。实际治疗、已发布账单及已记账资金通过保留版本或追加记录更正。

患者取消、诊所取消、改期和爽约表达不同事实。资金申请、独立审核、实际记账、账内日结及渠道对账也分别表达状态，防止使用一个“已完成”掩盖不同责任。

2.5 场景验证与管理指标

业务测试以真实流程结果为依据。例如，预约确认产生唯一记录，治疗意向不进入收费，退款不超过可退余额，设备恢复需有独立验收。异常测试覆盖资源竞争、撤销权限、旧页面、重复提交和跨诊所访问。

统计分析同时展示期间、样本量、分子、分母及待核实数量。取消高发时段首先是需要调查的业务信号，不能仅凭比例推断原因，也不能用合成数据证明真实患者行为。

思维导图 分析方法 → {用例、业务序列、领域、状态}；设计原则 → {信息隐藏、职责分离、一致性}；评价 → {业务结果、分母、异常}。

第 3 章 系统需求分析

3.1 业务范围与现状分析

3.1.1 业务边界与业务用例

业务边界仍取既有的“诊所服务与运营核对业务域”。患者和总部管理是该责任域的外部业务执行者；总部不因此成为 ADC 组织之外的机构。前台、牙医与财务是域内业务工人，既有载体及 ADC 系统按业务实体表达。业务用例描述对外价值，不表示菜单或操作顺序。（课件第 85—89、93 页）

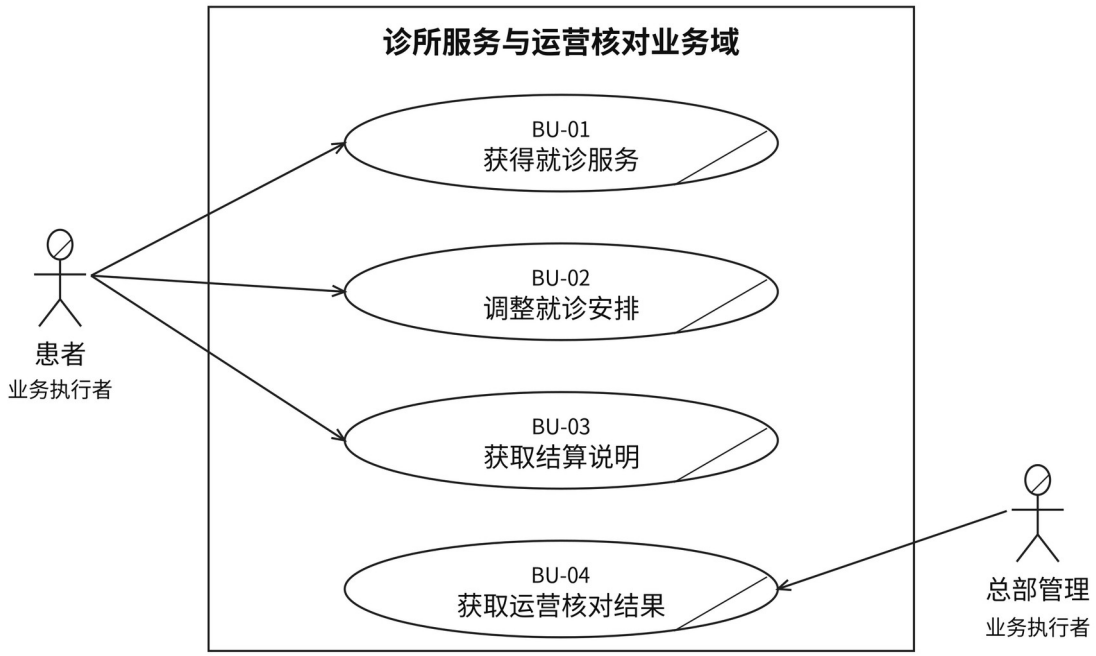

图 3-1 诊所服务与运营核对业务用例图（B01）

表 3-1 业务用例及成果

业务编号	业务成果	主要协作
BU-01	获得就诊服务	前台、牙医
BU-02	调整就诊安排	前台、主管
BU-03	获取结算说明	牙医、前台、财务
BU-04	获取运营核对结果	各店、牙医、财务

3.1.2 现状就诊服务

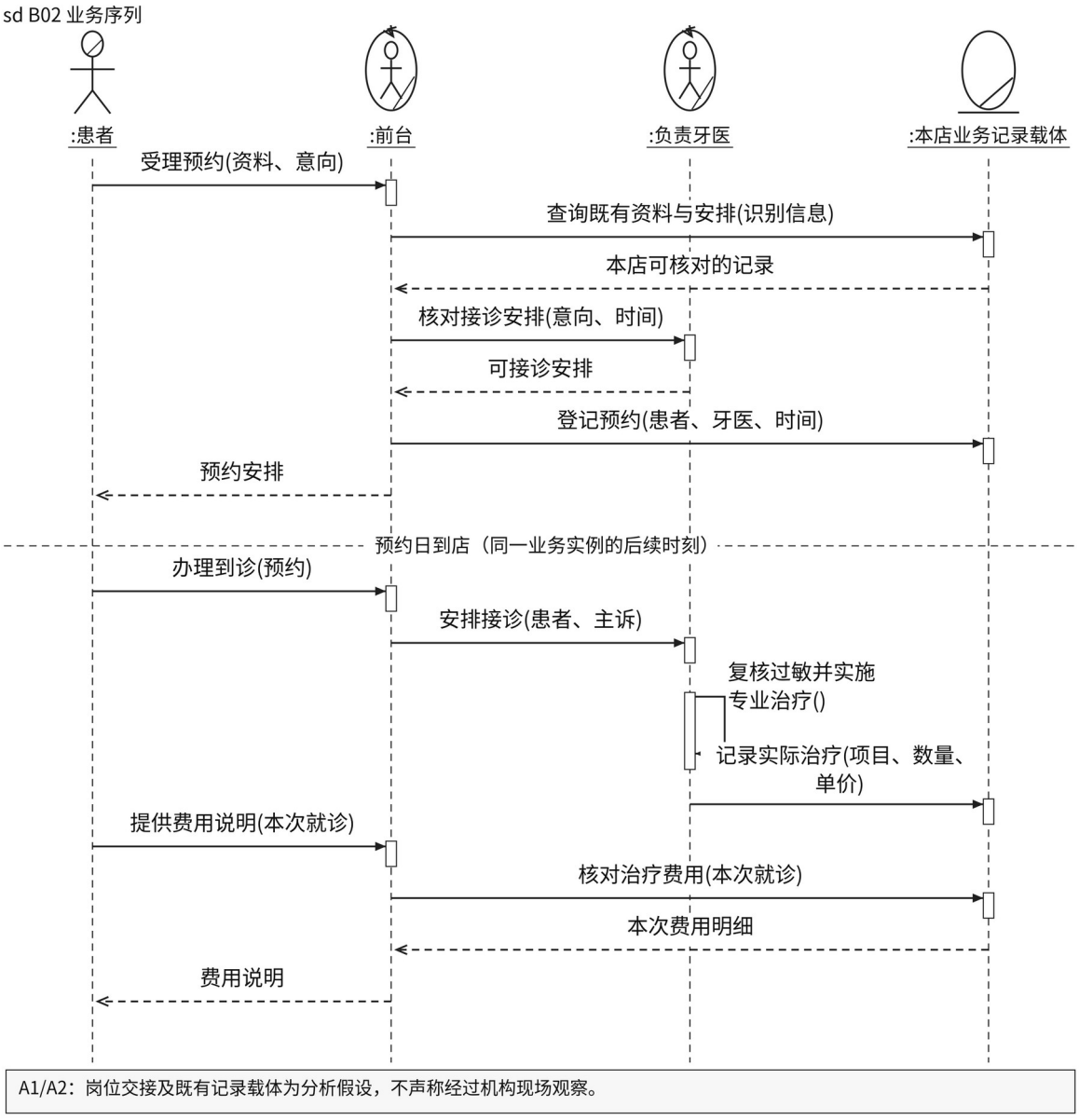

图 3-2 AS-IS 预约、接诊与费用说明（B02）

本图根据案例描述重建现状业务情境。电话预约、患者资料、治疗计量及费用信息由案例支持；由前台向牙医协调、何时读取本店记录采用 A1／A2 假设。[1]

问题定位：跨店识别、时间协调和结算依据缺乏统一核对时，可能产生反复确认。此模型不证明旧系统每次出错，也不提供现状耗时统计。

3.1.3 现状季度核对

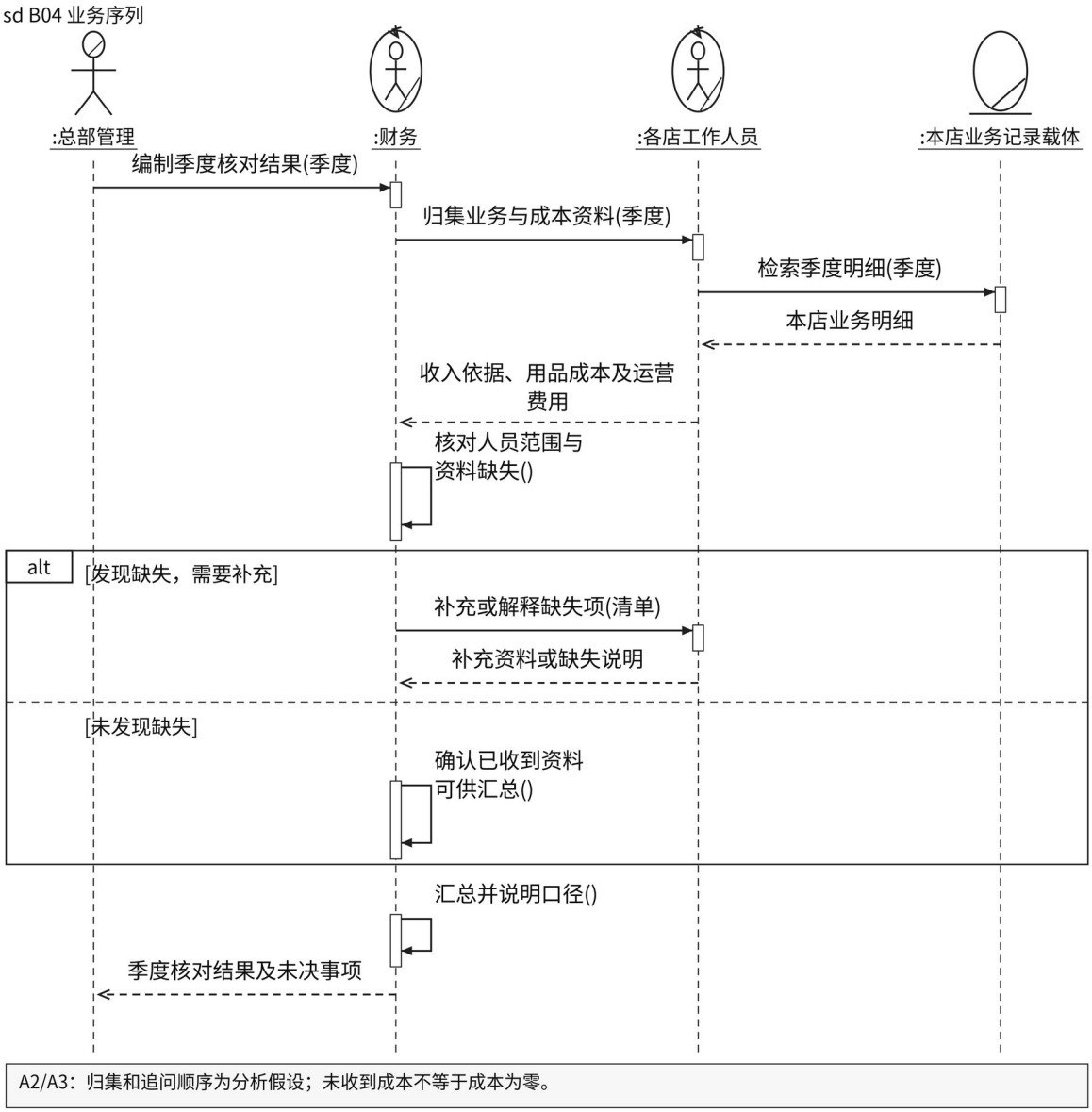

图 3-3 AS-IS 季度资料归集与核对（B04）

案例明确要求按季度跟踪牙医收入、用品成本及运营费用，并提出总体激励基金比例。具体归集、汇总与缺失追问顺序采用 A2／A3，不将补充流程冒充现场调研结论。[1]

核心风险是完整性不能由零散提交自行保证：未提交成本不等于成本为零，取得费用单也不等于已经收款。

3.2 系统总体目标与改进业务流程

3.2.1 统一服务

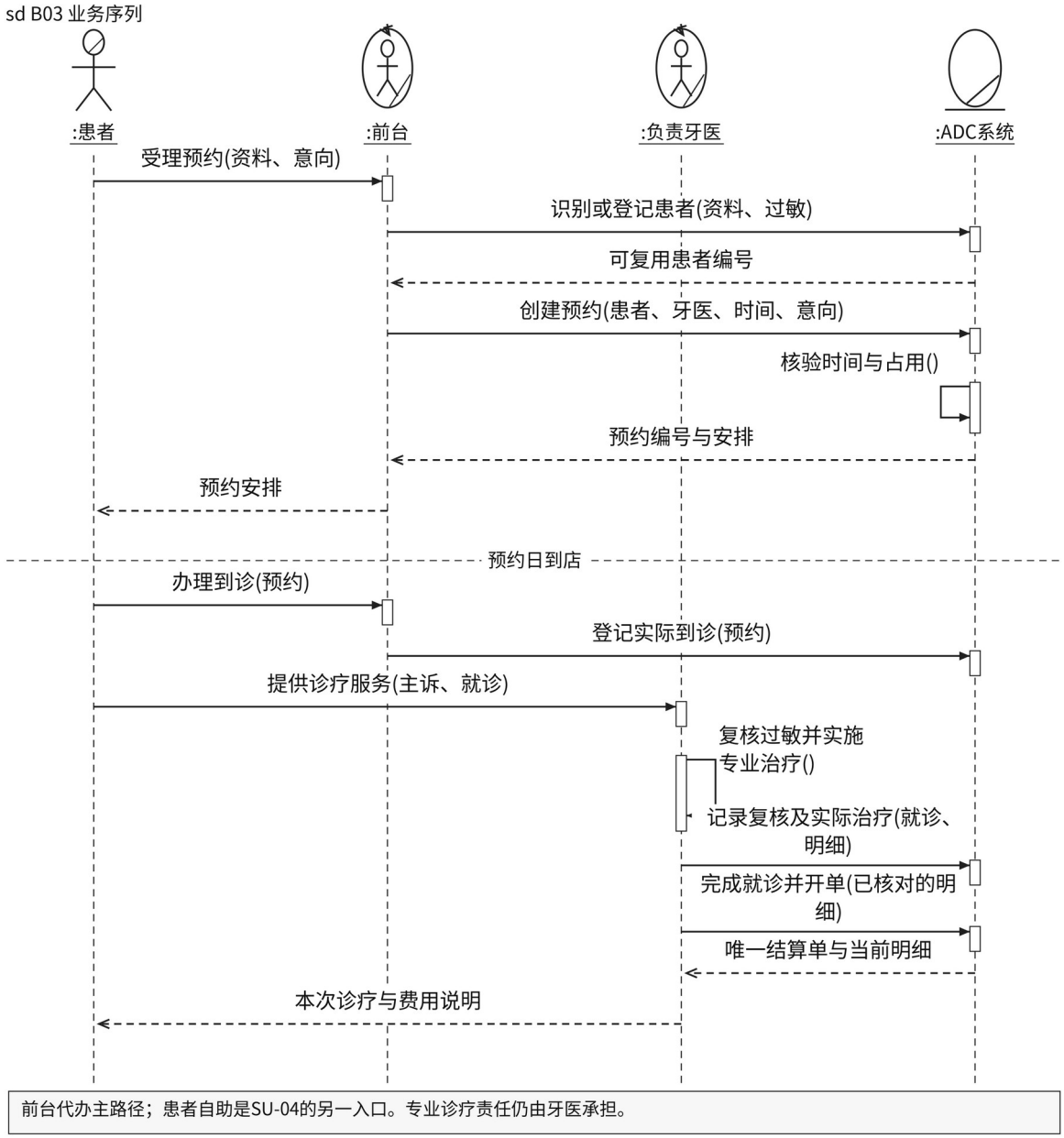

图 3-4 TO-BE 统一就诊服务主路径（B03）

ADC 系统在改进后的业务序列中是新增的业务实体；前台、牙医仍为业务工人。图中保留到店登记、专业诊疗及费用说明的责任区别；不展开软件内部边界类、控制类或 SQL。图示以前台代办为主路径，患者自助遵守同等预约约束。（课件第 87—89、108—112、314 页）

冲突、未知过敏、无治疗关闭和重复完成分别见 SU-04、SU-07、SU-08。预约意向不直接生成治疗或费用，系统不代替临床判断。

3.2.2 季度核对

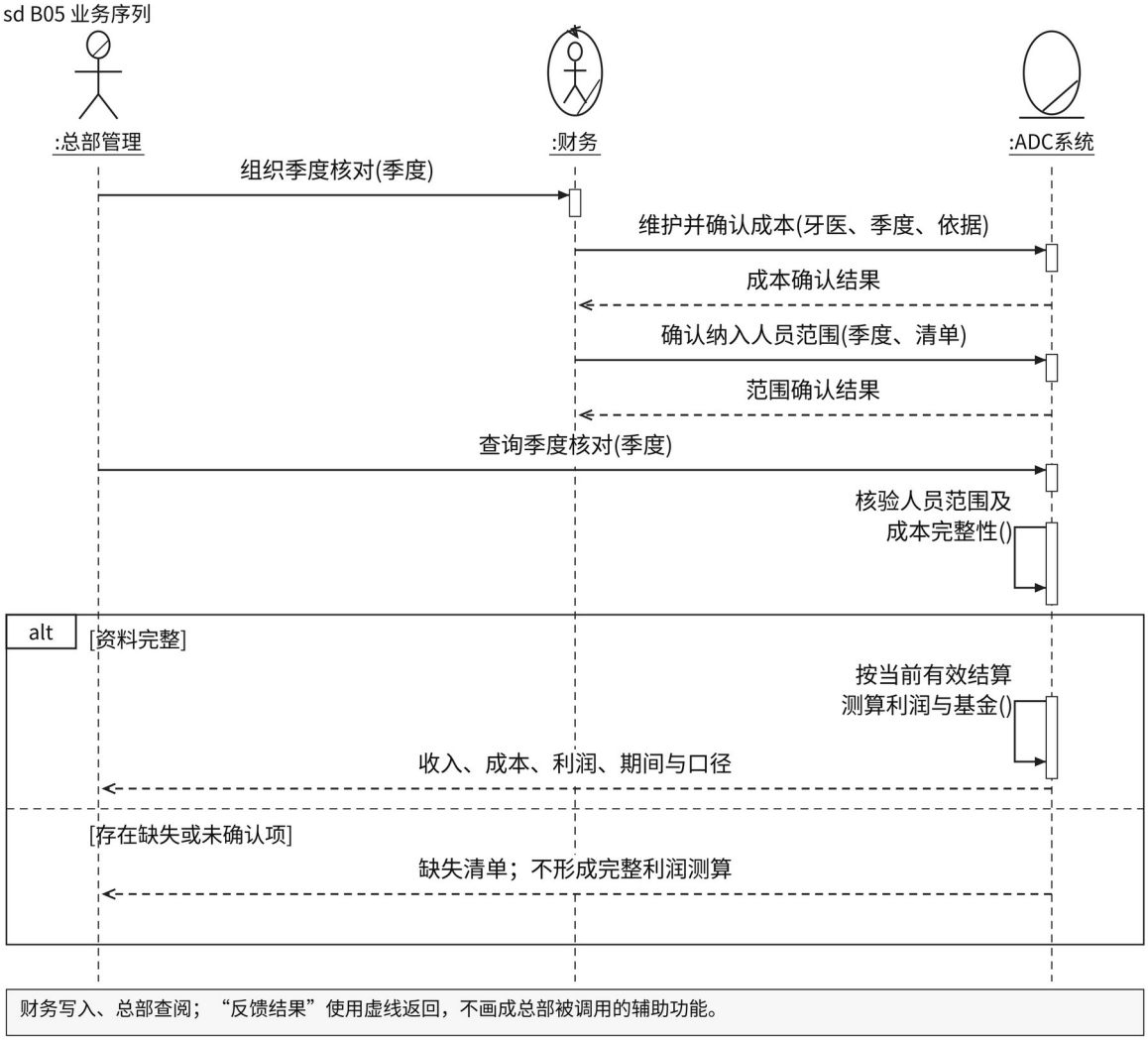

图 3-5 TO-BE 季度完整性核对及测算（B05）

财务维护、总部查阅分权。以当前有效结算单开单金额作为项目收入口径，按北京时间自然季度归属；先确认人员范围和成本，再形成测算。资料完整与资料缺失由 alt 片段表示为互斥分支。

对牙医 d、季度 q：$P(d,q)=R(d,q)-C(d,q)-O(d,q)$。总体 $P(q)$为纳入牙医利润贡献之和；资料完整且 $P(q)>0$ 时，$F(q)=10\%\times P(q)$。这是项目测算，不是法定财务净利润或个人奖金政策。有成本但无收入者仍需纳入，更正后只计当前版本。[1；项目设计]

3.2.3 候补协同

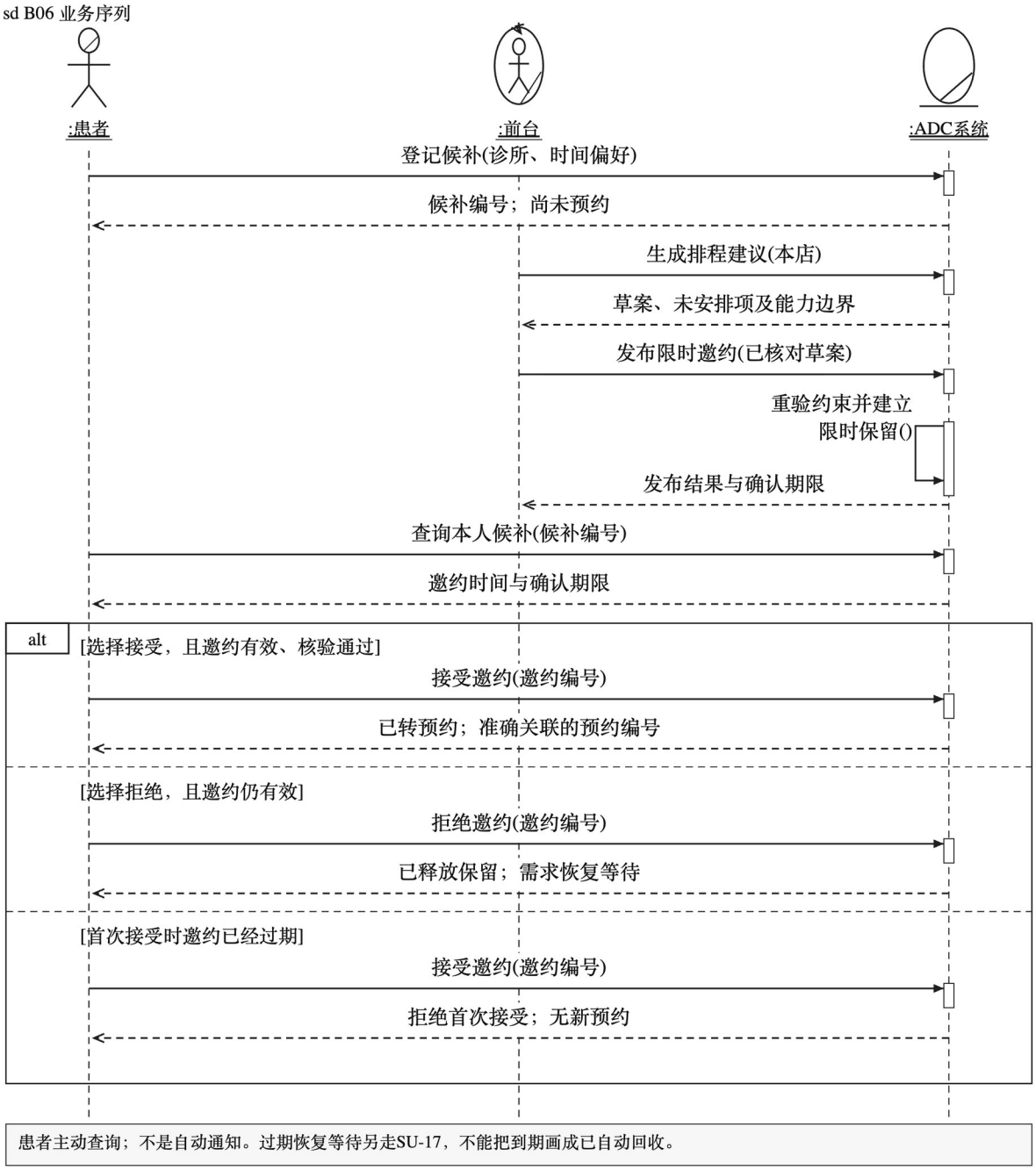

图 3-6 TO-BE 候补、限时邀约与明确接受（B06）

候补登记与排程草案都不等于正式预约。本店前台核对并发布后形成有期限的保留，由本人患者或取得明确意思的前台接受后才创建预约。接受、拒绝和失效在图中分别表达，不视为必然依次发生。

未启用资源控制的历史模式保留固定 30 分钟、有限候选最大匹配；已启用资源控制的诊所按服务时长、登记先后、可行时间和稳定资源顺序生成建议，不保证全局最

优。患者短信、邮件和自动确认不在本阶段范围。邀约仍保留至发布后 15 分钟或预约开始的较早时点。

3.2.4 责任协调

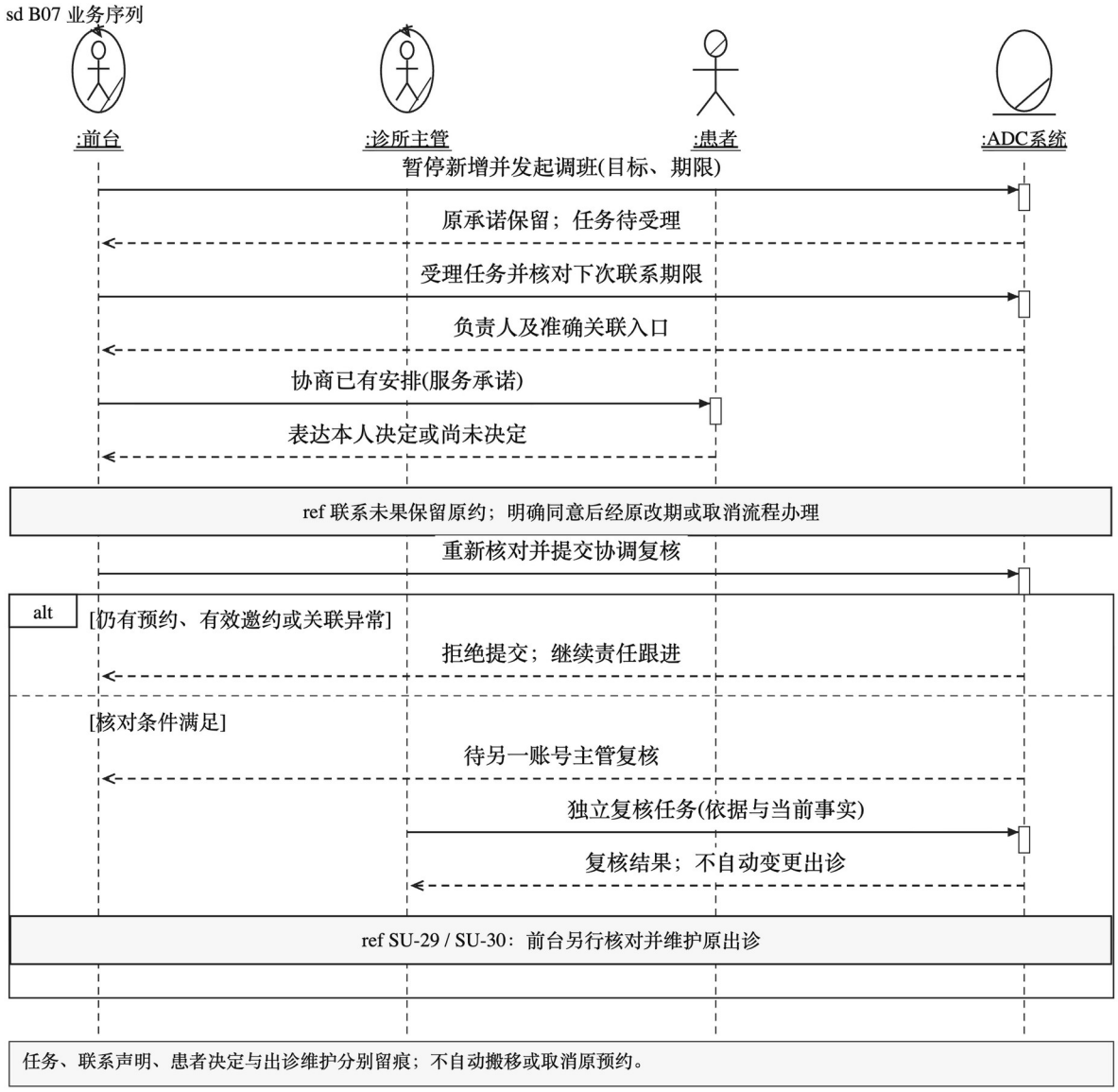

图 3-7 改进后的出诊责任协调业务序列（B07）

前台先明确暂停新增，再协商并通过原业务流程处理；有阻断不得提交。只在提交与独立复核成立的分支进入后续维护。该 TO-BE 模型不声称新增了临床停诊或患者自动同意。

3.3 用户需求分析

七类工作台按当前身份及对象范围授权。一个人可以有多个授予的岗位，但一次只激活一个；切换身份不能自行审核。技术管理负责普通账号和基础目录，不因维护职责取得患者病历或财务审核权。

表 3-2 利益相关者及职责边界

参与角色	核心工作目标	边界
患者	预约、核对本人安排与费用、登记候补	仅本人绑定资料；不编辑治疗
前台	电话接待、患者档案、日周排班、出诊维护、候补发布、调班联系与到诊	仅当前店；保护原承诺，不审核治疗、资产验收或资金
负责牙医	复核信息、记录治疗、核对结算	本人负责的接诊；专业判断由人承担
诊所主管	资源规则、维修协调、独立复核与本店经营汇总	当前店汇总及独立复核；日常排班由前台办理
总部	全链汇总、季度核对与设备查阅	只读汇总；不代办财务写入或审核
财务	渠道账户、成本、资金及匹配复核	经授权办理；不同账号独立复核
技术管理	普通账号、基础资料登记、资格记录关联与安全处置	不默认获得临床或财务编辑权

3.4 需求清单与优先级

表 3-3 需求模块与业务结果

模块	优先目标	受保护业务结果
患者与临床	关键	稳定编号、到诊、过敏复核、实际治疗、明确结束。
财务与设备	关键	版本化账单、真实资金及凭据、独立复核、费用来源。
预约与服务	关键	患者明确确认，电话接待有责任，资源核对有依据，取消改期可解释。
排班与协调	重要	既有承诺保留、明确受理与复核、消息不代替业务事实。
经营与保障	重要	时段指标带分母与缺失，服务中断可识别，业务记录可恢复。

3.5 系统用例分析

3.5.1 患者服务与接诊用例

系统边界为 ADC 软件。患者、前台、牙医和财务等作为执行者分别达成目标，每次工作上下文只激活一个身份。实线箭头表示功能交互，include 表示共享核验，不表示业务的时间先后。

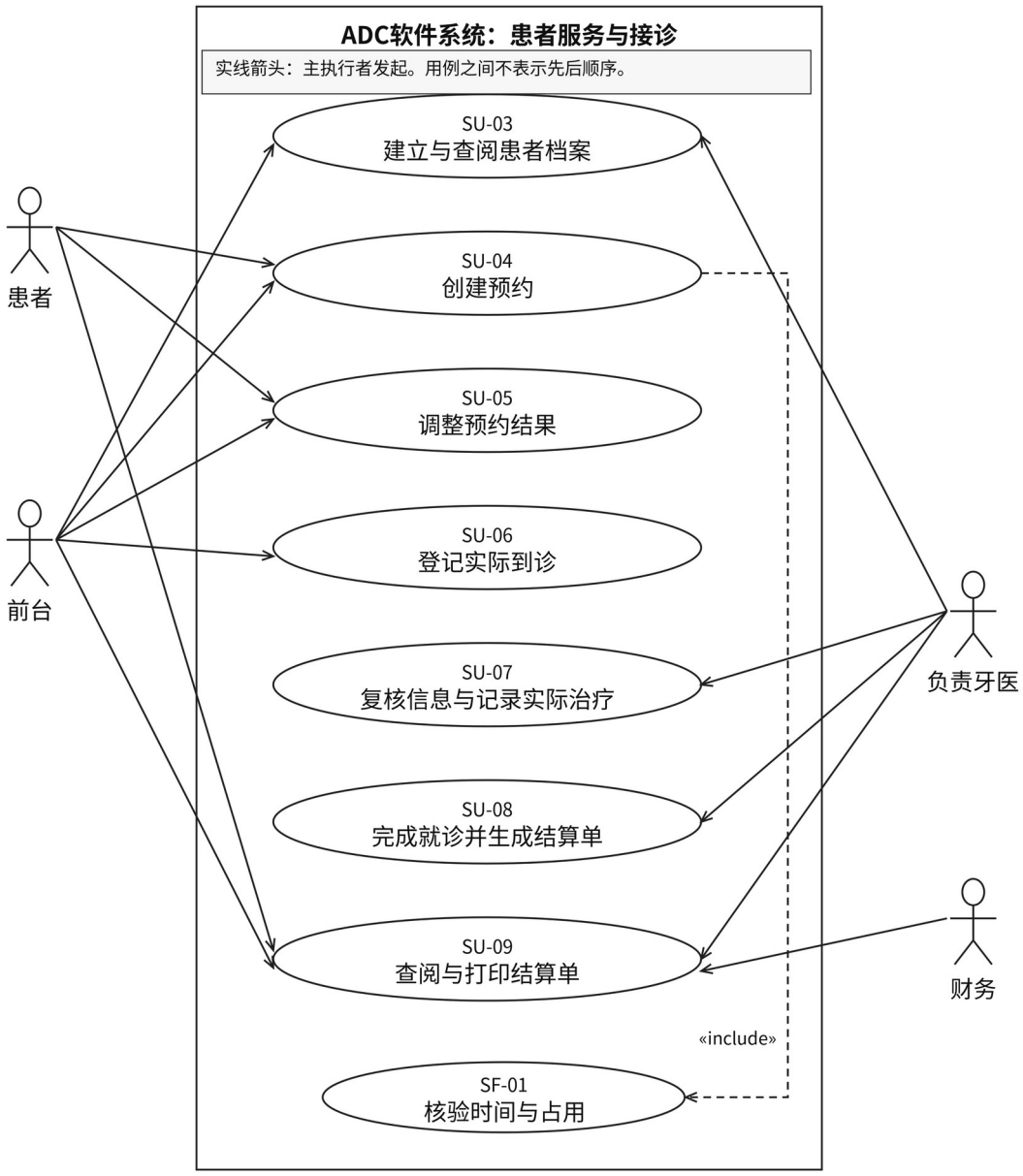

图 3-8 患者服务与接诊系统用例（S01）

SU-04 包含 SF-01，表示提交预约必须执行共享核验；患者在 SU-05 中仅取消本人允许取消的预约，前台还可办理本店改期与爽约核实。共用椭圆不代表角色具有相同权限。

3.5.2 候补 财务与运营用例

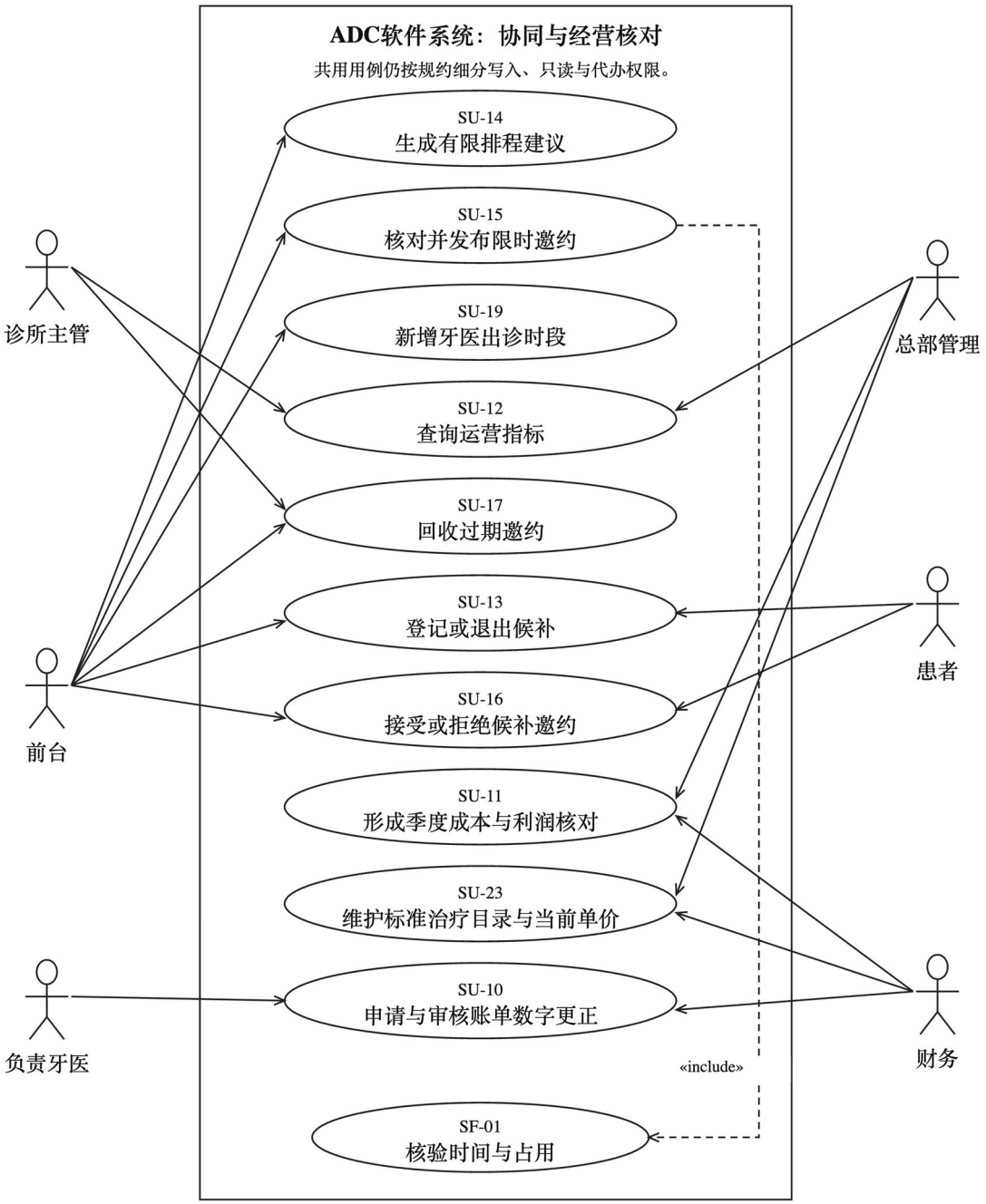

图 3-9 候补协同、经营核对与标准目录用例（S02）

SF-01 与图 3-8 为同一共享子功能。SU-16 仅接受分支复用占用核验，拒绝无需创建预约；SU-10 要求不同账号审核，不允许同一账号切换角色自批。SU-23 财务可维护、总部只读。取消与创建是不同目标，不滥用 extend 表示时间先后。

3.5.3 身份 引导与安全用例

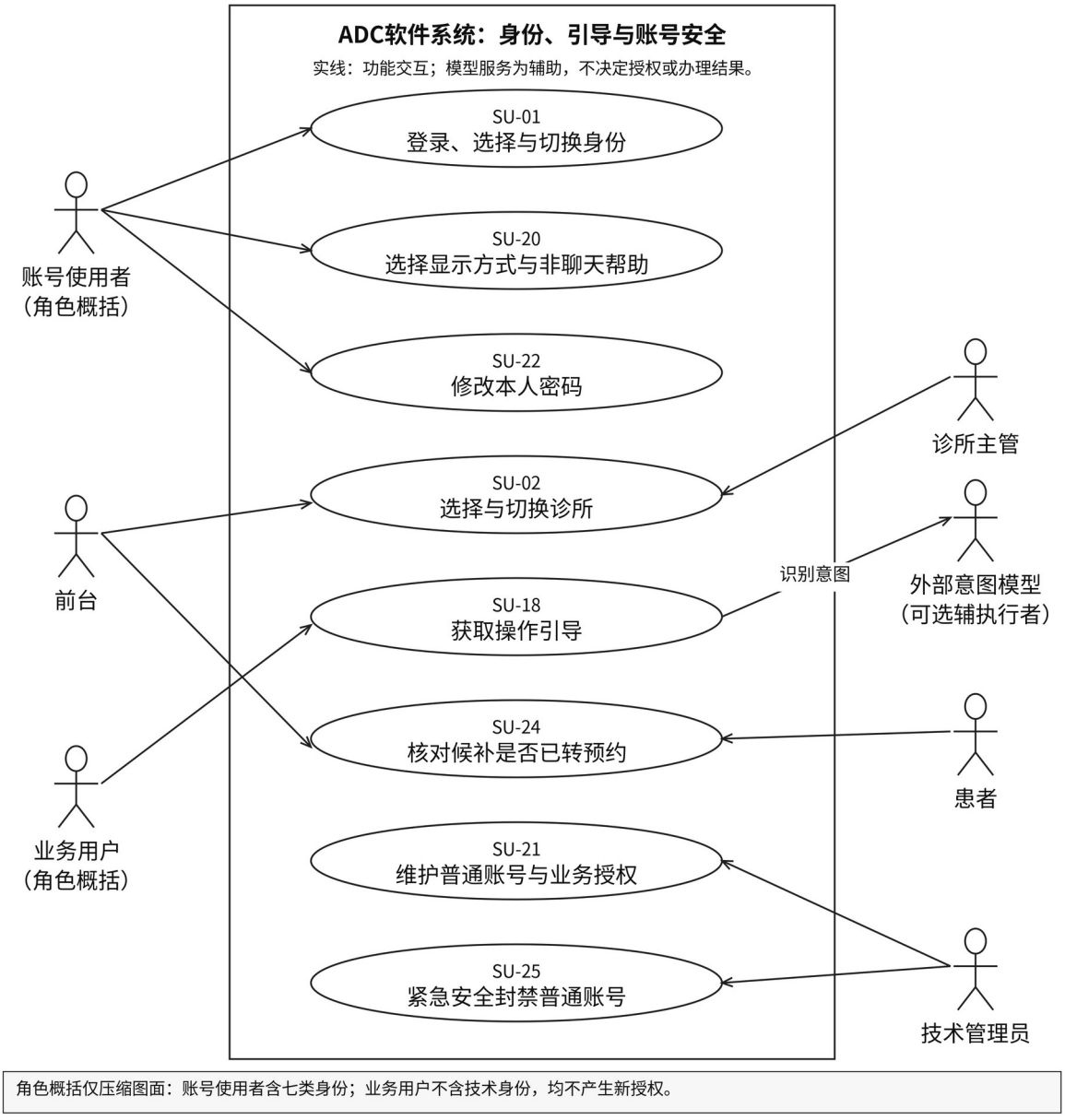

图 3-10 公共能力、结果核对及账号安全用例（S03）

SU-01—25 及 SF-01 规约见附录 A；SU-26—38 见附录 B。各用例表示独立可接受的用户目标，不用用例间箭头表达业务办理顺序。原始用例编号保持稳定，新增关系只在规约支持时引入。

3.5.4 资料与出诊维护用例

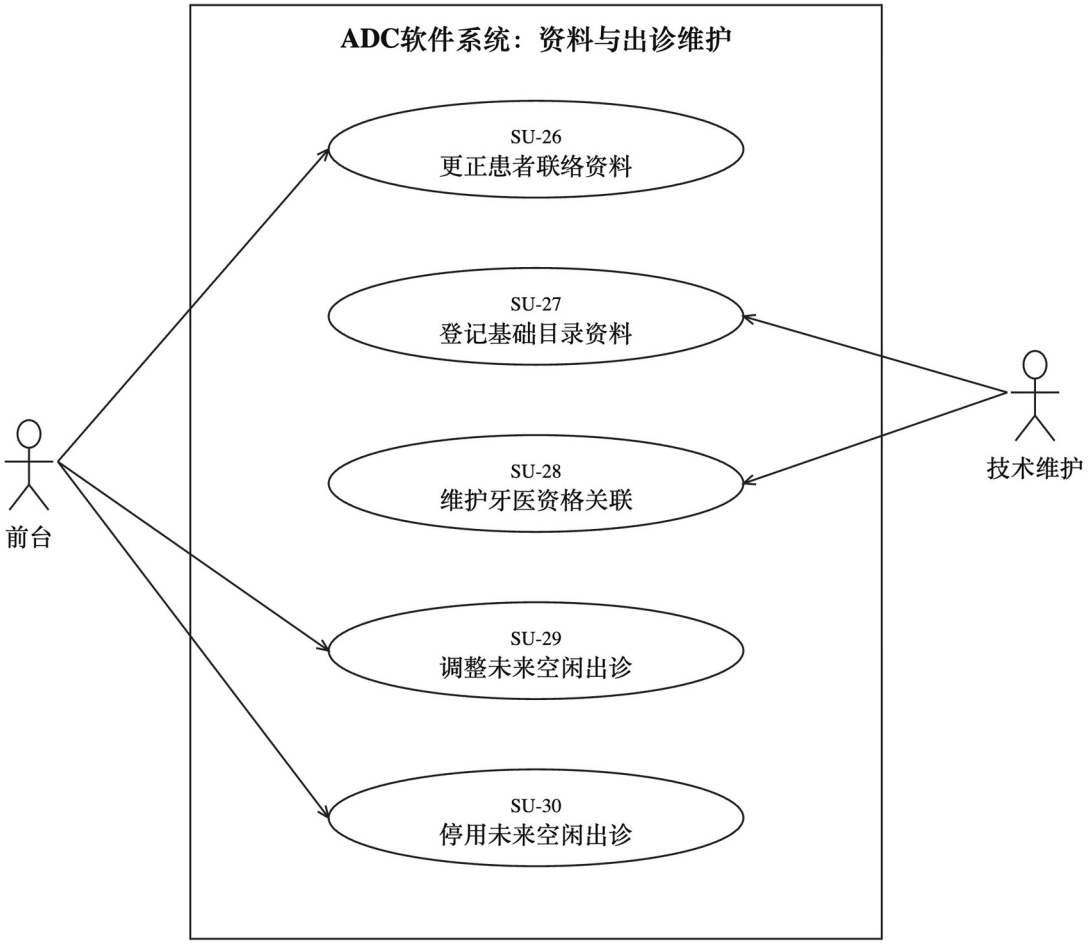

图 3-11 资料与出诊维护系统用例（S04）

角色来自实际业务交互，不因技术管理身份而扩大临床或财务权限；用例之间不以时间先后建立 include。详见附录 B 的 SU-26—30。

3.5.5 责任协调与通知用例

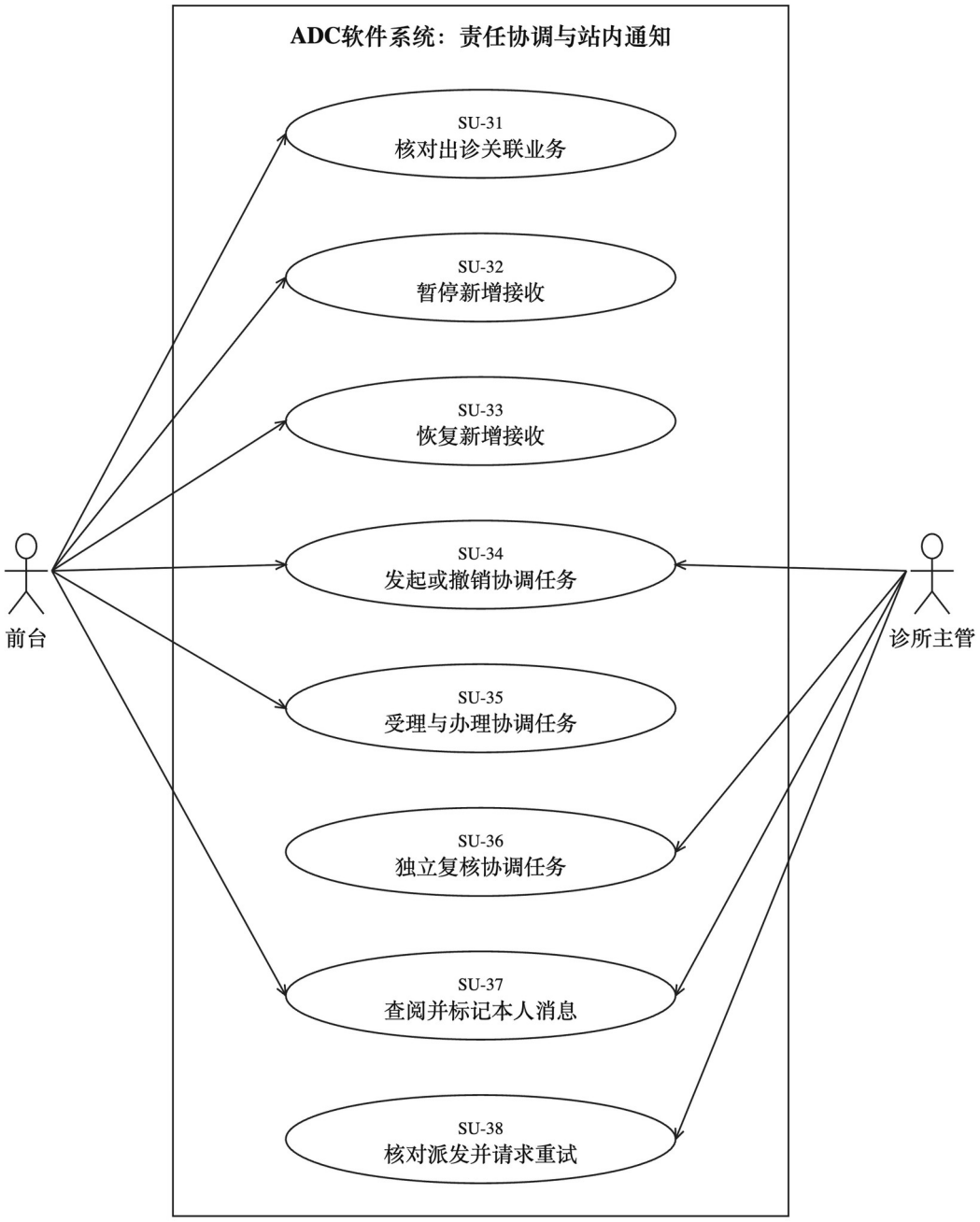

图 3-12 责任协调与站内通知系统用例（S05）

前台和主管分别承担受理与独立复核；两者均可查看本人的当前范围消息。通知后台属于内部实现机制，不冒充业务执行者。详见 SU-31—38。

3.6 用例清单与业务完整性

系统共定义 140 项编号业务用例和 1 项共享核验。附录 A 为 SU-01—25 及 SF-01，附录 B 为 SU-26—38，附录 C 为 SU-39—140。电话接待关注咨询与联系，SU-04 关注

正式成约；网站和原生微信小程序是预约、候补及改期的渠道路径，不按页面数量重复计数。

表 3-4 用例分组及业务目标

业务范围	编号	使用者目标
身份与资料	SU-01—03、21—23、25—28、64—67、83—86、97—101	账号、患者资料、基础目录、专业审核与限定转诊。
医保结算与基金清算	SU-91—96	原费用分担、银行分配、差额跟进和撤销分别核对。
连续诊疗	SU-68—80	自述检查、方案决定、实际执行、复诊与加工件验收。
医保资料	SU-87—90	来源目录、门店安排、收费适配及患者待遇分别核对。
预约与接诊	SU-04—10、19、29—33 SU-39—40、54、57—63	预约、变更、到诊、治疗、结算与资源核对。
候补与协作	SU-13—17、24、31、34—38	候补、邀约、任务办理、独立复核及消息。
经营与引导	SU-11—12、18、20、41、55—56、81—82	成本利润、取消分析和操作协助。
资金与对账	SU-42—49、53	渠道、收退款、凭据、流水、对账及日结。
设备维护	SU-50—52	资产、维修责任和独立验收。
画像与经营核算	SU-102—110	任职、资料审核、选诊、月度成本及利润核对。
病历与医疗决定	SU-111—140	文书与更正；本人及代理告知决定、开治、真实补记、归档与批准补正。

分组交叉列出的协作用例只计一次。每项规约说明触发、前置、交互、替代路径、成功结果、最低保证和验收目标；待实现设计在规约和第 5 章明确标注。

3.7 业务规则与非功能性需求

表 3-5 业务规则汇总

编号	规则内容
BR-01	身份与范围：有效授权、当前激活身份、诊所及对象范围共同核验。唯一身份也须正式激活；切身份清旧店，切店不改身份。

编号	规则内容
BR-02	资料：跨店复用患者编号；电话不是唯一身份。未知、已确认无已知过敏及具体过敏条目分别保存。
BR-03	时间与占用：开始早于结束；处于有效出诊时段；同一患者或牙医的有效预约与邀约保留不得重叠。
BR-04	状态：已预约、已到诊、治疗完成、无治疗关闭、取消、爽约、改期替代分别处理；普通编辑不任意回退终态。
BR-05	结算历史：实际治疗为计价依据；逐行舍入至分后汇总；闭合就诊恰有一张逻辑结算单，历史版本不原地覆盖。
BR-06	更正与季度：仅允许范围内的数字更正，独立审核；缺失不等于零，只计当前有效账单版本。
BR-07	候补：每患者同时最多一条有效候补；未来 14 天连续窗口，至少容纳 30 分钟；邀约有效且经明确接受才建预约。
BR-08	排程：最多 60 条需求、80 个出诊块、200 个候选格；只对枚举图最大匹配；草案超过 15 分钟不得首次发布。
BR-09	引导：页面与步骤来自维护目录；不自动点击或提交；外部模型可选，不将“下一步”当作业务成功。
BR-10	指标：按 Visit 而非治疗行计数；未来、改期替代、诊所取消与待核实分别列示；零分母显示 N/A。
BR-11	账号：目标状态、操作者和权限重新核验；普通停用遵守业务交接，紧急安全封禁按 BR-15 独立处理。
BR-12	目录：标准单价变化不回写已存治疗快照和历史结算；财务维护、总部只读。
BR-13	结果：沿选定候补—邀约—预约关联核对；区分曾转换成功与当前预约状态；查询失败不推断原办理失败。
BR-14	只读模式：按经审核的路由与操作语义放行受限查询，不将所有 POST 等同写入；任何业务写操作仍受限。
BR-15	安全封禁：立即停止受控普通账号访问并使原凭据失效，不等待未闭合业务、不自动取消预约；恢复先重置再启用。

令 t 为服务器核验时刻，s 为候补最早可开始时间，e 为最晚必须结束时间。候选代码采用 $s>t$、$e-s\geq 30$ 分钟、$e\leq t+14$ 天。跨多天窗口表示一个连续可接受区间，不表示每天重复的时段。合法偏好仍不保证存在匹配资源。

表 3-6 关键边界决策

条件	规范结果
s=t、e≤s 或不足 30 分钟	指出对应字段，不保存候补。
首次接受时 t≥截止时刻	拒绝首次接受，不创建预约。
已接受后再次提交	先核验当前权限，再返回既有预约，不因旧期限已过重建。
收到请求但回执丢失	查询已有结果；不能自动重复办理或断言未保存。
有未来业务但账号疑似泄露	允许受控安全封禁，保留业务；后续交接另行核验。

表 3-7 质量要求及验证方法

编号	可测试要求	证据方法
NFR-01	关键事务无部分生效，重复接受只关联一条预约。	真实 PostgreSQL 独立连接竞争、失败注入及前后数据核对。
NFR-02	320／390px 及桌面主要动作可达；键盘与文本错误提示可用。	真实模板、浏览器、键盘和辅助技术检查；无 AI 普通流程仍可用。[15]
NFR-03	直接 URL、POST、撤权、旧上下文及受限查询均不得越权。	角色—对象—范围正反矩阵；不能只查菜单。
NFR-04	指标带分子分母，邀约带期限，核对结论带读取时点。	固定样本独立计算和字段核对。
NFR-05	升级保留历史，备份能够恢复；公网配置单独验收。	隔离空库恢复、登录与金额核验；归档可读不等于恢复成功。
NFR-06	性能目标与已测能力分开；预约、接诊及财务办理分别测量，复杂分析与导出另行记录。	以可重复的预约、接诊和财务工作负载测量正常请求 p95 及失败率；五店已测，二十店规模仍需业务代表性验证（第 5、6 章）。

可测试性、异常响应与维护可读性来自课程要求的规格属性；上述具体指标为项目自定目标，不是教师额外评分线，也不是当前已测结果。[3]

3.8 电话预约与患者自助预约

电话接待先记录来电者、与患者关系、待核实联系方式及服务、日期和医师偏好。咨询阶段不占用资源，也不授予病历访问权。新患者成约前完成姓名、出生日期、账单地址、联系方式和紧急联系人等既有建档要求；老患者按完整业务编号核对，不以手机号自动合并。过敏状态允许未知，仍由接诊人员复核。

前台核对预约服务及其总时长、科室开放、接收医师、诊室椅位和必要设备，向患者解释可行组合。复述诊所、服务、医师和起止时间，记录患者明确同意后再次核验并保存预约、资源占用与接待关联。查询不保留时段，冲突时重新协商，不擅自更换安排。

联系未果和待回复均保留有效负责人、下次期限及沟通历史；无资源、拒绝方案或联系未果分别记录未成约原因。需要候补时先核实完整档案和可接受时间，接受原邀约后关联同一成功预约。接待已成约事实保留，后续取消与改期显示原预约的关联结果。

网站患者通过已绑定账号选择服务、日期和医师，系统核对可行资源组合，患者无需选择设备编号。本人未开始且仍为已预约状态的预约可在本店、同一服务的未来十四天内改期；原新医师、时间和时长均须明确复述并确认。患者可以使用本人同店同服务的有效候补邀约替换原预约，接受邀约和替换一并完成。查询不占位，确认失败保留原约；另行取消才进入取消原因跟进。待就诊与历史清单分开，当前结果和人工联系入口可查询。小程序已实现分配账号登录、服务查询、预约、改期、取消、候补登记与邀约办理，网站可查询同一结果；需人工协调时联系原店前台。本地账号申请与本人建档见 3.18；真实微信身份授权及微信支付另行接入。

患者网站和小程序先展示门店已发布且接诊配置有效的服务，包括适合需求、包含内容、限制、费用和准备事项。未知费用保持待评估，不显示零元。服务选择跨登录保留，儿童代办先交前台核验；撤下公开说明不撤销已有预约。

表 3-8 电话预约接待及交接流程

步骤	办理责任	业务动作与交接结果
受理与识别	患者／前台	登记来电者与患者关系、待核实联络及服务偏好，建立有责任的接待单。
需求澄清	前台／医护	区分初诊、复诊与服务意向；专业问题转交医护，明确预计时长依据。
可用性核对	前台／系统	按服务时长核对科室开放、医师、诊室椅位、必要设备及有效邀约暂占。
协商候选	前台／患者	提供可选方案，说明诊所、医师、时间及需准备事项；不合适则改选或登记候补。
复述与确认	前台／患者	复述最终安排并取得明确同意；最终提交重新检查占用，只生成一条正式预约。
交付与后续	前台／患者	交付编号及查询、取消、改期途径；联系未果保持待联系，不默认为同意。

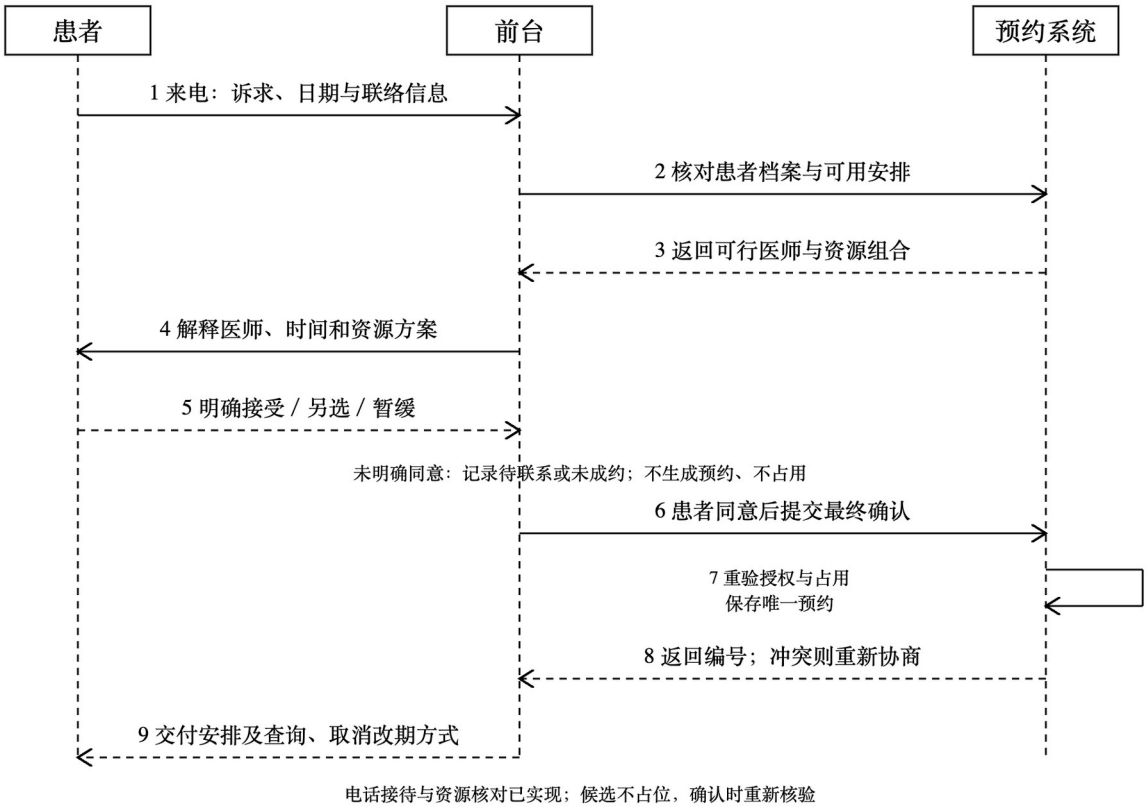

图 3-13 电话预约接待与最终确认的业务序列

接待、完整建档、服务及资源核验、明确同意与最终成约分别办理。图中查询候选不是占用；同意后仍须重检资源，接待与成约结果一并关联。

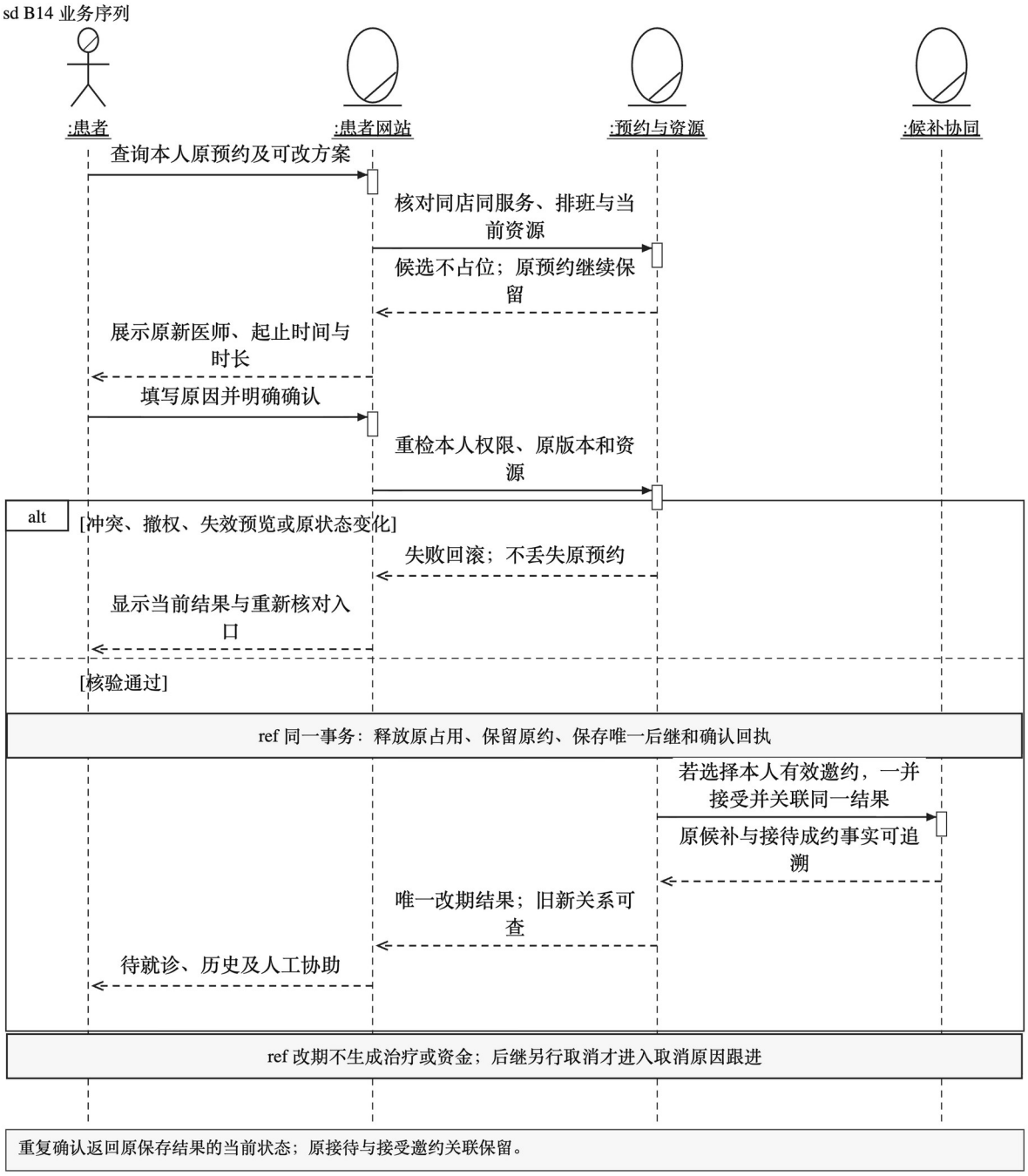

图 3-14 患者自助改期与候补替换的业务序列

患者选择与明确确认分开；原预约在确认成功前保留。统一资源核验、唯一后继、确认回执及必要的邀约接受在同一事务保存。真正取消仍通过原取消及原因跟进流程办理。

3.9 取消时段分析与业务改进

按诊所、预约开始日、星期和开始时间段观察成熟预约。默认时间段为 08:00—10:00、10:00—12:00、12:00—14:00、14:00—16:00、16:00—18:00、18:00—20:00，其

他时间单列；以北京时间计算，区间左闭右开。未来预约和改期前身不进入成熟结果分母，改期前身另列数量。

沿用现有运营口径：A 为到诊，P 为患者取消，C 为诊所取消，N 为已核实爽约，U 为到期未核实。患者行为分母 D=A+P+N，患者取消率=P÷D，爽约率=N÷D；诊所取消单列。补充整体取消率=(P+C)÷(A+P+C+N)，不得与患者取消率混称。完整性=(A+P+C+N)÷(A+P+C+N+U)。分母为零显示无法计算。

分析同时显示每格分子、分母、待核实、诊所取消和改期数量；D 不足 30 或完整性不足 95%的格标注样本不足或待核实，不列高风险排行。30 与 95%是本课程的展示规则，不能代替统计显著性。对比应先在同店、相近服务与同类日期内进行，再解释预约提前天数、取消提前量及原因。

原始取消发起方和文字说明保留，前台追加核实后的分类、联系结果、责任人和期限。分类包括行程、遗忘或联系、费用、诊所或医师调整、其他和未提供；历史无凭据保持未提供。取消时点只从明确取消事件读取，缺失时提前量未知。已经取消的预约保持原状态；“已另约”必须关联同店同患者通过正式流程产生的有效预约。

主管针对同店星期和开始时段建立措施，保留完整原窗口快照、负责人及期限。负责人开始执行、说明实际办理并提交，另一位主管核对完整后续窗口和执行依据，可退回补充、确认样本不足、标注不可比或记录变化待观察。后续窗口不得早于最近执行开始日，且必须在查询当日以前完整结束；不能把执行前资料或未结束日期作为改进效果。

待联系和待回复必须安排下次期限，逾期提示核实；联系人授权失效时可重新分配。取消分析不自动创建预约、发送患者通知、调整排班或更改费用。实际联系采用已获同意的现有渠道，不能把记录联系结果等同于外部消息已送达。

表 3-9 预约取消问题与改进措施

业务信号	建议措施及责任	复核结果
患者忘记或行程冲突	前台按患者联系偏好提醒；网站提供便捷取消与替代时段；患者明确确认。	核对实际联系结果和关联另约；联系率、改期保留率尚未作为独立指标交付。
诊所或医师临时变更	主管核查停诊和排班原因，先协调既有预约，再调整未来接收；提供替代医师或时间。	单独核对诊所取消、通知及时性和患者接受的替代安排。

业务信号	建议措施及责任	复核结果
临近开始才取消	前台征询符合条件候补患者；说明时限并由患者确认，不直接替补。	核对释放时段、有效邀约、成功补位及重复预约情况。
数据待核实或样本过少	前台核实原结果；主管延长完整观察期，保持预设分组口径。	保留原分组与样本量，不将偶然高比例解释为规律。

3.10 财务收退款与费用核对

结算单来源于负责牙医确认的实际治疗。已开单金额、应收余额、已记账收款和退款分别展示。前台按账单提出收款或退款申请，允许一张账单多次付款；财务以不同账号复核，只有通过并记账的记录改变现金事实。 患者本人可核对已记账收款、退款合计及分页明细，分别显示业务日期与记账时间；待审或拒绝请求不进入已记账资金。

资金凭据记录本店渠道账户、参考编号和经办信息。渠道流水先导入预览再确认，保留原始字节和规范化结果；已记账资金与流水按同店、账户、币种、方向、金额和凭据编号逐笔核对。日结负责账内交接，渠道对账负责外部凭据核对，两项状态并列，次日结算不强行改变原业务日期。

表 3-10 财务闭环与异常处理

业务事项	正常结果	异常处理
分次收款／退款	每次保留独立申请及审核；余额来自当前账单和已记账资金。	超额、同账号审核、来源变更或授权撤销时拒绝并重新核对。
凭据补充／更正	追加独立复核的凭据版本，保持原资金不变。	过期预览拒绝；凭据更正使受影响匹配失效并保留历史。
流水导入／逐笔对账	UTF-8、最多 2MiB 及 1,000 行；确认后逐笔提议和独立复核。	重复明确提示；无效或冲突批次不接受流水；组合款和手续费列为差异。
日结与迟到事实	分别核对收款、退款、设备支出及冲回四类总额。	后续资金变化提示重核，保留旧版本，不用对账动作自动记账。

3.11 设备维护与诊疗安排衔接

设备送修或退役立即影响新增可预约性，并依据实际资源占用列出受影响预约和有效邀约。系统保留原承诺，前台明确领取联系责任及期限，不能把送修等同于已通知、已改期或已取消。

同店、同医师、同时间的兼容资源可经前台预览确认替换，并保留原方案及依据；改变医师或时间须取得患者同意后走原改期流程。患者拒绝或未能联系时保留原预约及待办；取消另行记录发起方和原因。

到诊再次核对设备、位置、停用及实际使用状态。上一患者仍使用椅位或设备时，不能重复接诊，前台进入明确协调。治疗中故障由医护人工处置并记录，不自动搬迁患者、顺延预约或改变治疗状态。维修恢复继续要求另一主管独立验收。

3.12 患者关系核验与代约办理

家庭协助就诊时，实际操作账号与就诊患者可能不同。前台先按本店已有患者档案受理关系，记录关联人、关系类型和待核实事项；账号可稍后补充。系统不根据相同手机号、姓名或联系人资料自动合并患者，也不凭咨询记录开放患者资料。

具有本店关系核验职责的前台核对身份、账号归属与关系或委托依据，记录内部依据编号、核验时间和责任人。父母、监护人或患者委托人可获有明确有效期的本店预约代办授权；普通亲属及联系人记录不产生访问权。预约代办与临床知情同意分别办理。

患者网站和小程序均显示本次就诊人及本人或代约身份。切换就诊人后须重新核对原表单；可在授权店查询、新约、改期、取消和办理候补。授权暂停、撤销或到期后阻止新的代办，已承诺预约仍保留，由前台继续联系协调。

3.13 专业范围与跨店诊疗协作

医师身份、资质证据和操作授权分别管理。主管整理本店资质来源、依据、期限和服务范围，由受机构委任的另一医师独立审核查阅、记录及转诊动作；对象及整理人不能切换身份自审。技术人员登记审核职责，不因此取得病历权。

原负责医师明确接收店、指定医师、期限、披露同意和具体发布版本。接收店获明确职责的前台核对现有患者编号；不一致时保留待澄清，不按同名或同号合并。指定医师接收后才开放所选内容。

本人可在网站和小程序终止披露，代约人没有临床披露权。资质到期、撤权或离岗停止受限操作，原约、署名和发布历史保留并显式交接。

3.14 健康自述与实际检查记录

患者本人在网站或小程序补充既往健康、目前用药和过敏自述，区分尚未明确、自述有相关情况和自述目前无已知情况。每次提交保留来源、经办账号、时间及前版，不能覆盖原自述，也不自动改写已经复核的过敏资料。预约代办权限不包含临床自述。

负责医师在实际到诊后建立本次检查，引用本人提交或本店面谈取得的具体自述版本，分别记录主诉、检查、核对结论、差异及仍未知事项。恒牙、乳牙和混合牙列使用同一牙位、牙面规则；未记录的部位不推断为正常。

草稿保存在服务器，切换患者后旧表单不能继续办理。两页同时编辑时保留本页文字，先比较当前已保存内容，再明确继续；重复提交不重复新增。确认版本须重新核对自述和草稿，更正另建带依据的版本。检查记录本身不生成实际治疗、账单或收退款。

3.15 连续诊疗与后续责任

医师基于已经确认的检查形成跨次就诊方案，区分工作草稿、确认版本及稳定步骤沿革。步骤分别记录服务、牙位牙面、目标、估算、互斥选项、计费时点和加工依赖。费用未知保持未确定；互斥方案分别讨论，不相加为承诺价格。

负责医师针对具体步骤准备治疗目的、风险、其他选择及暂缓影响、麻醉、材料、费用变化、术后注意和沟通问题。准备完成后仍需明确确认方案版本才提供本人查阅；方案选择与医疗知情同意分别办理。

患者本人可以通过网站或小程序认可、暂缓或不选择某个具体版本步骤。新版方案必须重新核对，预约代办不包含方案决定。实际执行另行核对本次就诊、已提供项目、位置、数量及实际时间；计划估算和本人表态都不产生治疗或资金。

复诊要求由医师明确服务、建议窗口、临床目标及完成标准。前台承接责任、内部跟进期限和联系事项，关联经资源规则形成的正式预约。本人暂不继续时转医师核对；预约、到诊、部分治疗或接通电话不能代替实际完成依据。

3.16 加工件送返、验收与原约保护

医师针对当前已接受的具体步骤登记加工类别、临床要求、原需要日期与前台送返说明。前台认领协调责任，手工记录送出、返回、延误和交接凭据。原需要日期和既有预约保留，延误须明确协调，不自动取消、挪动患者或顺延承诺。

加工件返回后由具有相应服务记录范围的医师核对适配，分别记录通过与返工。返工进入新的送返周期；方案换版后沿用加工件也须明确核对新版步骤。物理返回不等于临床验收，缺少依赖信息不能自动判定为无需加工。

前台查阅安排、期限和交接投影，医师查阅临床规格及验收详情；主管和总部只查看状态与逾期汇总。加工件全部满足本周期和具体步骤要求后，实际执行才能继续确认；这一准备状态本身不生成收费。

3.17 公开找店与按需登录

患者首次进入网站或小程序时，可以浏览已发布门店和服务，按城市、区域或名称筛选。主动授权位置后按由近到远排列，直线距离仅供估算；拒绝或无法定位时仍能继续选择。门店显示明确地址入口、电话、每周营业安排与已确认的临时说明，营业中不代表该时段一定可预约。

患者选定服务后才进入患者登录和就诊人选择，继续查询原服务候选并明确确认。患者与员工采用独立登录入口，服务器限制该通道可激活的岗位；同一人有多个岗位也不在患者小程序切换员工权限。待选服务不是授权，登录、查询和就诊人选择本身都不创建预约。

公开资料只包括门店、服务及必要出诊参考，不披露患者、内部停用依据或员工私有联络信息。位置在客户端用于排序，不记录精确位置轨迹。微信账号、核验手机号、患者本人身份和关系授权继续分别办理，不以昵称、手机号或定位推断患者身份。

3.18 患者账号与本人建档核验

患者先浏览服务，按需选择小程序微信、网站小程序扫码或手机验证码。微信首次使用只建账号，不强制密码或手机号；旧账号关联须有效密码或先前短信核验，归属冲突不合并。

账号向明确门店申请新档或原档核验。有职责的前台核对本人、账号及完整资料并记录依据，不得自审；补充继续原申请，撤回保留历史。新档批准原子建档关联，原档不改资料，暂停仅恢复原关联。

短信挑战绑定用途、会话、账号及期限，换绑不改患者联络资料。微信身份、账号联络、患者档案及代约授权分开；批准后明确激活，预约、改期及候补继续核对原资源与权限。

3.19 医保资料核对与结算准备

医保办理首先需要明确地区及生效版本、门店安排、患者参保地和实际费用。湖南口腔项目支付政策自 2026 年 6 月 1 日起执行，甲类目录先自付为零仍按基本医保分担，不能据此推断患者报销 100%；乙类先自付与最终基金承担也须分别核对[21]。

财务导入已核对来源的目录包，保留原文件、摘要、规范编码、原表单元格及相同重复行位置，由另一财务账号决定是否启用。本店主管准备课程模拟安排，并将原收费项目的含义、单位及换算数量与目录显式适配；财务独立核对，缺失规则或单位保持待核对。

前台在本店可见患者档案中登记合成参保地、类型、有效期及核对依据，后续核对追加新版本。定位、微信登录、联络号码和患者自报均不能替代待遇核验；最新结果未核实或失效时不回退使用旧结果。目录、安排、映射和待遇准备不产生治疗、账单、收退款或基金应收。

3.20 医保结算与基金清算

前台从本店原结算单核对实际收费、明确适配及最新待遇，逐行记录本地模拟分担并确认唯一请求。处理中或回复未知时查询原编号，不能更换编号重复申报。财务以不同账号复核原费用和分担，原账单金额始终等于患者现金责任、个人账户承担与基金承担之和。

患者现金收退款继续采用原独立审核。已确认分担影响患者待缴，基金到账不重复计收入；若患者已经全额支付，则按当前余额明确申请应退现金。未经确认或未知的结果不能当作已经清偿，差额、扣减和未到账也不自动转嫁给患者。

财务从已导入银行流水核对基金用途，再按同店、同币种的已通过申报逐笔分配。待复核金额先占用可用额度，另一财务账号核对后才成为已到账分配。未到账、少到账、扣减和用途待核实事项均有责任人、联系期限及追加沟通。

撤销首先核对原受理结果。已到账基金须用出账凭据逐笔退回；未知撤销继续查询原编号，独立确认原撤销及净到账归零后才撤回原非现金分担。撤销不作废实际费用，也不自动办理患者退款。

3.21 医师与门店画像及连续选诊

患者在预约前需要判断门店服务条件、医师方向及近期出诊。系统公开头像、职称申报、专业方向、简介、从业起点、语言、适配服务和接诊门店；门店提供特色、团队、照片、交通停车、无障碍、电话地址、营业与费用说明。公开字段与内部来源证据分离；课程合成资料不代表真实机构和专业资格。专家目录的姓名、职称、科室组织可供学习[26]，具体画像字段和审核规则由本项目业务责任推导。

医师只提交本人介绍，主管审核本店采用版本。草稿和新提交不替换旧发布，退回与撤回保留历史。一个医师可常驻或轮诊多店，任职不复制身份、不自动授予临床权限；前台继续负责排班。退出任职阻止新增出诊和预约，已有承诺交前台逐项协调，不能自动取消。

门店、医师两条浏览路径最终进入同一服务与时间确认。登录前选择仅为意向，登录和患者切换后重新核验本人或代约权限及资源；无合适时间可选择其他医师、同城门店或候补。两端共用公开投影，不把空闲参考当作资源已保留。

3.22 月度经营成本与利润完整性

主管需要分清完成诊疗的账单产值、当期资金回款和经营成本。Open Dental 区分诊疗产值与实际回款[28]；ADC 按诊疗完成期汇总当前账单版本，按资金业务日汇总已记账患者收退款，基金到账与已核对分配依原合同归属，不把一次到账再次计为产值。

主管提交本店耗材、人工、租金、水电物业、维修、折旧、营销及其他费用，财务独立复核。总部费用由财务提交、另一财务账号复核，默认留总部中心。成本登记不付款，采购额不冒充当月折旧，旧季度成本不自动复制。维修引用原来源时，同一费用不能跨月重复计入。

直接成本归属医师，公共成本按本店当月有效已发布出诊分钟分摊；暂停接单不等于取消出诊。分币尾差按稳定医师编号分配，总额守恒。无工时保留未分摊金额；缺失费用与明确零费用区分，全部类别核对完整后才确认管理利润。月报保留版本及来源，补录、更正形成新版本，不改写旧报表。

3.23 以小程序为主的完整患者办理

患者应能在同一入口完成找店选医、服务比较、就诊人选择、预约改期、取消及候补，并找到已有的健康自述、治疗方案、转诊和本人结算单。四个主入口为主页、预约、就诊和我的。匿名浏览不强制登录，员工从独立通道办理。

每店四类基础服务为初诊检查、洁牙与牙龈护理、牙痛评估与基础修复预约、复诊；正畸、缺牙修复和儿童服务按实际课程配置区别提供。介绍存在不等于该店可接诊，必须同时核对服务说明、适配医师、有效授权、出诊、椅位及必要设备。医师方向与该门店可预约服务分开呈现。

筛选条件保留，结果明确区分不支持服务、未发布排班及该日无可用资源。不支持特色时仅推荐实际支持的同城门店；本市没有时明确说明。查询不占位，登录和患者切换后重新校验。儿童代约须使用本店前台已核验的监护授权；一般预约委托不能代替监护关系。

3.24 服务连续性与上线交付要求

患者与门店人员需要通过固定地址办理业务，前台排班、医师接诊和财务复核应在明确的岗位范围内持续可用。计划发布应设置维护窗口，告知暂不可办理的状态；恢复服务后可以查询原提交结果，不能因断网重试、重复初始化或版本切换形成第二次业务效果。

新课程实例应从空库准备经过核对的门店、医师、服务、资源和未来排班，并与其他实例的数据相互独立。初始化只产生合成的目录、岗位及患者示例，不导入联调预约、不生成已治疗或已收款事实。已经完成的初始化再次执行应返回原结果，保留账号密码；资料与排班的后续变更由各自岗位办理。

运行维护应能说明正在运行的版本、数据库结构、通知处理状态和最近可恢复时点。监测失效与备份过期不能显示健康。数据恢复需核对账户授权、业务金额、图片和全部版本历史，目标是在替换环境准备完成后三十分钟内恢复。真实微信、手机、目标服务器和持续运行分别验收。

3.25 初复诊完整文书与医师责任

检查确认通常发生在治疗前，不能直接代替包含实际处置和离诊医嘱的完整门诊文书。医师需要将本次主诉、病史核对、牙位检查、诊断判断、辅助检查来源、实际

处置及复诊建议连接起来，并能解释每项记录的来源、发生时间和确认责任。电子病历管理规范要求身份、操作时间及修改痕迹可追踪[29]，本系统据此采用准确来源与追加版本。

新接诊形成负责医师的文书待办；初诊按实际情况整理，复诊引用本人有权查阅的本店既往准确版本，院外或纸质来源单独说明。没有自述或观察的事项继续保留未知，不将未记录牙位推断为正常。患者本人和预约代办权限不因此扩大到完整文书。

一般未归档文书由本次负责医师确认，不机械增加第二名医师审批；完整归档后的准确补正须先独立医务批准。已确认后发现错误须说明依据、追加更正并保留原文；未确认草稿可以继续或有依据放弃。接诊、文书、结算和归档为相关但不同的完成状态，文书待办不额外占椅、不等待归档才结算。

3.26 具体医疗告知与本人决定

认可治疗方案是选择讨论，不等于同意具体医疗行为。负责医师核对成年患者本人身份及理解表达条件，并将告知绑定准确检查、方案步骤、牙位和八项治疗说明。年龄与微信身份均不能单独证明本人具备医疗决定条件；需要代理的情形另行核验，不借用预约代办关系。

患者可提问、同意、拒绝、暂缓或撤回。未答复问题进入负责医师待办，在答复前不能新增同意；答复不代替本人决定。每份告知保留一次明确决定，重新决定由医师重新告知并产生新版本。原同意和撤回事实分别保留；预约、治疗和资金由原业务办理，不随决定自动删除或回滚。

本人账号确认与医师登记纸质原件分开标识。纸件保留原件编号、实际决定时间及登记时间，不将早于本份告知的材料倒签为当前同意。课程账号确认不等于已验收可靠电子签名；本人路径与独立医疗代理、治疗前核对分别验证，适用范围保持明确。

3.27 医疗代理材料与责任核验

预约代办、账号身份和医疗代理分别核验。未成年监护及适用的成年患者书面委托通过独立办理单受理，记录实际代理人、身份材料与授权原件编号、本店、方案步骤、具体适用情形和有效期；材料不包含证件全文或附件库。前台需另有专项资料核验职责，默认不授予；负责医师确认本次临床适用性，疑难或冲突转另一名具有既有专业审核职责的医师。

资料核对、临床确认与代理的方案选择、医疗决定分别办理。申请代理人、资料整理人与核验人均不能通过切换岗位审核自己的办理。新资料追加版本，退回、暂停、撤销与到期停止新增办理，既有决定和原依据继续保留。患者本人明确意见与代理范围发生争议时，须返回负责医师重新核对，不自动采用最后一次提交。

患者网站和小程序显示具体可代约及可办理医疗决定的权限。独立医疗代理仅能读取指定步骤的必要说明、方案选择和医疗问答，不获得完整病历、预约清单或账单。资料未生效或授权结束的账号只能核对办理状态，不能借状态查询读取患者身份或临床内容。

3.28 治疗前核对与真实补记

临床规则由具有本店专业审核职责的医师版本化发布，逐项目区分具体医疗同意、沟通记录及待专业判断，不按预约名称或金额推断。启用前逐项明确当前实际项目；未知要求仍需专业判断。负责医师在开治前核对患者、项目及牙位、检查和方案版本、告知与决定、本人或代理依据、未答疑问、专业范围、加工件及资源。

通过核对只保存独立依据，不生成治疗或收费。实际执行确认时再次核对；撤回、代理失效、新疑问或重要来源变化须重新核对。其他步骤正常执行不改变本步骤的有效同意。已启用诊所的旧直接录入入口不能绕过控制，实际治疗与唯一收费来源仍由原模块维护。

实际治疗已经发生但缺事前材料时，如实登记发生时间、原因和缺失依据，建立独立医务复核待办。补记与原治疗、收费关联，不倒签、不补造事前核对；另一名具有职责和服务读取范围的医师复核后，仍保留原缺口。补记规则不自动推断紧急抢救资格或可靠电子签名。

3.29 病历归档与追加补正

负责医师在实际接诊结束、检查及初复诊文书确认后，核对准确版本、临床来源和选定的已发布收费记录，指定另一名有本店专项职责及对应服务读取范围的医师审核。文书确认、独立审核、固定文件生成、付款结清分别表达；未结清费用不阻止合格病历归档，待办不继续占用椅位。独立性为本系统的岗位控制设计，真实机构制度仍须专业核验。

未确认草稿、必要材料缺项、来源变化、未答医疗疑问及事前资料缺口均有责任岗位和继续入口。无法补齐时可以明确保全现有资料，保留缺项和未确认状态，不标为完整归档，不补造事前同意或开治依据。原办理期限保留，后续补充另有期限。

独立审核通过后由后台生成固定 PDF、来源清单及字节摘要，生成失败保留原任务并经明确重试；来源或职责变化需重新核对，文件完整并原子发布后才显示可下载。归档后的检查和文书更正分别提交准确草稿、原因和差异，获另一名医务审核医师批准后，由负责医师确认追加版本，再形成补充归档包。原文书、原包和审核不可覆盖。[32]

前台仅查看本店业务编号、责任期限及办理状态；主管与总部查看汇总。技术管理员仅按机构委任登记默认关闭的专项职责，不由主管身份或技术权限取得临床正文和医务批准权。患者、预约代理与指定步骤医疗代理均不因此取得整份病历或固定包；受控复制另建申请与材料核验流程。

思维导图 患者选择与机构经营 → {公开画像、本人关系、接待排班、诊疗连续、资金设备、月度成本} → 岗位责任 → 可观察规则 → 异常继续 → 用例验收。；完整病历 → {初复诊、作者、来源、异常与待办}。 医疗代理 → 材料责任 → 指定步骤 → 独立医师确认 → 方案及医疗决定 → 开治核对与真实执行。 归档责任 → 准确清单 → 指定独立医务审核 → 固定文件 → 缺项保全与有依据补正。

第 4 章 系统设计

4.1 领域关系与状态模型

领域关系分为诊疗结算、接待成约及资源占用三个主要视图，状态模型分别说明就诊、接待及资源协调。端点数字为关联多重性；图中为主要业务对象，不穷举全部数据表。咨询、资源占用、实际治疗与资金分别记录。

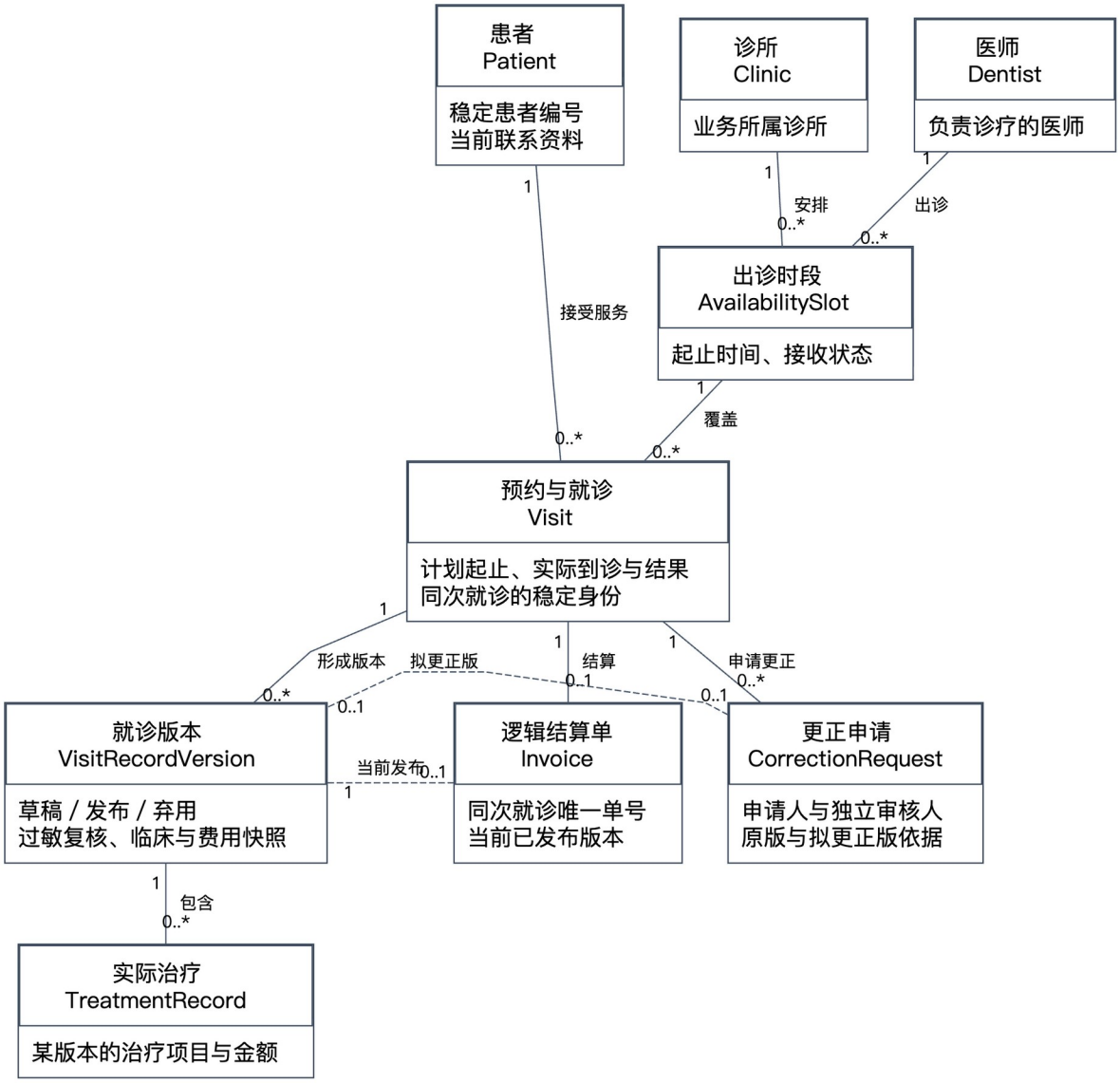

图 4-1 诊疗与结算的核心领域关系

一个患者可有多次就诊，每次由一个出诊时段覆盖；就诊保留诊所与医师引用并核对一致。每次就诊可形成多个记录版本，每版包含实际治疗；同次就诊至多一个逻辑结算单，指向当前发布版本。更正保留原版、拟更正版及独立依据。

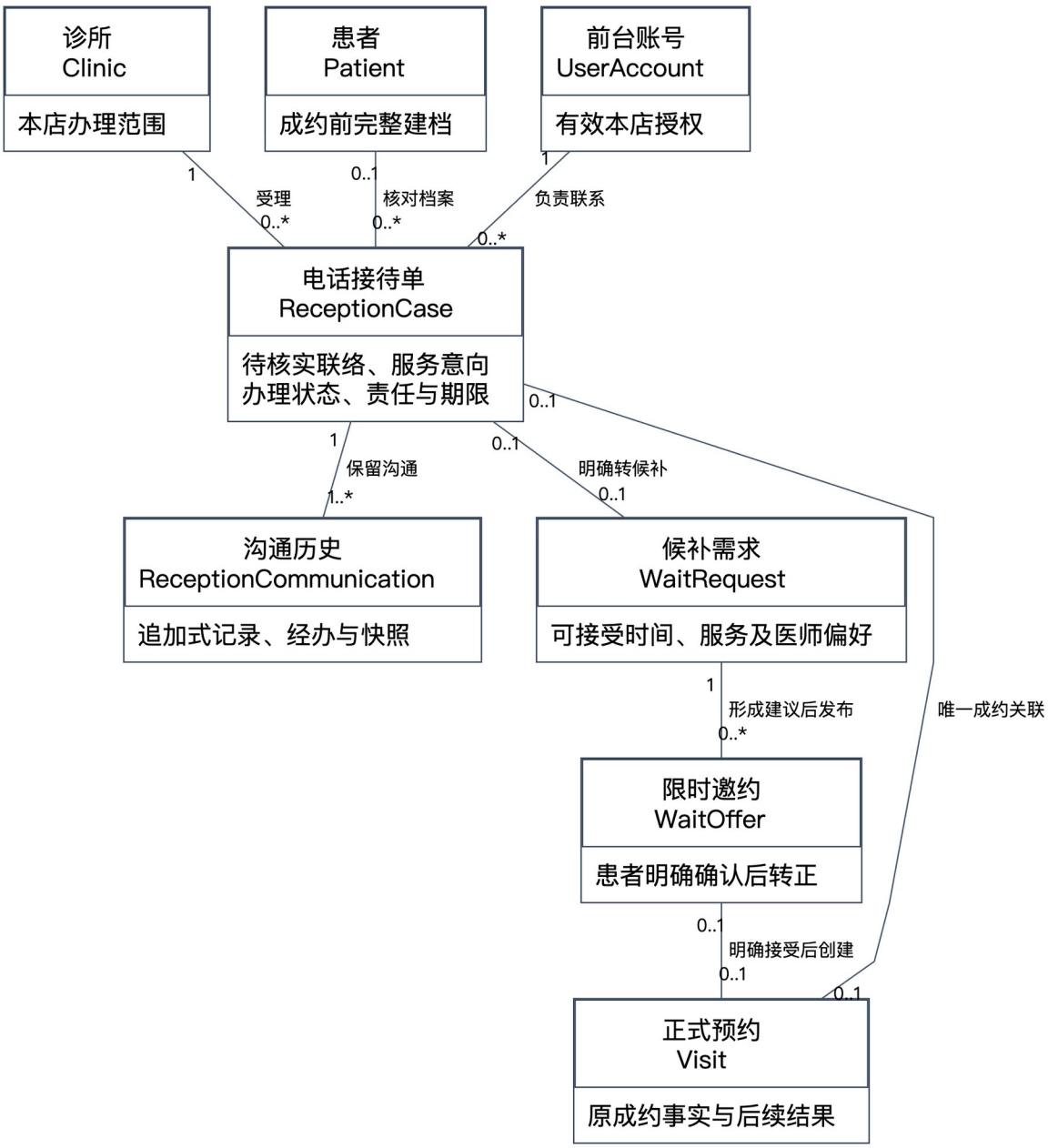

图 4-2 电话接待与唯一成约的领域关系

接待单属于一个诊所，咨询阶段可以没有患者关联；成约前须完成建档。每次沟通只追加，责任与期限可追溯。接待可以直接成约或转候补；候补接受后关联同一成功预约。接待的已成约事实不因后续取消或改期而改写。

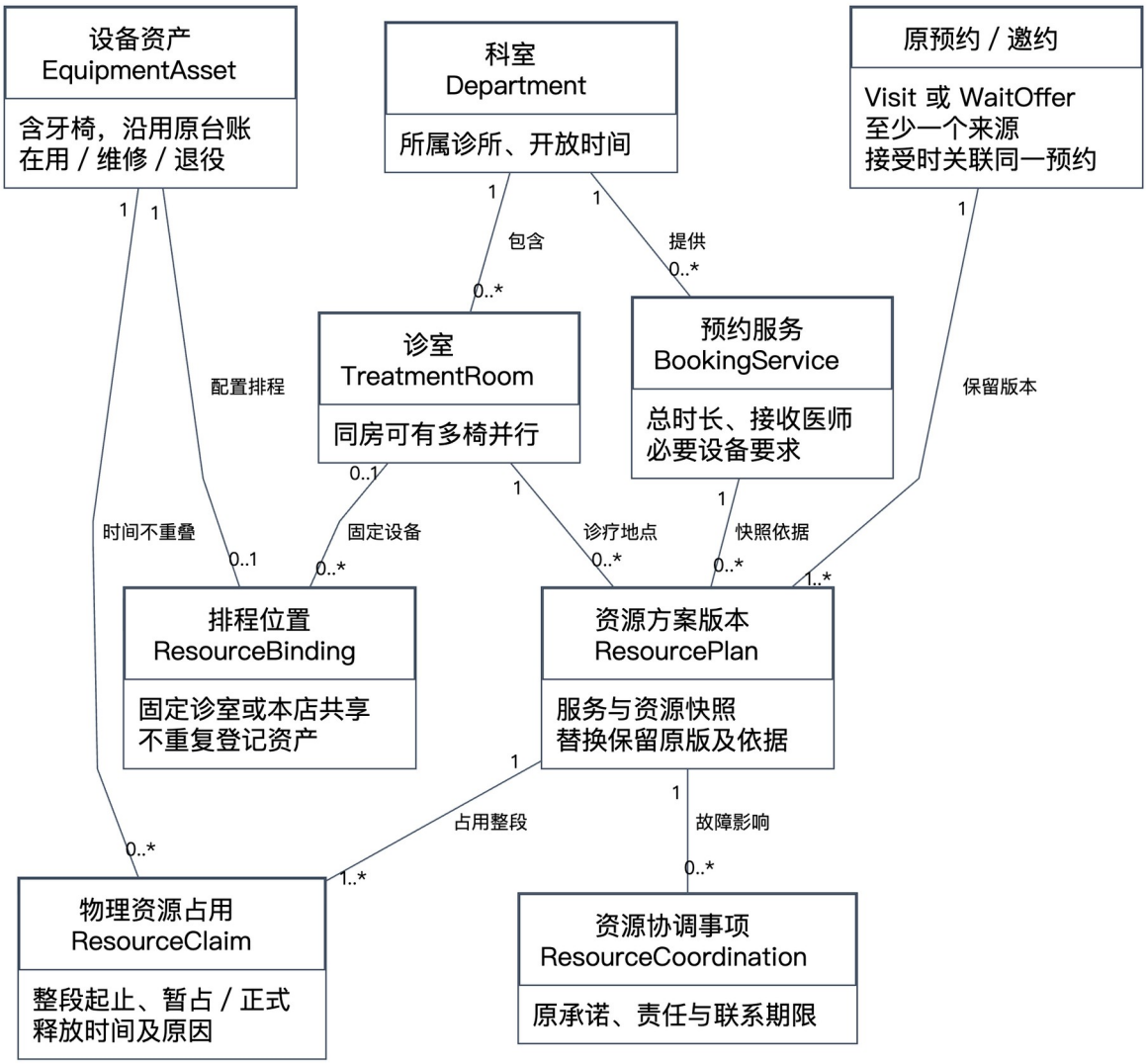

图 4-3 服务配置与资源占用的领域关系

设备资产通过排程位置确定固定诊室或本店共享；牙椅不重复建账。预约服务定义时长、医师及必要设备，资源方案保留当时快照，整段占用通过明细约束。来源框是预约与邀约的业务引用组合，不是新增来源表；接受邀约时原方案关联同一预约，替换时追加新版本。

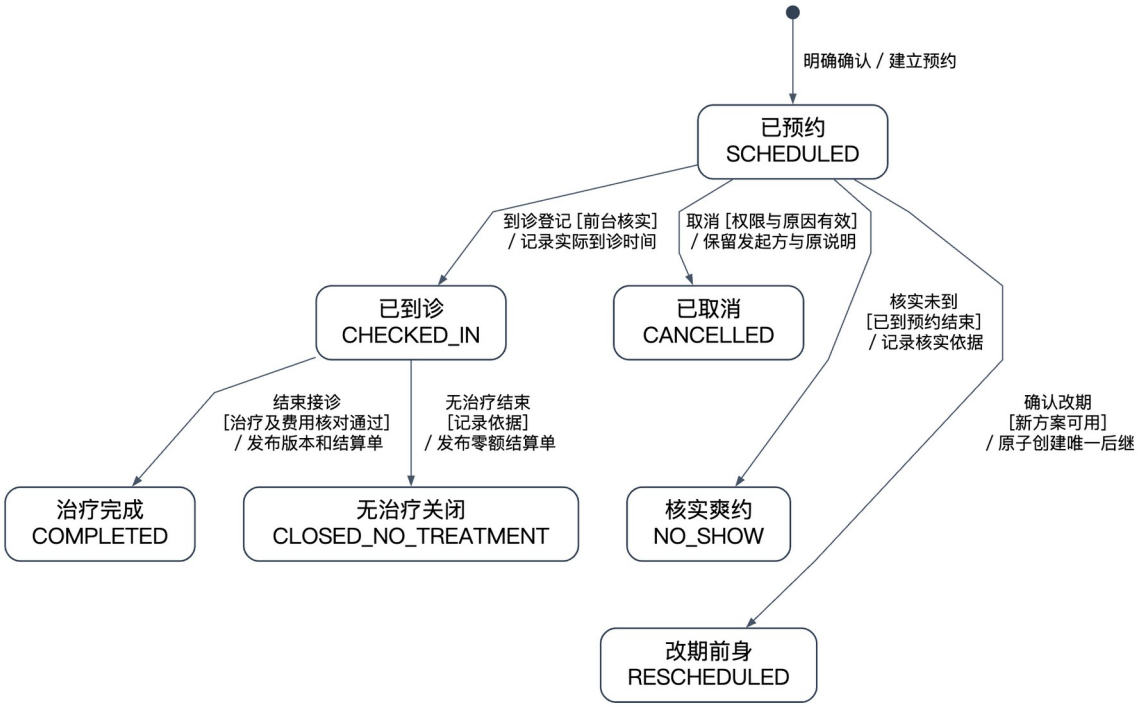

图 4-4 预约与就诊状态及业务守卫

箭头采用事件、条件及业务动作表达。到诊后才能完成治疗或无治疗关闭；取消、爽约和改期各有依据。改期在同一事务保留原终态并创建唯一后继；治疗后的更正通过版本和独立申请办理，不倒退就诊状态。

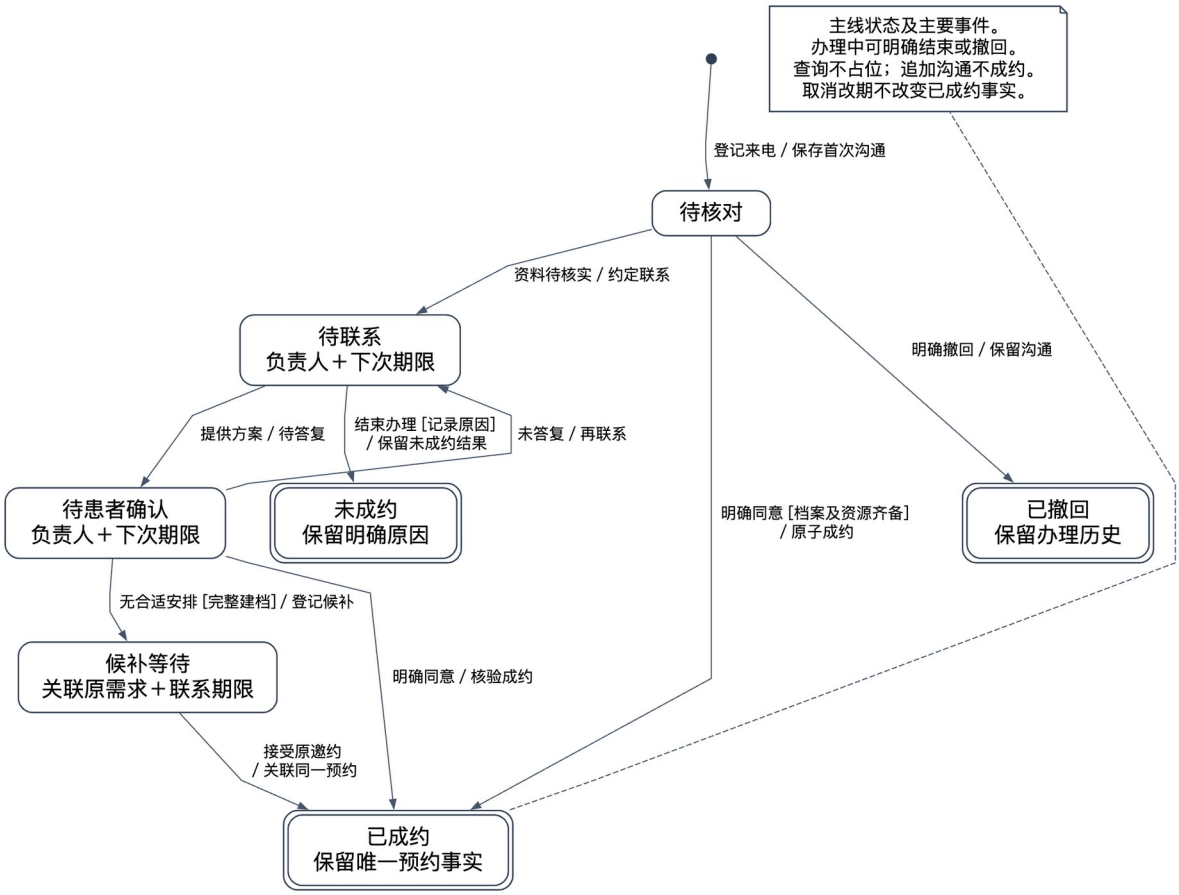

图 4-5 电话接待的办理状态与成约条件

图示为接待主线及主要事件。办理中可追加沟通、重新核实、明确结束或撤回；待联系、待确认和候补等待必须有有效责任及期限。电话成约须完整建档与明确同意；候补成约关联原成功结果，不另建预约。结束状态保留事实。

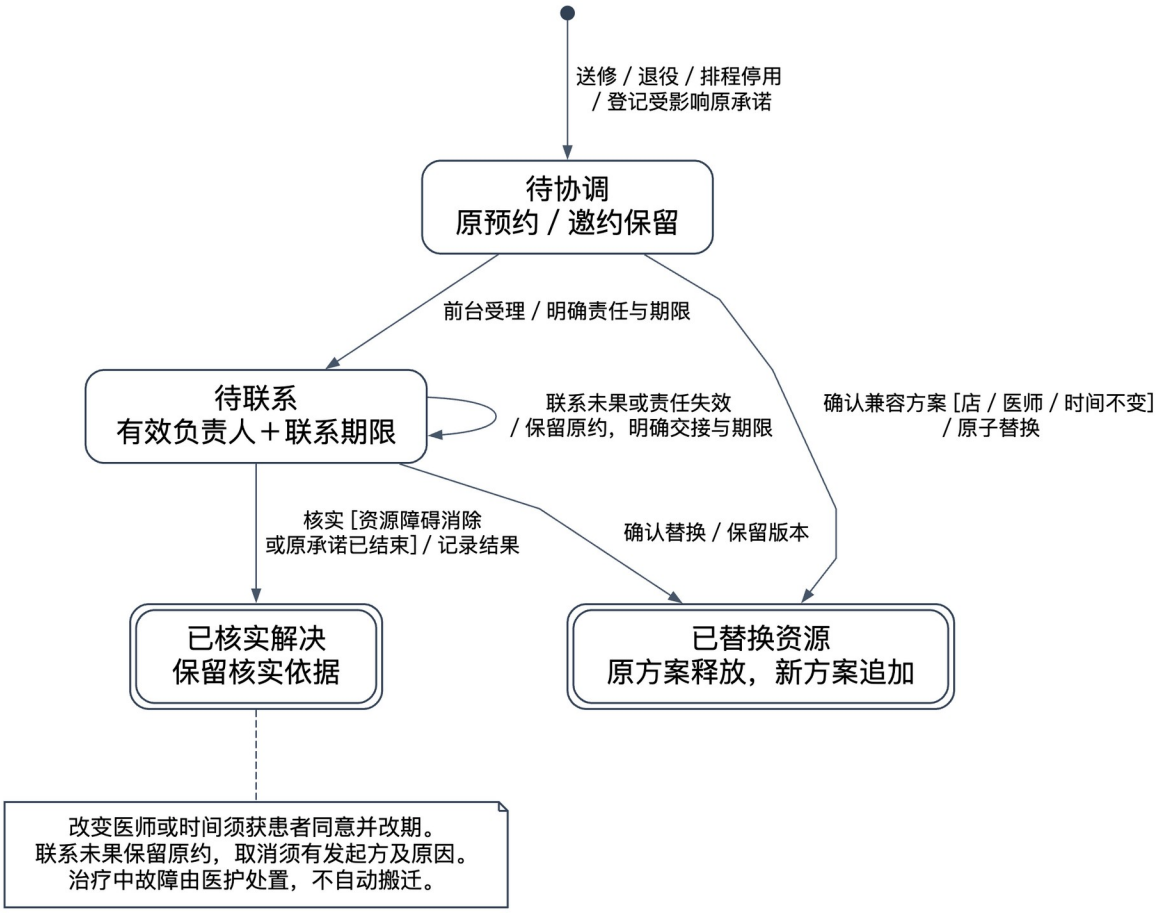

图 4-6 资源故障协调状态与原承诺保护

资源故障不自动取消预约。前台明确联系、兼容替换或核实解决，重复提交不重复替换；医师或时间变化须取得患者同意并改期。到诊仍在使用或设备不可用时不能重复接诊，治疗中故障由医护处置。

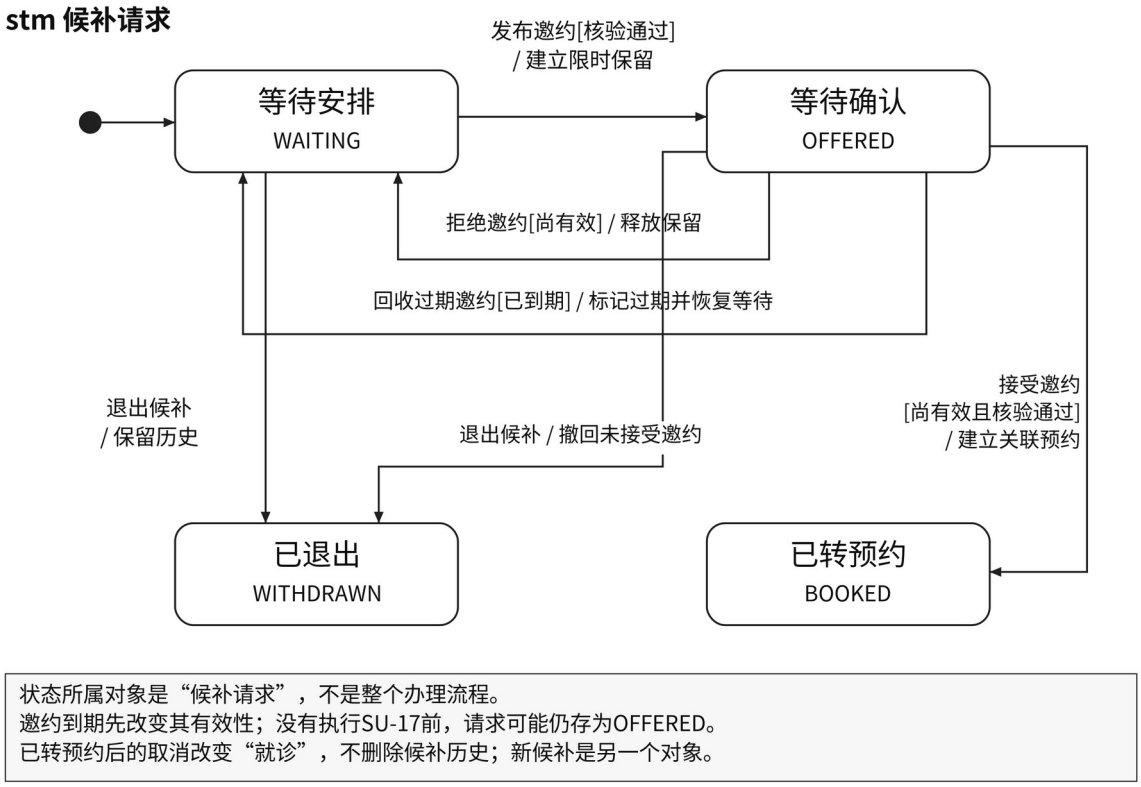

图 4-7 候补请求状态机及迁移条件（M01）

本状态机只描述候补请求。迁移按“事件[警戒条件]／动作”表达；初始点表示该对象的缺省状态，不是整项业务流程的开始。OFFERED 不保证邀约尚有效；到期阻止首次接受，执行回收后才恢复等待。BOOKED 保留历史转换事实，后续取消发生在就诊对象上。（课件第 339—345、350 页）

4.2 模块职责与接口合同

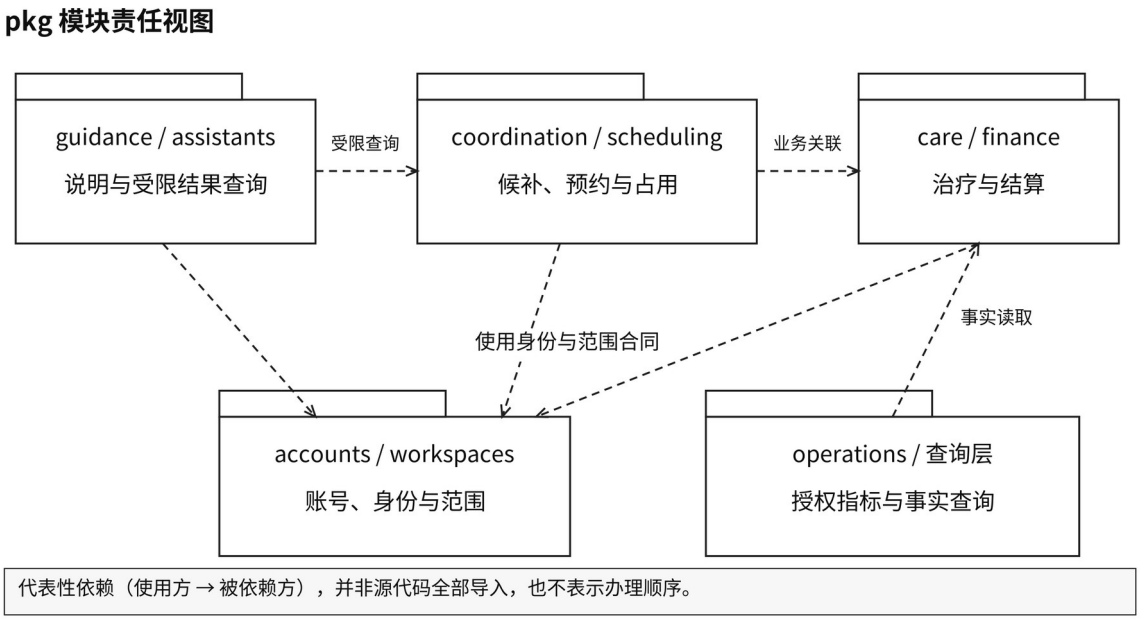

图 4-8 模块化单体的职责与代表性依赖（A01）

表 4-1 模块责任与接口边界

责任模块	公开合同	必须隐藏或隔离的决定
accounts／workspaces	核验身份、激活角色、选店、治理账号、校验上下文	授权存储、会话及修订机制；不得由模板自行授权。
scheduling／coordination	预约、变更、候补登记、建议、发布、接受	占用与锁协议、状态转换；各入口不能复制冲突逻辑。
care／finance	实际治疗、结算、更正、季度核对	价格快照、当前版本、成本完整性及计算粒度。
guidance／assistants	手动指南、受限结果核对、可选意图分类	模型输出不决定权限；纯规则不依赖网页布局或外部 API。
operations／查询层	授权范围内指标与事实读取	分母、缺失、期间及查询时点；不改业务状态。
notifications	事务内记录派发意图、个人收件箱、显式已读和有限重试	原收件授权与当前权限、去重与重试；消息不驱动任务状态。

图 4-8 是责任视图和代表性依赖，不是穷举的源代码导入图。功能与数据应并行细化，模块间联系应尽量少、明确且有序；拆分文件本身不能证明低耦合。[4-5]

4.3 结果核对与只读模式

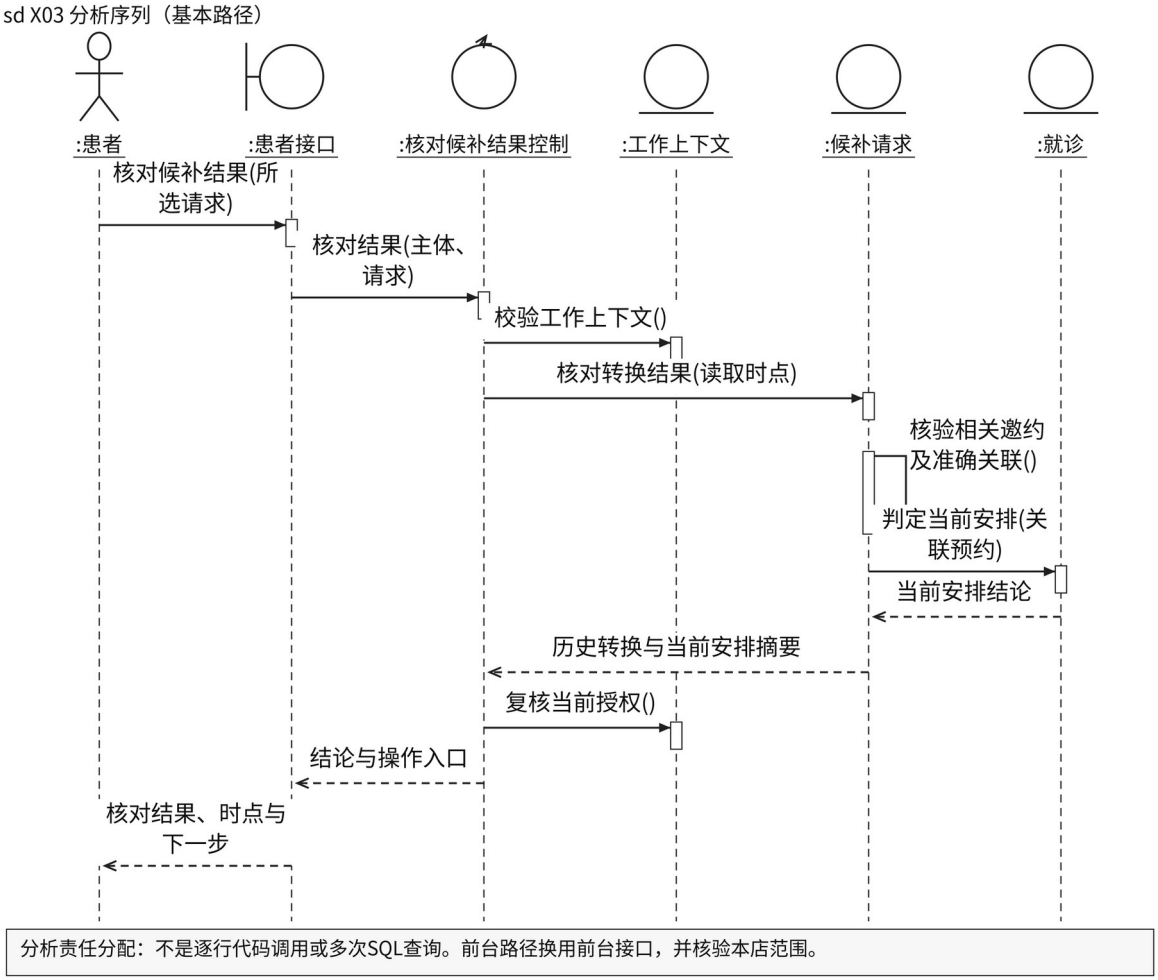

图 4-9 候补结果核对的分析序列（X03）

图 4-9 是 SU-24 的分析责任视图：边界类处理输入输出，控制类分配协作，领域对象判定授权和准确关联。前台路径换用前台接口并核验本店范围。它不是源码调用图；核对不得改写业务记录，会话与日志属于另一层。（课件第 287、314—320 页）

只读模式按业务副作用控制写入，允许经过授权的结果核对。查询仍需有效身份、诊所和对象范围；读取结果只表示当前时点，不构成后续预约的占用承诺。

放行查询不等于放行所有 POST，不采用宽泛路径前缀。HTTP 方法和业务副作用是两个不同维度；查询成功仅反映读取时点，不能锁定后续可用性。

4.4 账号安全封禁与业务退役

常规停用要求先处理未闭合业务，以保护业务连续性；但疑似凭据泄露时继续允许访问会妨碍安全处置。SU-25 因此将安全访问控制与业务责任交接分离；技术人员只能对受控普通账号操作，不开放自操作、技术账号或超级用户目标。

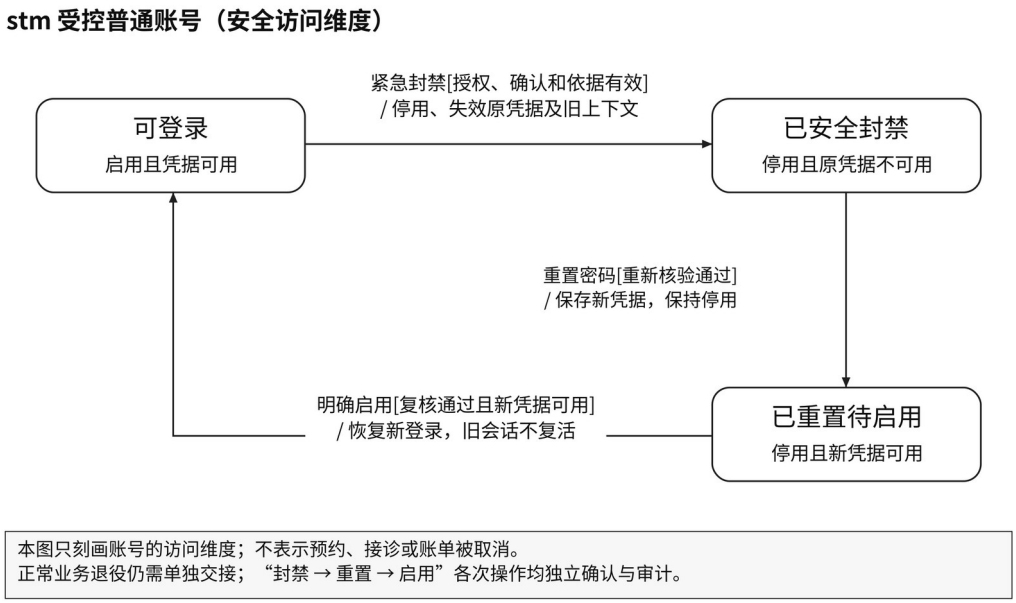

图 4-10 账号安全访问状态及分阶段恢复（A02）

表 4-2 安全控制与业务连续性分离

操作	凭据与访问	既有业务
常规业务停用	检查未闭合工作；不满足条件则拒绝	必须先明确处理或交接。
紧急安全封禁	停用账号，原凭据设为不可用；使旧上下文失效	不取消预约，不删除角色绑定，不转移治疗责任。
受控密码重置	设置新凭据，但仍保持停用	资料和历史保持原值。
再次明确启用	复核后恢复登录；旧会话不因启用自动复活	业务交接仍独立办理。

管理操作要求操作者重新验证密码、填写依据、核对目标签名，并对紧急封禁作专用确认。账号、工作上下文与审计在同一事务内更新。密码变更和会话失效策略参考框架机制，但本项目身份与数据库约束须经测试验证。[11-12]

封禁不撤销提交前已完成的事务，不清除浏览器已显示的信息，也不自动把患者交给另一位牙医。只读实例不执行封禁写入；技术／超级账号仍需离线受控维护。

4.5 设计原则在本项目中的应用

关注点分离体现在业务查询与写入、安全封禁与业务退役、预约意向与实际计费的区分。信息隐藏体现在授权、占用、结算和结果解释由小接口承接易变规则。简单性要求首先修复可复现的问题，而不以新增微服务或求解器替代验证。上述均为课程原则的项目应用，不是讲义指定的技术栈。[4-6]

质量评价覆盖核心业务完整性、权限、重复提交、回滚及历史金额。公开服务和更大规模需要独立验证，不能仅凭模型或功能数量作出结论。

4.6 协调与通知的数据责任

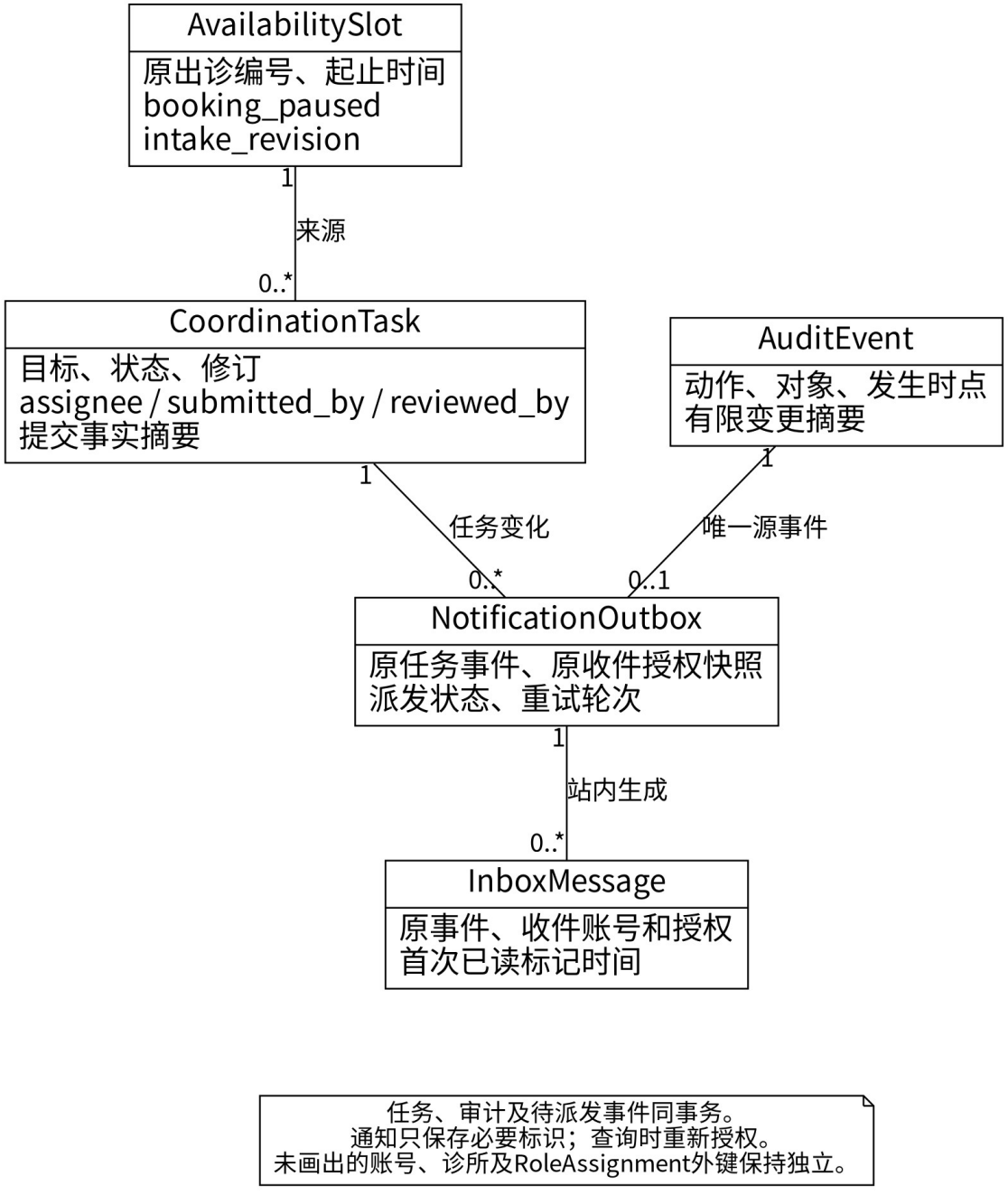

图 4-11 出诊、任务和通知的概念关联（D02）

补充类图仅展示新增关系；类分栏与端点多重性区分归属。源审计唯一、事件与原授权消息去重等约束由数据库和业务测试验证。既有患者、治疗和账单关系仍见图 4-1。

4.7 任务状态与独立复核

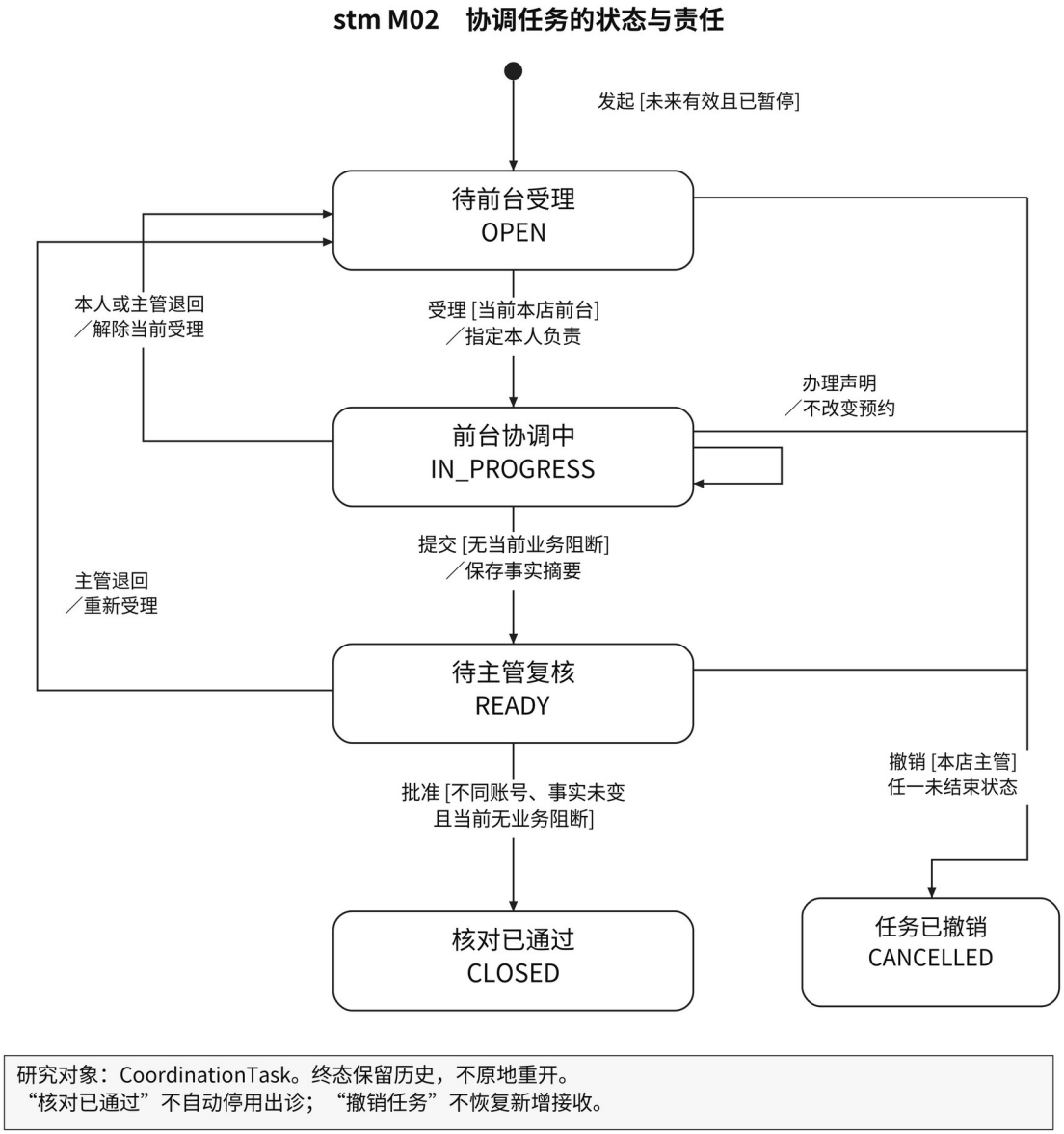

图 4-12 协调任务状态机（M02）

研究对象为 CoordinationTask；任务状态不能代替出诊、预约或消息状态。终态作为历史保存，不把对象的初始点解释为整个业务流程的开始。（课件第 339—345、350 页）

4.8 多渠道预约与接待记录设计

接待单独立于患者档案和预约。待核实联络、服务及日期偏好、责任人和期限构成当前办理资料；每次登记、核实、联系、交接及结束均追加沟通记录和当时快照。修正咨询联络不自动更改患者联系档案，原资料仍在历史中可查。

接待状态包括待核对、待联系、待患者确认、候补等待、已成约、未成约及已撤回。待联系事项有有效前台负责人和期限；授权失效时明确重新分配，保留交接依据。已成约单保留原成功事实，后续取消或改期在预约模块办理。

电话成约原子保存预约、资源占用和接待关联；失败不留下部分结果。网站与小程序共用本人绑定授权、候补登记及邀约处置。接受时明确选择新增预约或替换指定原约；拒绝继续候补，退出撤回未确认邀约，均不自动取消原约。重复提交返回当前结果，不恢复已退出记录。

前台查看本店个案及沟通文字；主管和总部仅取得对应范围的数量及逾期汇总。接待关联不扩展病历访问范围，联系人与临床文字不进入运行日志或总部汇总。

患者服务说明与预约服务一对一关联，接诊目录和患者文案分别管理。主管经预览、确认发布后才能供新预约选择；确认时按签名内容与当前资源重检。患者就诊需求进入本人预约，不作为已完成治疗，也不进入运行日志。公开说明下架不阻断原预约的合法查询、改期或既有邀约处置。

4.9 科室和诊疗资源设计

本店主管维护科室、每周开放区间、诊室、临时停用、预约服务、接收医师及必要设备。服务时长为 15 至 240 分钟、按 15 分钟递增，包含准备与周转；预约服务和收费项目分别管理。牙椅复用设备资产，不另建重复台账；一间诊室可有多椅，独占诊室仅配置一个椅位。

固定设备只能服务于所属诊室，共享设备可在同店调配。所有必要资源按完整预约时段占用。临时邀约保存暂占及到期时间；明确接受后原子转为正式占用，拒绝、撤回、到期、取消或改期分别记录释放。到期暂占不会依赖人工回收而持续阻挡新约。

出诊、患者、医师及物理资源使用统一锁序，物理设备按主键排序；数据库排斥约束拒绝重叠有效占用。确认重检当前授权、目录版本、设备状态和占用。预约与邀约保存当时服务时长及资源快照，目录修改不重写历史，资源替换另存版本。

诊所先进入资源核对，暂停新增成约和邀约并保留旧承诺；现有预约与有效邀约逐项核实资源后启用。未提供的历史科室、来源及设备保持未提供。新资源候补按登记先后、可行时间先后和稳定资源顺序生成有界建议，不保证全局最优；原固定 30 分钟算法保留历史适用边界。

4.10 资金与设备的协作合同

临床模块发布实际治疗版本，结算模块据此生成逻辑账单及版本；资金模块保存收退款申请和独立审核；凭据及对账模块解释资金的外部依据。账单更正不直接生成退款，对账完成不直接确认收款，设备维修成本也不直接成为设备支出。

设备维护工单关联送修事件、负责人、提交人与验收人，费用关联具有来源的维修或资产事件。费用更正与资金冲回分别保留历史，既有独立审核规则继续适用。

4.11 取消分析的数据与查询设计

运营模块拥有取消聚合、原因跟进及措施办理；预约模块继续拥有预约状态和资源确认。统计先限定授权诊所与开始日期，按北京时间分组，以就诊主记录计数，避免联接多个治疗明细放大分母。跟进只关联原取消预约及可选正式另约，不改动原预约、治疗或资金。

原因跟进保存当前联系结果与责任期限，办理历史保存每次核实快照。改进措施保存原窗口、执行记录、后续窗口和独立复核；历史只追加，数据库禁止改写或删除历史。两种业务对象不共用状态机，历史记录必须且只能归属其中一种。

所有变更先预览再明确确认；确认重新核对当前身份、诊所、授权、源对象版本与统计快照，过期、授权撤销或资料变化均需重核。重复确认返回已办理结果，并发办理仅产生一次效果。主管和总部读取汇总，患者身份及联系文字仅供当前店前台办理，权限不由菜单是否显示决定。

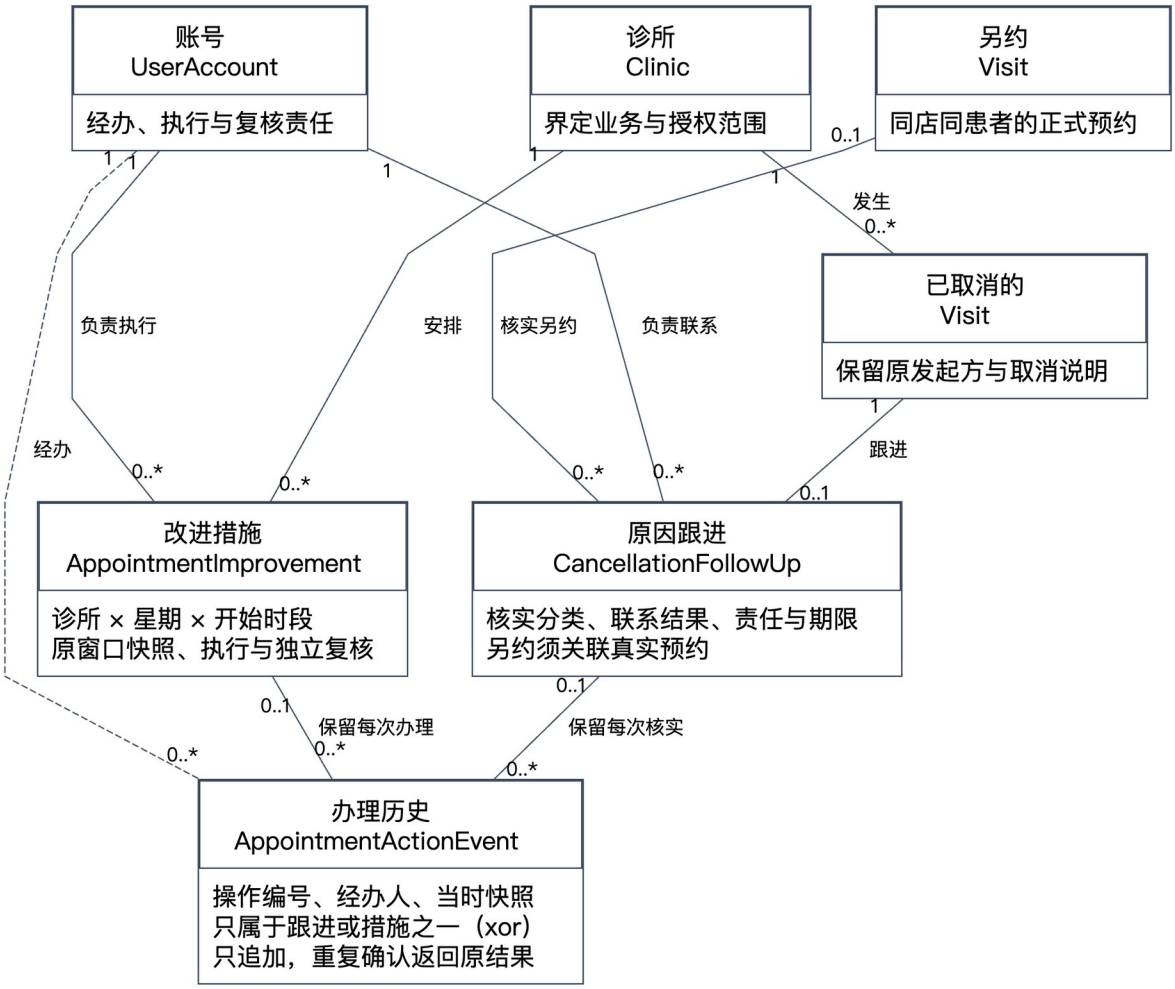

图 4-13 取消跟进与改进措施的领域关系

每个取消预约至多一个当前原因跟进，可引用正式另约；措施按诊所、星期和时段建立，不占用患者资源。每条办理历史只能属于跟进或措施之一，不能覆盖原预约和统计事实。

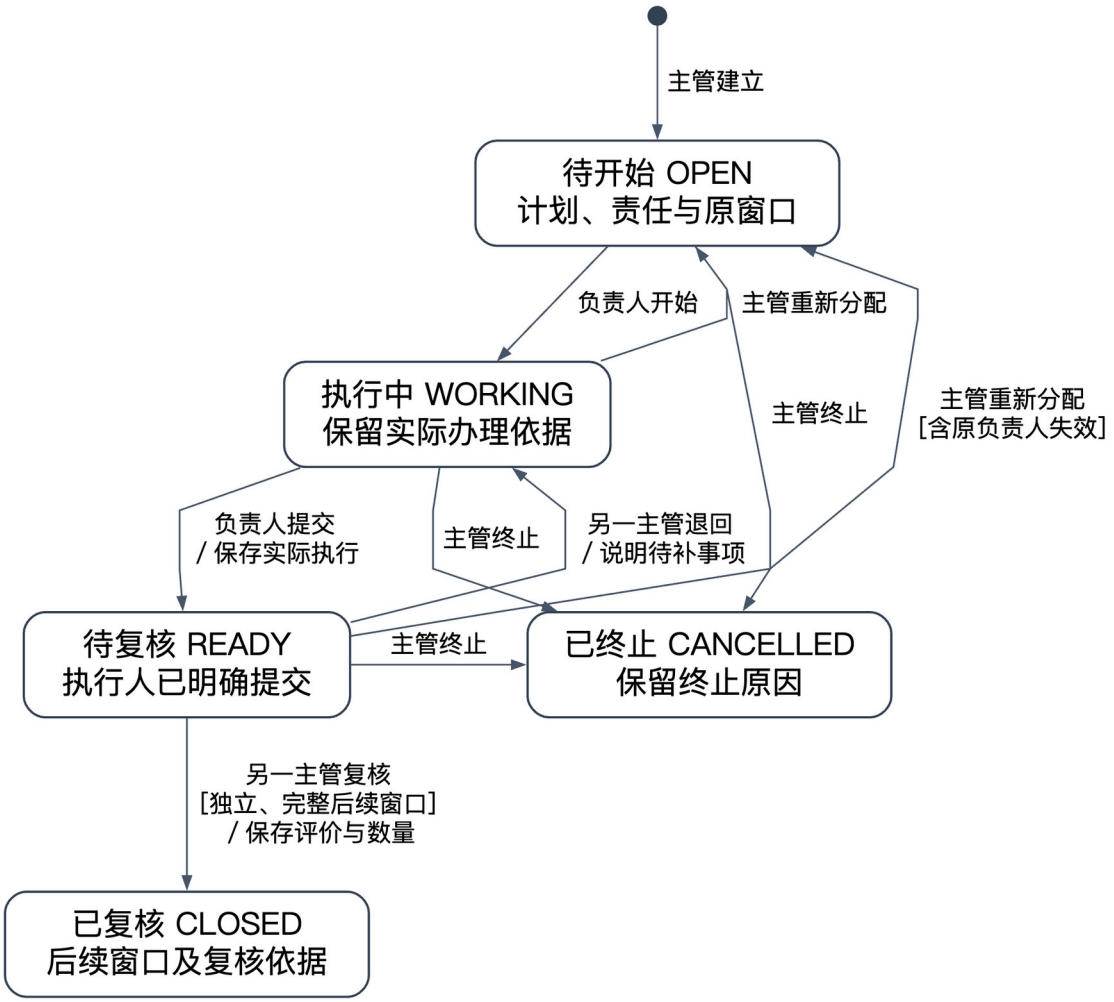

图 4-14 改进措施状态与独立复核

执行与复核采用不同账号；后续观察窗口完整结束且不早于最近执行开始日。样本不足、不可比和变化待观察分别记录，不把统计变化当作措施的因果效果。

4.12 权限、审计与服务连续性

身份和诊所范围在每次业务操作中分别核验。独立审核检查真实账号，角色切换不能自审；患者仅能访问本人绑定资料。重要变更保留经办、时间、原因及前后关联，便于解释预约和资金结果。

通知处理与业务提交分离，消息失败不撤销已成功的预约或资金事实，消息已读也不等于业务已办理。服务监测和备份恢复支持故障定位与数据连续性；具体部署和运行记录置于项目运行文档，业务报告仅讨论其对服务结果的影响。

4.13 数据库实体关系设计

数据库以实际 PostgreSQL 结构为依据分为四十一幅关系视图。现有 163 张 SQL 表，含 162 张 ORM 业务与框架表及 1 张迁移日志；475 条普通外键及 1 条账单复合外键共 476 条，135 项业务触发器。保留全部原 75 份迁移，本轮追加 2 份归档迁移和五张业务表，专项职责默认关闭。归档责任、准确申请、固定包、批准补正及办理历史分别关联；字段、类型、可空性、唯一关系和外键端点逐项与实际数据库核对。

PK 表示主键，FK 表示外键，UK 表示单列唯一，问号表示可空。关系端点采用乌鸦脚记法：双竖线为恰好一个，圆圈加竖线为零或一个，圆圈加三叉为零到多个。条件唯一、状态与时间规则在图后单独说明。

方案及检查的患者与诊所从原就诊推导，避免重复维护归属。方案步骤保留发布时的项目单位、服务名称、科室和时长；历史未登记定义与加工依赖保持空值。条件唯一、追加历史、完成依据和当前有效占用分别由实际数据库约束及对应业务命令核验；JSON 快照不伪画为外键。

4.13.1 预约与电话接待

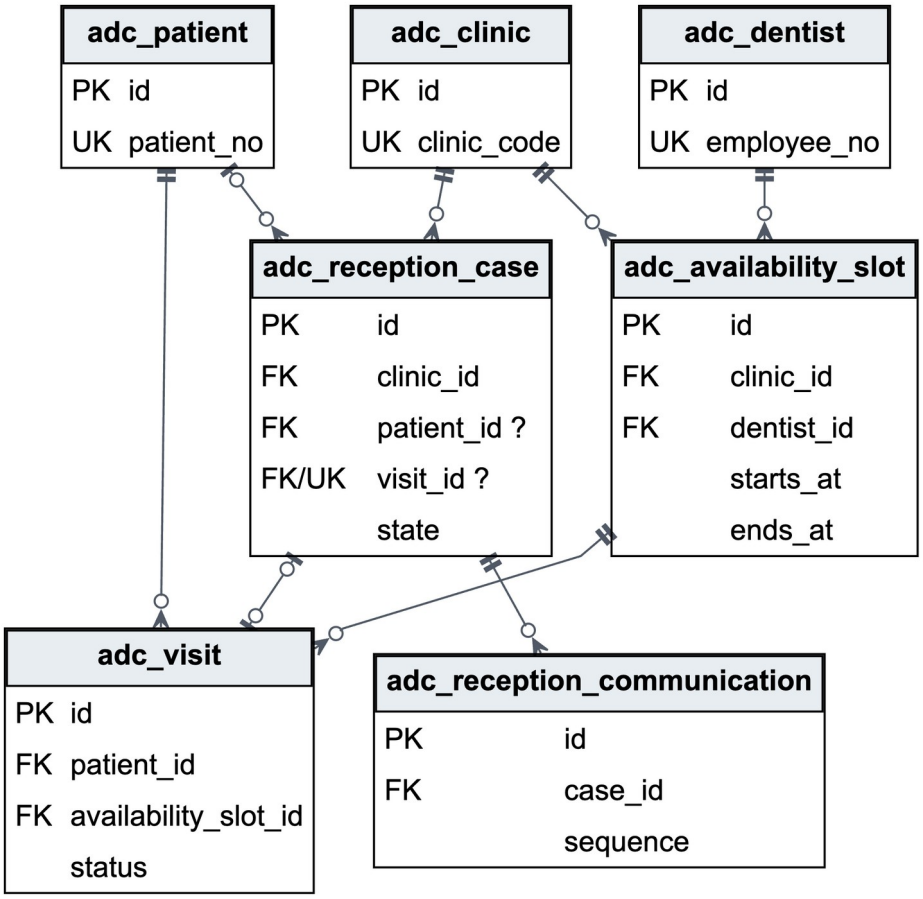

图 4-15 预约与电话接待数据库 ER 图

接待可以尚未建档；visit_id 唯一且可空，沟通按 case_id 与 sequence 保留历史。诊所与医师等未展开外键见字段目录。

4.13.2 排班服务与医师适配

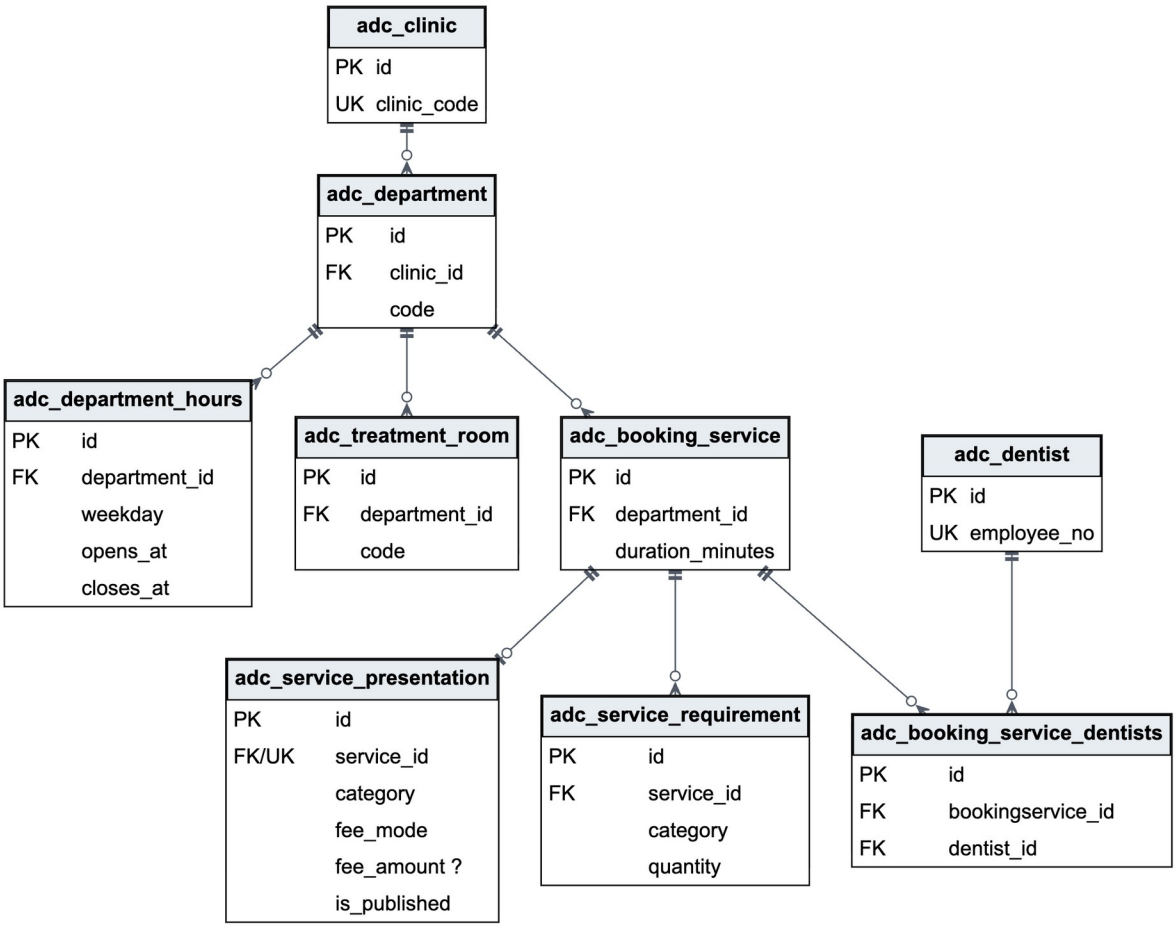

图 4-16 排班服务与医师适配数据库 ER 图

服务与医师的多对多关系通过真实连接表实现；科室开放与医师出诊分别保存。每项预约服务至多一份患者说明，未建立、草稿或不完整说明均不公开；费用说明不生成账单。

4.13.3 设备位置与资源占用

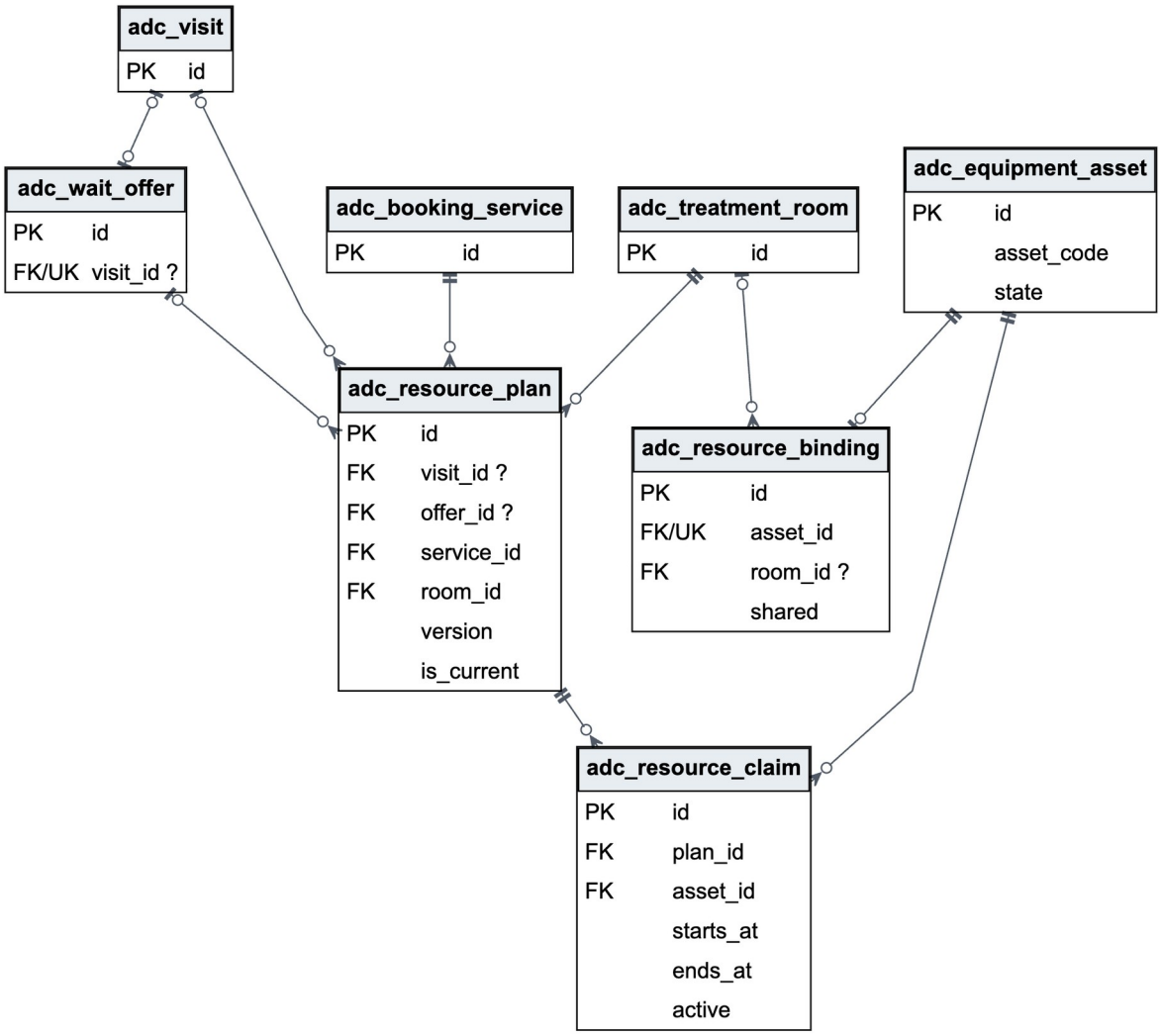

图 4-17 设备位置与资源占用数据库 ER 图

方案必须引用预约或邀约，接受邀约后允许两者同时存在；每个来源至多一个当前方案。牙椅使用设备资产，每项有效占用受时间排斥约束保护。

4.13.4 诊疗结算与资金凭据

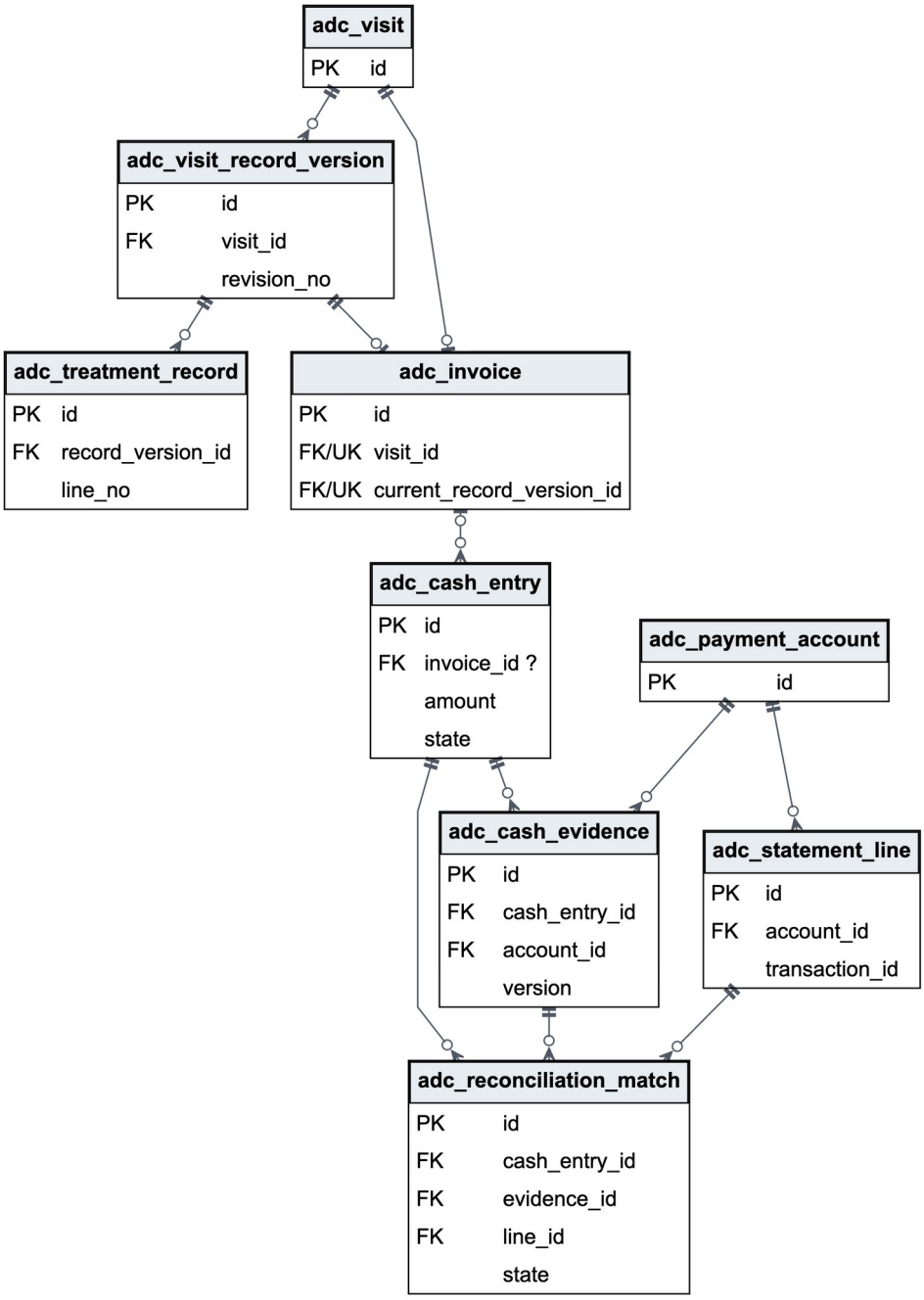

图 4-18 诊疗结算与资金凭据数据库 ER 图

每次就诊至多一个逻辑账单；账单另有复合外键保证当前记录版本属于同一次就诊。凭据与匹配保留多次历史，活动匹配的唯一性由条件约束限定。

4.13.5 前台排班与调班责任

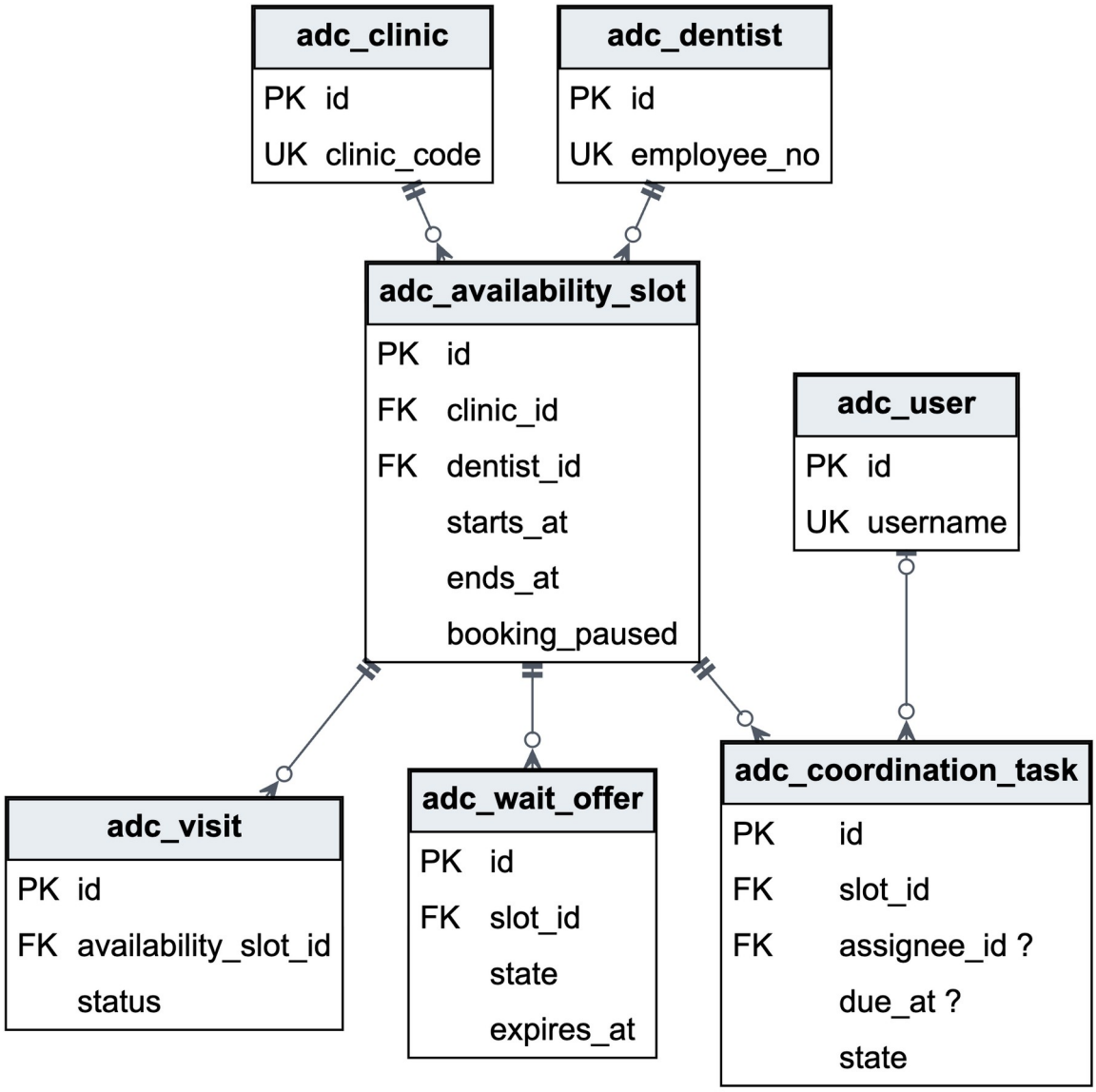

图 4-19 前台排班与调班责任数据库 ER 图

出诊是医师供给，预约与有效邀约是承诺；协调任务经 slot_id 归店，assignee_id 可空，due_at 历史可空。每个出诊至多一个活动任务；独立复核与具体预约变更另行办理。

4.13.6 患者授权与预约改期来源

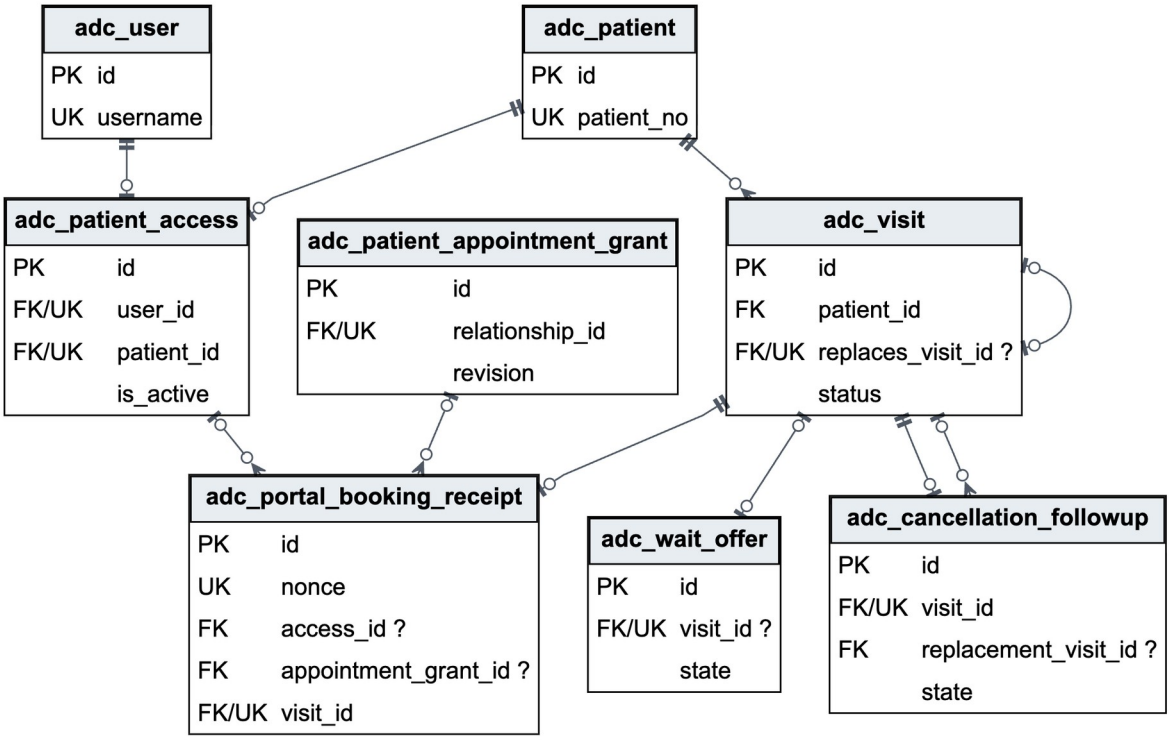

图 4-20 患者授权与预约改期来源数据库 ER 图

本人绑定保留；预约确认回执必须且只能引用本人绑定或预约代办授权之一，nonce 唯一，visit_id 唯一。预约自引用可空且唯一，构成原约与后继。邀约和取消跟进保留各自原关联，不因后续改期改写；当前患者、本店代约范围和活动状态由事务命令核验，不能从外键推定权限。

4.13.7 患者关系核验与预约代办授权

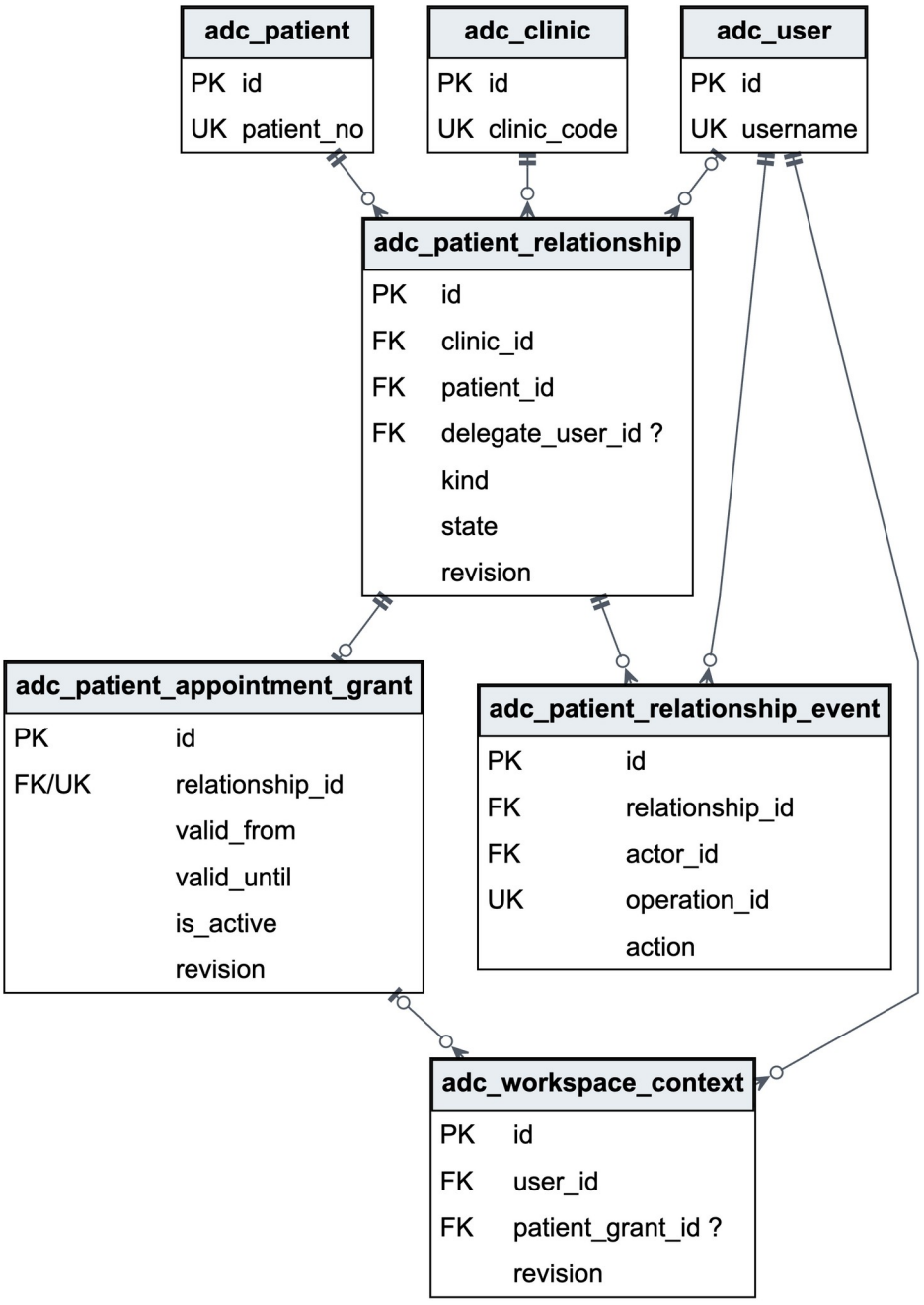

图 4-21 患者关系核验与预约代办授权数据库 ER 图

关系属于患者及核验诊所，账号可在待核验阶段补充。每项关系至多一项预约授权；联系人和普通亲属关系不生成授权。决定事件仅追加，operation_id 唯一。上下文可选一个授权，本人入口保持空；有效期、当前账号与本店范围由事务核验，不从外键连线推断病历、资金或临床同意权限。

4.13.8 专业资质来源与限定操作授权

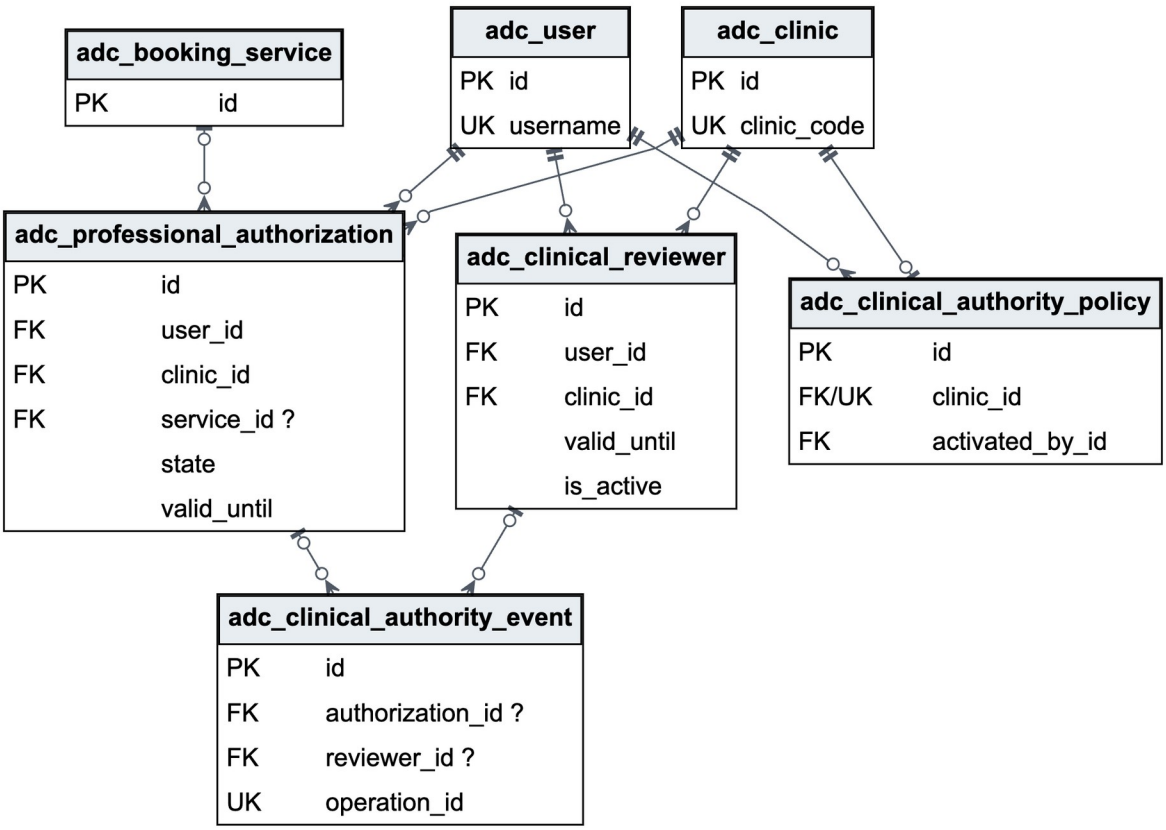

图 4-22 专业资质来源与限定操作授权数据库 ER 图

审核职责按账号与诊所唯一；机构委任不等于病历访问。专业申请分别引用账号、诊所和可空服务；空服务仅指无服务旧记录，不是全服务通配。决定历史及诊所启用事实不可改写。图中仅展开关键外键，来源证据、有效期及查阅／记录／转诊动作见完整目录与命令核验。

4.13.9 限定跨店转诊与敏感查阅留痕

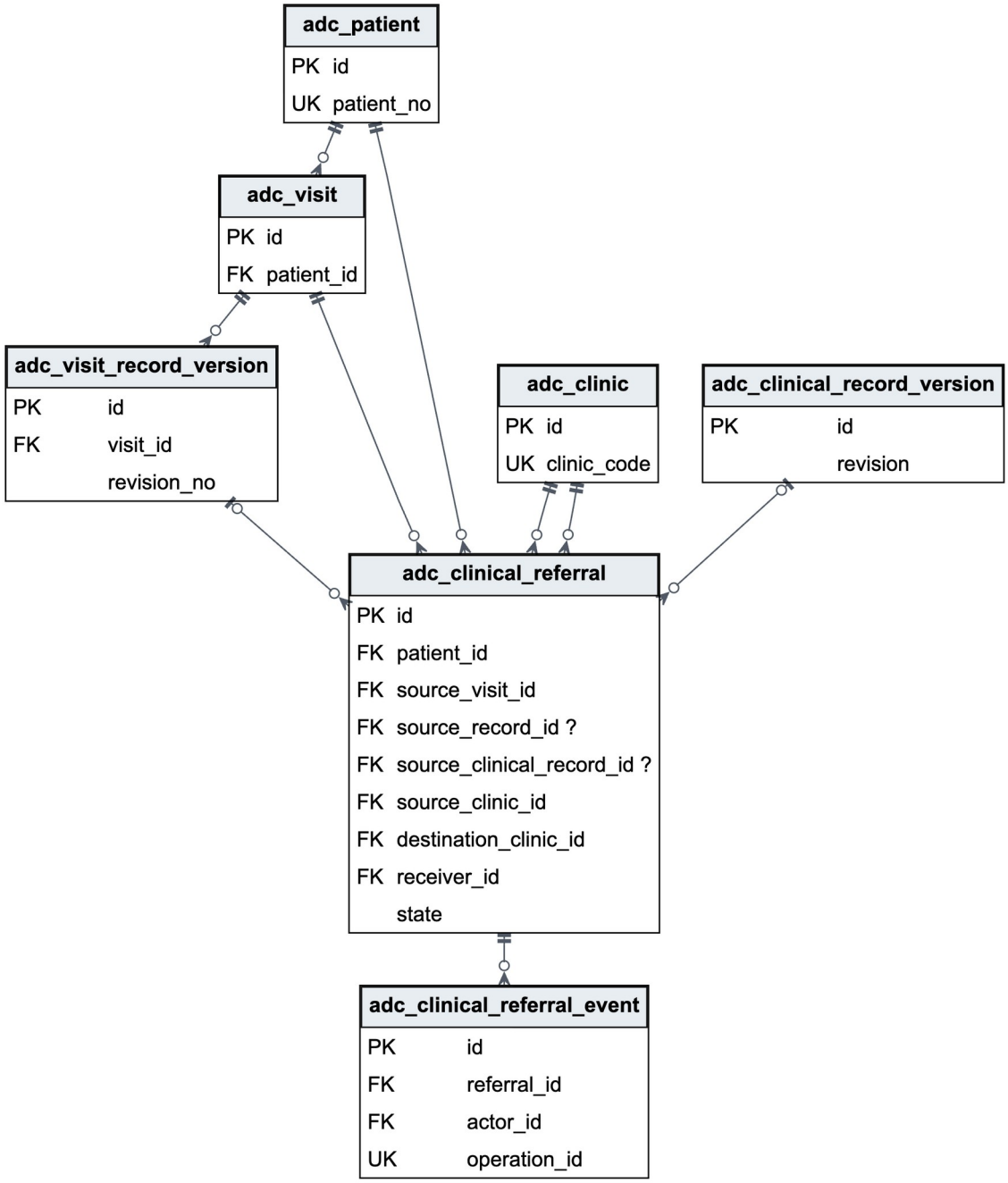

图 4-23 限定跨店转诊与敏感查阅留痕数据库 ER 图

转诊保留原患者、原就诊、转出／接收诊所及指定医师。来源可不选，选择时至多引用一个旧发布版本或结构化检查确认版本；必须属于同次原就诊。后续更正不改写已选择的版本。身份核对、临床披露同意和医师接收分别办理。查阅事件的 object_kind/object_id 为受控类型与对象编号，不是虚构外键。其余来源及有效期在完整目录保留。

4.13.10 患者自述来源与医师核对

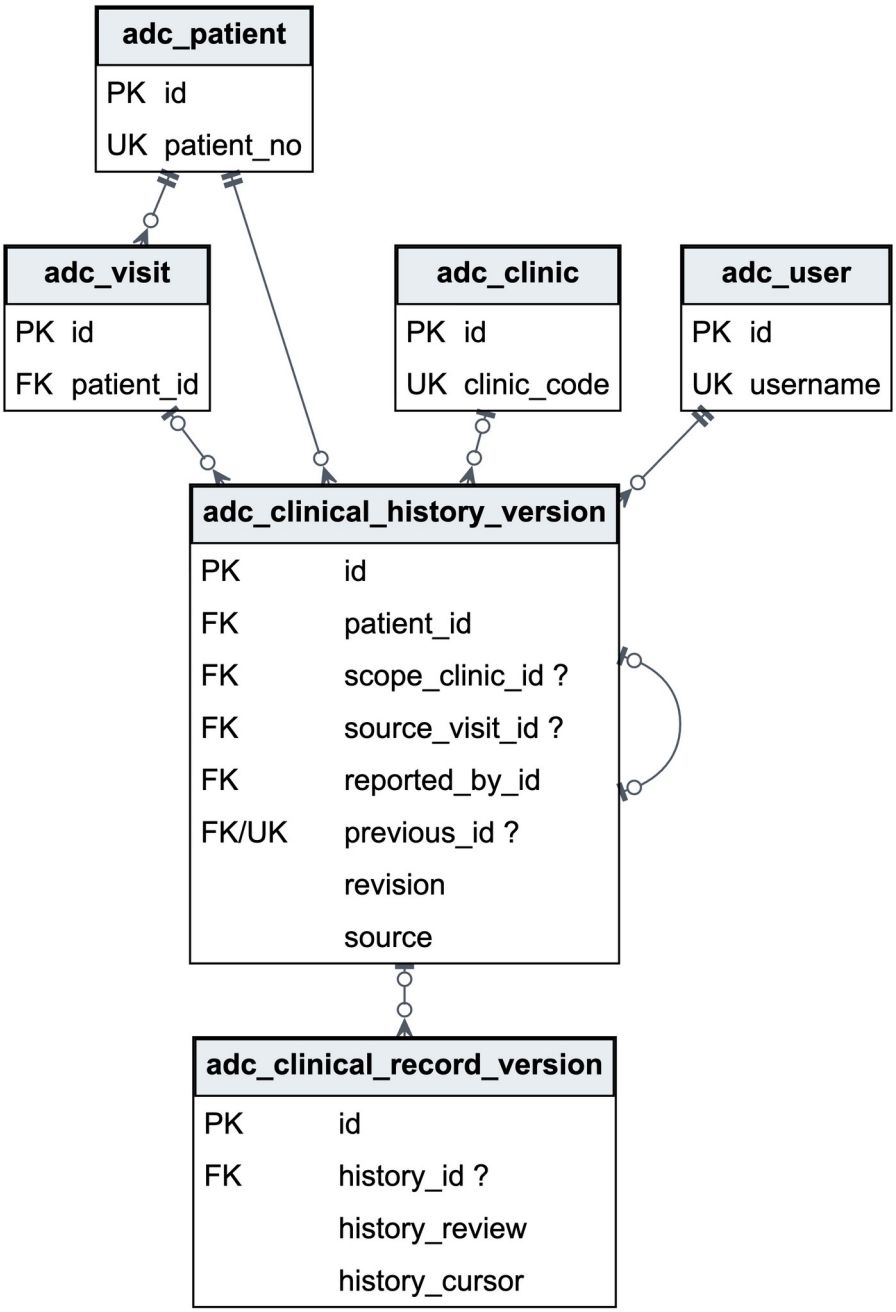

图 4-24 患者自述来源与医师核对数据库 ER 图

本人提交不归属某次预约或诊所；医师面谈引用实际就诊及当前诊所。患者与来源诊所及版号组成唯一键，空诊所也参与唯一性；各来源分别追加版本。检查记录可引用一个已核对的具体版本，并保留核对结论、差异和可见来源游标。自述不覆盖已复核过敏资料；外键不授予跨店查阅权限。

4.13.11 实际检查、草稿与确认版本

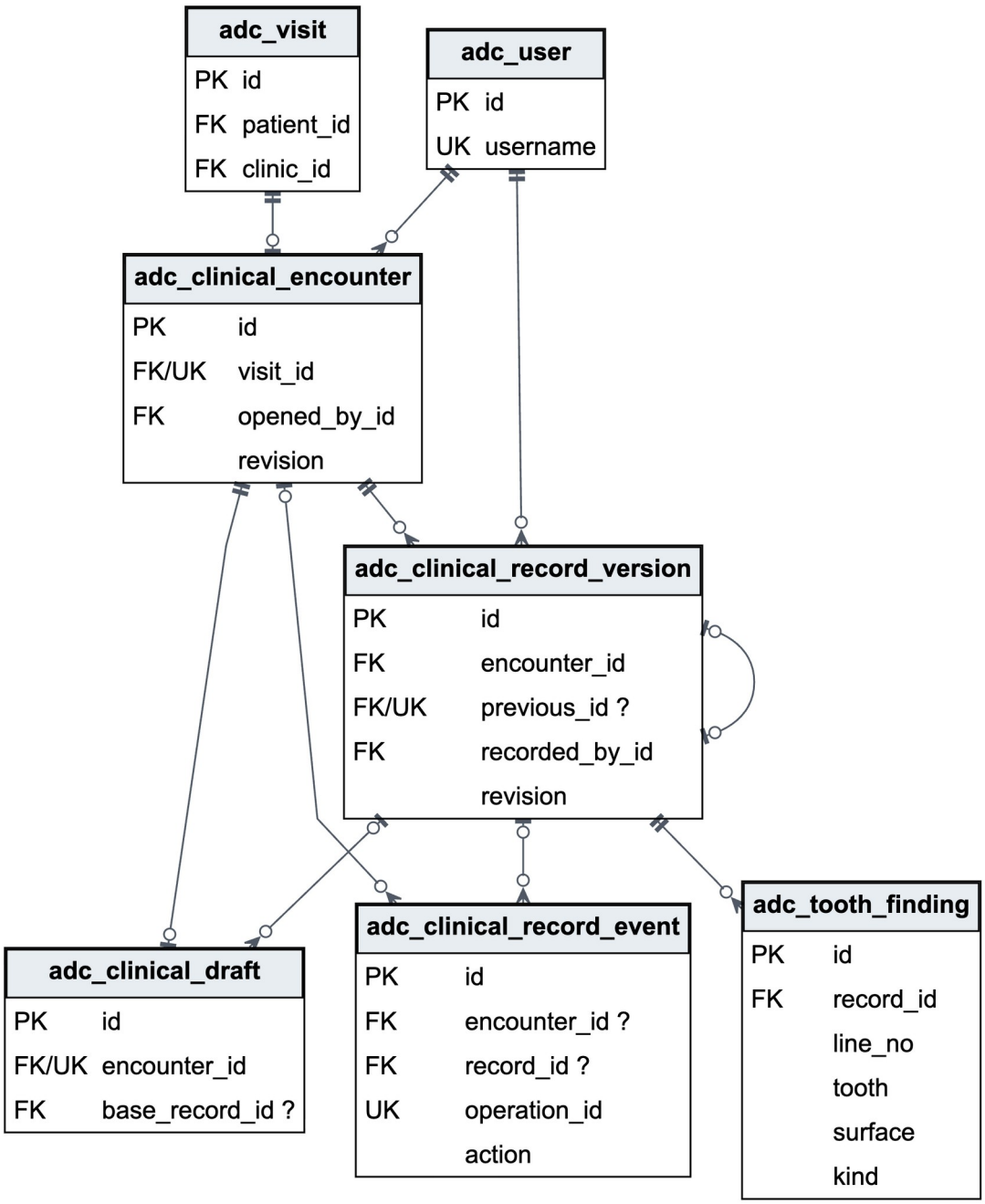

图 4-25 实际检查、草稿与确认版本数据库 ER 图

每次实际到诊至多一个检查头，患者与诊所经原就诊推导，不重复维护。每个检查头至多一个可修改草稿，base_record 可空；确认版本按检查头和版号唯一，前版引用可空且唯一。牙位观察属于具体确认版本，草稿观察尚在有界工作载荷中。确认版本、观察及决定事件只追加，草稿可明确放弃。检查记录本身不是治疗执行或资金事实。

4.13.12 跨次就诊方案与保留版本

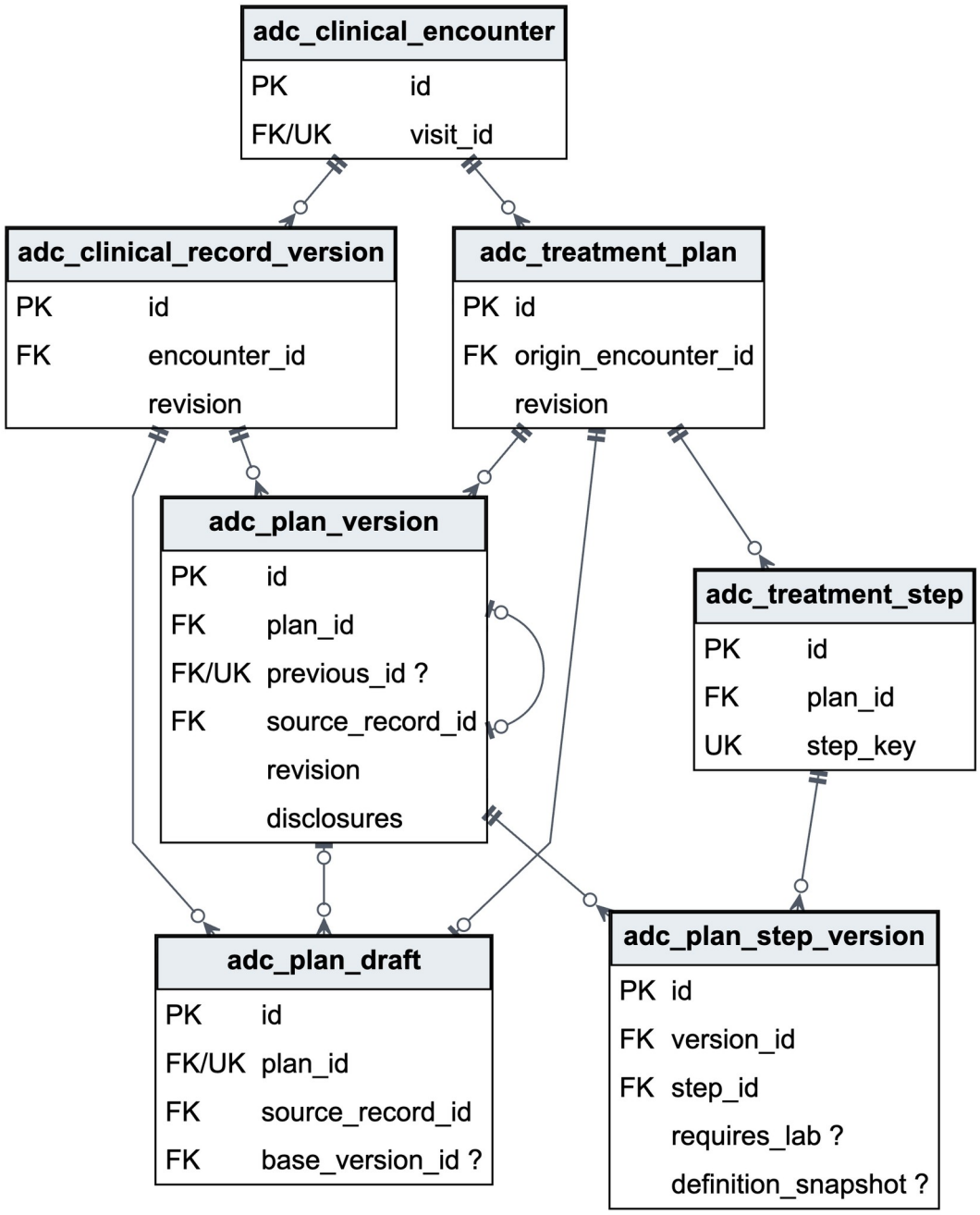

图 4-26 跨次就诊方案与保留版本数据库 ER 图

患者与诊所经原检查头及就诊推导；不重复维护患者归属。工作草稿可修改，确认方案和步骤版本保留历史。disclosures 为按稳定步骤编号保存的治疗说明 JSON 快照，不增加 SQL 外键，也不表示患者已同意。稳定步骤只表达沿革，不能把旧版本人决定或加工验收当作新版授权。目录定义与时长保留发布时快照，旧记录缺失保持未登记，不补造历史。

4.13.13 具体方案步骤与本人决定

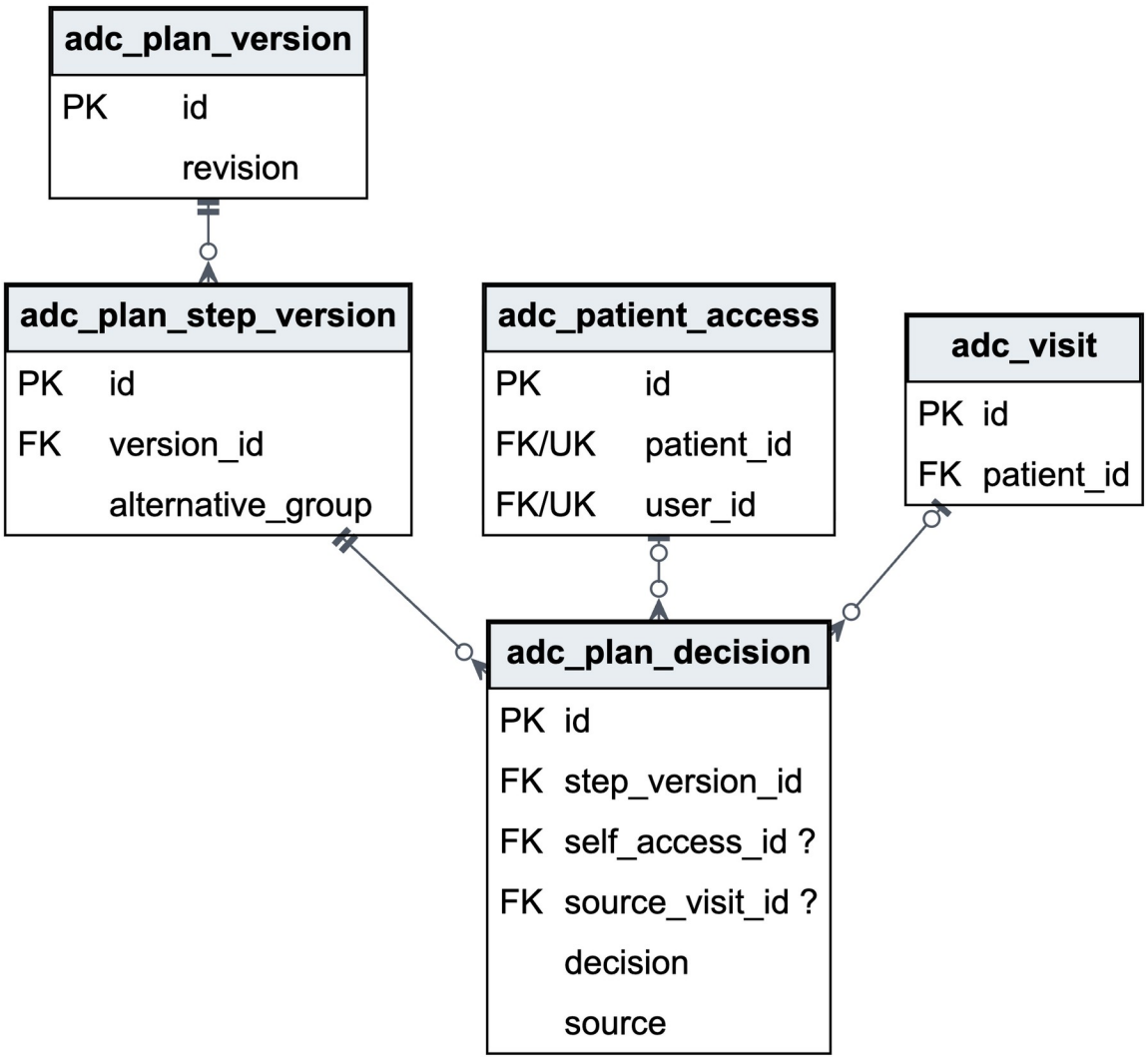

图 4-27 具体方案步骤与本人决定数据库 ER 图

每次决定绑定具体步骤版本。本人网站决定引用本人 PatientAccess，医师手工登记的讨论决定引用本次就诊，来源二选一；这不是手术知情同意签署。代约授权不授予方案或病历访问。互斥组不能同时形成两个已接受的当前选择；所有决定只追加。

4.13.14 实际执行、原始开单与账单版本

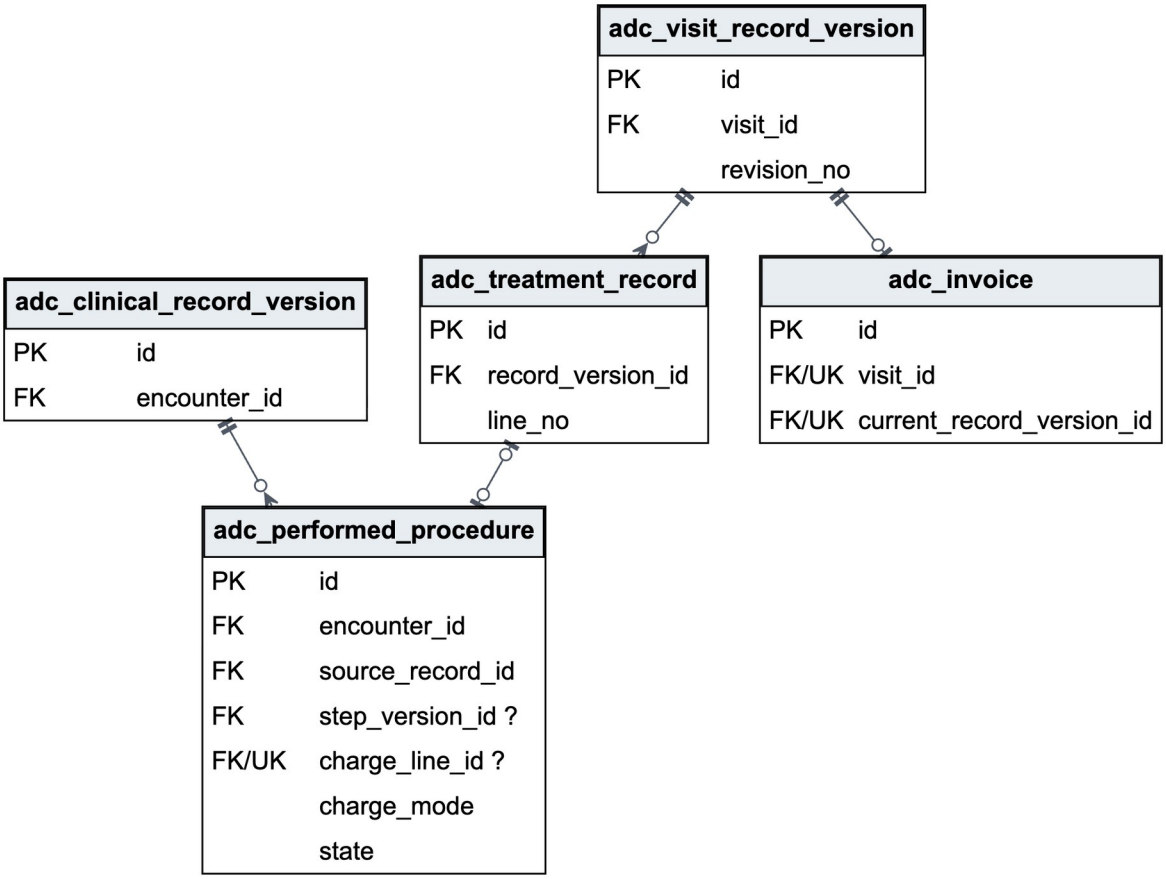

图 4-28 实际执行、原始开单与账单版本数据库 ER 图

实际执行可引用计划内步骤，也可明确登记计划外依据。原始收费行至多归属一个实际执行；审核后的账单版本副本不生成第二次执行。原开单快照保留在实际执行 JSON 中，不伪画为外键。完成时计费方案的中间阶段可不另收费，但仍属已治疗；未发布作废保留原执行与快照，已发布执行不能作废。

4.13.15 医师后续要求与原预约关联

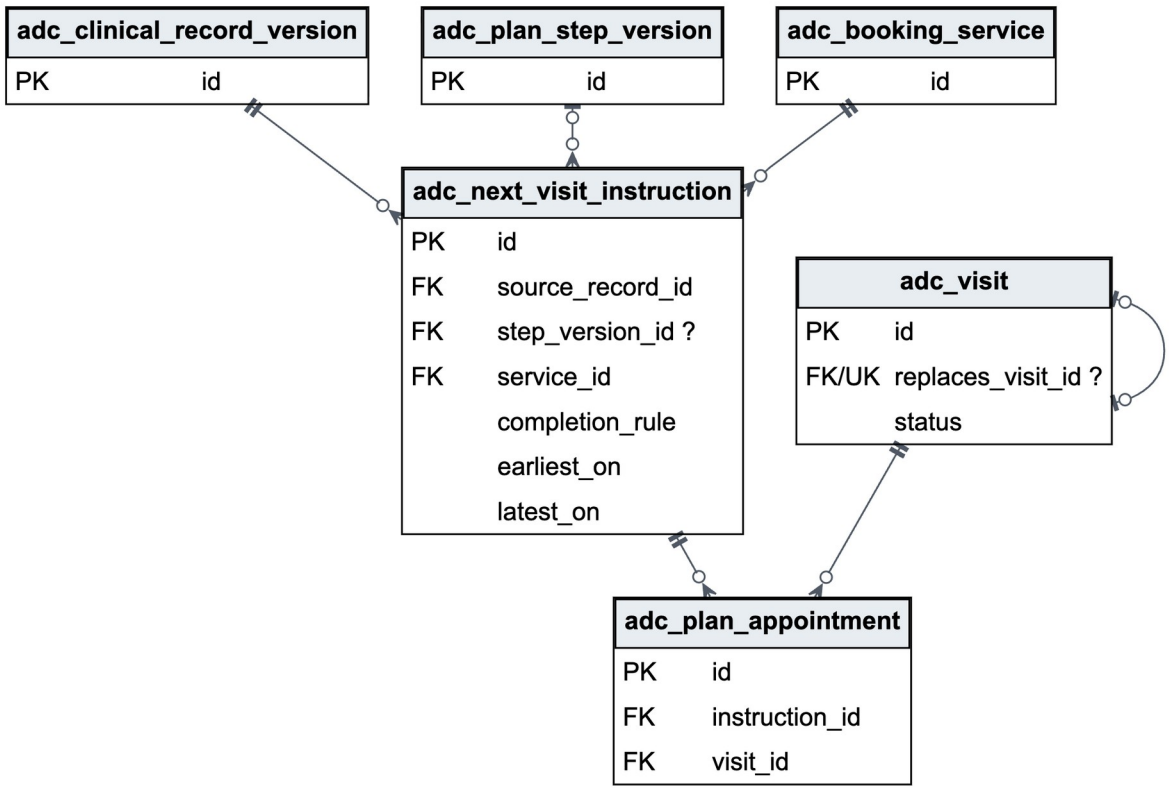

图 4-29 医师后续要求与原预约关联数据库 ER 图

后续要求保留原检查、具体步骤、服务、建议窗口和完成标准；前台只读取安排所需投影。先经统一资源规则成约，再明确关联原预约；改期沿唯一后继关系跟踪，取消不代表复诊完成。一次部分治疗关闭后，如未达到明确完成标准，可以继续安排。历史未登记完成标准的记录保留未明确状态。

4.13.16 复诊责任、沟通与实际完成依据

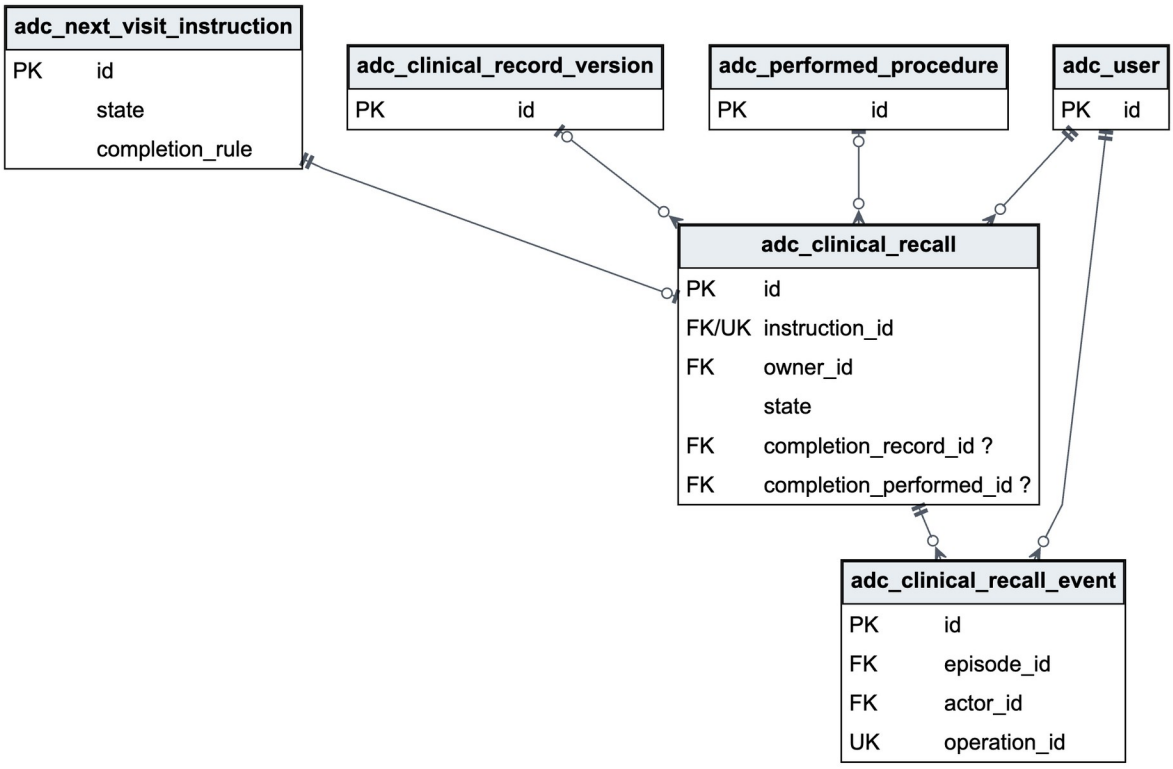

图 4-30 复诊责任、沟通与实际完成依据数据库 ER 图

一条后续要求至多一份随访责任，状态、负责人和期限变化追加事件。完成时仅选择同患者、同店、同服务且明确关联的已关闭后续就诊事实；确认检查或指定步骤完成依据二选一。晚于建议窗口如实记录，不改原日期。患者暂不继续转医师核对，未经明确恢复不重复对外联系，也不自动取消预约。

4.13.17 加工请求、物理送返与具体版本验收

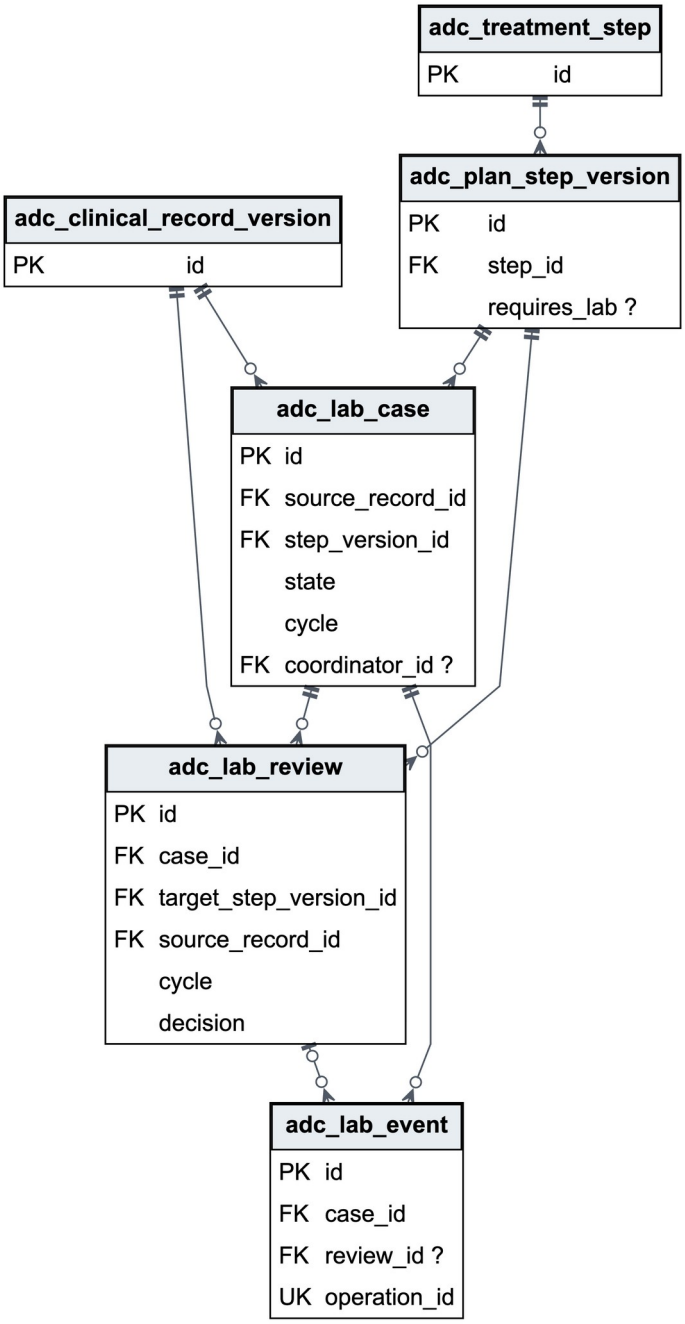

图 4-31 加工请求、物理送返与具体版本验收数据库 ER 图

医师请求绑定原确认检查及已接受具体方案步骤。送出、返回是手工交接事实，不代表临床适配；每次返工须经过新送返周期。验收绑定本周期及当前确切步骤版本，跨版本复用必须重新明确核对。前台不读取加工临床规格或验收详情；原需要日期与预约保留。只在所需加工件全部有效验收后允许相应实际执行，不自动产生收费。

4.13.18 门店公开资料与发布历史

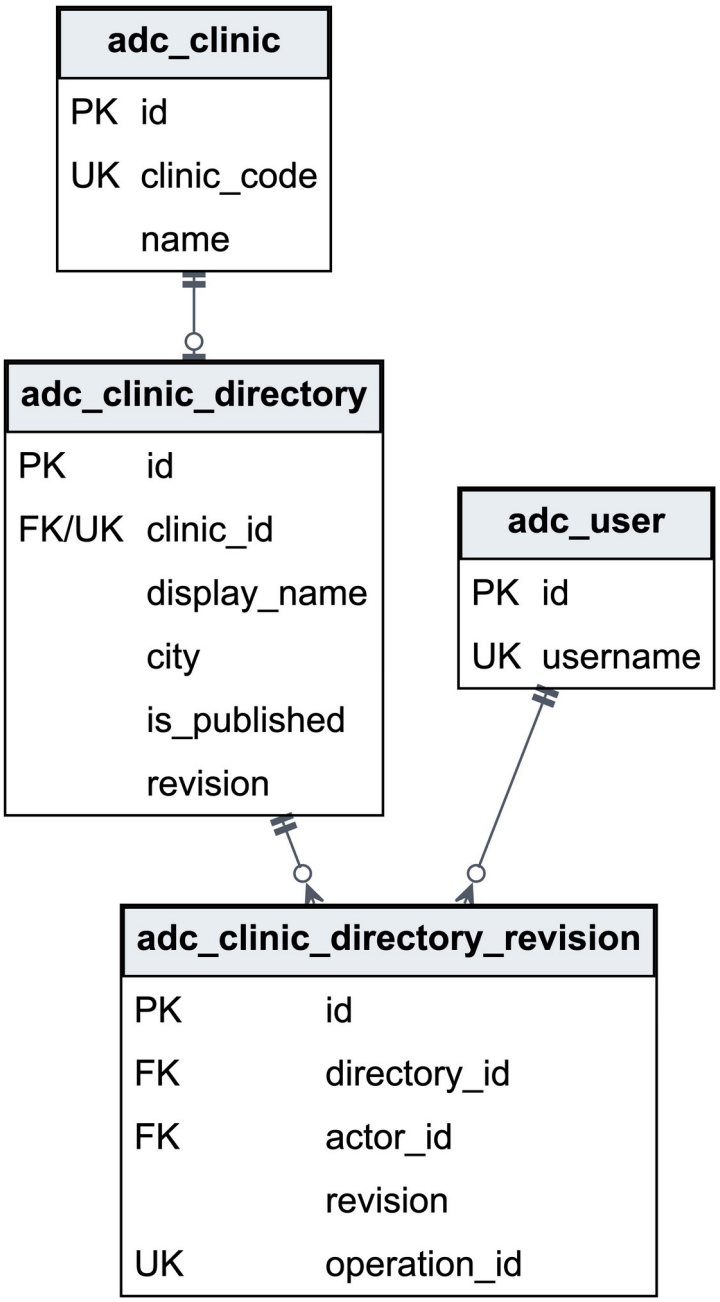

图 4-32 门店公开资料与发布历史数据库 ER 图

每家诊所至多一份当前公开资料；业务名称和既有单据身份不随公开别名改写。发布版本按资料及版号唯一，操作编号唯一，历史只追加。营业时间由科室开放和明确停用区间推导，不在资料中重复维护；WGS84 排序与 GCJ02 导航坐标分开，坐标缺失保持未知。外键不授予岗位权限。

4.13.19 患者渠道账号、凭证与联络来源

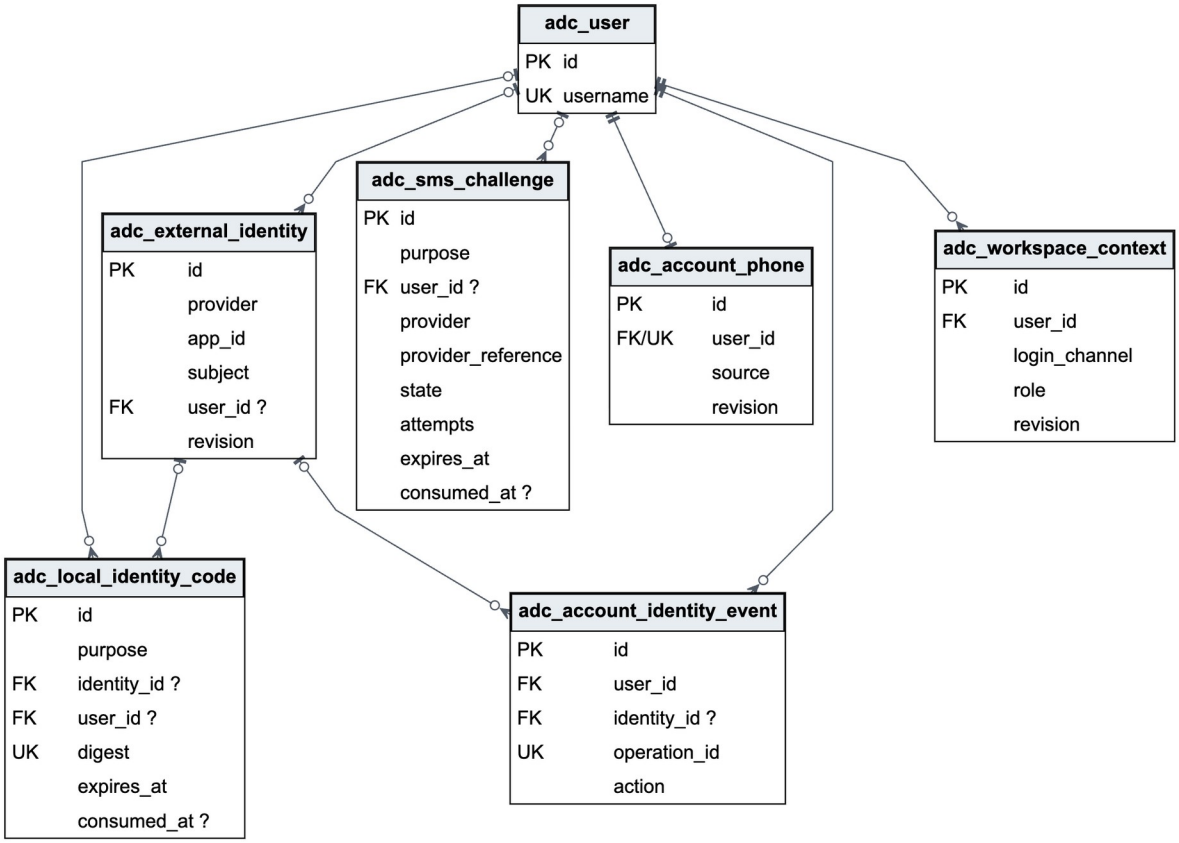

图 4-33 患者渠道账号、凭证与联络来源数据库 ER 图

外部身份按 provider、app_id 及 subject 联合唯一，当前账号引用可空；每个账号至多一个有效 SMS 登录身份，此条件不限制其余微信或本地绑定。解绑保留账号与事件。短信挑战仅 BIND 用途必须引用当前账号，LOGIN 用途引用为空；会话摘要不是关系外键。ADC 生成的验证码只存 HMAC 摘要；CloudBase 生成并核验验证码，ADC 只保存 provider_reference 挑战引用。两类均与用途、会话、期限及一次性使用绑定。账号联络按 user 一对一，不按手机号连接 Patient。微信身份由服务端交换，LOCAL 与 DEMO 来源仍明确标注；登录与手机号核验不授予员工、临床或患者档案权限。

4.13.20 本人建档申请、前台决定与唯一档案关联

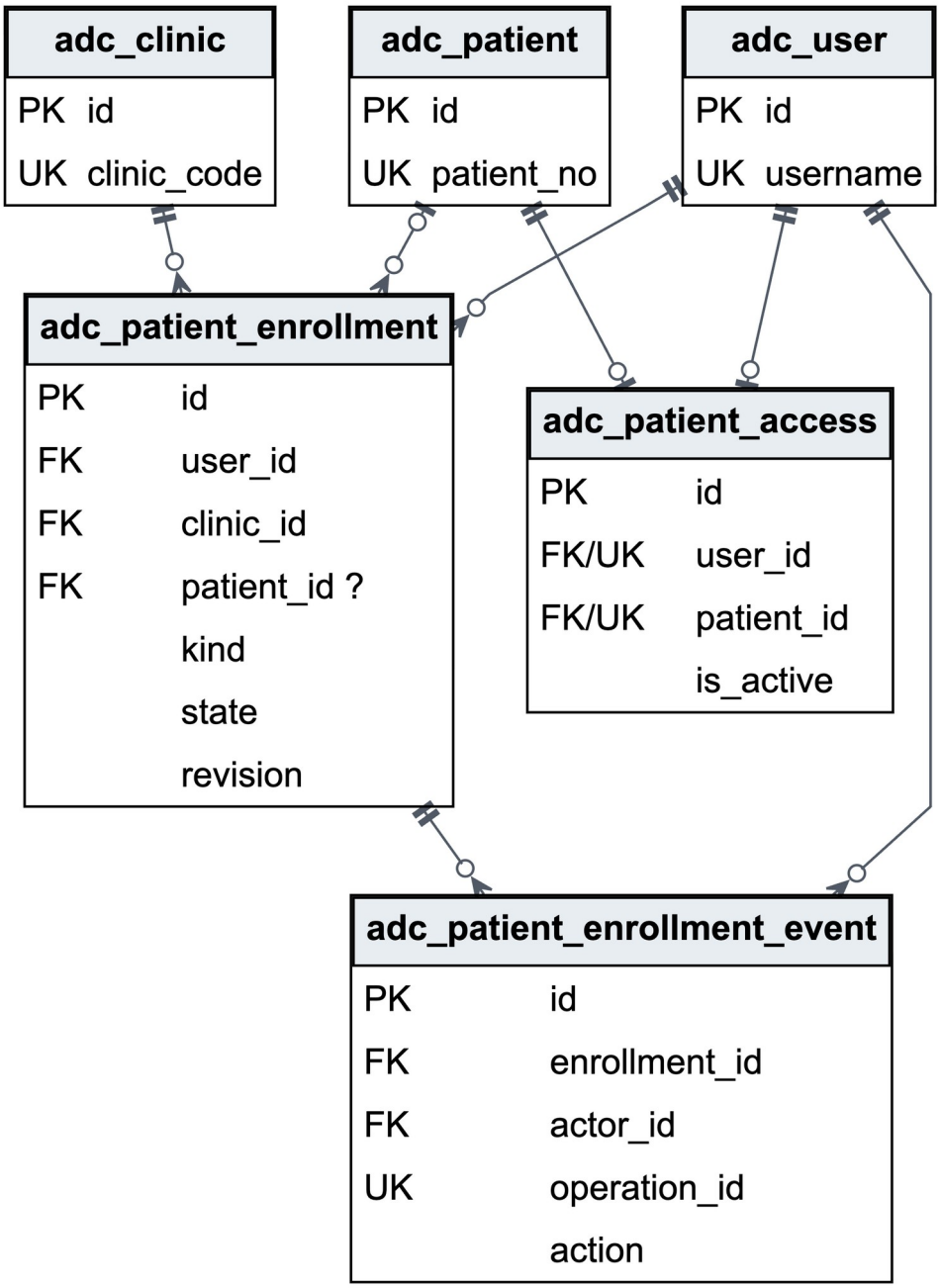

图 4-34 本人建档申请、前台决定与唯一档案关联数据库 ER 图

申请归属登录账号及办理诊所；同一账号至多一项待核验或待补充申请。患者引用在批准时才有值，待核验不创建正式档案或预约。前台以本店核验职责、当前申请版号及明确原档案核对，新档建档及关联同事务提交；旧档不改资料，暂停复核启用原 PatientAccess，决定事件一并追加。本人关联继续保持账号、患者分别一对一；手机号不合并患者。决定与原申请快照追加保留，撤回或解绑不删除原事实。

4.13.21 医保目录版本、门店安排与收费适配

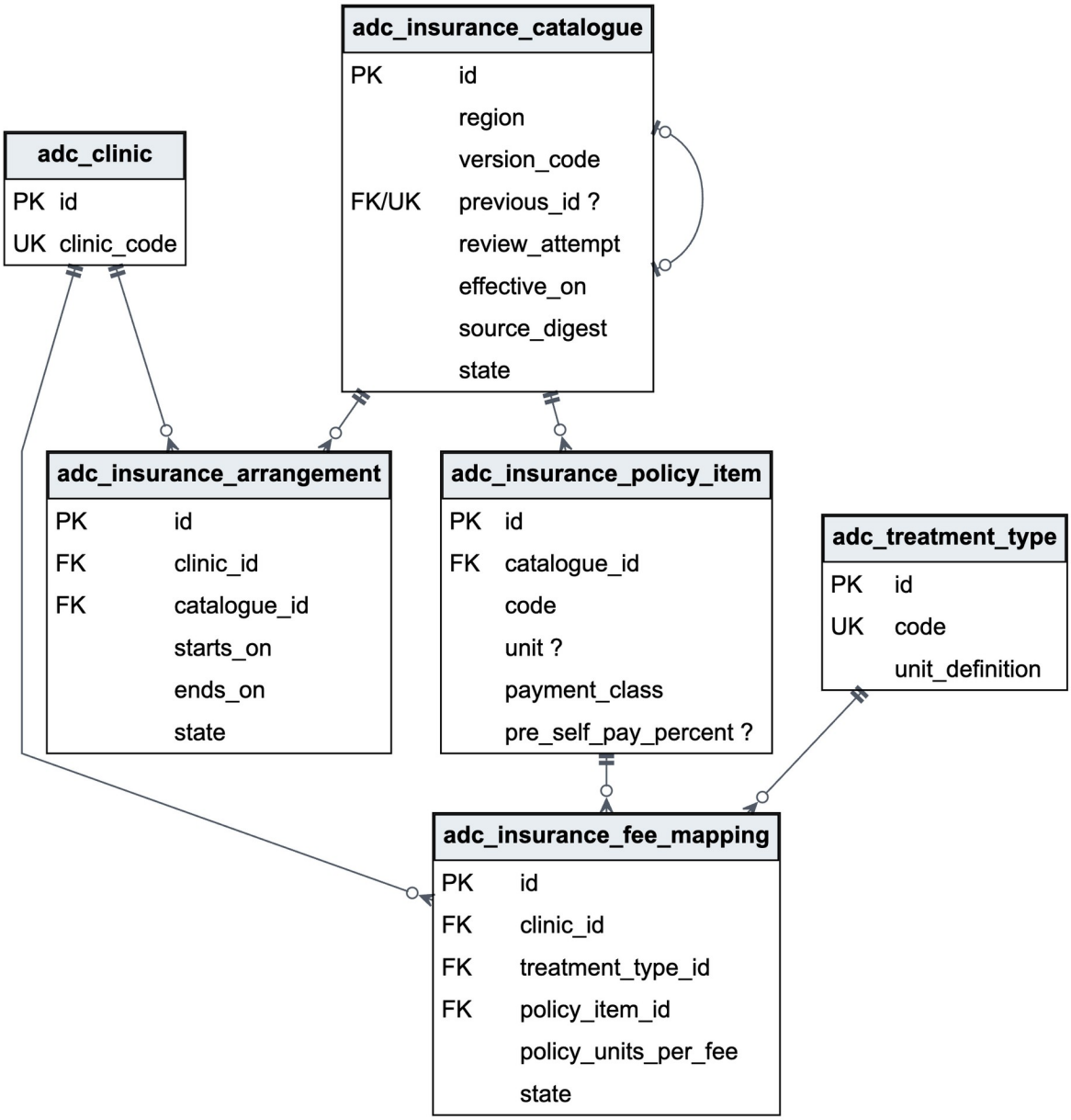

图 4-35 医保目录版本、门店安排与收费适配数据库 ER 图

目录保留原文件及规范记录，编码在目录内唯一；空白单位及规则保持未知。政策版本与审阅次数分开，同一来源至多一个待核对或已启用记录；未通过或停用后可明确提交下一次审阅，前次引用可空且唯一，原决定不改写。门店已确认安排按本店日期排斥重叠；收费映射按本店与收费项目限制一个启用结果。不同账号独立复核，重新核对不恢复旧安排或映射。图中省略操作人及其余事件分支，全部关系见完整目录；本图不表示真实定点资格或资金结算。

4.13.22 本店模拟待遇版本与办理历史

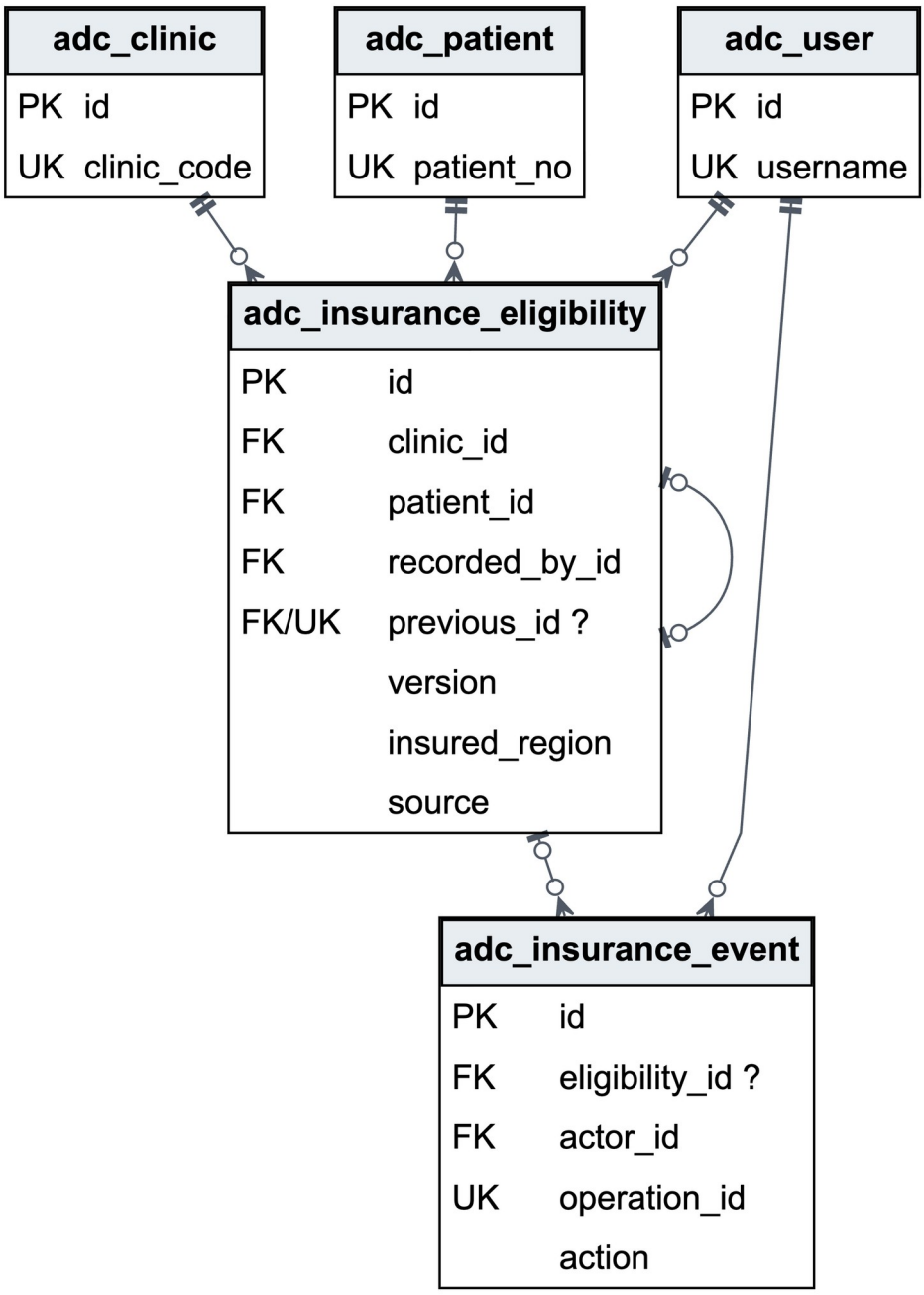

图 4-36 本店模拟待遇版本与办理历史数据库 ER 图

待遇事实按患者、诊所和版号唯一；前版引用可空且一对一，后续版本必须继续同一患者与诊所。记录及事件只追加，最新一版未核实或失效时不回退使用旧版。source 固定 LOCAL_SIMULATION，参保地不由定位或手机号推断；待遇资料不扩大本人或代约权限。办理事件在目录、安排、映射、待遇四个可空来源中恰选一个，本视图仅展开待遇分支，其余关系见完整外键目录。

4.13.23 原实际费用、唯一结算与独立分担

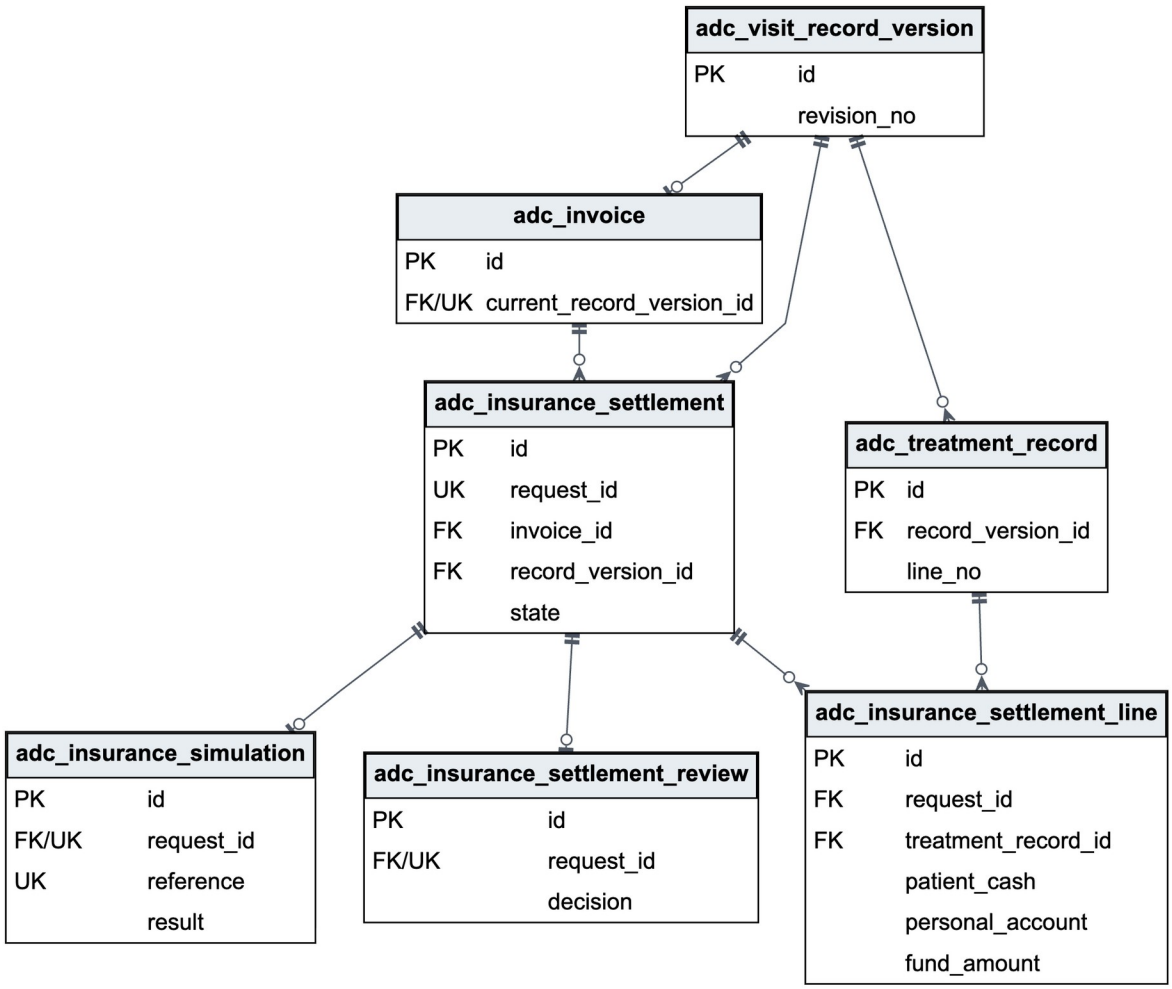

图 4-37 原实际费用、唯一结算与独立分担数据库 ER 图

每笔请求保留原账单的确切发布版本和全部实际收费行；同一账单至多一个未终结请求。原始模拟结果和独立分担复核分别一对一引用请求，回复未知时查询原编号，不重新申报。逐行现金责任、个人账户与基金之和等于原行金额；独立通过才影响患者待缴，不产生现金或新增收入。目录、待遇、操作人及事件外键见完整目录。

4.13.24 银行流水独占使用与基金逐笔分配

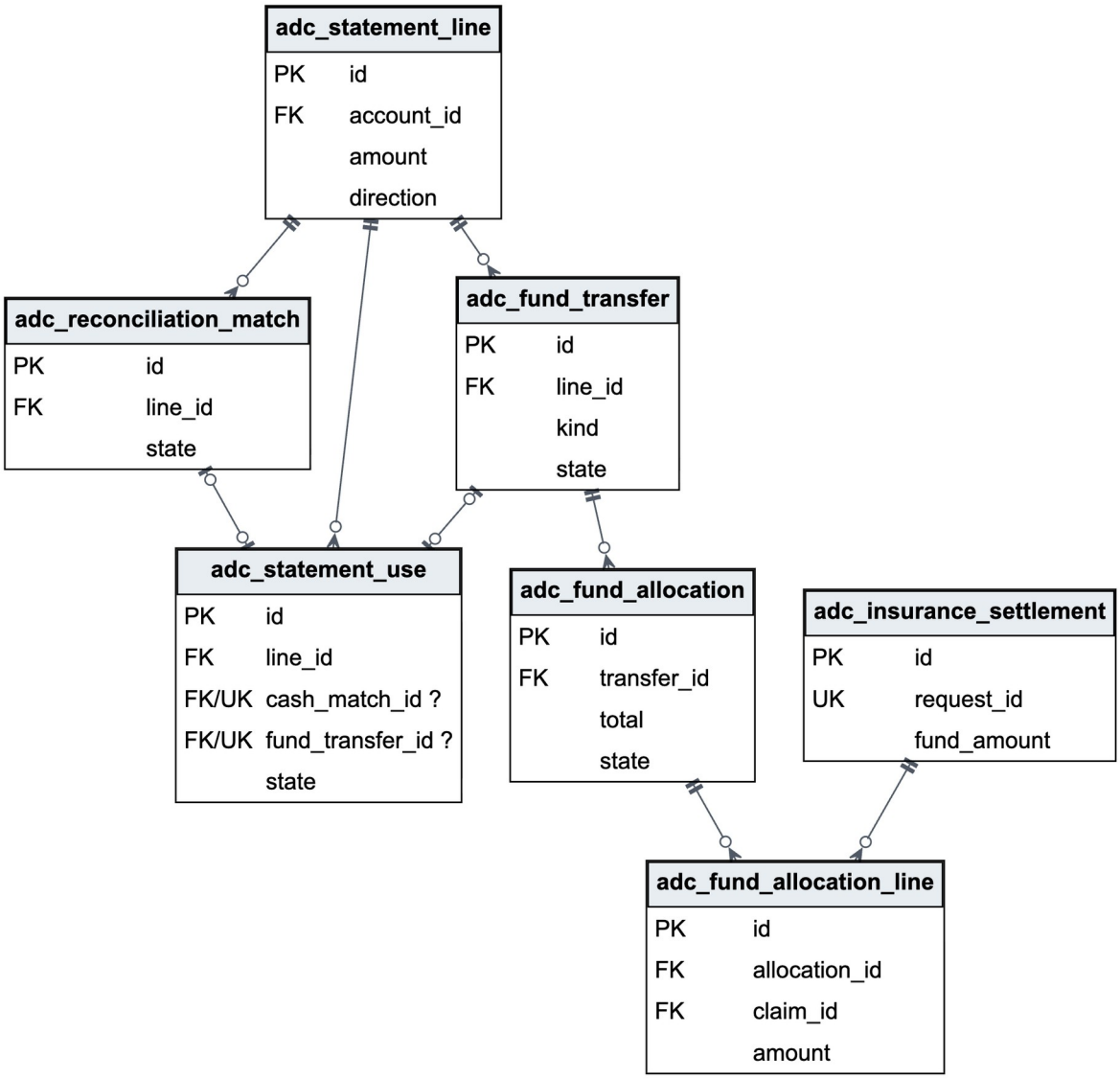

图 4-38 银行流水独占使用与基金逐笔分配数据库 ER 图

流水用途恰好引用现金匹配或基金凭据之一，两个来源各唯一且可空；每条流水至多一个活动用途。旧活动匹配仅派生用途记录，不重写原决定。已核对基金凭据可分批关联多笔同店同币种申报；分配行在批次内按申报唯一。待审及已通过分配共同限制可用银行金额；待审退回不能使用尚未确认的入账。到账、退回、现金账及原收入分开，完整账户和人员关系见目录。

4.13.25 基金差额责任与追加跟进记录

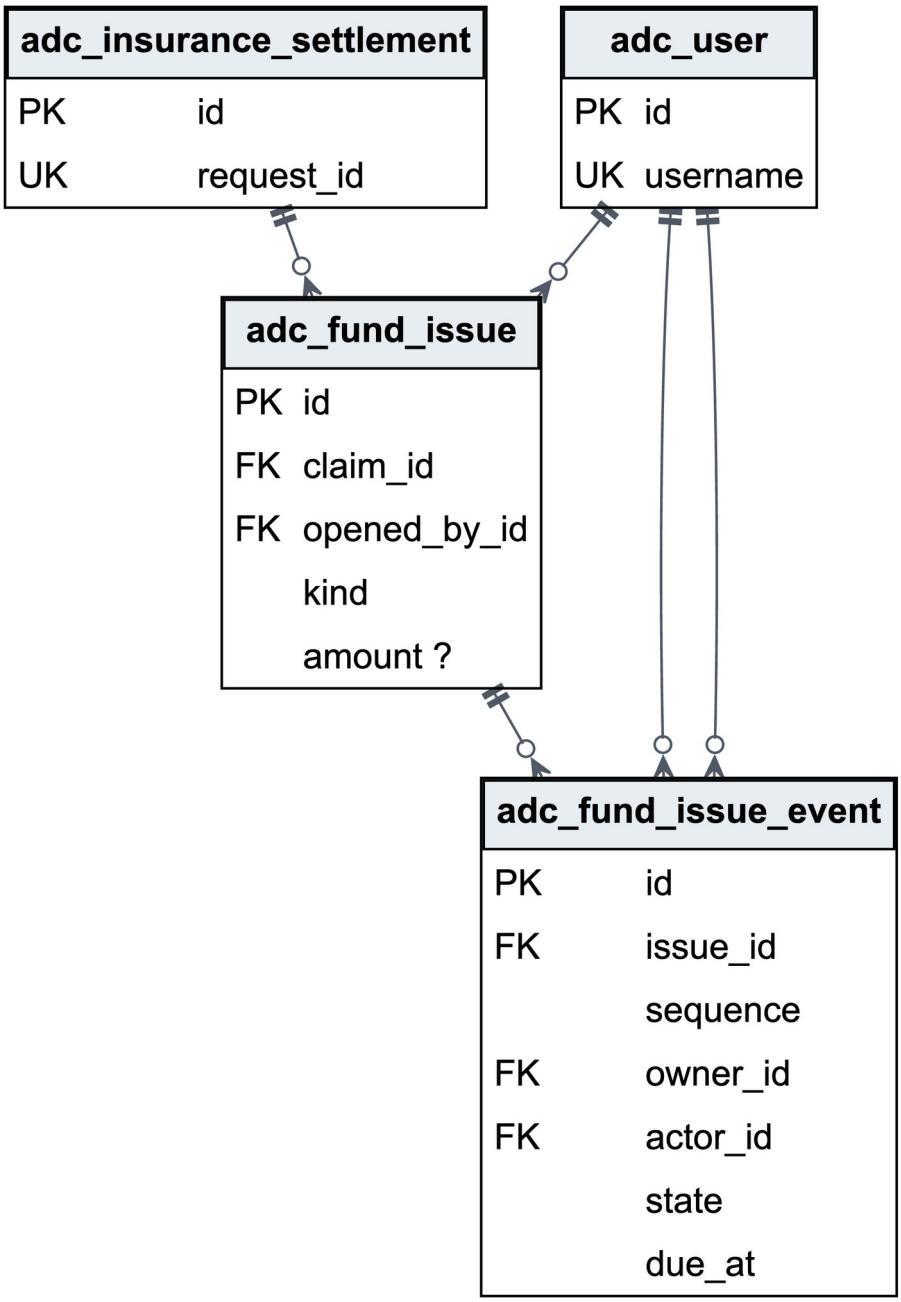

图 4-39 基金差额责任与追加跟进记录数据库 ER 图

未到账、少到账、扣减或用途未知均关联原申报；金额可空表示尚未核实。事项的责任人、期限、依据和状态由追加事件表达，每项按顺序唯一。负责人失效后可由现任财务明确重分配，原责任和沟通保留。结束跟进不核销基金，不生成平衡分录，也不转为患者欠款。

4.13.26 原结算撤销、原结果查询与独立退回核对

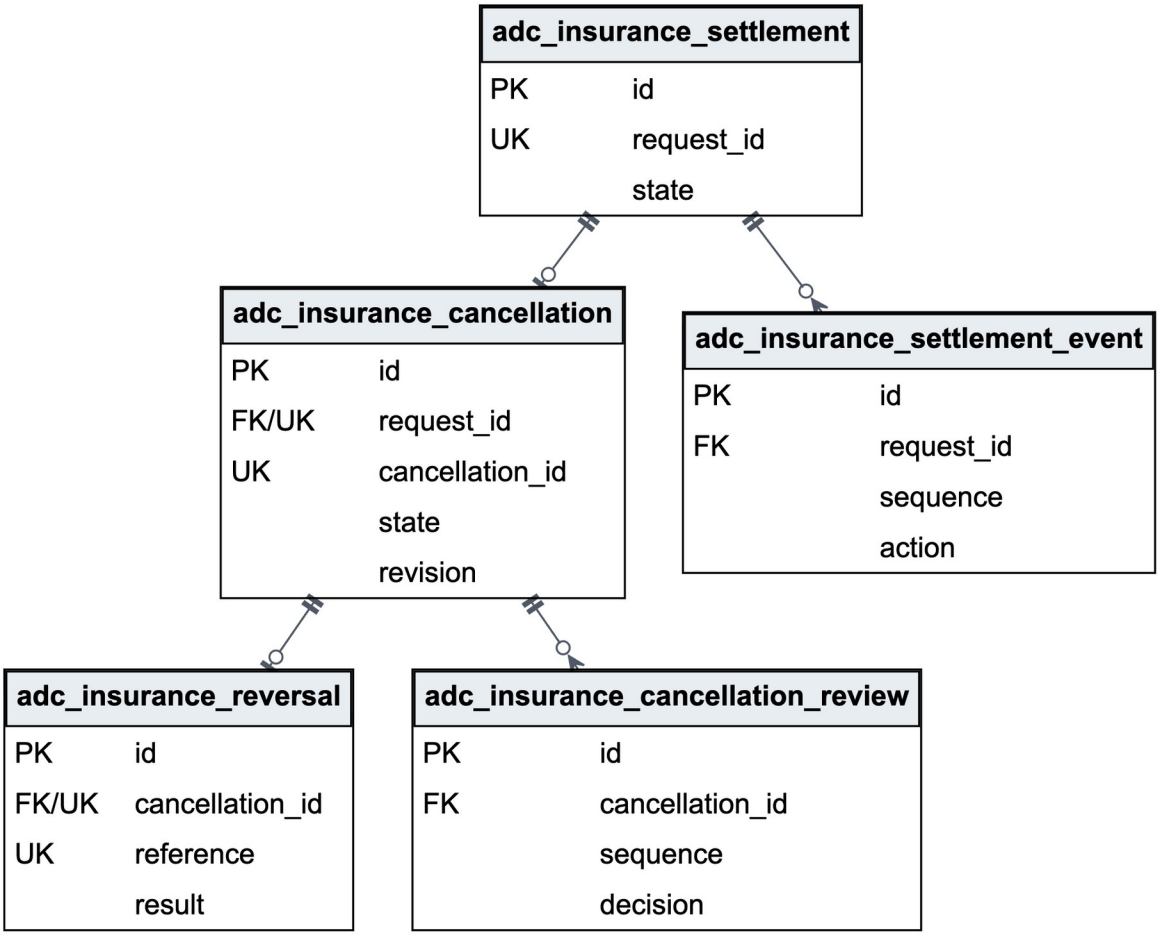

图 4-40 原结算撤销、原结果查询与独立退回核对数据库 ER 图

每笔原结算至多一个保留的撤销请求，撤销结果一对一引用；未知和处理中继续查询同一编号。复核可追加未通过决定，但至多一次通过；实际通过须已核对原撤销结果、基金净到账归零且没有待审分配或患者现金。撤销中的原已通过分担保持，原未通过分担不会产生抵扣。事件记录当时撤销状态；撤销不作废实际费用，不自动收退款。

4.13.27 网站扫码票据与微信独立确认

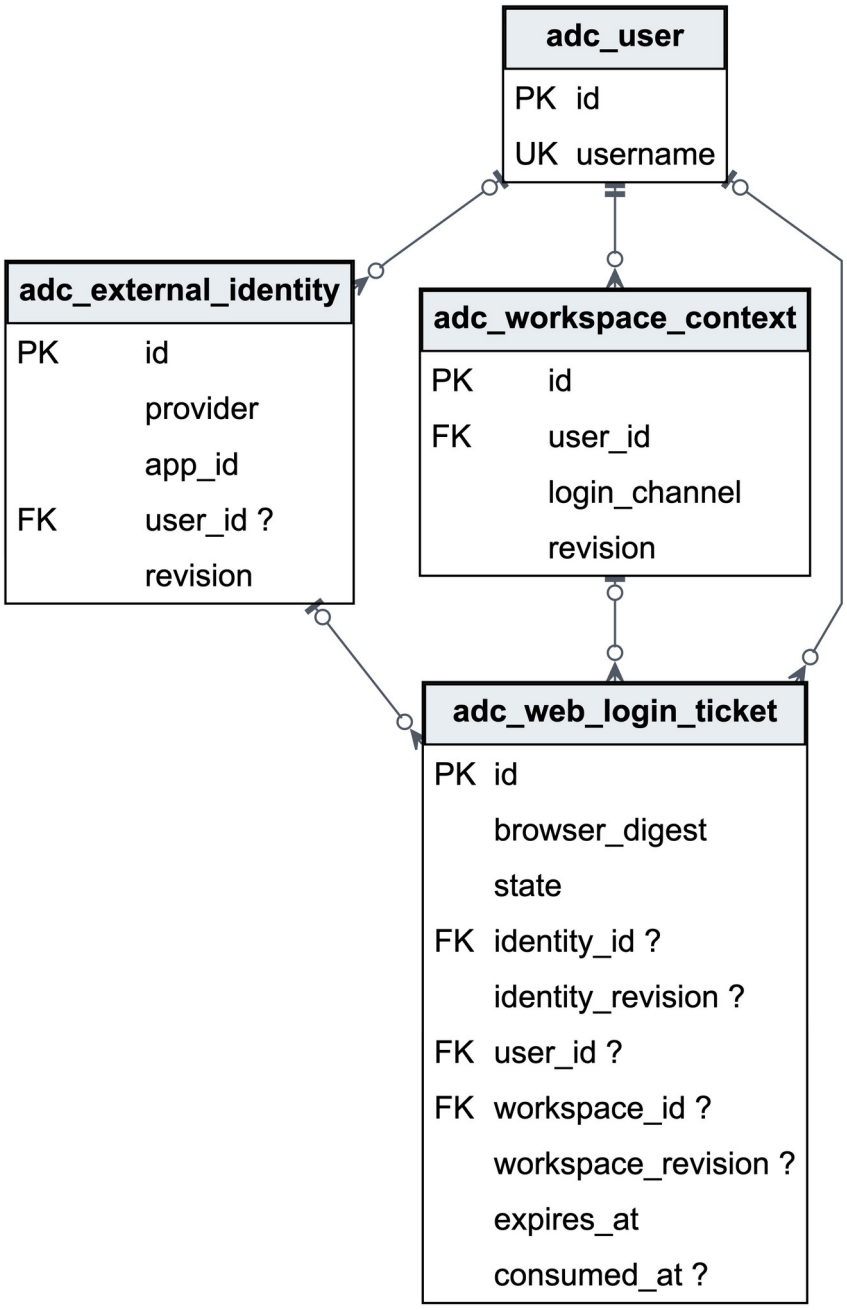

图 4-41 网站扫码票据数据库 ER 图

票据使用随机 UUID，二维码仅携带公开票据编号；browser_digest 是原浏览器私有凭据摘要，不是用户外键。待确认票据的账号、微信身份及会话引用均可空。手机明确确认时，新换取微信 code 且核对已绑定身份，再保留三条实际外键和身份、会话版本。浏览器消费时重核归属、版本、账号状态及期限；票据至多消费一次，解绑及恢复不复活旧授权。

4.13.28 统一医师身份、门店任职与专业授权

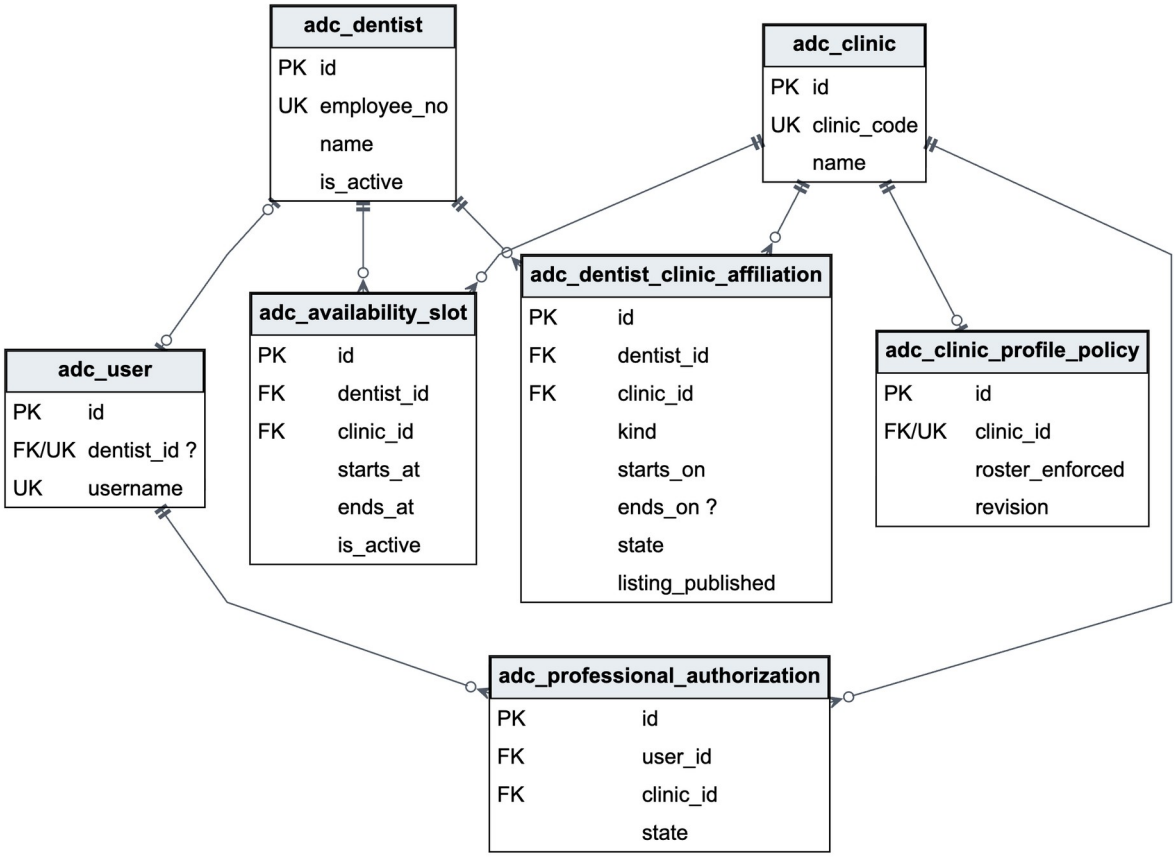

图 4-42 统一医师身份、门店任职与专业授权数据库 ER 图

统一医师可有多个接诊门店，每对医师与门店唯一；常驻与轮诊不复制身份。任职有效期、独立专业授权及前台出诊为不同合同，任职不自动授予诊疗权限。门店任职控制须先核对原出诊和承诺再明确启用；退出阻止新增排班与预约，保留原约并交前台协调，单纯撤回介绍不结束任职。

4.13.29 公开画像、不可变提交版本与门店采用

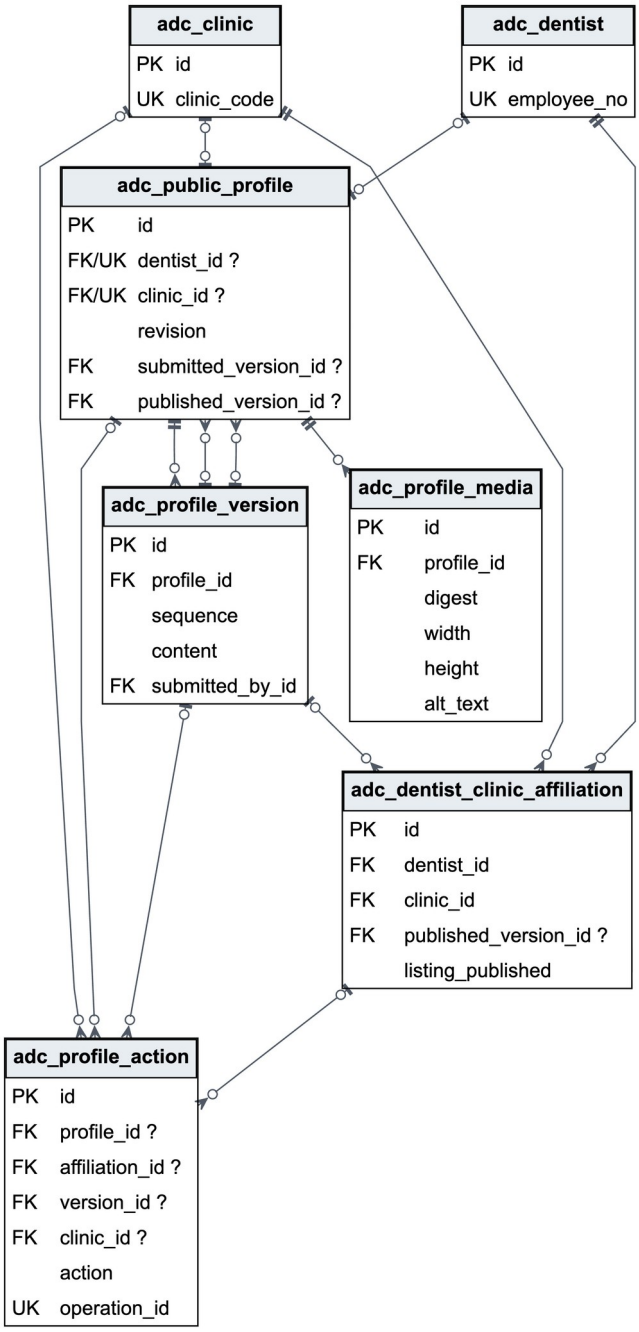

图 4-43 公开画像、不可变提交版本与门店采用数据库 ER 图

画像恰好属于一个医师或门店，各自唯一。草稿可编辑，提交版本与发布决定追加保留；门店采用医师的确切版本，其他门店不被自动替换。图片规范化字节保存在数据库，版本 JSON 中的图片编号是应用校验的逻辑引用，并非额外 SQL 外键；仅当前发布所引用的图片公开。职称来源留在内部，不把课程资料当作真实资格。

4.13.30 任职与选诊意向进入统一预约资源

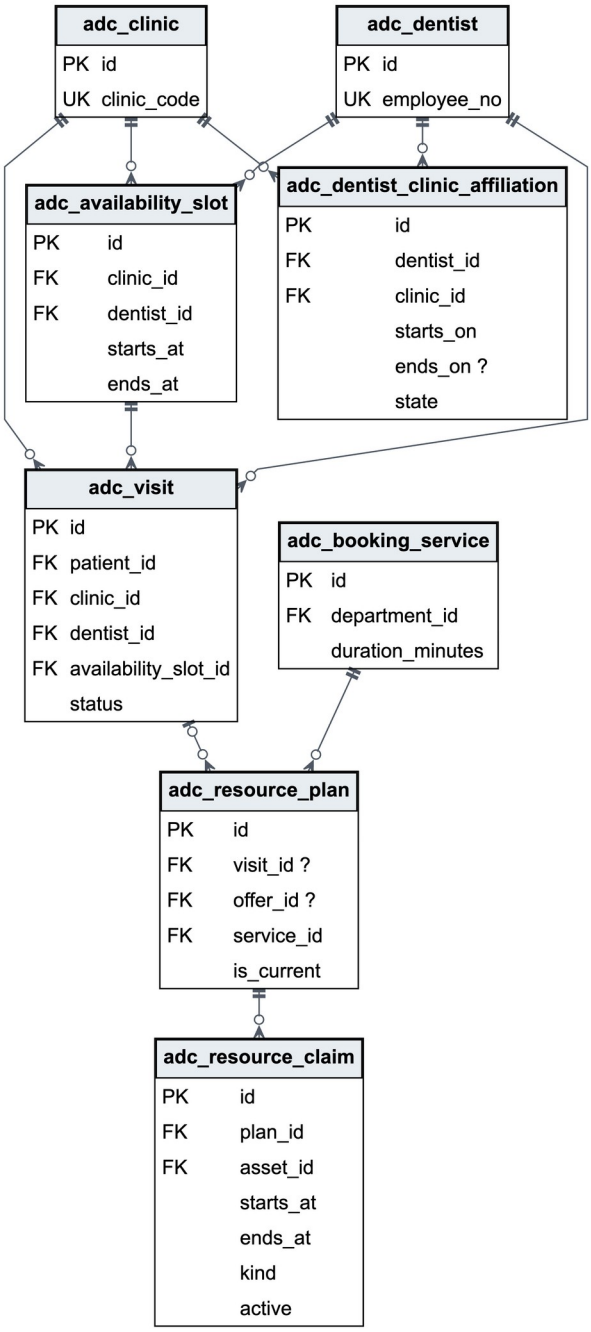

图 4-44 任职与选诊意向进入统一预约资源数据库 ER 图

公开医师选择只是可恢复意向，不授予患者权限。登录并选择本人或授权就诊人后，所有成约入口重核服务、专业范围、任职、出诊与物理资源。资源计划保留服务时长与原方案；任职结束、原约改期和资源历史分别保留。排程排斥约束及事务锁维持有效占用互斥；完整科室、设备与候补关联见既有资源视图。

4.13.31 月度成本、独立复核、工时分摊与留存月报

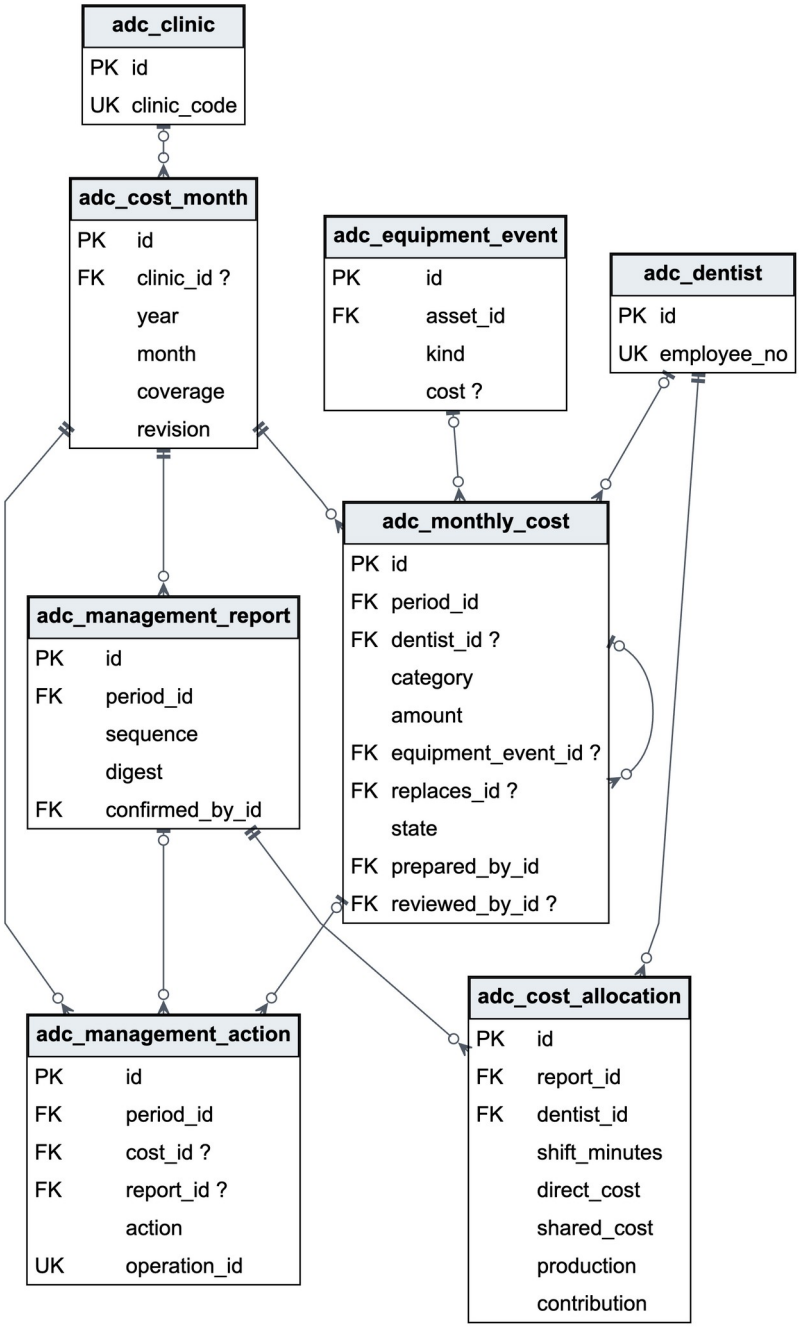

图 4-45 月度成本、独立复核、工时分摊与留存月报数据库 ER 图

门店月份唯一，总部月份使用独立空门店成本中心。主管提交，财务独立复核；来源及原金额不可覆写，修订引用上一笔。已确认公共成本按当月有效已发布工时分摊，稳定医师编号分配分币尾差，无工时保留门店未分摊。类别缺失不同于明确零费用。月报保存账单版本、工时、成本、来源修订及覆盖依据的 JSON 快照；这些快照编号是逻辑来源引用，不虚构月报到账单或出诊的 SQL 外键。登记成本不产生现金，旧季度台账不自动导入。

4.14 前台排班的职责与数据设计

日常排班由前台负责，包括医师出诊登记、未来空闲时段调整、停诊、暂停及恢复新增接收、候补建议核对与邀约发布。前台按当前店及已确认的医师工作安排办理，不因排班职责取得治疗、资产验收或资金审核权限。

主管维护科室、服务及设备等供给目录，并对需要独立复核的例外结果负责；正常日常排班无需主管逐条代办。已有预约或有效邀约时先由前台联系协调，未取得同意保留原承诺。

日周排班复用医师出诊、预约、邀约及资源占用事实，按本店、日期与医师筛选；有效邀约计入暂占，到期邀约显示待回收，接受后只计算正式预约。服务组合核对科室开放、完整时长及椅位设备；实际在诊超时另行提示，不将计划结束视为椅位已释放。

调班协调由前台核对依据、暂停新增并发起，明确受理人及下次跟进期限。联系未果保留原约，改变时间或医师须取得患者同意并另走原流程；无阻断后提交另一账号主管复核。复核通过后仍由前台明确维护出诊，任务结束不自动停诊或恢复接收。

数据库追加协调期限和按店、开始时间及邀约状态查询的索引。跨表约束检查设备绑定与停用对象同店、服务与诊室同科室、预约及邀约来源一致、资源占用与原承诺完整区间一致；旧记录不补造期限，历史时间和资金事实不改写。

表 4-3 排班与资源的岗位分工

职责	目标办理岗位	业务边界
日常出诊与候补排班	本店前台	核对工作安排、供给与承诺；明确确认，不自动代患者接受。
资源目录和供给规则	本店主管	维护科室、服务、医师适配及设备；修改不重写历史。
例外结果独立复核	另一获授权主管	保留原有独立复核；不成为每次日常排班的新增审批。

4.15 实际操作人与就诊人的分离设计

患者关系、预约授权与核验历史由患者入口模块负责。原本人绑定保留，每项关系属于患者及核验诊所；经核验的关系至多关联一项预约授权。决定事件追加保存操作人、依据和授权快照，数据库禁止更新或删除既有事件。

工作上下文保存当前所选授权和版本；本人入口不引用代约授权。预约回执必须且只能引用本人绑定或代约授权之一，保留实际办理来源。签名确认绑定操作账号、当前患者、授权版本、上下文和操作编号，确认时重新核验，不信任客户端传入患者编号。

不同合法操作者为同一患者办理时，共用原有出诊、患者、医师和物理资源锁及事务。暂停后重新核验产生新授权版本，旧预览不能恢复效力。关系记录、授权变更和患者切换均不产生治疗、账单或资金事实；代约投影不展示既有临床文字和结算单。

4.16 专业权限与限定披露设计

专业模块保存机构审核职责、专业授权申请、决定事件、诊所启用事实、转诊单、转诊事件和敏感查阅事件。每项申请绑定具体账号、诊所和预约服务；空服务只适用于无服务的旧记录，不代表所有服务。操作有效期必须处于资质证据有效期内，更新资质应另建申请，不覆盖原证据。

跨店转诊保存原患者、原就诊及可选的已发布记录版本，不创建重复患者或第二套预约库存。身份核对、临床披露同意和医师接收为不同业务事实；接收范围不扩展普通患者搜索。披露仅包含原版本的诊疗文字、该次过敏复核和治疗事实，不包含账单地址或资金金额。

专业范围变更与诊疗写入按固定账号顺序串行核验，再检查上下文、当前职责及业务版本。数据库保留源证据、决定和查阅历史；查阅事件只保存操作人、角色、类型化对象、用途、结果、追踪编号和时间。运行日志不记录临床文字、联系信息或凭据。角色失效后的患者清单也重新限定过敏资料访问。

转诊可明确选择既有发布记录或结构化检查确认版本之一，不接受未确认草稿。后续检查更正不改变已经选定的披露版本；接收医师仍须经过身份核对、本人同意及指定接收，普通跨店搜索权限不扩大。

4.17 检查记录的版本与状态设计

检查模块拥有患者自述版本、实际检查头、工作草稿、确认版本、牙位观察和操作事件六张关系表。每次实际到诊至多一个检查头，患者与诊所从原就诊推导；每个检查头至多一个草稿。本人自述与各店面谈分别按来源追加，避免通过版号或列表泄露其他诊所的面谈内容。

确认版本按检查头及版号唯一，引用具体自述与可见来源游标，保存观察发生时间、记录时间、作者和核对结论。牙位观察属于某一确认版本；数据库禁止改写确认内容、观察和既有事件。更正以工作草稿引用原确认版本，明确放弃草稿不删除原版本。

患者切换、专业范围失效、双页冲突及预览后新增自述均在确认时重检。新检查草稿未确认或有新自述待核对时，阻止直接结束接诊，并给出返回检查入口。旧诊疗和结算版本保留原含义，结构化检查与实际治疗收费分别核对；合格电子签名、归档和文书复制不是保存状态的别称。

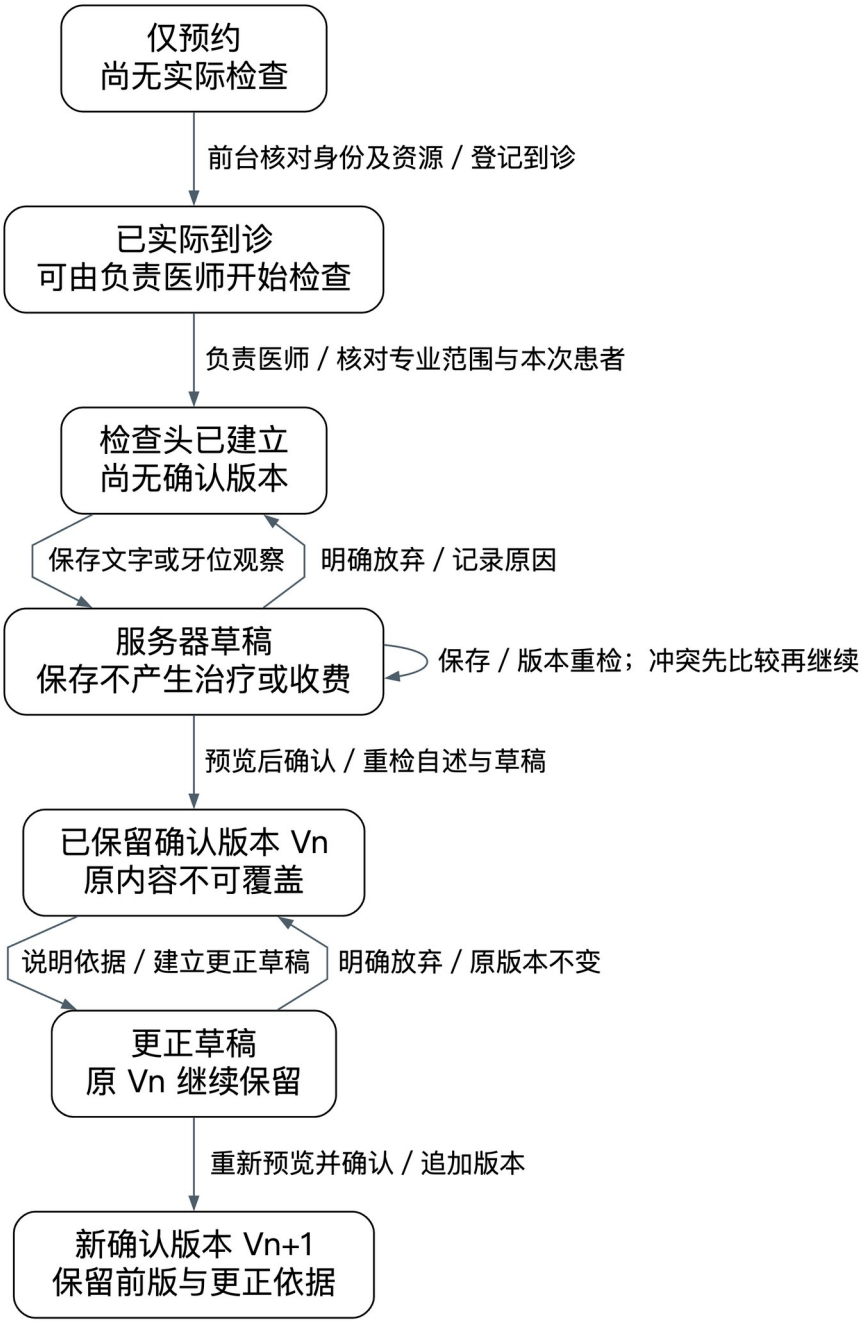

图 4-46 检查草稿与确认版本的业务状态

状态图描述可观察的业务阶段，不增加虚构的状态列。旧确认版本在更正草稿期间继续保留；确认及保存不等于合格电子签名或实际治疗。

4.18 方案、执行与唯一收费来源

临床模块拥有治疗计划、工作草稿、确认版本、稳定步骤、步骤版本、本人决定、实际执行、后续要求、预约关联和办理事件。确认版本引用具体检查依据，后续

修改另建版本；稳定步骤表达同一目标的沿革，不代表旧决定和旧加工验收自动适用于新版。

治疗说明按稳定步骤编号保存在工作草稿，并随确认方案冻结为 JSON 快照，保留准备医师、时间及范围摘要。步骤、方案摘要、检查来源或目录定义变化后，须重新复核说明才能发布。未完成文字不对患者公开，历史缺失不补造；预约代约关系不增加临床阅读权。

实际执行引用本次确认检查，可以引用当前已认可的具体步骤，也可明确登记计划外依据。一个实际执行至多拥有一个原始收费行，并保留原开单快照；账单更正产生的审核版本副本不会制造第二次实际执行。完成时计费的已约定步骤，其中间阶段可以明确不另收费，但仍为已治疗，不能记成无治疗。

尚未发布的误录可以填写依据明确撤回，原执行及快照继续保留。已发布实际来源不能通过此入口作废，原账单与资金历史继续由各自更正和独立审核流程负责。临床签署、知情同意及受控归档另有专业合同，不把讨论决定称为合格签名。

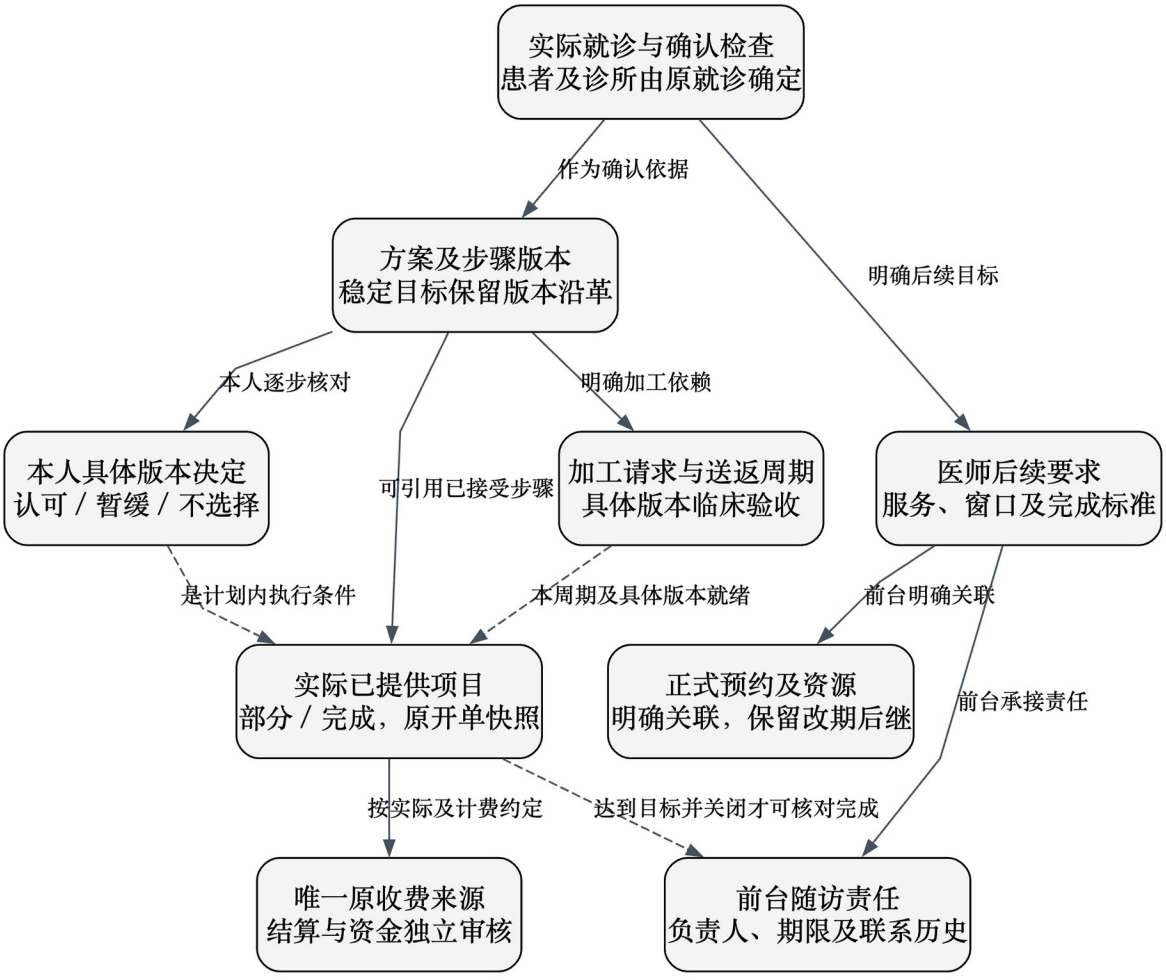

图 4-47 连续诊疗与后续责任的领域关系

4.19 随访完成与加工就绪状态

一条医师后续要求至多一份随访责任，状态为继续协调、本人暂不继续转医师核对、已核对实际完成、原指示已撤回。责任、期限及联系变化追加历史。完成只选择明确关联预约及其唯一改期链上，同患者同店同服务且已经关闭的实际就诊；确认检查或指定步骤完成依据二选一。晚于原窗口照实记录，不改原建议日期。

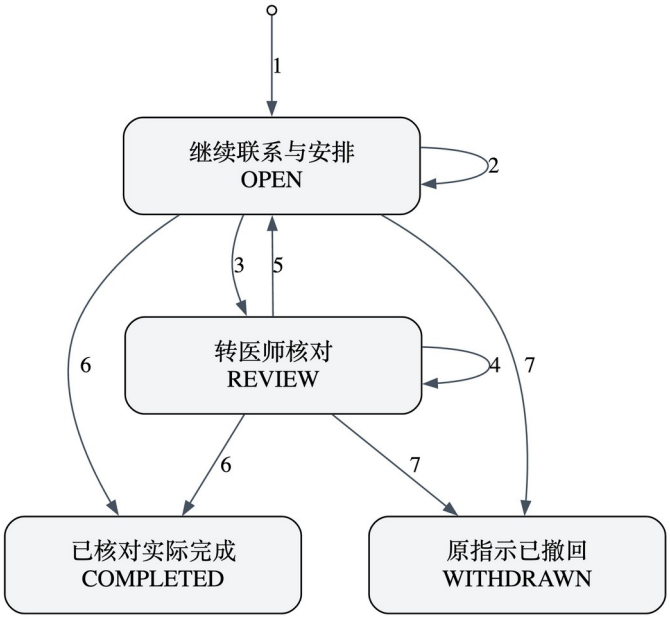

图 4-48 复诊责任状态与实际完成依据

1 前台明确认领责任和下次内部期限。
2 记录联系、未回复、内部协调或责任接续，历史追加。
3 本人暂不继续，转医师核对；不自动再次联系。
4 内部协调并保留责任及期限。
5 有明确依据后恢复协调。
6 关联后续就诊已关闭，患者、诊所及服务相符，达到原完成标准。
7 医师已撤回原指示，前台明确核对；不记成实际完成。

候选查询、送返登记、临床验收与实际执行分别由各模块拥有。重新确认时核对当前主体、岗位、诊所、服务范围、版本及依赖；同一提交返回原成功结果。设备故障仍调用原资源替换和改期合同，既有预约与原始关联均保留，不以准备状态静默改变临床或资金事实。

加工请求保留原检查及具体步骤，状态为待安排、已送出、已返回、已验收、需返工和明确撤回。验收绑定物理周期和确切目标步骤，实际验收时间不晚于记录时间；实际执行不能早于所依据的验收。行政责任交接不会使未改变的临床验收失效。

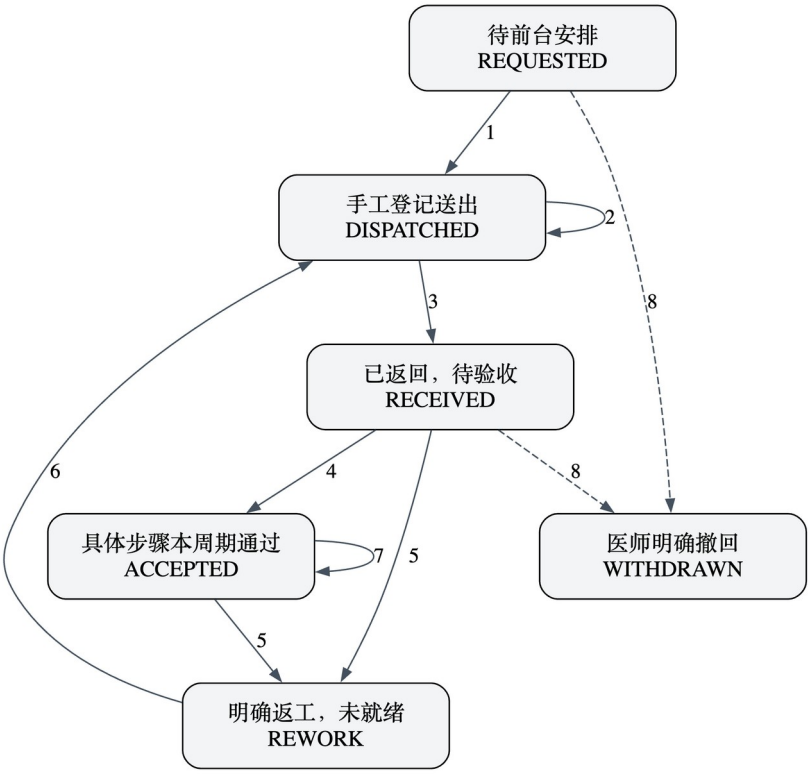

图 4-49 加工送返周期与临床验收状态

1 前台认领责任，记录实际送出；开始新物理周期。
2 获悉延误，记录内部跟进；原需要日期和预约保留。
3 前台记录本周期实际返回，不代表临床适配。
4 医师验收当前确切步骤，记录实际时间及结论。
5 医师明确返工，并单列前台需协调的事项。
6 重新送出、返回，进入下一物理周期后重新验收。
7 新版复用须重新核对具体步骤，旧验收不自动继承。
8 各非撤回阶段均可由医师明确撤回，保留原请求。

4.20 门店资料版本与患者入口

门店业务身份与对外资料通过唯一外键关联。当前资料保存展示名称、行政区、地址入口、公开电话、发布状态和坐标来源；每次明确确认追加具体版本与操作者，版本不可普通更新或删除。营业时间从原科室开放及有效停用区间计算，避免两套营业表相互矛盾。

距离计算使用同一 WGS84 坐标系，导航单独使用核对后的 GCJ02 坐标。未知坐标保持空值，不能作为零点；用户位置只在客户端参与排序。合成门店明确标识，拨号和地图操作在外部调用前拦截，不能把虚构号码及地址当成真实服务机构。

登录通道是服务器工作上下文中的受约束属性，不是另一套岗位授权。患者通道只激活有效患者身份，员工通道只激活有效员工岗位；具体患者或预约代办范围仍由原关系规则核验。服务延续绑定明确服务及短期提示，过期、撤回或撤权后重新选择，不自动替换服务或创建患者。

公开资料更新与资源目录共用锁并递增版本，旧预约预览不能在资料变化后直接确认。既有预约与有效邀约保留，新增资源方案保存当时公开联系快照；历史缺失快照不补造。实际搬迁及停诊影响交由前台明确协调，公开改名不静默移动原承诺。

4.21 账号身份与建档决定设计

账号模块拥有微信身份、手机凭证与追加事件。微信身份按提供方、应用和主体联合唯一，服务端以一次性 code 换取身份，不接受客户端自报 OpenID。短信由平台生成并核验验证码，ADC 保留挑战引用、用途、会话和期限；本系统只签发自己的账号会话。真实认证环境关闭本地身份替身和演示短信，旧记录仍保留来源。

门户拥有申请及决定。一个账号至多一件待核验或待补充申请，批准后才引用患者。事件保留操作者、依据和当时快照。审核人与申请人必须不同，核验职责及诊所由原岗位规则决定。

账号、患者授权及工作上下文分开。批准不自动激活；预约仍核对原本人或代约权限。恢复启用同一关联，旧业务预览不复活。服务器版本、事务锁及重复操作回执共同保证唯一结果，失败不留下部分档案或授权。

扫码票据有效期 180 秒，仅携带随机编号，另与原浏览器私有凭据绑定。手机确认重新取得微信 code，核对其属于当前账号的已绑定身份；仅密码或短信会话不能代

替微信证明。APPROVED 表示手机同意，CONSUMED 才表示原浏览器成功领取，查询本身不登录。

确认和消费均锁定票据并重新核对状态、身份版本、账号与会话。拒绝、过期、刷新、解绑、停用或恢复使旧票据无法领取；并发请求至多一次生效。服务选择、本人核验和患者切换仍由原有模块处理。

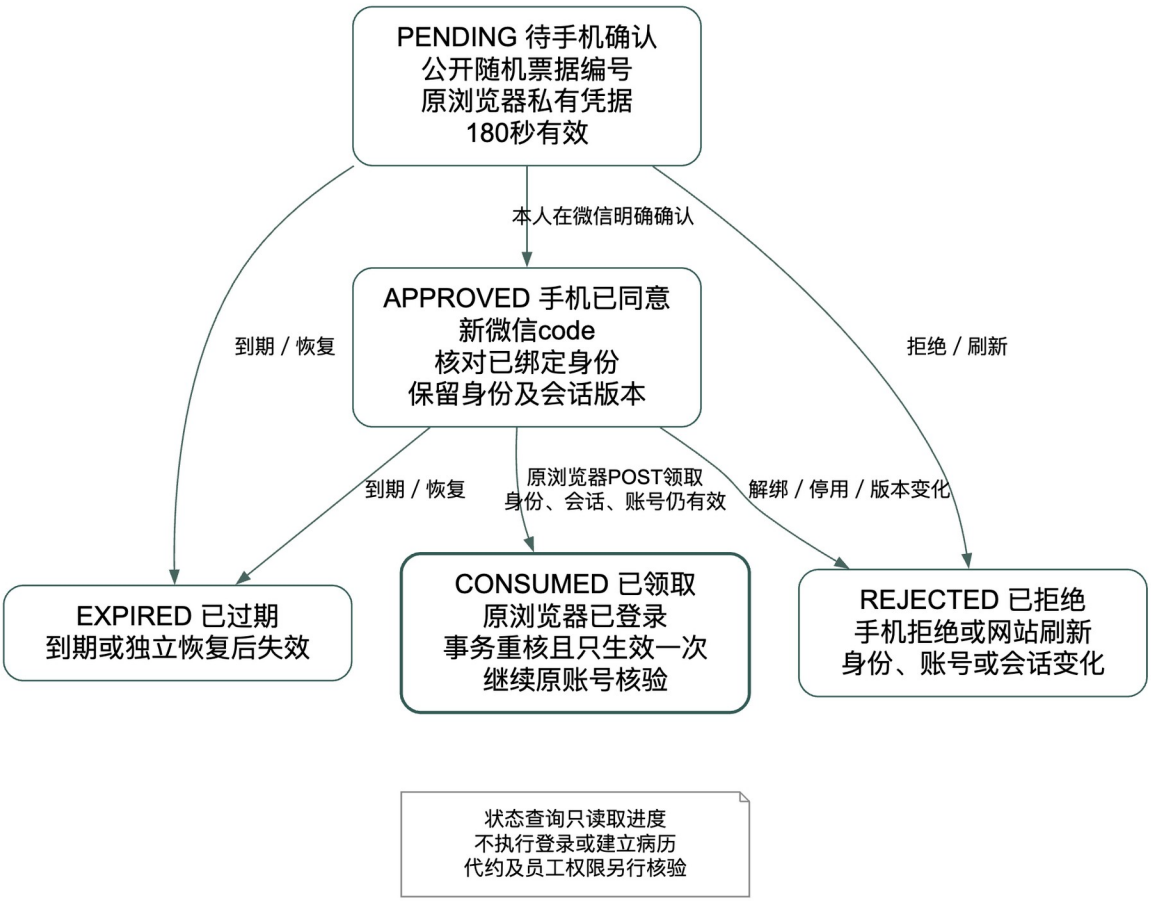

图 4-50 网站扫码登录的状态与责任

手机确认与浏览器领取是两个独立阶段。到期、刷新或权限变化均须重新核对；恢复时未完成票据失效，既有账号和病历保留。

4.22 医保资料的版本与独立核对

地区目录保留原件、规范记录及各自摘要，版本内编码唯一。湖南原表 232 行中有 202 个不同编码、30 行完全重复；一行支付分类与先自付未知，两条单位缺失，均保留原状。编码包括变体，不等于基础治疗数量。

门店安排引用已核对目录和有效期，同店已启用区间不得重叠。收费适配保留两端名称、单位及换算数量；单位变化须重新核对，不改写历史治疗及价格。准备、确

认、未通过和停用分别记录；同来源重新提交关联前次决定，由另一财务账号核对，旧安排不自动恢复。

待遇按患者、诊所及版号唯一，前版必须属于同一患者与诊所；事件只追加且恰好引用一种准备来源。JSON 快照不画成外键。确认时重检岗位、诊所、来源及版本，重复操作返回原结果。

4.23 结算责任与资金清算模型

结算请求引用原账单确切版本及实际收费行，原模拟结果与独立分担复核分别关联同一请求。同一账单至多一项未终结请求；通过的分担参与患者余额计算，原收入、实际现金和基金应收分别保留。

同一流水在现金匹配与基金凭据之间排他使用。已核对基金凭据可以分批分配多笔申报；已通过与待核对分配共同占用额度，不超过银行到账及申报有效应收。退回须有原确认到账，无来源平衡分录不入账。

差额事项引用原申报，未知金额为空；责任、期限、处理和状态追加留痕。结束事项不改变金额，原负责人失效可明确交接。账内日结、渠道对账、基金清算独立，次日到账不改原业务日。

原结算的处理中、未知、待复核、已确认、未通过分别保留。撤销请求唯一关联原申报，保留原结果和复核历史；处理中维持原已通过分担，未通过分担不抵扣。原撤销结果明确、基金已退回且无待审资金事项后，另一财务账号才可确认终结。

4.24 画像版本、门店采用与任职退出

PublicProfile 恰好属于一个医师或门店，草稿可编辑；ProfileVersion 保存不可变提交版本，ProfileAction 追加办理决定。医师—门店任职各对唯一，并分别保存采用的版本、展示状态和有效期。主管只可处理当前门店；医师本人不能通过切换角色复核自己的介绍。统一医师身份和门店层级配置的区分也可见 Open Dental 的机构关联思路[27]。

头像与每店最多三张图片经服务端规范化，去除原始元信息，按摘要、尺寸、说明及字节保存于数据库。公开读取只允许当前已发布版本引用的图片。课程插画由项目自制，不挪用真实医师形象或虚构机构认证。

门店任职控制在原出诊、预约及有效邀约逐项核对后启用。结束任职保留原约及历史，前台在协调清单中处理；撤回介绍仅隐藏展示。病历、专业授权、门店介绍与任职不互相替代。

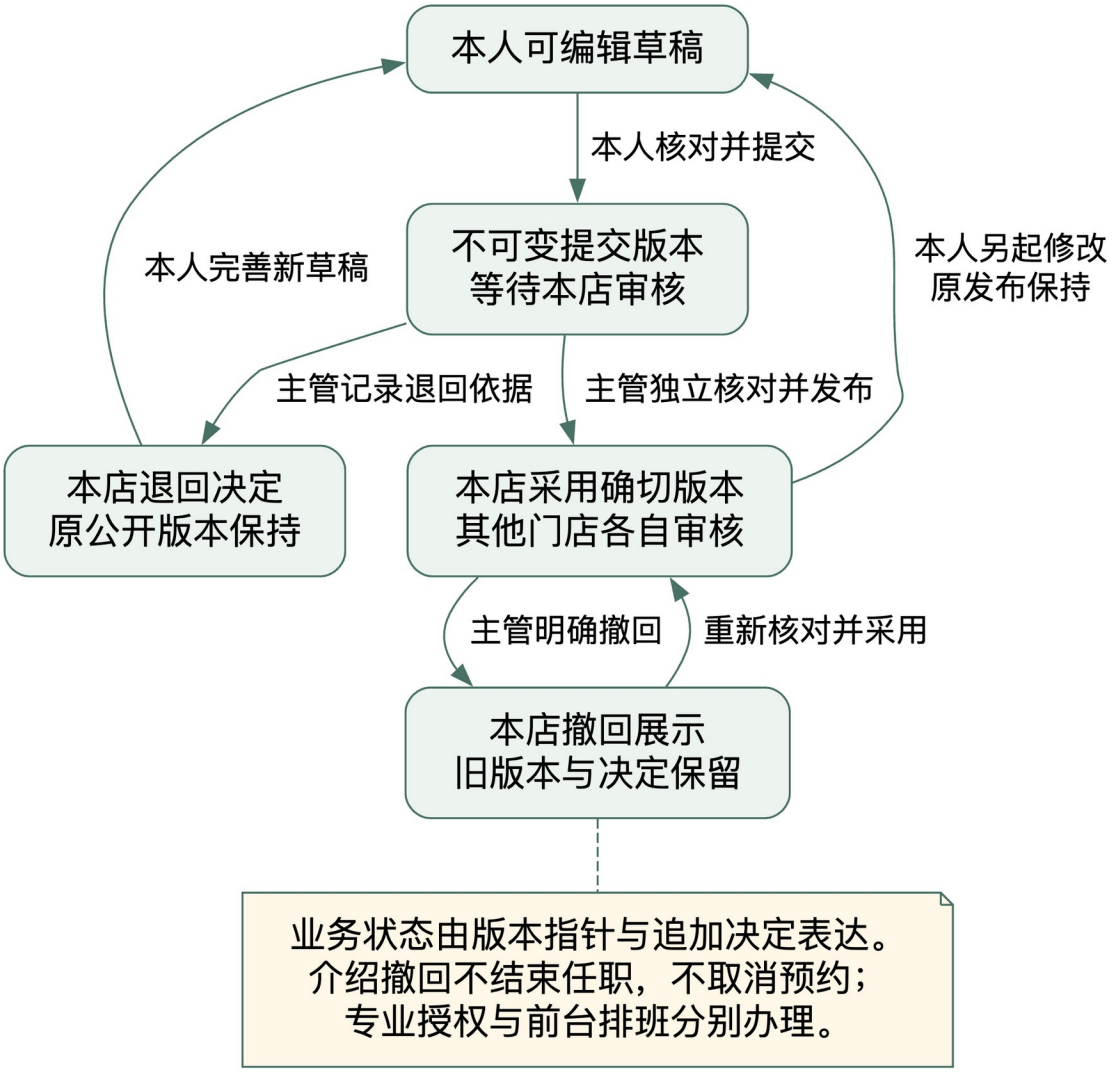

图 4-51 医师介绍与门店采用的状态

4.25 月度核算、分摊与报告版本

CostMonth 按门店和年月唯一，总部使用独立空门店成本中心。MonthlyCost 保存来源编号、期间、类别、金额、直接归属、原设备来源及修订链；提交后只允许独立复核改变状态，金额和依据不可覆写。同一来源引用的互斥与事务重检共同防止跨月重复。

核算在一致数据库快照中读取当前逻辑账单、已发布出诊、已确认成本与完整性依据。每类别显式确认完整或为零；新成本、设备来源金额变化会使原完整性或月报

预览失效。公共成本先按精确比例向下取分，再按医师编号分配剩余分；总分摊加未分摊严格等于公共成本。

ManagementReport 保存序号、摘要、来源快照、确认人及时间；CostAllocation 保留该版本每医师工时、产值、直接和公共成本。旧账单、成本和报表保留，新版本显示差异。JSON 中的来源编号为逻辑追踪，不伪画为数据库外键。净收款不等于账户余额，未核实期初时明确显示余额待核对；工资、税务和完整总账另行建设。

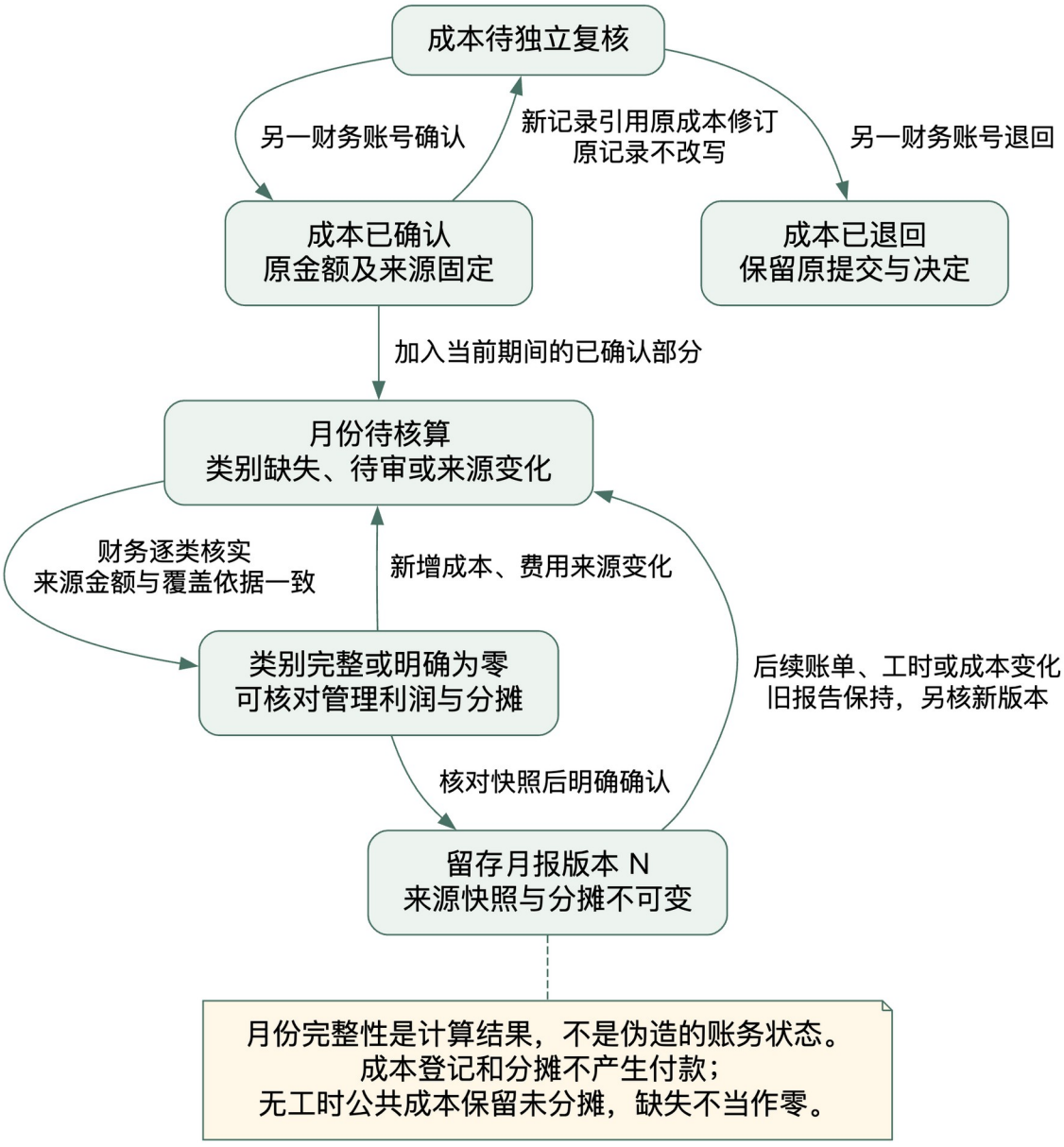

图 4-52 月度成本与留存月报的状态

4.26 两端选诊与查询边界

公开投影批量读取门店营业、服务、团队及近期出诊；图片与出诊明细按需加载。网站提供门店详情、医师目录和详情，小程序使用同一公开投影。门店可按城市、区域、服务与线上可约条件筛选；用户主动提供位置后按由近到远排列。

公开医师与服务意向通过短时、受账号及会话约束的继续标记恢复，不携带授权。预约、改期、候补接受继续使用原业务命令，重核患者关系、医师出诊、专业范围、任职及椅位设备。主管查看本店核算，医师只看本人贡献，前台查看排班履约，财务与总部按既有范围处理汇总。

本人结算单共用已发布账单、当前余额与财务只读投影。逐笔仅显示种类、金额、业务日期、记账时间和状态，按稳定顺序每页 20 笔；不返回员工备注或渠道凭据。历史收费版本与当前收退款分别标识；翻页重新核验本人权限。该投影复用 Invoice 与 CashEntry 关系，不新增持久实体。

4.27 多端共享投影与患者只读结算

门店轻量索引一次提供二十店必要资料与服务覆盖，未压缩 JSON 上限 100KiB。坐标只在客户端用于完整索引排序，再分批展示，不能先截取门店再声称最近。完整介绍、三张门店图片、团队与出诊在详情按需读取；旧接口保留兼容。共享筛选逻辑同时产生网站与小程序的数量、分类和替代门店。

门店、医师、服务及日期作为短时选诊意向贯通登录与就诊人选择，不携带业务权限。未选日期时使用所选组合最近的真实出诊日；改期先显示原约日期与历史服务，不受当前营销介绍撤回影响。配置变化清除旧候选并说明重新核对原因。正式写入沿用原患者、医师、出诊与物理资源事务合同。

本人结算查询复用诊疗发布版本和财务余额投影，只提供读取。历史版本保留原项目及金额；收退款余额明确属于当前账单版本且只汇总已记账资金。每次查询重新核对本人权限，代约人不能通过猜测编号读取临床或结算。该调整不增加数据库表，身份任职、公开画像、预约资源和经营核算 ER 关系继续与实际 PostgreSQL 结构逐项核对。

4.28 版本发布与异地恢复设计

应用版本与持久数据采用分离管理。发布记录将源版本、镜像摘要和迁移摘要关联，切换镜像时保留同一数据库卷、账号及私有配置。现阶段仅允许数据库迁移文件完全一致的版本直接回退；需要结构变更时另行设计兼容与迁移合同，不通过恢复旧数据库撤销已经发生的新业务。

版本切换先暂停外部写入并创建加密检查点，再启动候选版本核对 Web、通知、数据库及观察来源，验证通过后恢复网关。旧观察和未解决事件保留，不能用新进程的健康状态改写历史结论。正向墙上时间与单调时钟间断时，合法同来源的旧观察归档后从未知重新采样，需要两次正常样本才能恢复健康；不同来源或损坏记录不能采用该处理。

备份使用接收方公钥加密，服务主机不保存解密私钥。服务器保留七个日常副本，独立存储保留三十个日副本，完整上传并回读校验后才推进异地恢复点。失败保留此前已验证副本，不能用再次上传的时间替代原数据时点。恢复到独立空库后先比对完整事实与结构，再使未完成认证票据失效。

4.29 完整文书版本与责任待办设计

ClinicalDocument 与实际接诊一对一，记录责任账号、首次期限、后续更正期限及下次跟进。ClinicalDocumentDraft 保存可继续编辑内容及所基于的确认版本；ClinicalDocumentVersion 保留文书类别、准确检查和接诊版本外键、既往就诊文书、正文、来源快照、确认人和服务端时间。ClinicalDocumentEvent 追加保存办理决定与唯一操作编号。

文书冻结当时患者、医师和诊所的显示资料，以及检查、病史、方案和实际执行来源。金额不复制成另一套可写账本。确认版本的前版为一对一追加链，复诊来源为同患者同店另一实际就诊的可空多对一关系；来源 JSON 中的编号为逻辑追踪，不能冒充 SQL 外键。数据库触发器禁止改写或删除确认文书和事件。

草稿保存与确认分别办理。预览绑定服务器内容摘要、工作身份、来源游标与当前版本，确认事务重复核验专业范围、就诊人、临床状态和来源；网络重试不重复确认。并发保存时保留本页填写，比较最新内容后仍需明确提交。文书可在接诊中整理，接诊按原规则结束后才确认完整版本，文书不反向改写治疗或资金。

工作台按待完善、待确认、来源变化与超期组织。默认 24 小时是课程办理目标而非法定归档期限，机构可配置；更正单独计时，跟进不能消除原期限或迟记事实。历史和打印读取准确版本，不跟随当前目录重绘。当前实现区分医师账号确认、纸质原件引用、具体医疗决定及独立归档批准，可靠电子签名仍须独立验证；可打印页面不等同于获准交付的病案副本。

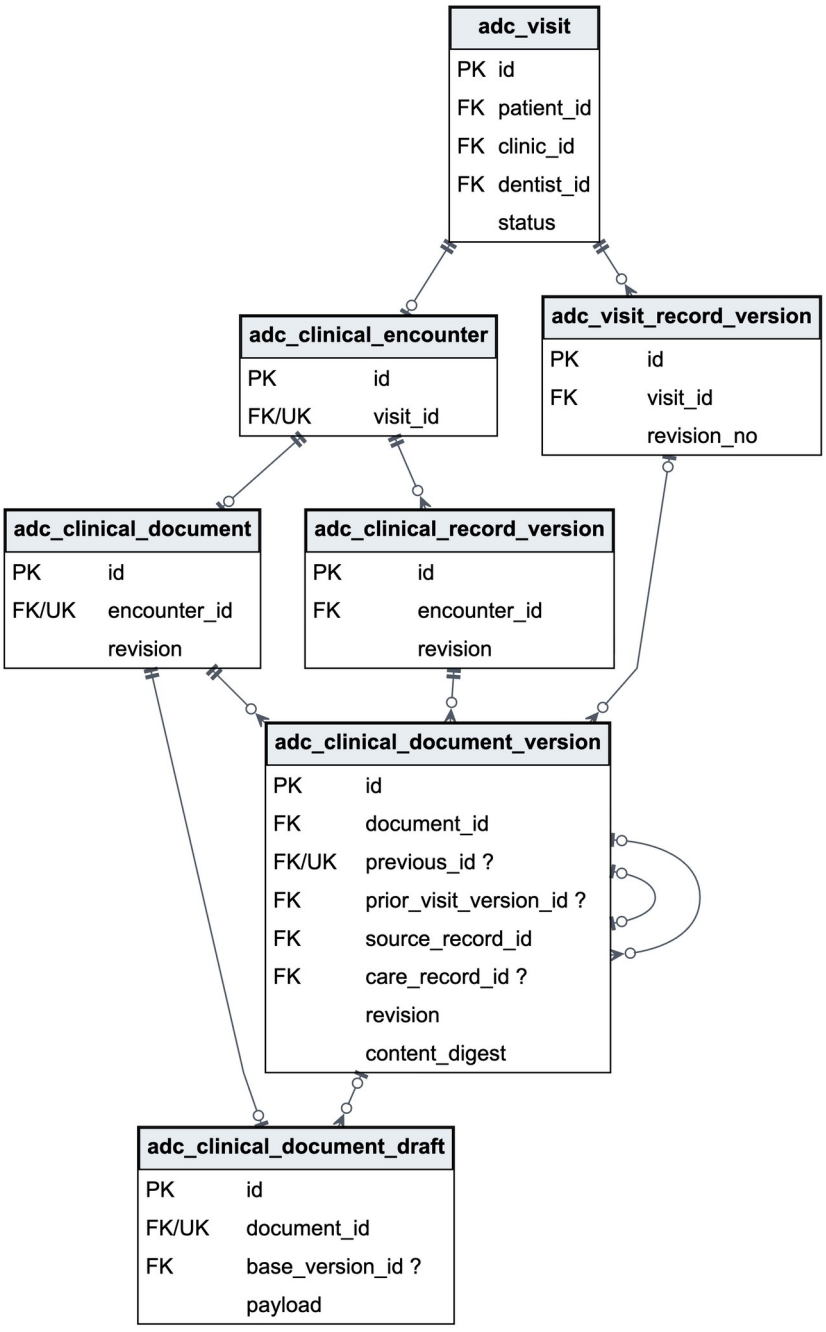

图 4-53 初复诊文书版本与准确来源数据库 ER 图

一次实际接诊至多一个完整文书入口；草稿与确认版本分开。确认版本引用准确检查与接诊处置，previous 为同文书的一对一追加链，prior_visit_version 为同患者同店另一就诊的可空多对一

复诊来源。正文及来源 JSON 冻结事实与当时身份，内容摘要不等于可靠电子签名。原金额由财务模块拥有；具体告知、医疗决定和固定归档分别见对应视图，不因文书确认而自动完成。

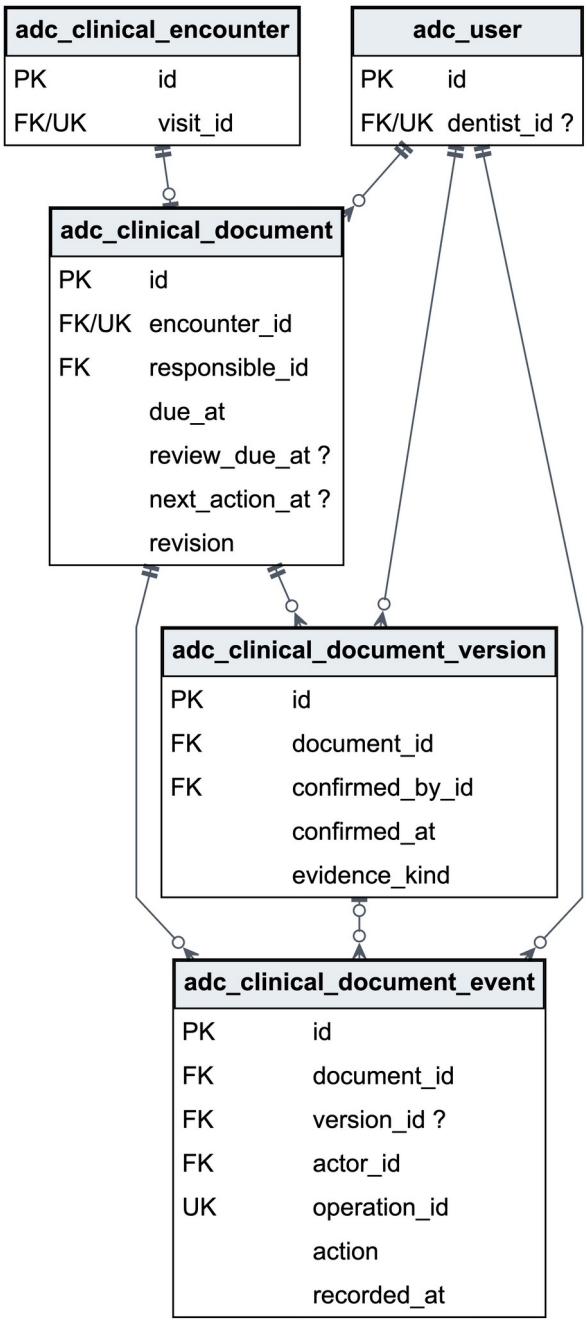

图 4-54 文书责任期限与办理凭据数据库 ER 图

新检查开始时形成责任文书待办，不补造旧签署。原办理期限保留，更正有自己的期限，下次跟进不消除超期事实；待签、来源变化和超期由当前事实推导，不是独立虚构 SQL 状态表。确认人与事件均为真实账号外键，事件操作号唯一。账号确认、纸质原件引用及可靠电子签名分开；既有专业范围仍须重检，责任归属不自动授予权限。

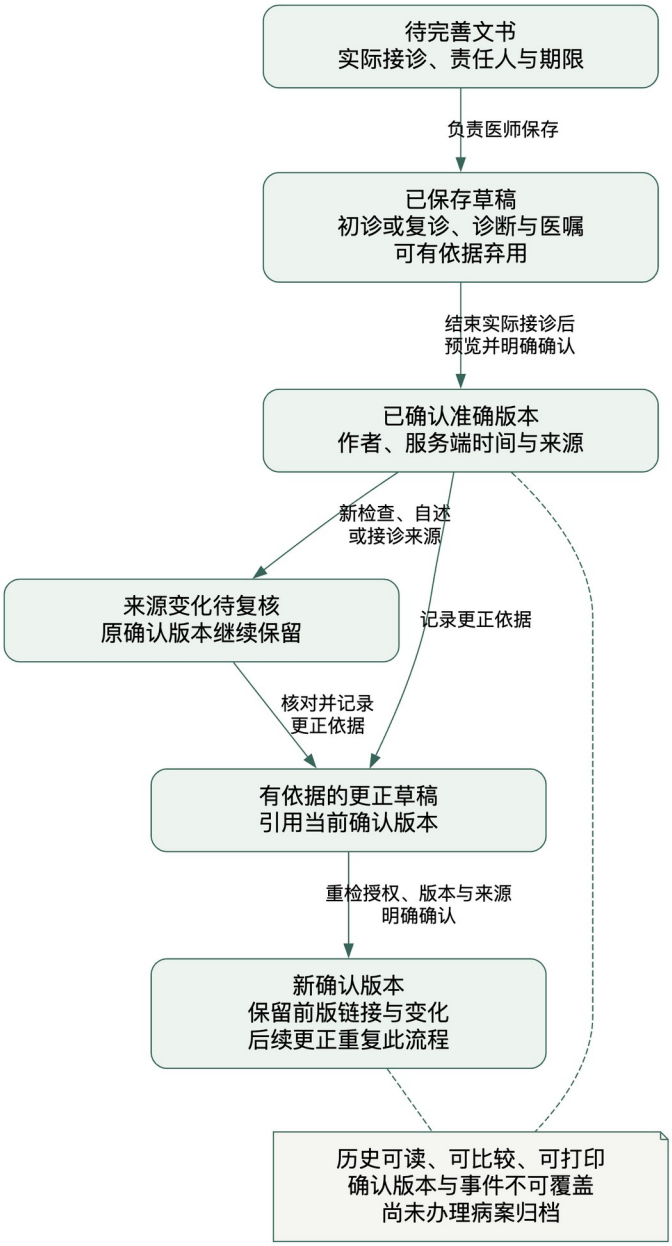

图 4-55 完整文书确认与追加更正状态

4.30 本人医疗决定的版本与沟通设计

MedicalConsent 为稳定治疗步骤的一对一办理入口，ConsentVersion 为不可改写的告知版本，ConsentEvent 保存追加式沟通和决定。版本引用准确 PlanStepVersion 和 ClinicalRecordVersion，保留医师、身份核对依据、患者快照和范围摘要；previous 指向本入口的上一版本。摘要用于核对内容一致性，不表示已实现可靠电子签名。

问答与决定事件保留来源、账号、实际时间和登记时间。ANSWER 仅答复同一入口的 QUESTION，单条疑问不被重复覆盖；换版不会消除未回答问题。SELF_ACCOUNT 引用本人 PatientAccess，PAPER_REFERENCE 由医师登记原件。预约授权表不成为医疗决定的签署依据。图中的待决定等状态由准确版本及事件推导，没有另造可任意编辑的状态表。

预览绑定工作身份、患者、方案与告知游标；确认按参与账号、既有患者和方案的顺序加锁并重检。重复操作返回原事件，旧预览不覆盖新沟通。肯定决定还核对当前检查、方案选择及告知医师专业范围；拒绝和撤回不因医师撤权而被阻挡。读取采用一致性快照，运行日志仅保留编号、动作和来源。

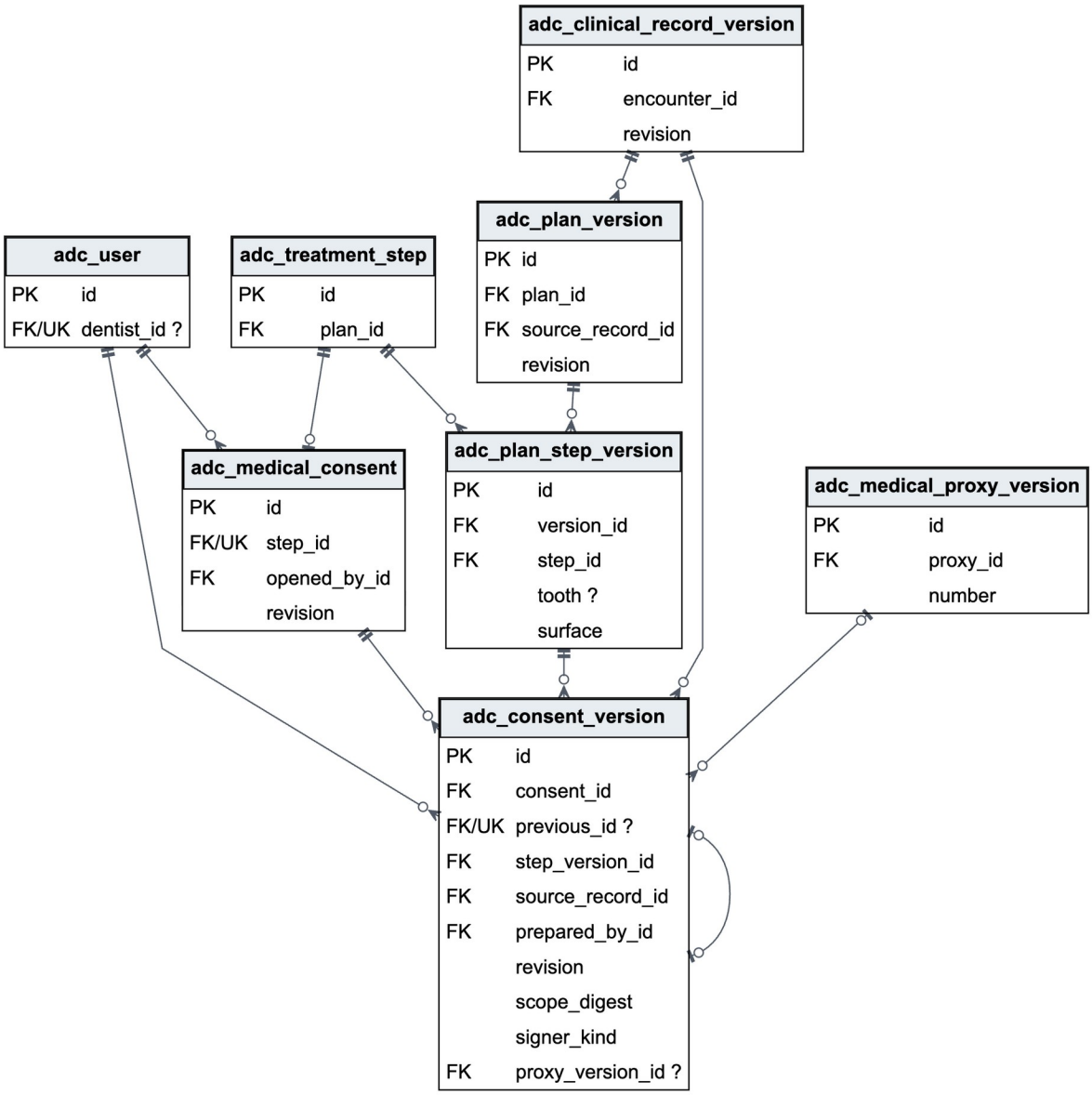

图 4-56 医疗告知与准确步骤版本

稳定步骤至多一个医疗告知入口；版本引用准确方案步骤和检查，previous 为同入口的一对一追加链。原方案 JSON 保留当时八项说明，新表保留身份核对依据、患者快照与范围摘要。方案选择、告知和医疗决定分别办理；图中只绘制实际 SQL 外键，不把 JSON 内的编号画成数据库约束。指定决定人分为本人和已核验医疗代理，代理告知引用准确代理版本；两者均保留原版本，不因身份切换转移决定。

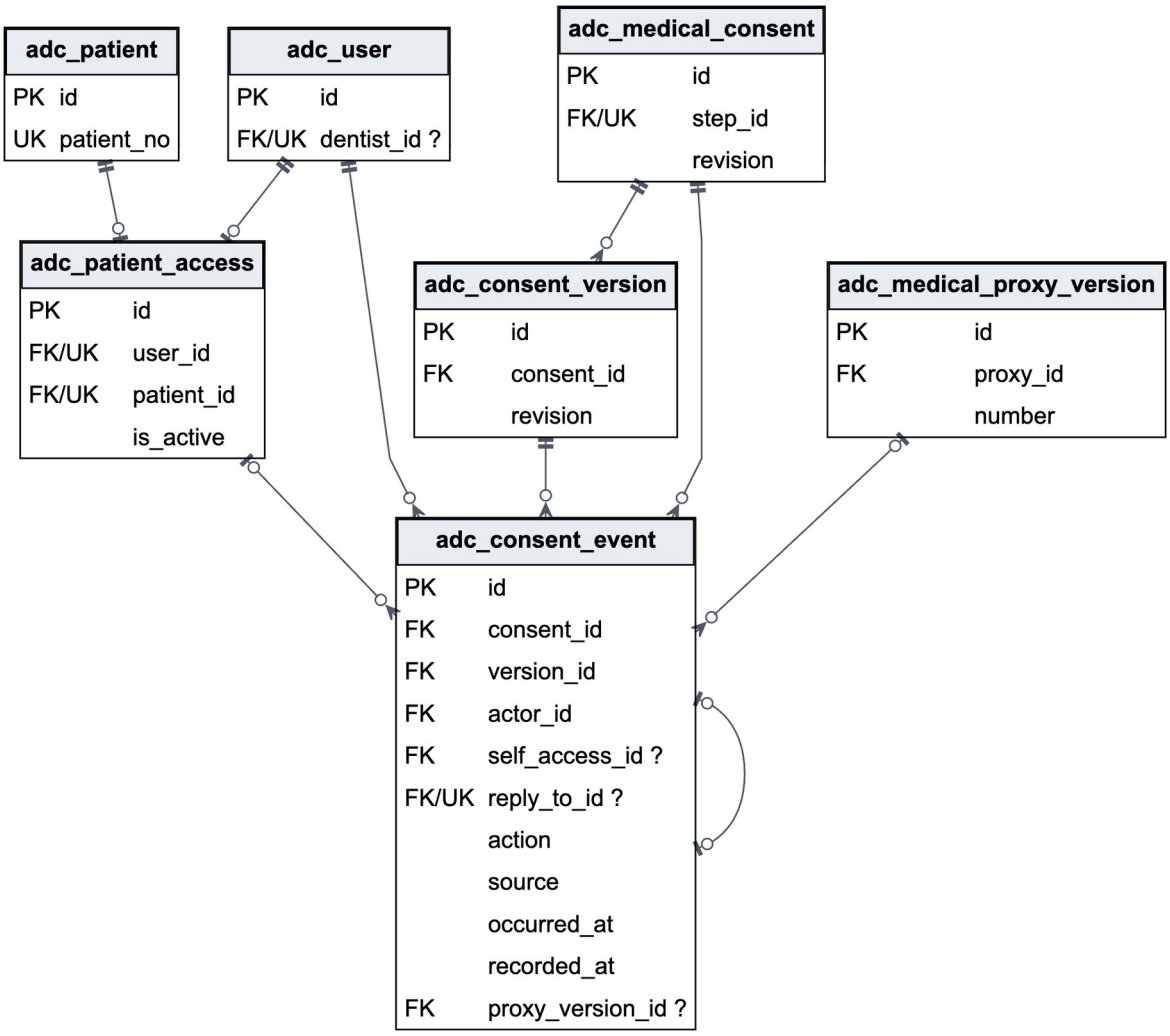

图 4-57 医疗问答与决定来源

每个事件只能属于一份准确告知；本人来源引用自己的 PatientAccess，纸质原件登记不冒充本人点击。reply_to 为可空一对一答复关系，同一问题不能被重复覆盖，触发器核对同入口问题。历史事件不可改写；撤回另记事件，未答复问题和新版本待决定由事件推导。预约代办授权不作为临床读取或医疗代签依据。 PROXY_ACCOUNT 保留独立医疗代理版本与实际提交账号，纸件仍由负责医师登记；任一来源均不证明已验收可靠电子签名。

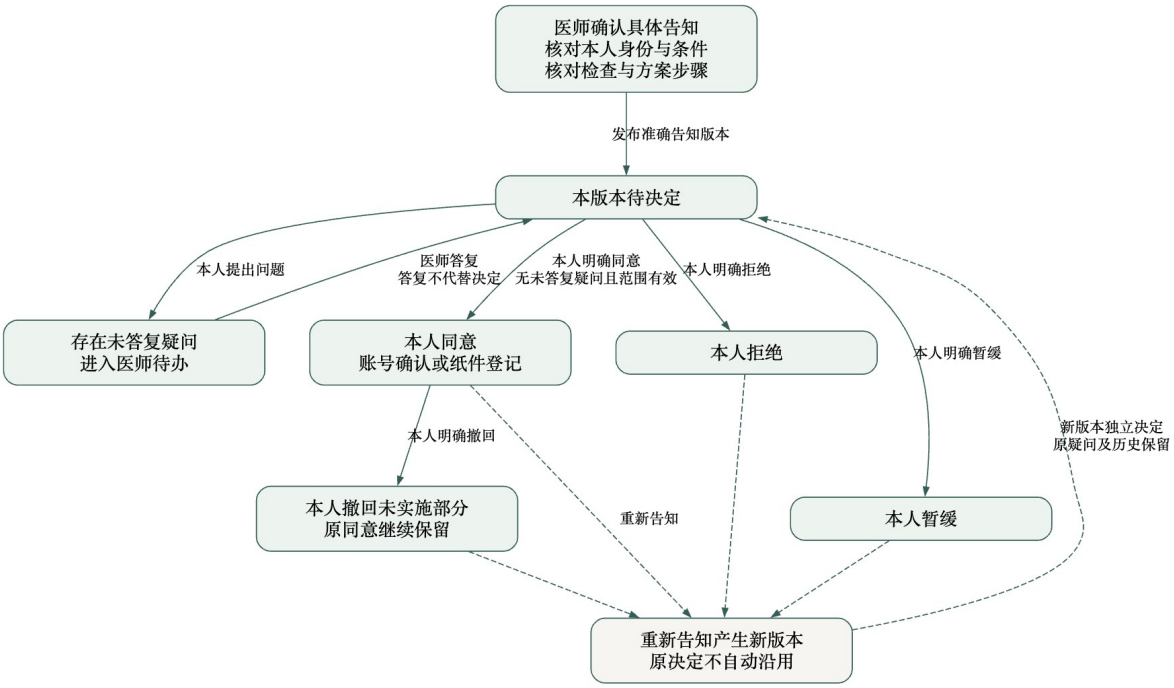

图 4-58 单份医疗告知的决定与换版状态

状态由告知版本和追加事件推导。拒绝、暂缓或撤回不删除原预约与已发生治疗；重新告知建立独立新版本。疑问可在决定前后继续提出，医师答复不代签；正常开治须按独立核对流程办理，实际执行引用准确依据。

4.31 医疗代理依据与限定访问设计

MedicalProxy 保存稳定的患者、诊所、代理账号和依据类型；MedicalProxyVersion 追加身份快照、代理姓名、原件编号、适用情形、计划及期限，MedicalProxyScope 关联本版本授权的稳定步骤，MedicalProxyEvent 保存办理责任及结果。修改资料先退回或暂停，再提交新版本，不覆盖原事实；同一步骤、重叠期限的多个有效代理进入核对流程。

工作区分别保存代约授权与医疗代理游标。仅获医疗授权时，患者渠道可以选择医疗事项，但预约、完整健康自述及结算接口仍调用原本人或代约规则。PlanDecision 新增真实代理来源和准确代理版本；ConsentVersion 指定本人或代理，ConsentEvent 保留实际提交人和依据。每次读取、预览及确认重新核对有效范围、患者身份与工作区，代理失效不改变历史作者。

事务按参与账号、既有患者和方案锁序办理，资料办理另锁独立代理记录。签名预览绑定版本和工作区，确认重新校验职责、有效期和旧预览；重复请求返回已保存结果。数据库保留材料版本、范围及事件，禁止覆盖或删除已提交依据。运行日志只记业务编号、动作和结果，不记录材料、问答或临床正文。

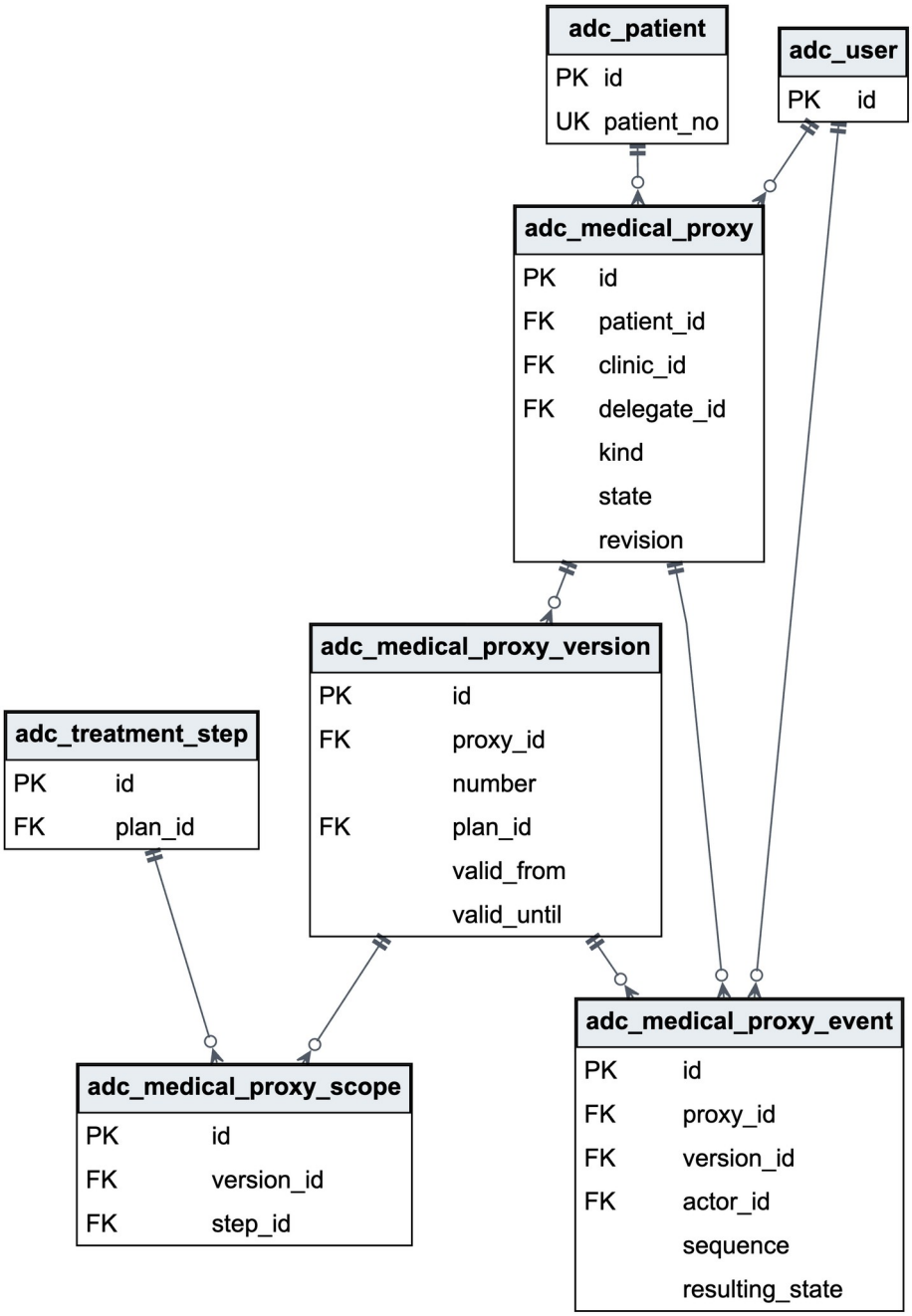

图 4-59 医疗代理材料版本与限定步骤

代理身份、诊所、依据类型保持不变；材料修订追加版本，范围指向稳定步骤。前台专项核验与医师适用性确认分开，疑难事项转另一审核医师。有效期和患者身份在读取与提交时重检，预约授权不能转换为医疗授权。图仅绘实际 SQL 外键，计划及临床审核关系详见全字段目录。

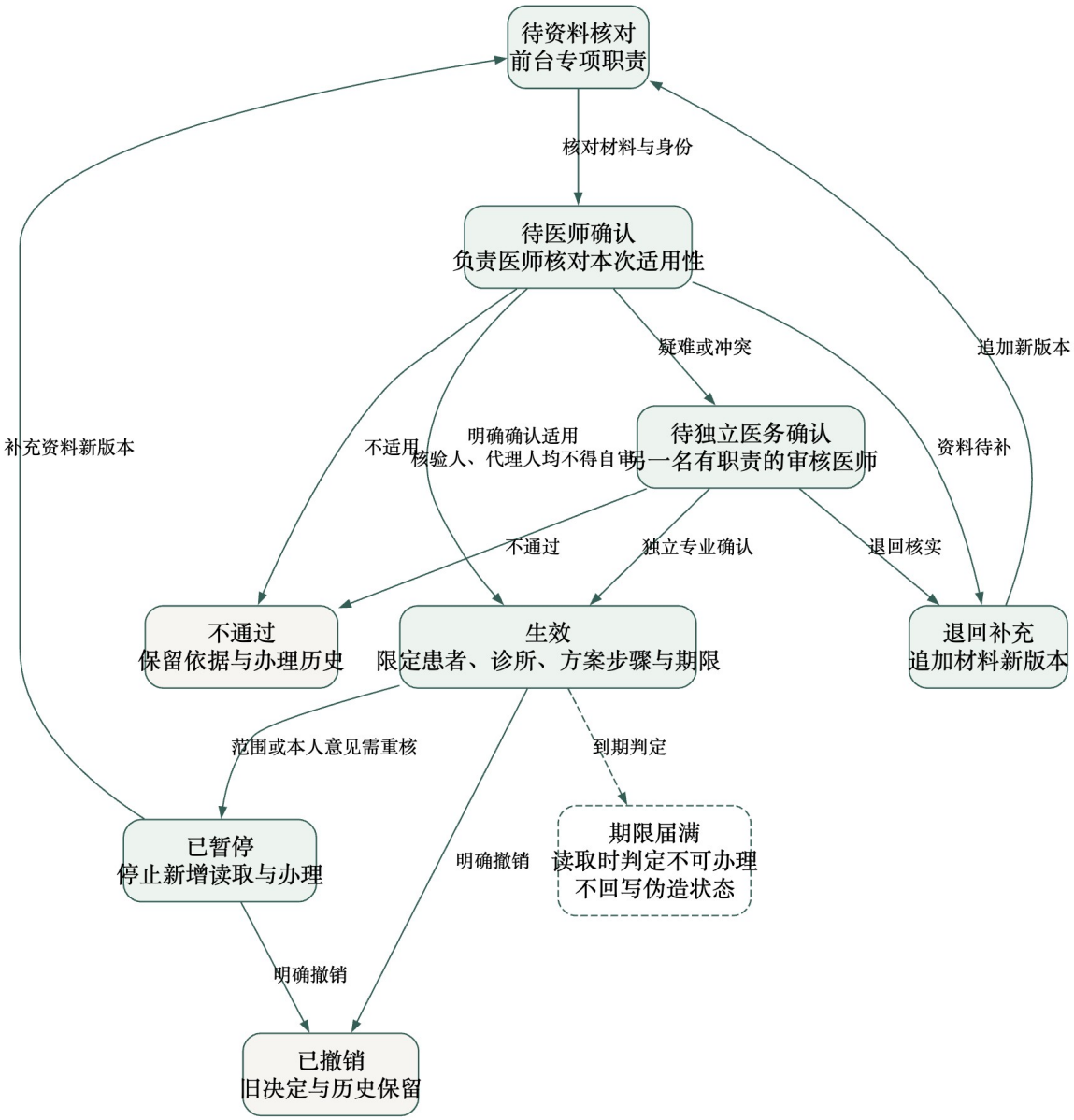

图 4-60 医疗代理材料与临床适用性状态

生效、暂停与撤销为留存办理状态。到期由期限实时推导，资料修订追加版本；旧决定和材料不被覆盖。

4.32 开治依据执行与缺口复核设计

ClinicalConsentRule 保存每店每实际项目的规则版本，TreatmentControlPolicy 记录明确启用。TreatmentPreflight 引用准确检查、步骤、规则、告知、决定及代理版本，同时保留本次资源与加工件依据快照。PerformedProcedure 通过可空一对一关系引用核对，每份核对最多支持一次实际事实，独立收费关系沿用原设计。

确认核对与实际执行均串行核验当前事实，撤回和实际提交按同一参与账号及对象锁序协调。具体同意的未答疑问、撤回或范围变化阻断新开治；已有医疗决定办理不能通过更换为沟通记录类规则绕过。过时开治依据继续留存，重新核对另建记录，不重写旧依据。

ProcedureGap 与实际执行一对一，记录真实缺失依据和补记责任；ProcedureGapReview 与缺口一对一，保存独立医师职责及结论。复核只改变待办状态，原实际发生时间与未取得事前依据的事实保持可读；不制造事前核对，不重复产生收费或付款。

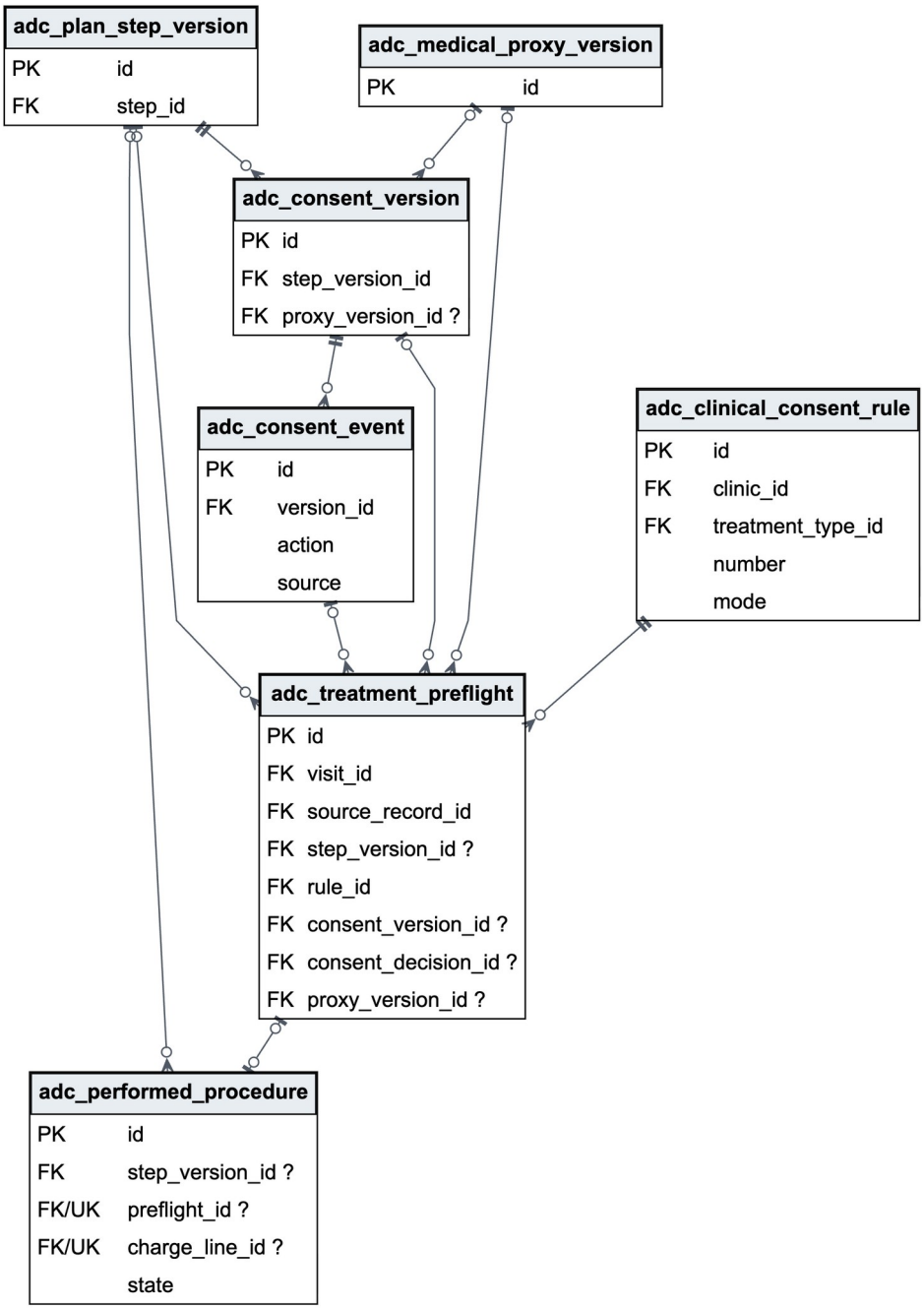

图 4-61 准确同意与治疗前核对执行

核对保存独立依据，实际执行以可空的一对一 preflight 引用准确核对；每份核对至多支撑一次实际执行，撤回原执行也不能复用。具体医疗同意引用准确事件，代理版本和临床规则分别保留。JSON 快照存本次资源与来源编号，图不将其虚构成 SQL 外键；实际确认重新核验，核对本身不产生收费。

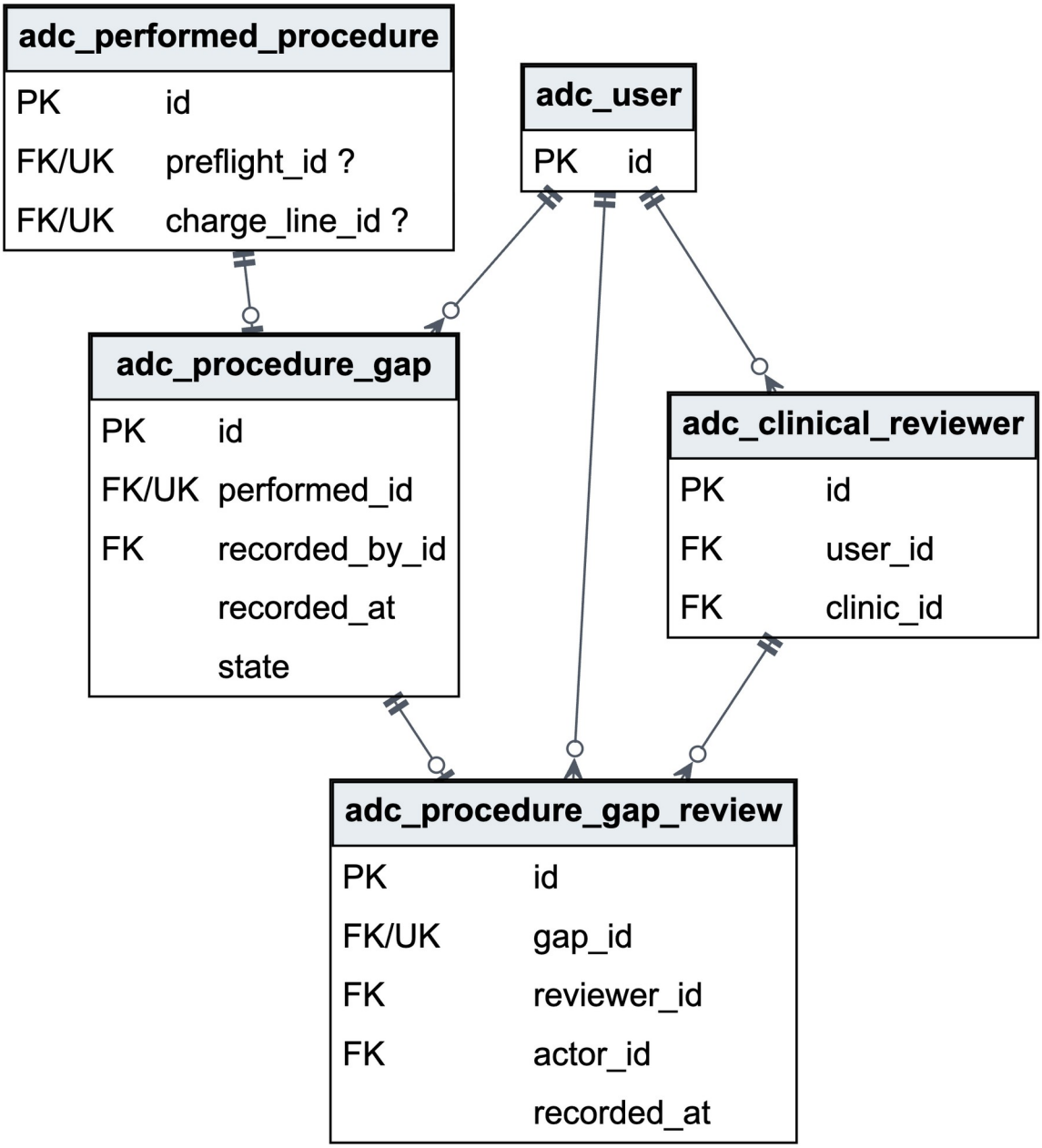

图 4-62 已发生治疗补记与独立缺口复核

真实补记仍使用原实际执行与唯一收费来源，preflight 保持为空；一份实际事实至多一项缺口及一份独立复核。缺失依据和原因不可覆盖，复核账号须具本店职责与具体服务读取范围，不能复核本人补记。复核改变待办状态，原缺口继续保留，并不补造事前通过。

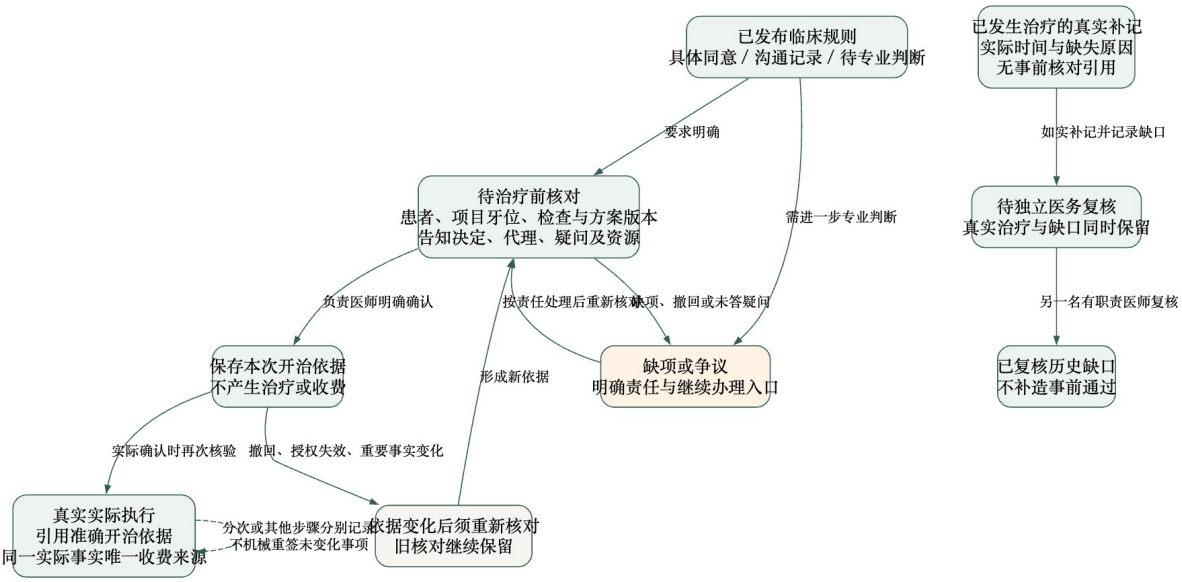

图 4-63 开治核对与真实补记的不同责任路径

通过核对、实际执行和真实补记为不同事实。变化后新建核对，原依据保留；缺口复核不产生事前同意。

4.33 归档、独立审核与准确补正设计

ClinicalArchive 与实际接诊一对一，保留负责医师及原期限。ArchiveSubmission 引用准确文书和冻结来源清单，区分完整归档与缺项资料保全；每个归档事项至多一个待审核、待生成或生成失败申请。指定审核人引用有效机构委任，新增归档职责默认关闭，并与诊所、具体服务读取范围共同核验。申请及审核账号必须独立于本次负责医师。

ArchivePackage 与申请一对一，通过可空一对一 previous 引用同事项前一包。固定 PDF、清单、字节摘要和渲染版本保存在数据库。原姓名与机构资料取文书快照；收费取选定已发布版本，不用后来资金余额重绘旧文件。ArchiveEvent 只追加办理历史。固定文件摘要检查一致性，不等同可靠电子签名或法定共同封存。

ArchiveAmendment 引用已完成的完整归档包、准确更正草稿、差异来源及审核责任。获准后仍须原临床命令确认，且重检账号、职责、原包和准确内容；实际结果通过可空一对一关系指向文书或检查版本，恰选一个。PostgreSQL 延迟约束检查已归档后的追加版本必须对应获准内容与来源；不同临床对象分别批准，其他新就诊无需解锁旧病案。

保留同一事务内的账号、专业范围、出诊、患者、接诊及归档锁序。耗时文件排版在事务外读取冻结快照，发布时重核来源和审核适用性，文件与回执一并保存。重复确认返回原结果，重复生成不重复发布。现有通知工作进程每轮有界生成，失败保留安全分类，运行日志不记录病历正文。

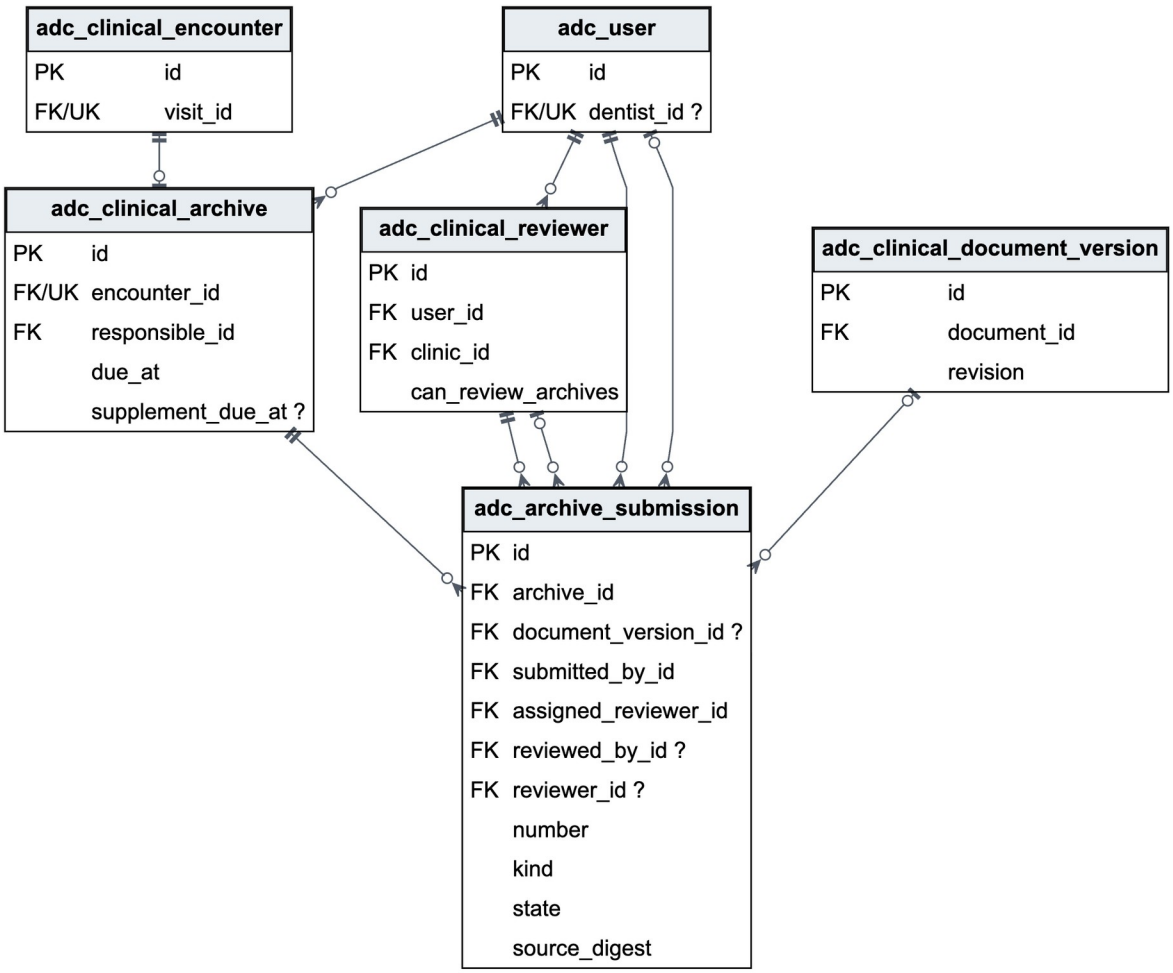

图 4-64 归档事项、准确来源与独立审核

每次接诊至多一个归档责任入口。申请引用准确文书，待审核及生成中每入口最多一个有效申请；材料保全与完整归档分开。专项审核职责默认关闭，还须当前诊所及各具体服务读取权限；申请人及负责医师不能审核自己。snapshot 保留原始事实和逻辑来源，不把 JSON 编号虚构为 SQL 外键。

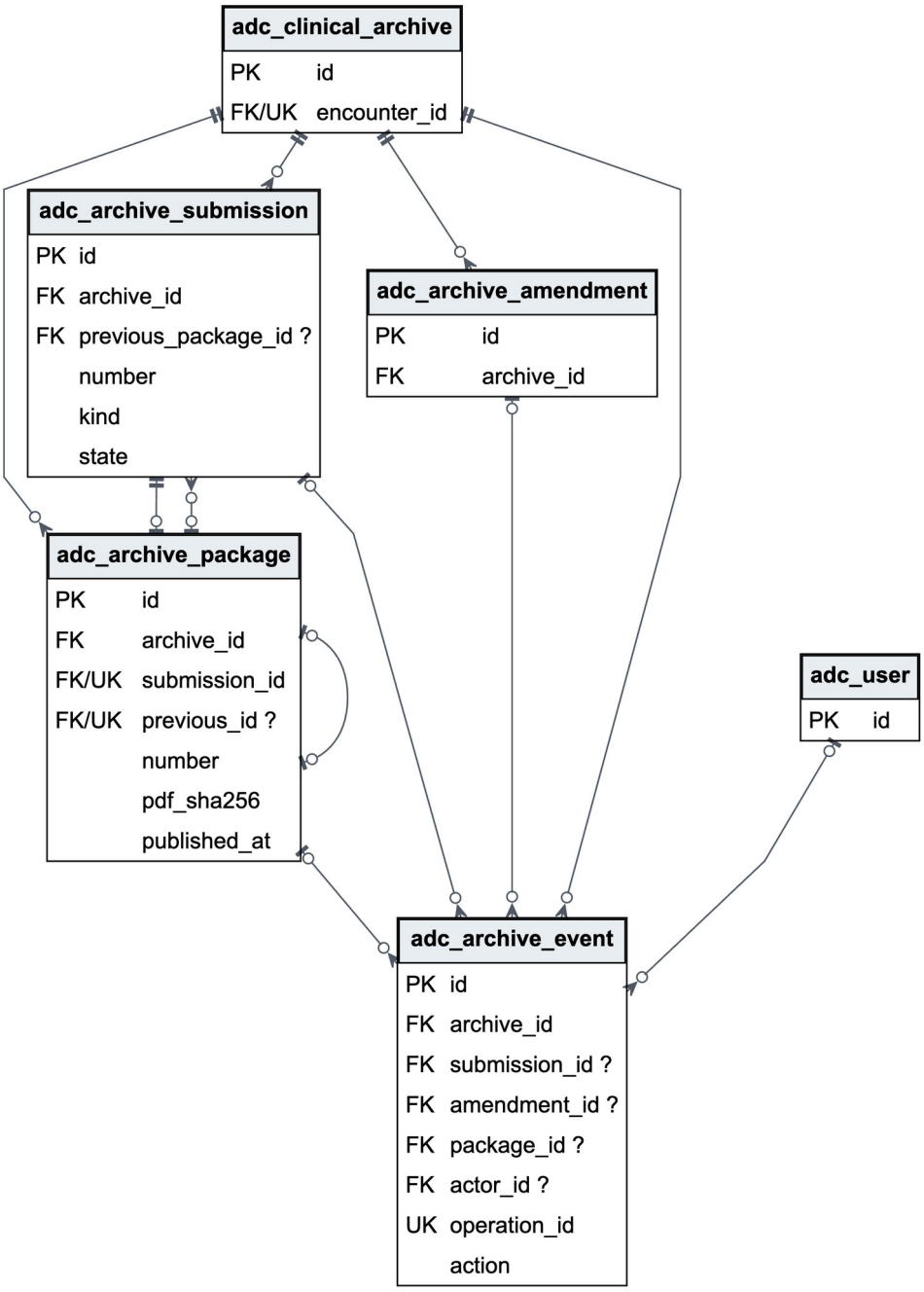

图 4-65 固定归档包与追加办理历史

一份获准申请至多生成一个固定 PDF 和清单；previous 为同事项的一对一追加链。文件字节、清单、摘要和原审核不可覆盖，重复任务不重复发布。生成失败须明确重试，来源或职责变化转待重新提交。事件的申请、补正、文件引用可空，具体含义按 action 核对；旧包不因后续费用、姓名或授权变化而重绘。

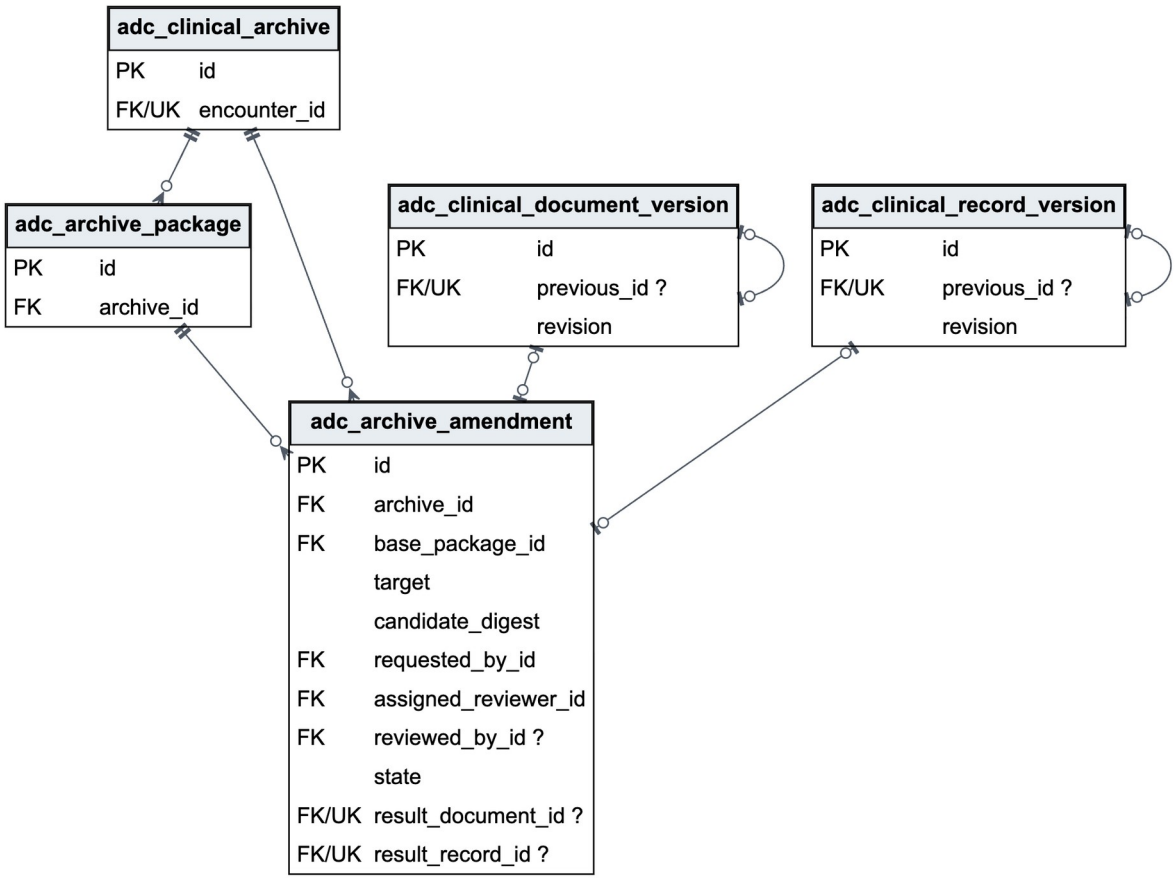

图 4-66 准确补正批准与临床追加版本

补正针对完整文书或检查牙位的准确草稿，保留原包、差异和原因。独立批准后仍由负责医师确认；实际追加版本通过两个可空一对一结果关系恰选一个，未实施时两者为空。数据库延迟约束核对追加版本与批准内容、来源相同；批准不是直接改病历，旧批准不能套用变化后的草稿。补正后另提补充归档，原包继续可读。 审核人与委任的完整关系见归档提交视图；本图保留相关外键列，仅展开补正结果关系。

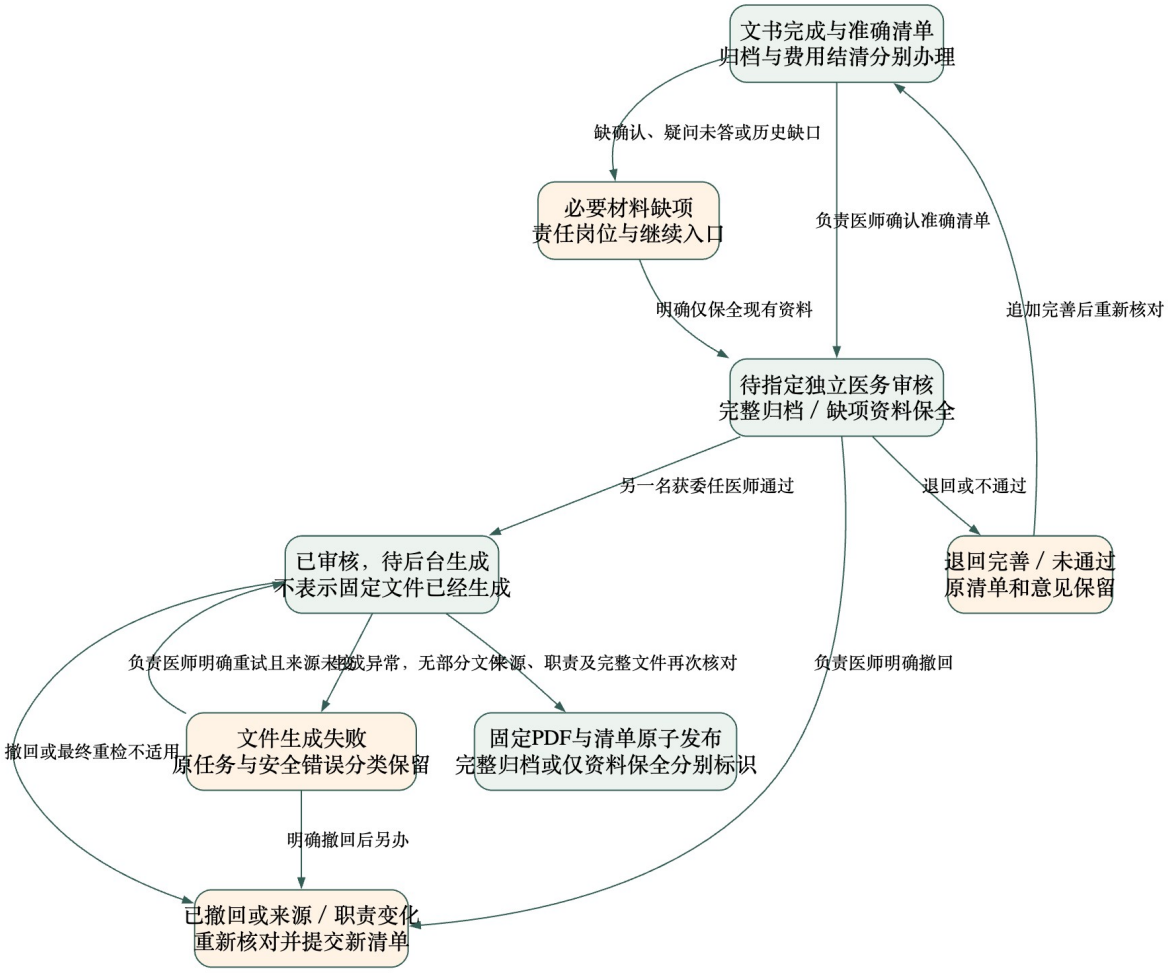

图 4-67 归档审核与固定文件生成状态

状态说明：实际来源、岗位责任与固定版本分别保留；缺项保全不冒充完整归档，批准补正不代替医师确认。

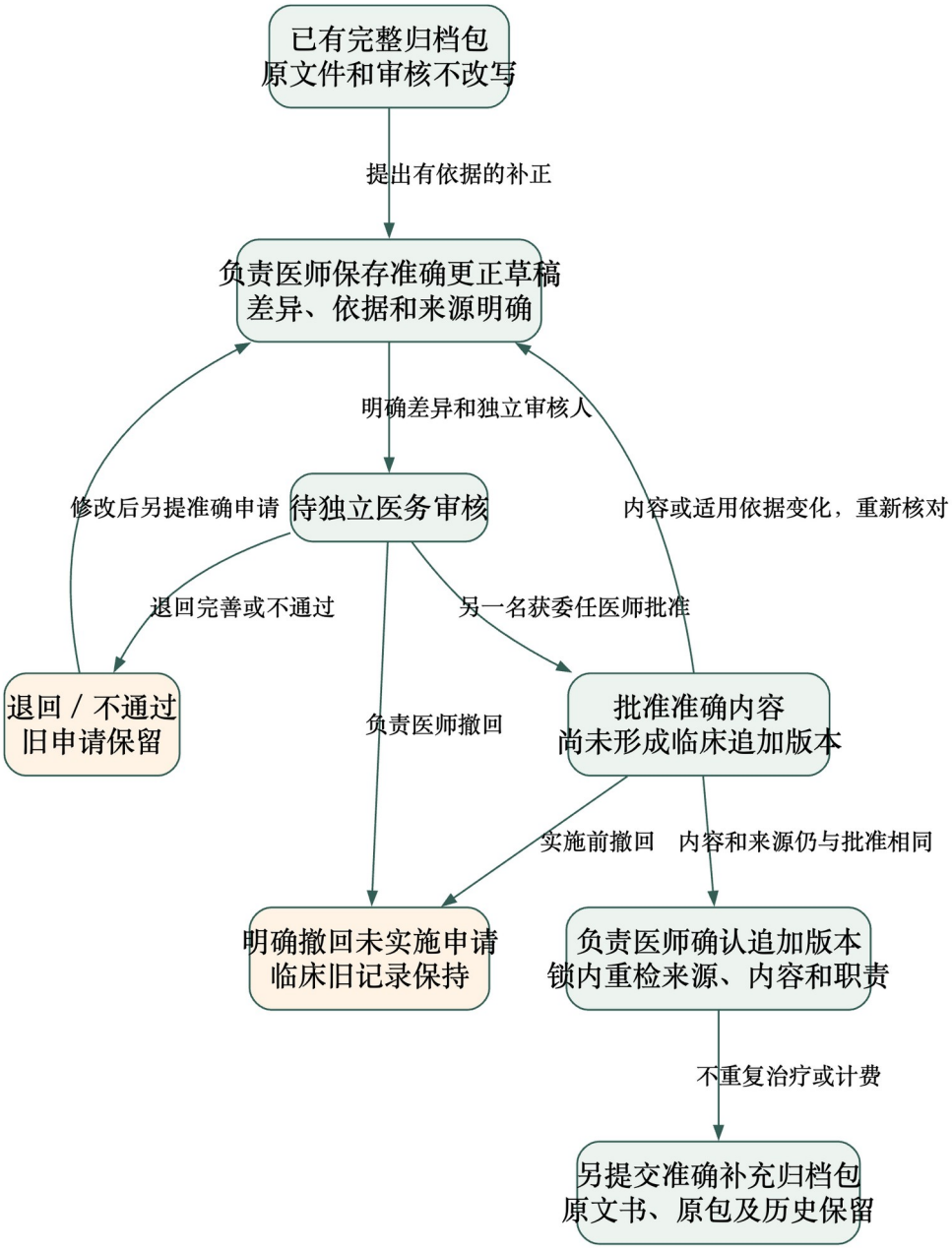

图 4-68 归档后准确补正与追加版本

状态说明：实际来源、岗位责任与固定版本分别保留；缺项保全不冒充完整归档，批准补正不代替医师确认。

思维导图 统一身份 → 任职与独立专业授权 → 版本画像及选诊 → 统一患者与资源核验 → 完成诊疗 → 产值／回款／成本 → 工时分摊与留存月报。； 文书来源 → 准确确认 → 追加更正与比较 → 责任期限。 医疗代理版本及范围 → 告知与决定来源 → 临床规则 → 开治依据 → 实际事实与唯一收费 → 补记缺口及独立复核。 归档入口 → 申请快照与审核 → 固定包及前序链 → 准确补正批准 → 临床追加版本与补充归档。

第 5 章 系统实现与测试

5.1 功能范围与完成状态

系统已实现七类岗位工作台、结构化电话接待、责任联系、统一服务与资源核对，以及患者自助预约和改期、到诊、治疗记录、版本化结算、收退款审核、资金凭据、渠道对账、日结和设备维护。网站、前台、电话、改期与候补共用资源规则，原有取消时段分析和改进措施独立复核继续可用。

下表按可观察的业务能力区分现有功能与后续范围。课程实例使用明确标注的合成资料，已实现功能仍需在真实业务环境评价其运营效果。

患者关系受理、账号补充、明确职责核验、有效期授权、暂停和撤销已实现。网站及原生患者端均可切换就诊人，预约、改期和候补调用原有业务命令；临床同意、完整纵向病历和处方流程仍须后续设计与验证。

专业操作申请、独立审核、明确启用、有效期及撤权核验已接入接诊。跨店转诊由原负责医师发起、接收店核对身份、指定医师接收；本人患者的终止披露在网站和小程序调用同一业务命令。

网站与原生小程序共用本人健康自述。医师工作台已接入实际到诊、主诉检查、具体自述核对、牙位牙面观察、服务器草稿、预览确认及追加更正；七类岗位和本店专业范围仍分别核验。

连续诊疗已接入具体方案版本、本人决定、实际执行和后续就诊；前台工作台接续复诊责任与手工加工送返，医师负责适配验收。网站和小程序展示同一本人方案及执行进展；代约仍限定在预约事项。

表 5-1 业务功能的实现范围

业务能力	当前状态	使用边界
门店服务内容与多渠道选约	已实现	主管发布范围、费用及准备；网站和小程序选约，儿童代办先核验。
网站患者预约与取消	已实现	已核验本人或本店有效代约；首次来访先办理建档核验。
电话接待与正式成约	已实现	独立接待单、追加沟通、完整建档核对、候选协商和唯一成约关联。
统一服务与诊疗资源核对	已实现	按诊所启用；同房多椅、共享设备、服务时长、医师适配和停用共同核验。

业务能力	当前状态	使用边界
本店资源目录维护	已实现	主管预览确认配置；旧预约与有效邀约逐项核实后启用，不补造历史。
前台日常出诊与候补排班	已实现	前台在当前店预览并确认出诊、接收控制及候补发布；日周视图与期限协调衔接，主管独立复核。
接诊、治疗与结算	已实现	由负责牙医确认实际治疗；账单与资金分别记录。
收退款、对账和日结	已实现	独立账号审核；真实支付接口不在课程范围。
设备维护与独立验收	已实现	送修影响与原承诺关联；兼容替换保留版本；恢复仍需独立验收。
取消时段、原因与措施	已实现	样本及完整性提示、实际联系与正式另约关联；后续完整窗口由另一主管复核。
患者网站自助改期	已实现	本人或授权患者的未来预约、本店同服务；时段与有效邀约均须预览确认，失败保留原约。
原生患者预约与候补	业务主链已实现	预约、改期、候补及邀约共用原有规则；微信平台实际运行另验收。
专业操作范围与独立审核	已实现	限定来源、诊所、服务、动作与期限；合成证据不等于真实临床资格认证。
限定跨店转诊与披露终止	已实现	接收店核对身份、指定医师接收；网站和小程序由本人终止披露。
本人自述与面谈来源	已实现	网站及小程序本人提交，本店医师面谈独立保存；未知及原版本保留，不覆盖过敏复核。
实际检查与版本更正	已实现	实际到诊、负责及专业范围核验；图形与键盘牙位、服务器草稿、冲突继续、预览确认及带依据更正。
跨次方案与本人决定	已实现	具体版本及互斥选择，估算不收费；新版须重新核对本人决定。具体步骤说明随方案版本保存，患者双端读取，旧版缺失不补造。
实际执行与唯一开单	已实现	实际项目、位置、阶段与时间独立记录；中间阶段不另收费仍属已治疗。
复诊责任与加工协同	已实现	前台负责联系与送返，医师核对实际完成及具体步骤适配；原预约保留。
医保资料与模拟待遇	已实现	来源目录、独立核对、本店安排、收费适配及待遇历史；真实机构资格另行确认。

业务能力	当前状态	使用边界
医保模拟结算与原编号查询	已实现	原实际收费、逐行分担、独立复核；未知结果继续原请求。
基金到账分配与差额跟进	已实现	保留银行凭据、不同账号核对、逐笔额度、责任期限和沟通历史。
原结算撤销与基金退回	已实现	同一原撤销结果、独立核对及已到账退回；患者现金按原流程办理。
微信与手机账号协同	代码与隔离流程已实现	微信单账号登录已完成工具联调；双账号、真机扫码、实际短信和体验发布另行验收。
完整门诊文书	初复诊、医师确认、历史比较、追加更正、责任待办与准确版本打印。	文书、医疗决定及员工侧归档已实现；可靠签名、专业审定及受控复制另验。

5.2 预约与接诊的界面组织

患者入口按就诊需求、门店实际开放服务、费用及到诊准备组织信息，选择服务后继续登录和查询时段；不以设备编号或内部验收清单作为患者入口。公开页面采用响应式布局，支持键盘与系统缩放，未启用脚本时仍可阅读服务并使用普通表单办理预约。

前台从接待与联系待办核对责任、期限和沟通历史，按服务查询医师、时间、诊室椅位和设备组合。确认页复述安排及患者同意，未建档或冲突时返回明确继续办理入口。网站患者选择服务、日期和医师，由系统安排兼容资源组合。 患者改期页并列原新安排和原因，明确区分普通候选与本人有效邀约；确认前原约继续保留，冲突时可重新选择或联系原诊所。待就诊、历史和全部分别查询，旧接受与取消跟进依据继续可追溯。

接诊界面按患者和过敏信息复核、实际治疗、治疗完成及结算查看组织。草稿只供负责牙医修改，已发布治疗事实保留版本。未到诊不能直接完成治疗；无实际治疗也需明确结束原因，避免以预约意向或草稿内容收费。

取消原因待办按联系状态和责任筛选，进入详情后可核对联络资料、办理正式另约或查看候补。另约入口带入患者编号，最终确认仍由预约模块核验；跟进页只保存已经成功的预约编号，联系结果修改追加历史。时段分析显示原数量及完整性，措施清单区分待开始、执行中、待复核及终止结果，并提供执行记录和独立复核入口。

5.3 财务与设备的操作衔接

资金表单将金额及日期、渠道凭据、申请依据分组，错误摘要可定位字段，提交后仍需预览确认。前台办理收退款申请，主管办理设备费用，财务分别复核；更正后原申请和凭据历史保留。

逐笔对账区展示待核对流水和资金记录，同金额并不能自动形成匹配。设备维护区展示负责人、期限、维修说明、费用和验收状态；独立验收通过后设备状态与费用来源可追溯，后续支付继续走资金流程。

设备维护直接展示已登记资源影响；前台办理同医师同时间替换，改变时间或医师需患者同意。到诊发现资源不可用或前一患者未结束时进入协调，原约和治疗事实均保留。

图 5-1 收退款申请的分组表单

5.4 典型业务场景与测试设计

验收采用合成患者、医师、设备及渠道流水，分别从使用者可见结果和持久化业务事实核对。已执行场景与下一阶段目标分列；测试项数量只说明执行范围，不等于逐个用例均已完成业务验收。

日周排班、调班责任和数据库关系已有跨店场景验证；患者自助改期进一步核对本人候选、候补替换、原约保护及真正取消的跟进。当前业务演练、负载和恢复分别核对，不把测试总量表述为全部业务效果。

表 5-2 跨岗位业务场景及验证状态

场景	关键核对结果	验证状态
前台排班→调班联系→独立复核	当前店办理、明确期限，未联系上保留原约；同意后唯一改期，复核后前台维护。	既有五店调班与 293 项浏览器核对；完整回归继续通过。
患者改期→本人邀约→接诊收款	原约和接受历史保留；后继唯一；真正取消另行跟进；实际治疗后开单和独立收款审核。	五店 173 项、诊疗收款 68 项、跟进 22 项；数据库核对 45＋8 项通过。
预约→到诊→治疗→账单	确认后唯一预约；复核实际治疗；结算按行金额及版本核对。	已有服务和浏览器验证。
分次收款→退款→独立审核	多次收款分别保留；超额和自审拒绝；已记账金额独立计算。	已有五诊所合成验证。
流水导入→提议→复核	重复不重复接受，匹配条件逐项核对；原资金不被导入改变。	已有导入、权限及并发验证。
设备送修→办理→验收→费用	责任人与验收人分离；费用有来源；不自动改动患者安排。	已有工单及费用验证。
电话接待→候选→联系→确认	多次沟通、完整建档、明确同意后唯一成约；无资源、失联和拒绝均有责任结果。	五诊所电话成约至治疗结算、网站 45 分钟预约、15 分钟候补及维修协调已执行。
取消时段→原因→措施→复核	分母及缺失可解释；不混计爽约、改期和诊所取消。	五诊所浏览器、数据库独立核算及并发验证通过；真实改善尚待观察。
椅位设备竞争与原约保护	不同椅位并行；同椅和共享设备竞争仅一个成功；送修不自动取消。	资源服务、数据库并发与浏览器场景执行。
资源到诊→治疗→结算	前一患者未结束不得重复接诊；预约服务及资源不制造实际治疗和资金。	独立核对预约、治疗、账单及资金事实。
专业审核→跨店核对→指定接收→本人终止	临床权限按期限及服务核验，转诊不制造预约、治疗或资金。	五店 126 项浏览器与原生页面核对；核心业务表及资金合计保持一致。

场景	关键核对结果	验证状态
初复诊文书	检查、实际处置和离诊医嘱汇成完整记录，复诊指向准确既往版本。	更正留原文；草稿与来源冲突保留填写；无治疗不虚构项目和金额。

5.5 业务测试结果与质量评价

回归验收覆盖既有规则、真实数据库、HTTP 权限与并发场景；新增关系受理、核验职责、授权有效期、切换旧页、代约回执、跨店拒绝及候补衔接场景。测试总量和合成结果不表示真实临床运营已经合格。

五诊所真实浏览器场景核对普通改期、本人邀约改期、重复确认、前台资源日历和真正取消的原因跟进。两店继续由患者明确同意变更医师，办理兼容椅位协调、到诊、实际治疗、开单和另一账号收款复核；每笔账单和收款为 100 元，合计 200 元，金额另按数据库事实计算。改期和候补接受本身不生成治疗或资金。 取消后正式另约、患者再次改期和原跟进依据的保留另行核对。

五诊所、二十患者账号连续三十分钟负载执行 9,000 次请求，80%读取、20%合法提交。提交包括 900 次改期预览及 900 次确认，共形成 900 次实际改期；普通请求 p95 为 0.453 秒。逐笔核对唯一后继、资源占用、回执及原有资金，无意外失败、重复业务效果或可见内存耗尽事件。该患者工作负载与既有岗位混合负载分开记录，不代表二十诊所全面运营能力。

浏览器检查七角色权限、390 像素大字号和键盘提交；待就诊与历史列表分别显示，原新预约及人工协助可直接定位。加密备份在独立空数据库恢复，全部记录、结构以及当时 42 项触发器定义和启用状态一致；回执、资源方案、候补接受历史和取消跟进关联均保留。

原生患者服务在五诊所合成环境完成候补登记、网站前台发布邀约、邀约替换原约、新增预约、拒绝及退出，网站显示同一结果。二百五十八项联调检查和数据库独立核算确认唯一后继、占用释放及原账务保留；重复提交不恢复已退出记录。此前九页通过官方离线语法编译，微信运行时、手机及体验版仍须单独验收。

服务发布与双端预约场景另在五家合成诊所通过 187 项检查：患者选择服务、网站或小程序明确确认，原预约可跨端查询；下架阻止新的失效确认，同时保留既有预约和合法改期。此前十一页原生工程通过官方离线语法编译，仍需独立完成微信运行时、手机和体验版验证。

患者关系场景核对相同联络号码不会合并患者、普通联系人不能代约、撤销后原预约保留、两名合法操作者争用同一患者时段只产生一次有效预约。网站与原生页面共享后端事实；独立恢复包含关系、授权、事件和本人／代约回执，该关系场景验证时结构触发器数量为 43 项。

专业范围测试覆盖自审、失效审核职责、无服务通配误用、授权到期、撤权与接诊并发、离岗后历史保留、跨店身份争议及限定版本查阅。敏感查阅的许可和拒绝分别留痕，重复确认不会重复创建专业申请或转诊决定。

前述负载保留其预约场景的验证范围，不能据此推定新增专业协作或后续连续诊疗的容量；相应工作负载需分别测量。

检查场景覆盖五家合成诊所，核对未知保留、本人及面谈来源、图形与键盘录入、网络响应丢失后的同次重试、双页冲突继续、历史版本及跨店拒绝。独立核对显示自述和检查操作不改变原预约、治疗、账单与资金事实。

连续诊疗整组回归执行 1104 项源码规则及 1688 项真实数据库、HTTP 和并发场景。五诊所实际浏览器及原生页面处理器核对方案换版、加工返工、明确复诊、资源故障替换和分阶段结算；离线语法编译与页面处理器验证不代替微信平台运行。

5.6 预约指标的独立核算示例

合成核算示例：到诊 A=6、患者取消 P=2、诊所取消 C=1、爽约 N=1、到期未核实 U=3、改期前身 R=5。D=9；患者取消率 22.22%，爽约率 11.11%，整体取消率 30.00%，完整性 76.92%；R 不进入结果分母。

该示例样本与完整性不足，不列高风险排行。期间按预约开始日划分，未来预约单列，原因与取消时间缺失不补造。

5.7 需求、用例与验收追踪

以业务问题关联用例、设计责任和验收条件。原 AT-01—25 及维护协同编号保留，AT-B 补充可观察场景；自动测试总量不等于用例覆盖率，微信平台实际运行、云端访问与真实运营效果仍需单独验证。

表 5-3 业务需求到用例与验收的追踪

业务需求	用例及设计责任	可观察验收
患者服务说明与公开	SU-59；本店主管、患者服务与排班模块	草稿与已发布分别显示；未知费用不作零元；下架拒绝旧预览，已有预约保留。
患者自助预约	SU-04／SU-05；患者端与预约模块	本人或本店有效代约范围；选择不占用；确认唯一；取消仅限允许状态。
电话接待与替代协商	SU-39；接待单与预约模块	登记需求和来源；可回访；患者明确同意后成约；未成约有原因。
取消时段及改进	SU-41／55／56；运营聚合、原因跟进与措施办理	五诊所原数量与比例一致；不足不排行；联系与正式另约可查；独立复核拒绝执行前或未结束窗口。
统一资源核对	SU-54／SF-01；排班与设备模块	网站、电话、改期及候补重检同一资源；原约保留；兼容替换有历史。
收退款及日结	SU-42—46／49／53；资金与审核	来源和余额一致；不同账号审核；四类总额分别核对。
逐笔对账	SU-47—48；流水与匹配模块	上传预览不接受流水；重复明确；独立复核；不改原资金。
设备维护	SU-50—52；设备与协调模块	负责人、期限、独立验收及费用来源可追溯；影响预约明确处理。
资源目录与启用	SU-57；本店主管与排班模块	同店配置、时长及位置适配；逐项核实原承诺后启用。
患者自助改期	SU-40；患者端、统一预约与候补模块	本人或授权患者同店同服务；原新方案明确确认；候补原子接受；重复确认唯一；失败保留原约，取消另行跟进。
跨次方案与本人决定	SU-72／73；临床方案及患者本人渠道。	保留方案与目录定义；新版重核决定，估算及互斥方案不自动生成收费。说明草稿与发布分开，变更范围须重新复核；不生成医疗同意。
实际执行及唯一来源	SU-74；临床、接诊结算与资金模块。	部分与完成分别记录；一个原始收费来源，重复确认唯一，退款不改原执行。
后续目标与责任	SU-75／76／77；临床要求、前台随访与资源预约。	取消和改期保留关联；未达到明确目标不完成，责任失效可明确接续。
加工与管理投影	SU-78／79／80；加工送返、医师验收及管理汇总。	返回不等于就绪，返工进入新周期；前台和管理投影不读取临床规格。

业务需求	用例及设计责任	可观察验收
完整文书与责任	SU-114—120；文书模块与原临床／财务接口。	医师确认准确来源；追加版本；待办不阻断原周转；越权和重复效果被拒绝。

5.8 专业协作的实施与适用边界

五店合成流程核对原负责医师、接收前台、指定医师和本人患者之间的业务交接。身份待澄清时不能接收，接收前不披露临床文字，接收后只显示选定历史版本，终止后停止后续查阅。财务和技术身份不能打开临床披露记录。

上述软件流程以明确标注的合成资质、机构委任及同意依据验证。真实临床使用仍需要机构聘任合格审核人员、确认临床披露与法定代理政策，并审核后续临床记录术语和模板。微信实际运行、真实云环境和持续运行结果另行验证，不由离线编译或合成测试推定。

5.9 检查业务的应用与限制

临床检查以患者、实际就诊和负责医师为主线。草稿允许分次保存；冲突先比较再继续，确认另经预览和当前来源复核。网站与小程序读取同一已提交自述；转诊只披露被选中的确认版本。到诊、治疗、结算及资金审核继续由原有岗位按各自业务事实办理。

上述流程使用明确标注的合成资料核对软件行为。完整文书与作者确认、追加更正已经实现；临床模板、术语和诊疗范围仍须合格专业人员审定。具体医疗沟通决定、专项复核与员工侧归档另按已实现流程办理，可靠电子签名和真实机构制度仍待独立验收。小程序部署、真实手机、短信、独立云环境及持续运行分别验收。

5.10 连续诊疗业务的跨岗位核对

五家合成诊所分别从原确认检查建立方案，患者本人认可确切步骤，医师登记加工要求，前台手工送返并记录延迟。医师返工后进入下一周期，换版又重新核对本人决定及具体版本适配，全部就绪后才登记实际执行。

原就诊的中间阶段按完成时计费约定不另收费，仍发布已治疗的零金额结算单。前台按原医师目标关联后续预约，明确改期保留后继，牙椅故障阻止到诊，经同店同

医师同时间的兼容资源替换后继续。后续实际步骤完成并关闭接诊，前台才明确核对目标完成依据。

临床完成、开单收入、实际收退款和渠道对账分别核算。不同财务账号独立审核收款和部分退款，原实际执行与原账单不因退款而改写。主管和总部仅查看状态与逾期汇总，临床规格、联系文字及本人方案不进入汇总。

独立核对上述五例新增业务：五次中间治疗均为零金额结算，五次完成治疗各产生一条 200 元原收费，共开单 1000 元；另行审核收款 1000 元、退款 500 元，净收款 500 元、未收余额 500 元。退款不自动改写原开单收入，需要调减账单时另走独立更正；预约、方案和联系记录均不直接产生资金。

另以独立合成病例核对具体治疗说明：医师不完整提交保留输入，草稿不向本人提前展示；旧预览在再次保存后被拒绝。发布后，网站与小程序接口读取同一版本说明；修订保留原版。并发仅一份保存生效，代约人及无临床权限岗位不能查阅。此项为软件流程验收，真实手机与医疗同意签署另行验收。

5.11 门店发现与登录延续核对

网站与原生小程序共用已发布门店和服务来源，访客入口仅提供公开只读投影。核对匿名访问不建立工作上下文或业务记录，定位失败可手动选城，同名距离采用稳定编号排序。患者选择服务后，经普通登录及合法就诊人选择继续原预约流程。

业务核对包括多岗位账号的登录通道、跨店与撤权、资料版本竞争、重复确认、公开撤回后旧预览、营业例外和原约联系快照。课程门店网络覆盖长沙等八省会二十家合成门店，均已准备基础服务、医师、牙椅设备与前台出诊；是否可约仍核对具体资源，容量以实际负载测量，不从门店数量推断。

关系图由实际迁移后的数据库结构生成，逐列核对类型、可空、唯一及外键。已核对的软件业务路径与微信平台运行、真实手机号授权及医保联网分别记录；尚无平台及机构测试条件时，不将本地接口或合成数据称为真实授权或医保结算。

5.12 本人申请与跨渠道办理核对

网站与原生小程序共用账号、联络、本人申请和结果页面。前台核对本店明确档案后预览决定，申请人再明确进入患者服务；未批准时不读取患者业务。

合成场景核对新档、旧档、补充、撤回、同一关联恢复、同号不合并及凭证有效性，并覆盖撤权、跨店、并发和独立审批。真实后端联调接续预约、改期及候补，断网重试保持唯一结果；窄屏大字检查长账号换行。

本地凭证和号码只证明合成来源。微信平台身份不等于患者实名，真实微信运行和手机号能力须另验收；人工本人建档路线不以外部平台资料为前提。

网站和小程序使用同一 ADC 账号及已授权患者列表。微信快捷登录、原账号关联、网站扫码确认和手机号换绑均保持账号与患者档案分离；登录后的服务选择、改期和候补仍核对原资源与当前授权。

5.13 医保资料基础的业务核对

财务预览官方原件、项目和缺失统计后确认导入，另一财务账号独立启用。主管准备本店安排及收费映射，财务独立复核；前台从原患者档案追加合成待遇，不另建患者或扩大代约范围。

核对覆盖原件摘要、缺项、重复、日期重叠、单位变化、自己复核、撤权、跨店和并发重试。后续审阅明确关联前次，不改原决定或恢复旧安排；待遇版本与来源保留，准备不制造诊疗或资金事实。

上述资料与后续模拟结算共用明确患者、本店、原实际费用及来源版本。真实医保办理仍须取得具体机构资质、地区规则和接口条件，不能由目录导入、合成待遇或模拟资金结果推定。

5.14 模拟结算和基金资金核对

合成实例的原账单为 1000 元，明确模拟分担为患者现金责任 300 元、个人账户 200 元、基金 500 元。只有独立分担核对通过后，患者未缴金额才按 300 元核对；先收 100 元则尚待缴 200 元，已经自付 1000 元则显示待退 700 元，由原独立退款流程处理。基金到账不改变 1000 元原收入，也不会再记一笔患者现金。

银行 500 元到账可以先分配 300 元，剩余 200 元继续显示未到账或未分配原因；待复核的 300 元不能再次分给其他申报。同一银行凭据可在同一诊所关联多笔申报，原现金对账与基金用途互斥。基金扣减和联系未果保留原应收及负责人，不自动转成患者欠款。

结算或撤销回复丢失时均查询原唯一编号。已到账 500 元而只退回 200 元时，撤销继续处置并保留原分担；全部退回且独立核对后才撤回分担。若患者已净付 300 元，撤销后原 1000 元实际费用仍在，余额显示待缴 700 元，不制造退款或作废费用。

验证分别核对金额投影和持久化事实，覆盖跨店、币种、超额、待审预留、重复操作、撤权、独立复核、并发分配、未知结果和已到账撤销。银行入账日期与接诊业务日分开，原治疗、账单版本、日结及现金凭据可继续追溯。

5.15 微信登录和短信核验的验证

隔离 PostgreSQL 覆盖微信首次及重复登录、原账号关联、扫码确认与领取分离，以及不同浏览器、过期、刷新、解绑、停用、会话变化和并发领取。受控提供方响应仅验证系统合同，不代表实际微信或手机网络交互。

CloudBase 按官方接口生成并核验验证码，ADC 保存服务端挑战。错误、过期、重放、其他会话、号码冲突、发送失败及免费条件未确认均不产生错误关联。仅向约定号码联调，整轮最多 10 次且失败计入上限，不充值或启用付费通道。

一个真实微信账号已通过开发者工具换码、退出后重登及映射一致核对。第二真实账号、手机扫码和教师体验仍待条件；真实短信尚未具备已核验免费条件，保持关闭，不将单账号工具结果视为整轮验收通过。

个人小程序不启用一键取手机号，微信登录不强制电话。身份、联络、本人档案及代约分开；恢复后未完成认证票据失效，账号、密码及原授权保留。

5.16 医师与门店选诊的跨岗位核对

课程场景采用八城二十家门店，每店配置至少三名可接诊医师、四类基础服务及按店配置的特色服务、两个椅位与必要设备，并由前台发布未来十四天出诊。长沙包含同城轮诊：同一医师在两店展示分别适配的服务与日期，不复制账号或专业身份。课程新增配置与原业务事实分别保留。

浏览器场景依次完成匿名选医、登录恢复、预约确认、重复确认及患者改期；两端按同一患者权限读取预约。医师提交新介绍后，主管退回仍保持旧展示；新版本再提交并由主管发布，网站与小程序投影同步。岗位和跨店拒绝、键盘进入、390px 窄屏与放大文字另行核对。

小程序提供二十四页及主页、预约、就诊、我的四个稳定入口；正式编译、真实开发工具运行和手机试用分别验证。单个真实微信账号的工具换码已通过；手机扫

码、第二身份及真实短信仍待配套条件，不以课程身份或账号密码登录替代实际验收。

5.17 经营核算的独立业务校验

独立场景核对零收入成本、缺失与明确零费用、跨月收退款、一个逻辑账单的多发布版本、设备费用修订和重复来源。主管提交成本后不新增资金流水；财务复核、类别完整核对与新月报确认分别办理。设备来源更正后，原月报不被覆盖，当前核算先显示缺口，完成成本修订后再留存新版本。

分摊例：公共成本 0.02 元，D1、D2、D3 各有 1 分钟出诊。先向下取分后均为 0，按编号将两分分给 D1、D2，结果为 0.01、0.01、0.00；总额 0.02 严格守恒。三人均无工时时，0.02 全部保留门店未分摊，不制造医师成本。实际出诊按月边界截取，完整依据随报表留存。

原五店临床基准与新二十店画像、经营读取和合法草稿写入分别执行；持续 30 分钟、20 个账号和 80%读取／20%写入为验证条件，结果只解释对应负载与资源范围。加密恢复核对图片字节、提交版本、成本、分摊及月报历史，工程执行证据另附，不据此声称已完成独立云端商用验收。

5.18 二十店能力矩阵与患者渠道验证

覆盖矩阵逐店核对四类基础服务在网站和小程序的服务、医师与时段，包括广州越秀牙痛评估与基础修复。特色不支持时核对同城替代；每店完成一次明确确认的预约，再以明示原因取消测试预约并保留历史。儿童场景由已核验监护人选择就诊人，预约权限与账单权限分别验证。

微信开发者工具连接实际应用后端，通过真实控件操作门店筛选、服务、登录恢复、预约改期与就诊功能；工具执行与手机预览分别记录。只通过模拟页面处理或离线编译不能证明微信运行。手机预览、真实微信换码和真实短信均需各自执行证据，不能以分配账号登录替代平台验收。

工程验收覆盖 PostgreSQL 回归与并发、七角色权限、窄屏与字体放大、二十账号三十分钟混合负载，以及图片字节、发布版本和账单历史的加密独立恢复。负载按约五请求每秒、八成读取及两成合法写入，普通请求 95 百分位应小于五秒；具体执行结果与版本见独立验收记录，不把目标当成已通过。

5.19 初始化与运行交付验证

独立环境的初始化验证覆盖二十家合成门店与八十组基础服务组合，逐项核对可接诊医师、出诊和物理资源。完整初始化后重复调用两次，比对所有业务数据组及账号密码，确认不重复创建目录、预约或资金记录。角色权限、患者授权及前台排班职责继续按原用例验证。

发布验证应覆盖同一数据卷内升级、重复确认、旧期望版本拒绝、并发互斥、候选失败后的镜像恢复，以及新版本写入后回退仍保留新业务。加密备份在另一空库恢复，核对历史与图片字节并检查认证票据失效。目标服务器的容量、证书续期、重启及持续观察独立记录，局部演练不替代公网验收。

真实微信换码、网站扫码和两名体验成员的手机流程需要配套平台配置与实际操作。课程业务资料为合成数据，不等于真实专业身份或诊疗资质；手机、真实短信及独立服务器的未完成条件保持可查。患者与员工通过各自授权入口办理业务；平台、手机和目标环境验收未完成时，保留对应状态与后续责任。

5.20 初复诊文书与更正的业务核对

初诊场景核对主诉、病史、牙位检查、诊断、实际处置和离诊建议，确认前页面不生成文书版本；无治疗场景仍形成完整记录但不新增处置和金额。复诊关联既往准确版本并说明变化。纸质原件引用缺失时不能冒充完成证据，未知情况不能自动填无。

更正场景保留原文书及来源，追加依据和新版本；历史比较逐项显示诊断、医嘱和临床来源差异，打印固定所选版本。两连接并发确认、断网重试、旧预览、患者绑定变化、撤权和七角色访问分别核对。草稿冲突保留未提交内容；跟进不清除原期限，迟记保存实际确认时间。

文书待办存在时，原临床条件满足仍能完成接诊并释放资源；登记和更正文书前后独立比较原账单、治疗行及现金记录，确认未产生费用效果。实际 PostgreSQL 结构、完整回归、浏览器布局与加密独立恢复按可复核记录评价；文书历史一致不代表已完成医疗同意、可靠电子签名或法定归档。

5.21 本人医疗决定与沟通闭环核对

在独立课程合成环境中，以准确检查和方案准备医疗告知，核对患者提问、医师答复、同意、拒绝、暂缓、撤回及新旧版本。网站与小程序调用同一业务命令和投影；本人、另一患者、预约监护代办及其他岗位分别验证，临床读取不随宣传资料或预约权限扩大。

新增 26 项 PostgreSQL 测试覆盖版本、来源、撤权、历史保留、实际数据库并发及问答待办，连同既有治疗说明和完整病历文书共 66 项定向回归通过。小程序新增 6 项实际页面处理逻辑测试使用受控接口，不能代替微信开发者工具和手机结果。完整回归、恢复和准确版本交付证据另附于仓库，未执行的设备尺寸、真机和平台资格继续分别标明。

医疗沟通与决定不生成实际治疗、账单或资金。医师待办显示未回答问题；重新告知保留原拒绝、暂缓、同意与撤回。纸质来源与本人点击区分，实际时间不被登记时间覆盖。上述结果验证软件业务规则，不能替代专业人员参与的临床有效性和签名资格评价。

5.22 医疗代理及开治业务场景核对

以独立课程合成资料验证未成年监护、适用成年委托、前台资料核对、医师适用性确认、代理方案选择及医疗问答。网站与小程序使用同一投影和事务命令，办理状态查询、临床读取与预约权限分别核对，未给前台或主管增加临床正文和医疗审批权。

在 PostgreSQL 验证撤销与决定、撤回与开治、重复确认等并发；检查旧预览、到期、材料版本、独立核验、患者切换和越权访问。实际浏览器办理代理提问、医师答复、明确决定、开治、真实补记和独立复核，并检查窄屏、放大与键盘操作。实际执行、收费、账单与资金事实分别计算核对。

完整回归、混合容量及加密独立恢复的执行结果随正式验收记录列明。原病历与本人医疗决定工具结果作为既有证据保留，本轮六项新增患者工具业务场景已核对闭环；网站尺寸、页面处理逻辑、官方工具和实际手机结论各自独立，不相互替代。

5.23 归档、独立审核与追加补正核对

在独立课程合成环境通过既有预约、资源协调、接诊和文书命令准备五店归档案例。真实浏览器完成负责医师提交、另一名获委任医师审核、后台生成文件、准确补正审批、医师追加确认及第二包生成。核对原包字节不变、原治疗和资金事实不因归档而新增；无治疗和未付款场景按实际来源保留。

PostgreSQL 专项场景验证自审、跨店、职责撤回、专业范围失效、旧预览、未答疑问、缺项资料保全、生成异常重试以及并发提交、审核和生成。实际浏览器发现旧文书预览被业务规则阻止时错误返回异常，修复后显示明确继续入口，并纳入回归。网站 375、390、430 像素宽及字体放大和键盘分别检查，不替代小程序官方设备或手机验收。

固定版本发布依据为准确提交的完整回归与独立加密恢复记录。恢复至空数据库核对固定文件字节、来源清单、审核、补正、图片、权限和原资金历史；采用同版本迁移建库路径，现有一般等价结构比较限制保留。已有容量证据保留原版本与范围，本批不凭局部读取或后台文件生成宣称新一轮三十分钟容量通过。

思维导图 业务场景与实际数据 → {多端与岗位权限、初始化与重复操作、版本切换} → {资源与财务约束、通知与监测、加密恢复} → {容量与持续运行、平台及手机分别验收}

第 6 章 总结与展望

6.1 设计成果与业务价值

本文围绕连锁牙科的服务与管理过程，完成电话接待、统一资源预约、健康自述与检查、连续方案与实际执行、复诊责任与加工协同、到诊治疗、结算资金、设备维护和取消改进的业务设计。参与者、交接责任、状态、异常及最低保证通过用例和模型相互对应，使系统能够解释谁办理、依据什么、成功后得到什么，以及失败后如何继续。 初复诊完整文书进一步明确作者确认、准确临床来源、追加更正与责任期限，并与原资源周转和资金核对保持分工。

现有能力支持合成课程场景的核心运营闭环，并将取消统计推进到原因核实、实际联系、责任期限、正式另约和独立措施复核。评价重点为一次业务能否办完、异常能否继续、管理者能否解释；比率下降不直接等于服务质量改善。

6.2 下一阶段业务完善计划

现有合成系统已形成服务发布、患者关系、限定专业范围和转诊、多渠道预约、前台排班、检查方案、实际执行、复诊加工及资金设备协同。后续面向单一连锁独立部署，确认真实机构政策与专业责任，已补齐初复诊文书、作者确认、追加更正及具体治疗说明准备，已实现本人医疗沟通与决定，下一步推进患者受控复制、可靠签署、处方药事和材料执行；预约、方案讨论或账单记录不能替代完整临床专业制度。

微信小程序真实登录已通过一个账号的开发者工具联调，网站扫码确认已实现，实际手机、第二账号和教师体验仍分别待验收；真实短信尚未具备已验证免费条件，保持关闭。微信身份与患者档案、医疗同意资格分别核验，医保真实结算仍须取得具体机构资质、地区规则和接口条件。

表 6-1 以业务完整性为主的后续安排

顺序	业务交付	完成条件
身份与专业责任	明确患者与监护关系、机构及医护药事岗位权限。	资格证据可追溯，撤权、跨店和非本人访问被拒绝；新增专业权限经明确设计。
专业适用性确认	将已实现检查、方案、实际执行、随访与加工规则纳入真实服务矩阵。	由专业人员核对术语、服务字段、完成标准及加工要求，不把合成验收当成专业审定。

顺序	业务交付	完成条件
可靠签署与受控复制	患者申请与材料核验、复制范围批准、可靠签署和受控交付。	绑定正确患者与版本，保留原签署内容，按适用专业要求验收。
处方与药事	药品字典、处方、独立审方和实际调配。	未审方不进入药品计费和发药；专业资格、单位、部分执行及撤销可核对。
护理与材料	实际执行、批次效期、植入物和器械使用追溯。	患者、医嘱、执行人与批次一致；并发不得产生重复使用或负库存。
财务与外部衔接	实际诊疗与费用、预收分配、支付和所需外部接口。	临床与收费、渠道与账内资金分别核对，重复通知不重复记账。
目标环境交付	独立云端运行、微信平台试用、备份恢复及监督试用。	准确版本通过安全、业务、恢复和目标容量验收；实测地址与平台能力分别交付。

6.3 研究限制与进一步评价

课程规则尚未经过真实诊所岗位访谈确认；已实现的接待与资源规则属于课程业务方案。合成数据可检验计算、权限和一致性，不能证明真实取消行为、临床质量或收入改善。未来评价应观察患者体验、前台工作量和服务可达性，不以降低取消率作为单一目标。

课程试用使用分配账号及合成资料。微信开发工具运行、手机预览、真实微信身份换码与实际短信分别评价；前者通过不能替代后者。真实临床使用仍须由具备相应资质的人员确认业务和专业要求，公网独立运行另行验收。

思维导图 现有业务闭环 → {身份与专业责任、连续诊疗、签署归档、处方药事、护理材料} → 财务外部衔接 → 目标环境验收与监督试用。

参考文献

[1] CHEN Z. ANDREW'S DENTAL CHAIN：数据建模：W44694[Z]. 指导：Derrick Neufeld. Ivey Publishing, 2024-10-08. 课程提供案例，第 1—2 页。

[2] LEVESON N. Software Engineering Concepts：过程模型[Z]. 课程提供讲义 note__2，年份未注明. 第 4—5 页。

[3] LEVESON N. Software Engineering Concepts：Requirements Specification[Z]. 课程提供讲义 note__3，部分页版权标记 1999. 第 1—5、11 页。

[4] LEVESON N. Software Engineering Concepts：Software Design[Z]. 课程提供讲义 note__4，部分页版权标记 1999. 第 7、10—11、15—16 页。

[5] LEVESON N. Software Design Principles[Z]. 课程提供讲义 note__5，部分页版权标记 1999. 第 4—10 页。

[6] LEVESON N. Reuse and COTS[Z]. 课程提供讲义 notes__6，部分页版权标记 1999. 第 4、8—9 页。

[7] LEVESON N. Software Engineering Concepts[Z]. 16.355, Fall 2005. 课程提供讲义 note__1，第 8、18—21 页。

[8] OBJECT MANAGEMENT GROUP. Unified Modeling Language, Version 2.5.1[S/OL]. 2017[2026-09-27]. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

[9] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Deployment checklist：Django 5.2 documentation[EB/OL]. [2026-09-27]. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/howto/deployment/checklist/

[10] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Middleware：Writing your own middleware[EB/OL]. [2026-09-27]. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/http/middleware/

[11] OWASP FOUNDATION. Authorization Cheat Sheet；Session Management Cheat Sheet[EB/OL]. [2026-09-27]. https://cheatsheetseries.owasp.org/

[12] DJANGO SOFTWARE FOUNDATION. Using the Django authentication system[EB/OL].[2026-09-27]. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/auth/default/

[13] GUNICORN AUTHORS. Gunicorn Settings[EB/OL].[2026-09-27]. https://gunicorn.org/reference/settings/

[14] F5 NGINX. Module ngx_http_proxy_module[EB/OL].[2026-09-27]. https://nginx.org/en/docs/http/ngx_http_proxy_module.html

[15] W3C WAI. Understanding SC 3.3.1：Error Identification；Use Clear Step-by-step Instructions[EB/OL].[2026-09-27]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/error-identification.html

[16] OPEN DENTAL. Appointment Views[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/appointmentviews.html（访问日期 2026-10-18）.

[17] ODOO. Search filter and group records[EB/OL]. https://www.odoo.com/documentation/19.0/applications/essentials/search.html（访问日期 2026-10-18）.

[18] W3C. Understanding Reflow[EB/OL]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/reflow.html（访问日期 2026-10-18）.

[19] W3C. Understanding Target Size Minimum[EB/OL]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/target-size-minimum.html（访问日期 2026-10-18）.

[20] W3C. Understanding Focus Not Obscured Minimum[EB/OL]. https://www.w3.org/WAI/WCAG22/Understanding/focus-not-obscured-minimum.html（访问日期 2026-10-18）.

[21] 湖南省医疗保障局 湖南省人力资源和社会保障厅. 关于确定耳鼻喉、神经系统等九大类医疗服务项目医保支付政策的通知 湘医保发〔2026〕12 号[EB/OL]. https://ybj.hunan.gov.cn/ybj/first113541/firstF/f3113607/202603/t20260331_33945644.html（访问日期 2026-10-25）.

[22] 微信开放文档. 小程序登录[EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/open-ability/login.html（访问日期 2026-10-25）.

[23] 微信开放文档. 获取不限制的小程序码[EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/server/API/qrcode-link/qr-code/api_getunlimitedqrcode.html（访问日期 2026-10-25）.

[24] 腾讯云开发. 发送与验证短信验证码[EB/OL]. https://docs.cloudbase.net/http-api/auth/auth-send-verification ; https://docs.cloudbase.net/http-api/auth/auth-verify-verification（访问日期 2026-10-25）.

[25] 微信开放文档. 手机号快速验证组件[EB/OL]. https://developers.weixin.qq.com/miniprogram/dev/framework/open-ability/getPhoneNumber.html（访问日期 2026-10-25）.

[26] 长沙市口腔医院. 专家目录[EB/OL]. https://www.csskqyy.cn/keshijss/zhuanjia/（访问日期 2026-10-26）.

[27] Open Dental. Provider[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/providerseditwindow.html（访问日期 2026-10-26）.

[28] Open Dental. Production and Income[EB/OL]. https://www.opendental.com/manual/productionincome.html（访问日期 2026-10-26）.

[29] 国家卫生计生委 国家中医药管理局. 电子病历应用管理规范 试行[EB/OL]. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_59868.html（访问日期 2026-10-29）.

[30] 国家卫生健康委员会. 病历书写基本规范 第十条[EB/OL]. https://www.nhc.gov.cn/wjw/c100175/201002/b1bec53d90f243e0861529723f00221a.shtml，2026-11-01 核对。

[31] 国务院. 医疗纠纷预防和处理条例 第十三至十五条[EB/OL]. https://xzfg.moj.gov.cn/front/law/detail?LawID=438，2026-11-01 核对。

[32] 国家卫生计生委，国家中医药管理局. 电子病历应用管理规范（试行），第十四至十七条[EB/OL]. https://www.beijing.gov.cn/zhengce/zhengcefagui/201905/t20190522_59868.html，2026-11-01 核对。

附录 A 基础系统用例规约

本附录给出 SU-01—25 及共享核验 SF-01。规约以业务目标、交互、正常与异常结果为核心；验收编号为需求追踪标识，功能完成状态见第 5 章。

附录中固定 30 分钟、200 个候选格及最大匹配描述适用于未启用资源控制的历史模式。已启用资源控制的诊所按 SU-54 与 SU-57 核对服务时长、椅位和必要设备，并按登记与可行时间先后生成建议；14 天候补范围、明确接受、发布重检和原承诺保护继续适用。

SU-01　登录、选择与切换身份

表 A-1 SU-01　登录、选择与切换身份用例规约

标题	内容（SU-01）
用例名称	SU-01　登录、选择与切换身份
执行者／触发	所有系统用户；登录或点击“切换身份”。
涉众利益	账号使用者希望少走无效步骤；机构需防止身份混用和越权。
前置条件	能够打开登录页，已通过受控方式取得账号；本用例包含凭据校验，不把登录成功当作前置条件。
基本路径	1）账号使用者提交账号和密码；系统验证凭据及账号状态。2）系统核对有效身份；无身份时反馈待授权，唯一身份时正式激活，多身份时由账号使用者选择后激活。3）系统再次核验授权并清除旧诊所范围；前台／主管随后通过 SU-02 选择诊所。4）账号使用者请求切换时，系统仅提供有效身份；唯一身份不增加重复选择。
扩展路径	凭据错误或账号停用：留在登录入口，反馈不泄露账号是否存在。 无身份／选择期间撤权：说明原因并提供退出；不授予新身份。 旧标签页提交：拒绝并要求核对当前身份与诊所；不得借用账号的其他身份。
成功结果	只改变当前工作身份，不增加权限，不改变已有业务记录。
最低保证	失败不进入受保护工作区，不改变患者、预约或账单。
追踪与状态	BR-01；AT-01；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-02　选择与切换诊所

表 A-2 SU-02　选择与切换诊所用例规约

标题	内容（SU-02）
用例名称	SU-02　选择与切换诊所

标题	内容（SU-02）
执行者／触发	当前为前台或主管的用户；进入角色首页或点击“切换诊所”。
涉众利益	前台／主管需明确当前店；其他诊所不应因切换受误操作影响。
前置条件	账号已登录并激活前台或主管身份。可进入的诊所集合由系统核验；空集合属于本用例的替代结果。
基本路径	1）系统反馈当前前台／主管身份可进入的诊所。2）前台／主管提交选定诊所；系统验证该身份与诊所的授权关系。3）系统激活选定诊所范围并反馈当前范围；不改变工作身份。
扩展路径	没有有效诊所：说明原因，不展示合并数据。 目标诊所停用或无授权：拒绝，不能借用另一角色的范围。 切换后旧表单提交：拒绝并要求刷新。
成功结果	当前店明确；另一家店的业务不会混入当前查询或提交。
最低保证	选择失败不激活未授权诊所；合法切换不修改业务记录，旧页不得沿用原范围提交。
追踪与状态	BR-01；AT-02；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-03　建立与查阅患者档案

表 A-3 SU-03　建立与查阅患者档案用例规约

标题	内容（SU-03）
用例名称	SU-03　建立与查阅患者档案
执行者／触发	前台建档；负责牙医查阅授权记录；新患者需要建档，或工作人员需要查阅。
涉众利益	患者希望跨店资料一致且隐私受保护；工作人员需可靠识别患者。
前置条件	有效工作身份与范围；仅使用合成资料。
基本路径	1）前台提交识别条件；系统检索既有患者，支持跨店复用编号，不按相同电话自动合并。2）前台为新患者提交姓名、出生日期、账单地址、电话、可选邮箱、紧急联系人及逐项过敏资料。3）系统校验资料并分配稳定编号；负责牙医请求查阅时，系统只反馈获授权的接诊所需资料。
扩展路径	疑似重复：提示核对，不按相同电话自动合并。 必填缺失、未来出生日期或过敏状态矛盾：阻止保存。 无关联/无授权的直接访问：拒绝，不泄露资料。
成功结果	成功建档产生一份可查询档案；查阅不修改数据。患者业务编号不是登录凭证；完整编辑／合并不在本次实现范围。
最低保证	建档失败不留部分档案；查阅失败不暴露对象，疑似重复不自动合并患者。
追踪与状态	BR-02；AT-03；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-04　创建预约

表 A-4 SU-04　创建预约用例规约

标题	内容（SU-04）
用例名称	SU-04　创建预约
执行者／触发	具有有效本人或代约入口的账号，或当前诊所前台；患者通过网站、微信小程序、电话或现场明确提出预约。
涉众利益	患者需要可理解的就诊安排；前台和医师避免冲突，并保留明确同意及原承诺。
前置条件	完整有效患者档案、可接收的出诊；已启用诊所提供服务和资源目录，工作人员有当前店权限，当前选择为本人或经核验的本店代约患者。
基本路径	1）核对患者及服务、日期和医师偏好。2）系统按服务时长查询科室、出诊、椅位及设备的可行组合。3）患者选定方案；复述诊所、服务、医师及起止时间，取得同意。4）执行 SF-01 并重检授权和资源。5）同一事务保存唯一预约与占用，电话接待同步关联成功结果。
扩展路径	无资源则协商或经同意转候补；联系未果保存责任及期限。冲突、旧预览或撤权时返回重新核对，原承诺保留。候补已有成功结果则关联原预约；重复确认返回原效果。
成功结果	获得唯一且可查的正式预约及资源方案；服务意向不产生实际治疗或收费。
最低保证	失败不新增部分预约或占用，不改变其他患者安排，不按电话推定身份或来源。
业务规则	15 至 240 分钟、15 分钟步长，整段占用；网站、小程序及候补未来十四天，前台按已发布排班。本人改期按已实现的 SU-40 办理，继续核对相同资源和唯一结果。
追踪与状态	BR-03；AT-04；功能范围及业务测试见第 5 章。
渠道说明	小程序使用分配的课程账号登录，共用当前患者授权与资源核验；本地客户端已联通预约服务。微信开发者工具、真机及体验版发布须单独验收，不把微信请求来源当作患者身份。

SU-05　调整预约结果

表 A-5 SU-05　调整预约结果用例规约

标题	内容（SU-05）
用例名称	SU-05　调整预约结果

标题	内容（SU-05）
执行者／触发	当前诊所前台；本人或有效代约人在授权范围取消预约，或按 SU-40 申请改期。
涉众利益	患者明确确认变更；诊所保留取消原因、原承诺及改期历史。
前置条件	有效身份和对象范围，原预约处于允许状态且修订号有效。患者自助仅针对未开始的已预约记录。
基本路径	1）核对原预约、当前状态及操作目的。2）患者取消时填写原因并明确确认；改期按 SU-40 核对同店同服务的新方案。前台还可按原业务规则办理本店取消、改期或核实爽约。3）系统重检授权、版本、时间及资源，在同一事务保存结果和历史。4）显示当前记录、合法关联结果及后续办理入口。
扩展路径	尚未达到核实条件时不能认定爽约。已到诊或结束、无权限、旧版本或资源冲突时拒绝不适用操作；改期失败保留原约。患者无法在线办理时联系原诊所前台，不能因联系未果自动取消。
成功结果	取消、改期或已核实爽约分别保存事实；改期保留原记录和唯一后继，取消保留发起方、原因及跟进依据。
最低保证	失败不新增部分预约或占用、不改变原状态；历史记录不删除，不制造治疗或资金。
业务规则	网站与小程序支持本人或有效代约患者改期及候补邀约替换，见 SU-40；前台可协助。取消与改期不混计，技术请求重复不能产生重复业务效果。
追踪与状态	BR-04；AT-05；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-06　登记实际到诊

表 A-6 SU-06　登记实际到诊用例规约

标题	内容（SU-06）
用例名称	SU-06　登记实际到诊
执行者／触发	当前诊所前台；工作人员选择“登记到诊”。
涉众利益	患者与牙医需真实到诊队列；管理者不应得到虚假的出勤指标。
前置条件	当前前台身份和诊所范围有效，目标为已预约；前台须在路径中确认真实到达。系统只核验提交的登记信息，不能独立感知患者到店。
基本路径	1）前台核对本店预约，提交已确认真实到达的到诊登记请求。2）系统核验当前店权限、原预约状态及修订号。3）系统保存到诊标志、实际到诊时间与事件，并反馈登记结果。真实到达由前台核实，不由软件自行感知。
扩展路径	已经取消/爽约/改期替代：拒绝直接到诊。 旧修订号或授权撤回：拒绝并提示刷新。 重复或失败请求不产生第二次独立接诊。

标题	内容（SU-06）
成功结果	到诊=true，状态已到诊；此时尚无治疗完成或收款事实。
最低保证	校验失败不新增到诊时间；重复请求不产生第二次到诊事件或越过终态限制。
追踪与状态	BR-04；AT-06；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-07　复核信息与记录实际治疗

表 A-7 SU-07　复核信息与记录实际治疗用例规约

标题	内容（SU-07）
用例名称	SU-07　复核信息与记录实际治疗
执行者／触发	本次负责牙医；从接诊队列进入工作区。
涉众利益	患者需准确治疗与过敏记录；牙医需保留已存草稿和专业责任。
前置条件	牙医身份有效，目标本人负责且已到诊。
基本路径	1）牙医请求办理本人已到诊接诊；系统反馈获授权的主诉与过敏知识状态。2）牙医提交当次复核结果，以及实际治疗项目、标准单位、数量和当时单价。3）系统验证并保存治疗草稿；误录草稿由牙医说明原因后请求撤回。本任务不自动关闭接诊，结束须另行明确请求 SU-08。
扩展路径	未知过敏可以保存草稿，但不能当作已确认无过敏。 数量/价格不合法或页面过期：阻止保存。 已发布内容不在此处直接修改；非本人接诊拒绝。
成功结果	实际治疗草稿可供后续核对；SU-08 必须由牙医另行明确启动。已发布版本不可从本页原地改写。
最低保证	本次失败不新增治疗行；之前已保存草稿不丢失，历史已发布内容不受影响。
追踪与状态	BR-02、BR-05；AT-07；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-08　完成就诊并生成结算单

表 A-8 SU-08　完成就诊并生成结算单用例规约

标题	内容（SU-08）
用例名称	SU-08　完成就诊并生成结算单
执行者／触发	本次负责牙医；核对后明确关闭本次接诊。
涉众利益	患者需可核对费用；机构需闭合状态与唯一结算一致。
前置条件	已登录为本次负责牙医；目标可查阅。首次完成须已到诊；已经完成的重复请求走既有结果分支。

标题	内容（SU-08）
基本路径	1）系统反馈待核对的项目、数量、单价、行小计与总额。2）牙医核对后明确请求治疗完成；确无治疗时请求无治疗关闭并提交原因。3）系统验证完成条件，一并保存已发布内容、唯一结算单、闭合状态及事件，反馈结果；已成功完成的授权重试返回既有结算单。
扩展路径	有实际治疗但过敏未复核、数据不完整或数值非法：指出缺口，不完成。 有治疗却选无治疗：拒绝；确无治疗可保留未知信息，填写原因后生成零明细零金额单。 首次完成的中途失败：本次关闭与开单全部撤销；经授权核验的重复完成返回既有结算单。
成功结果	闭合就诊恰有一张逻辑结算单；到诊仍为 true；不代表已收款。
最低保证	失败不出现“已闭合却无结算单”或半张账单；已成功完成的结果不得因重试再创建。
追踪与状态	BR-04、BR-05；AT-08；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-09　查阅与打印结算单

表 A-9 SU-09　查阅与打印结算单用例规约

标题	内容（SU-09）
用例名称	SU-09　查阅与打印结算单
执行者／触发	本人患者、授权前台/负责牙医/财务；用户打开账单或选择历史版本。
涉众利益	患者需看懂本人的费用；机构需保护历史及他人隐私。
前置条件	账单已发布；对象属于当前允许范围。
基本路径	1）患者／获授权工作人员提交目标结算单或历史版本的查阅请求。2）系统核验对象范围，反馈单号、患者、诊所、牙医、时间及对应版本的实际治疗明细和总额。3）患者／工作人员可请求打印已发布版本；系统标识历史版本“非当前”，不增加交易。
扩展路径	其他患者/诊所的对象：拒绝。 草稿版本不对患者公开；未开单不解释为免费。 历史打印明确“非当前”，不新增一笔交易。
成功结果	只读展示；任何目录调价不改变历史单据内容。
最低保证	本用例只读，不因查看或打印改变账单、增加收入或使患者看到他人的资料。
追踪与状态	BR-05；AT-09；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-10　申请与审核账单数字更正

表 A-10 SU-10　申请与审核账单数字更正用例规约

标题	内容（SU-10）
用例名称	SU-10　申请与审核账单数字更正
执行者／触发	负责牙医申请；不同账号的财务审核；发现原治疗行数量或单价误录。
涉众利益	患者需纠正误录；机构需独立审核、不覆盖原账单历史。
前置条件	基版仍为当前版；无另一待审核申请；在允许更正范围内。
基本路径	1）牙医选定一条原治疗行，提交正确数量或单价及事实依据。2）系统核验基版与申请条件，形成完整草稿，原版继续有效。3）不同账号的财务核对差异并明确批准或拒绝。4）系统在批准时一并发布后继版本、更新同一账单当前指针并保留历史。
扩展路径	同账号切换财务身份自批：仍拒绝。 基版已变化、撤权或非法数值：不发布。 拒绝/技术失败保留原版；不支持项目增删、身份或退款纠错。
成功结果	单号不变，旧版可查；收入只计当前有效版。
最低保证	批准失败或拒绝时旧版本继续有效；已发布历史不覆盖，未审核草稿不计入收入。
追踪与状态	BR-05、BR-06；AT-10；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-11　形成季度成本与利润核对

表 A-11 SU-11　形成季度成本与利润核对用例规约

标题	内容（SU-11）
用例名称	SU-11　形成季度成本与利润核对
执行者／触发	财务维护；总部授权查阅；选择季度进行核对。
涉众利益	总部需可信季度结果；牙医需避免漏计成本或重复计算收入。
前置条件	自然季度与纳入范围明确，当前角色允许读或写。
基本路径	1）财务提交季度和纳入牙医，包括有成本但无收入者。2）财务逐人提交并确认用品成本、运营费用及依据。3）财务确认人员范围；系统检查遗漏开单人员和未确认成本。4）资料满足条件时，系统反馈收入、利润贡献、总体基金、期间与查询时点；总部按只读授权核对结果。
扩展路径	未填与确认零值分开；资料不全不发布完整利润。 零/负总体利润：基金政策待确认，不生成负奖金。 旧页面修订号、权限或跨季度对象不符：拒绝写入。

标题	内容（SU-11）
成功结果	结果带期间、查询时点与口径；不是奖金发放或不可变关账报表。
最低保证	未确认成本不被默认为零；失败不半途确认人员清单，不对缺失数据发布完整利润。
追踪与状态	BR-06；AT-11；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-12　查询运营指标

表 A-12 SU-12　查询运营指标用例规约

标题	内容（SU-12）
用例名称	SU-12　查询运营指标
执行者／触发	本店主管或授权总部；用户提交只读筛选条件。
涉众利益	主管需可解释指标；患者和牙医不应被错误统计结论误导。
前置条件	有当前范围和明确日期区间。
基本路径	1）主管／总部提交授权范围内的日期筛选条件。2）系统按计划日期筛选已到结束时间的就诊，区分到诊、患者取消、诊所取消、爽约与待核实。3）系统反馈分子、分母、样本量、查询时刻及缺失说明，不改变业务状态。
扩展路径	未来预约与被改期替代记录不混入主要分母。 零分母显示 N/A；未判定记录不假装为爽约。 范围外查询被拒绝，不用费用或少量样本判断临床能力。
成功结果	只读结果可解释，数据不因查询改变。
最低保证	只读查询不改状态；非法范围不扩大权限，零分母不显示为 0%。
追踪与状态	BR-10；AT-12；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-13　登记或退出候补

表 A-13 SU-13　登记或退出候补用例规约

标题	内容（SU-13）
用例名称	SU-13　登记或退出候补
执行者／触发	本人患者或该店前台；无合适时段，或者不再需要等待。
涉众利益	患者需保留时间选择权；诊所需区分等待偏好与正式承诺。
前置条件	患者及诊所有效、当前主体获授权；本用例校验时间窗口和现有候补，不预设输入已合法。

标题	内容（SU-13）
基本路径	1）患者提交诊所、可选牙医及连续可接受区间；前台代办时另核对患者编号。2）系统核验最早可开始和最晚必须结束时间，至少容纳 30 分钟且在滚动 14 天范围内；区间不是每天重复时段。3）患者／前台明确确认这只是偏好；系统重验时间与唯一有效候补，保存等待安排。4）患者／前台请求退出并确认后，系统撤回未接受邀约并保留历史；已成预约须走 SU-05，不由退出候补取消。
扩展路径	过去时间、倒置区间或不足 30 分钟：在对应字段指出具体原因，不使用笼统合并提示。 页面停留后时间失效、已有有效候补、账号／诊所停用：拒绝，不留下第二条有效需求。 需求已转预约：不删除正式预约；引导到预约详情。
成功结果	登记不是预约；退出不删除历史，也不取消其他正式预约。
最低保证	非法登记不产生第二条有效候补；退出不删除历史，也不取消已成立的预约。
追踪与状态	BR-07；AT-13；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-14　生成有限排程建议

表 A-14 SU-14　生成有限排程建议用例规约

标题	内容（SU-14）
用例名称	SU-14　生成有限排程建议
执行者／触发	当前诊所前台；前台请求生成候选安排。
涉众利益	前台需可行且有边界的建议；患者既有预约不得被自动移动。
前置条件	当前诊所前台身份与范围有效；本用例负责检查有无候补需求与可用出诊，不把“必有可行方案”当成前置条件。
基本路径	1）前台请求生成本店建议；系统按登记顺序纳入最多 60 条需求、80 个出诊块，并枚举最多 200 个 30 分钟候选格。2）系统排除当前预约、有效保留、时间及牙医偏好冲突。3）系统在有限二部图中求最大匹配，保存并反馈草案、未安排项、生成时点及截断范围；不占位，不移动既有预约。
扩展路径	无候选：展示未安排及原因范围，不伪造可行解。 达到上限：说明仅处理枚举范围，不称全域最优。 此步骤不锁定时段；求解后可用性仍可能变化。
成功结果	仅保存草案；不修改已有预约，不声称椅位/资格/通勤优化。
最低保证	无候选或计算失败只给出说明；不产生邀约、不占用时间、不移动已有预约。
追踪与状态	BR-08；AT-14；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-15　核对并发布限时邀约

表 A-15 SU-15　核对并发布限时邀约用例规约

标题	内容（SU-15）
用例名称	SU-15　核对并发布限时邀约
执行者／触发	当前诊所前台；前台核对建议后确认发布。
涉众利益	患者需明确确认期限；前台需避免半批发布及过期草案生效。
前置条件	草案属于本店，未发布且生成未超过 15 分钟。
基本路径	1）前台核对本店草案、生成时点、所涉需求和候选时间，明确请求发布。2）系统执行 SF-01 并重验授权、需求修订及占用。3）全部通过时，系统整批建立限时邀约；期限为发布后 15 分钟或预约开始时刻的较早者。4）系统反馈发布结果及确认期限；正式预约数不因发布而增加。
扩展路径	任一项已变化或发生冲突：整批不发布，提示重新生成。 空草案/过旧草案：拒绝发布。 重复成功提交返回既有结果，不增加同一请求的邀约。
成功结果	请求转等待确认；邀约暂占资源，但正式预约数不因发布增加。
最低保证	任何一项不再可行则本批不发布；不得只发一部分而回执声称整批失败。
追踪与状态	BR-07、BR-08；AT-15；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-16　接受或拒绝候补邀约

表 A-16 SU-16　接受或拒绝候补邀约用例规约

标题	内容（SU-16）
用例名称	SU-16　接受或拒绝候补邀约
执行者／触发	本人患者或当前诊所前台；用户主动查看邀约并作出决定。
涉众利益	患者保留最终决定权；诊所需保证一次确认仅形成一条预约。
前置条件	已登录为本人患者或有当前店权限的前台；能读取目标邀约。首次接受须待确认且未过期；已接受的重试另行核验关联预约。
基本路径	1）患者请求查阅本人邀约；前台在当前店代办时取得患者明确意思。2）系统反馈诊所、牙医、时段与截止；患者／前台明确选择接受或拒绝。3）接受时系统执行 SF-01 并排除自身保留，重验有效性后同步保存预约、候补及邀约关联。4）拒绝时系统释放保留并恢复等待；接受成功时系统反馈准确关联的预约供核对。

标题	内容（SU-16）
扩展路径	拒绝有效邀约：不创建预约，释放保留；需求恢复等待。 首次接受已过期、被撤回或已冲突的邀约：拒绝并解释下一步，不创建预约。 已接受的重复请求：先核验当前权限及关联预约，返回同一预约，不因原确认期已过而创建新预约或误报原预约不存在。 当前主体无权、上下文已变或保存失败：拒绝／回滚；无法确定请求结果时先查询既有结果，不盲目重建。
成功结果	接受恰形成一条正式预约；拒绝不形成预约、不删除需求。
最低保证	一次成功接受只关联一条预约；失败不半途释放尚有效的保留后丢失原机会。
追踪与状态	BR-07；AT-16；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-17　回收过期邀约

表 A-17 SU-17　回收过期邀约用例规约

标题	内容（SU-17）
用例名称	SU-17　回收过期邀约
执行者／触发	当前诊所主管或前台；在候补页明确执行回收。
涉众利益	候补患者需重新参与匹配；已确认预约不得被清理误删。
前置条件	有本店到期仍待处理的邀约。
基本路径	1）主管／前台请求回收本店过期邀约，核对影响后确认。2）系统按当前时刻核验应处理对象，并将到期未确认邀约标为过期。3）系统恢复相应候补的等待状态，保留历史；每批最多 200 条，可继续处理剩余项。到期是否有效不依赖后台或本次清理。
扩展路径	仍有效、已接受或其他店邀约不受影响。 单次最多 200 条；剩余可再次执行。本版没有后台自动回收；过期时间本身已使保留不再阻挡新预约。
成功结果	历史保留；回收不删除已经成立的预约。
最低保证	回收只作用于应到期的未确认邀约；不改变已接受邀约或删除正式预约。
追踪与状态	BR-07；AT-17；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-18　获取操作引导

表 A-18 SU-18　获取操作引导用例规约

标题	内容（SU-18）
用例名称	SU-18　获取操作引导

标题	内容（SU-18）
执行者／触发	患者、牙医、前台、主管、总部、财务；用户提问或从任务目录选择指南。
涉众利益	初次使用者需找到真实办理路径；机构需防止越权与虚假成功说明。
前置条件	已选有效工作身份；普通业务无需 AI 也可用。
基本路径	1）业务用户提交办理意图或选定任务；系统依据当前身份匹配适用指南，不明确时先澄清。2）仅经同意，系统可请求外部模型识别白名单意图；无钥、不同意或故障时系统明确使用本地模式。3）系统按维护目录反馈真实页面、条件与操作步骤，不把记录治疗扩大为结束接诊。4）业务用户自行办理并确认；说明进度不等于业务完成。候补结果可另用 SU-24 核对，其他任务尚无通用事实核对能力。
扩展路径	换身份/诊所：旧引导失效；网络返回后再次检查上下文。 模型失败明确降级；不伪造链接或办理成功。 医学判断转人工；无权任务说明切换已有身份，不新增授权。
成功结果	聊天无业务写入；只有实际业务页面提交才可能改变记录。
最低保证	不自行选患者、提交或宣布成功；错误分类可返回任务目录，原业务表单仍可用。
追踪与状态	BR-09；AT-18；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-19　新增牙医出诊时段

表 A-19 SU-19　新增牙医出诊时段用例规约

标题	内容（SU-19）
用例名称	SU-19　新增牙医出诊时段
执行者／触发	当前诊所前台；新增供预约/排程使用的可用时间。
涉众利益	前台需协调本店可用时间；牙医需避免跨店出诊重叠。
前置条件	牙医及本店有效；时段在未来。
基本路径	1）前台提交本店有效牙医及未来出诊起止时间。2）系统核验当前范围、牙医状态、时间顺序及跨店出诊重叠。3）前台明确确认后，系统保存出诊安排与事件并反馈结果；这本身不等于患者预约或临床资格确认。
扩展路径	无当前店权限、牙医停用、开始晚于结束或冲突：拒绝。 既有时段变更另见 SU-29／30；不能任意覆盖原时间。 新增时段不意味着医学资格适配或椅位资源已保证。
成功结果	形成可查询的出诊安排；患者仍须另行确认预约。
最低保证	冲突或校验失败不写入新的出诊时段；已有预约和出诊记录保持不变。

标题	内容（SU-19）
追踪与状态	BR-03；AT-19；功能范围及业务测试见第 5 章。
重复与旧页	新增先预览再明确确认，同一有效操作重复或并发确认返回同一出诊；授权撤销、身份切换或预览后冲突拒绝且不留下部分记录。

SU-20　选择显示方式与非聊天帮助

表 A-20 SU-20　选择显示方式与非聊天帮助用例规约

标题	内容（SU-20）
用例名称	SU-20　选择显示方式与非聊天帮助
执行者／触发	所有系统用户；用户调整字号、使用键盘或进入帮助目录。
涉众利益	不同使用习惯的人需可达的操作方式；个人资料不应被自动外传。
前置条件	已打开支持的页面；业务入口依然存在。
基本路径	1）账号使用者自主选择标准／大字简明模式，系统不按年龄强制分流。2）系统保留文字、键盘、普通业务和可返回退出的说明路径。3）账号使用者主动请求朗读时，系统仅在设备有可用本地中文声音时提供朗读，不自动录音或上传云端。
扩展路径	无可用语音：保留文本，不自动上传云端语音。 JavaScript 或 AI 不可用：服务端普通表单仍可使用。 切换身份前提示未提交内容；不声称已自动保存草稿。
成功结果	用户明确当前模式与进度；无自动录音、病情上传或业务提交。
最低保证	显示方式调整不改变业务资料；无语音或外部 AI 时保留文字、键盘与普通操作路径。
追踪与状态	NFR-02；AT-20；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-21　维护普通账号与业务授权

表 A-21 SU-21　维护普通账号与业务授权用例规约

标题	内容（SU-21）
用例名称	SU-21　维护普通账号与业务授权
执行者／触发	当前具备有效技术管理身份的维护人员；为演示用户开户、授权、停用、绑定或重置密码。
涉众利益	业务人员需取得适当权限；患者与机构需避免误绑定和擅自提权。

标题	内容（SU-21）
前置条件	操作者的技术授权有效；能够核对目标账号与操作依据。此页不维护自身或技术管理／超级用户目标。
基本路径	1）技术管理人员重新验证本人密码，核对目标账号与当前状态，并提交理由。2）系统按明确请求创建默认无业务身份的普通账号，或授予／撤回允许的身份和诊所范围。3）技术管理人员核对既有患者后请求绑定；系统不允许自行认领或覆盖已有绑定。4）系统执行获准的启用、常规停用或密码重置，保存审计并使受影响旧工作上下文失效；未闭合业务的常规处理限制不变。
扩展路径	密码错误、目标已变或旧表单：拒绝并要求重核。 给自己提权、发放技术身份、组合错误范围、牙医关联无效：拒绝。 已有患者或牙医关联不覆盖；未闭合业务阻止正常退役或受限撤权。凭据失效的账号须先受控重置密码，再明确启用，不自动恢复旧会话。
成功结果	成功变更仅作用于核对过的目标；默认不开放临床资料，也不删除业务历史。
最低保证	任一校验或审计失败时本次管理操作不部分生效；密码不写入操作说明与日志。
追踪与状态	BR-01、BR-11；AT-21；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-22　修改本人密码

表 A-22 SU-22　修改本人密码用例规约

标题	内容（SU-22）
用例名称	SU-22　修改本人密码
执行者／触发	已登录的账号使用者；用户从工作台打开“修改我的密码”。
涉众利益	账号使用者需安全更换凭据；已有授权与业务应保持不变。
前置条件	当前会话有效，并能提供原密码；遗忘原密码不属于本用例。
基本路径	1）账号使用者提交当前密码和两次一致的新密码。2）系统验证原凭据、新密码规则及当前会话；账号使用者明确确认。3）系统保存新凭据，要求重新登录并重新确定身份及必要诊所范围；不改变角色、患者绑定和业务记录。
扩展路径	两次新密码不一致、原密码错误或新密码不符合规则：显示字段原因，不保存。 身份变化或页面过期：拒绝，重新开始。 遗忘密码：引导到受控管理员重置，不通过该页面跳过旧密码核验。
成功结果	仅本人登录凭据发生变化；角色、患者绑定、预约和账单不改变。
最低保证	失败保留旧凭据；不在页面、聊天或日志回显密码。
追踪与状态	BR-11；AT-22；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-23　维护标准治疗目录与当前单价

表 A-23 SU-23　维护标准治疗目录与当前单价用例规约

标题	内容（SU-23）
用例名称	SU-23　维护标准治疗目录与当前单价
执行者／触发	财务维护；总部只读；新增标准项目，或因业务依据调整当前标准单价。
涉众利益	财务需维护标准单价；患者与总部需保证历史费用不被回溯改写。
前置条件	当前财务／总部身份及权限有效；写操作仅财务。目标为允许维护的标准治疗目录，不是某次就诊的账单。
基本路径	1）财务／总部请求查阅标准目录；系统反馈编码、名称、单位和当前单价。2）财务提交未使用编码的新项目，或既有项目的新单价与依据，并明确确认。3）系统重新核验权限、目标状态和数值，一并保存目录变更及审计。4）新录入治疗按相应计价规则办理；系统不回写已存治疗快照或已发布账单。
扩展路径	总部只有查阅能力；其他身份不能借目录入口改价。 重复编码、非有限／负金额、超过两位小数、依据不足：明确拒绝，不自动舍入用户单价。 目标已变化、过期页面、撤权或审计失败：不变更；本例不支持删除目录、回溯调价或替代账单更正。
成功结果	目录当前单价可查；已保存治疗与历史结算单保持原值。
最低保证	目录和审计一起成功或一起撤销；不以改变目录方式修改历史收入。
追踪与状态	BR-05、BR-12；AT-23；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-24　核对候补是否已转预约

表 A-24 SU-24　核对候补是否已转预约用例规约

标题	内容（SU-24）
用例名称	SU-24　核对候补是否已转预约
执行者／触发	本人患者或当前诊所前台；在选定候补或邀约页点击只读核对；尤其是确认后未见回执、不确定是否办成。
涉众利益	患者需辨别准确办理结果；前台需避免因回执未知重复建立预约。
前置条件	已登录并激活患者／前台身份；前台已选店。目标可访问性、页面上下文和记录一致性由本用例核验，不预设已办理成功。

标题	内容（SU-24）
基本路径	1）患者／前台选定具体候补并请求核对，不自动换成他人或最近一条预约。2）系统重验当前身份、本人／本店范围与页面上下文，读取该请求及直接关联邀约、预约的必要事实。3）系统先核对已接受历史与关联，再区分当前取消、改期替代、到诊或结束；返回前复核当前授权。4）系统反馈读取时点、规则版本和下一步，仅在关联一致时提供准确入口。5）业务只读模式仍允许此核对，但不赋予接受、撤回、创建或其他业务写入权限。
扩展路径	无权或记录不存在：不给他人详情；切身份、切店、撤权或旧页面：停止核对并要求返回工作台。 首次确认机会已过期：说明不能首次接受；已转预约不因原截止时间已过而消失。关联缺失／矛盾：提示前台核对，不猜测成功。 读取暂不可用：提示结果未知、不代表此前失败，不自动重发。刷新后的状态可能变化，正式业务提交仍独立核验。
成功结果	返回所选候补在读取时点的受限结论及真实操作入口；不把历史转换与当前有效预约混淆。
最低保证	本用例不更改患者、预约、候补、邀约或账单；不调用外部模型，不查临床内容，不以查询失败推断原办理失败。
追踪与状态	BR-01、BR-07、BR-13、NFR-03、NFR-04、BR-14；AT-24；功能范围及业务测试见第 5 章。

SU-25　紧急安全封禁普通账号

表 A-25 SU-25　紧急安全封禁普通账号用例规约

标题	内容（SU-25）
用例名称	SU-25　紧急安全封禁普通账号
执行者／触发	当前技术管理人员；发现普通账号疑似泄露，需要立即阻止后续访问。
涉众利益	机构需及时阻止受损账号访问；患者与牙医的既有承诺仍须保留。
前置条件	操作者有有效技术身份并可重新验证自己的密码；目标不是本人、技术管理或超级用户账号。未闭合业务不是本用例的阻断条件。
基本路径	1）系统反馈目标账号状态及封禁影响：停用、使原凭据失效，保留角色、患者关联和既有业务。2）技术管理人员提交依据，重新验证本人密码，并明确确认紧急封禁。3）系统重验操作者、目标状态和只读限制，一并停用目标、失效原凭据及旧工作上下文并保存审计。4）系统反馈结果和恢复方式：先受控重置密码，再单独启用；业务责任交接由获授权人员另行办理。
扩展路径	操作者密码错误、目标签名过期、越权或只读实例：拒绝，不改变账号。 目标受保护或已经停用：提示按受控恢复／维护流程处理，不重复授予权限。 审计或保存失败：回滚账号与上下文变更；网络回执未知时先重新查询，不声称已经封禁。

标题	内容（SU-25）
成功结果	提交生效后，目标不能凭原密码或旧会话继续发起受保护操作；预约、候补、治疗及账单未被该操作取消或转移。
最低保证	失败不部分封禁；不修改专业责任归属。封禁不撤销其提交前已经完成的业务，也不承诺清除浏览器已显示的信息。
追踪与状态	BR-01、BR-11、BR-15；AT-25；功能范围及业务测试见第 5 章。

SF-01　核验时间与占用（共享子功能）

表 A-26 SF-01　核验时间与占用（共享子功能）用例规约

标题	内容（SF-01）
用例名称	SF-01　核验时间与占用（共享子功能）
调用关系	SU-04 创建预约和 SU-15 发布邀约必须执行；SU-16 仅接受分支复用。无独立用户入口。
输入及前置	提供患者、牙医、诊所、起止时间及可排除的自身保留；上层已识别主体，但仍需核验当前权限及对象范围。
行为	检查时间顺序、有效出诊覆盖和已有预约／邀约冲突；查询可用性不形成保留，写入前再次核验。
结果与最低保证	返回可继续办理或具体失败原因；核验本身不创建预约。现有合同不保证椅位、设备或通勤，后续资源扩展不得绕过统一核验。

附录 B 维护 协调与通知用例规约

SU-26—38 说明资料维护、出诊协调和站内任务消息。消息仅提示办理，不代替患者同意、任务受理或资金事实；资料更正、出诊维护及重试按各自业务流程办理。

SU-26　更正患者联络资料

表 B-1 SU-26　更正患者联络资料用例规约

标题	内容（SU-26）
用例名称	SU-26　更正患者联络资料
业务问题与涉众	当前档案已经能够建档和查阅，但电话、邮箱或地址发生变化后，前台缺少受控更正入口。患者希望后续联系准确；前台希望一次核对后保存；负责牙医不希望临床内容被联络维护改变；财务希望历史单据仍能反映当时结算依据；维护人员希望差异、责任与重复请求有明确规则。
执行者	当前激活前台身份并选择授权诊所的工作人员。患者为资料涉众，本用例不开放患者自行编辑。
触发	前台取得患者说明，需要更新联络资料或更正已核对的录入错误。
前置	账号已登录，前台工作上下文存在。对象关联、权限是否仍有效、输入是否合法属于执行中检查，不预设成功。仅使用合成演示资料。
成功后置	恰好更新经预览确认的联络字段，并保存一条与操作编号关联的审计事件。
最低保证	校验失败不写入任何联络字段；审计或保存失败时本事务不部分生效；只更正指定档案，不触碰身份、过敏、账号关联、预约、治疗及已发布账单。
BR-16	联络字段严格白名单；患者在当前店创建或有当前店就诊关系才可维护，全局精确查号本身不授予修改权。跨店患者仍是一份共享档案，修改不会复制成另一个人。
BR-17	预览不改业务数据；最终确认必须重新校验授权、上下文和快照；同次成功请求不重复写入。
BR-18	联络变更事件不保存原始电话、地址或邮箱。已发布结算头快照保持不变。
设计决定	预览令牌有效 15 分钟；更正依据从三个固定理由中选择，不允许在自由原因栏填写病史或其他敏感内容。

标题	内容（SU-26）
基本路径	1. 前台指定患者，请求更正联络资料。 2. 系统核对有效账号、前台身份、当前诊所和患者关联，提供允许维护的当前值及受签名保护的资料快照。 3. 前台提供五项完整联络字段和更正依据，请求核对变更。 4. 系统复核权限与资料版本，校验字段，反馈变更前后的差异；此时不写入业务数据。 5. 前台核对患者、差异与业务边界，明确确认保存。 6. 系统在同一事务中锁定授权上下文及目标患者，校验签名、时间、对象、资料指纹和操作编号，更新允许字段并记录事件。 7. 系统反馈本次保存结果并返回同一患者的档案；前台核对当前值。
扩展路径	• 2a／4a／6a 无关联、停用或无权限：拒绝，不暴露越权患者；账号拥有其他身份不抵销当前身份限制。 • 4b 输入缺失、超长、非法邮箱、不可见控制字符或夹带姓名/过敏字段：指出原因，不保存。 • 4c 没有实际差异：说明无需保存，不增加审计。 • 4d 编辑期间已被更新：重新读取，不合并或覆盖他人值。 • 5a 放弃：返回档案；预览不产生待办记录或部分保存。 • 6b 未明确确认、令牌篡改、过期或工作台变化：拒绝旧确认，要求查询当前资料。 • 6c 相同成功操作再次提交且仍有权限和有效令牌：返回原事件结果；后来的合法新值不被撤销。 • 6d 两个不同预览竞争：在应用行锁协议下只允许一个基于旧快照的更正；另一个必须刷新。 • 6e 联系方式 A→B→A：审计游标变化，原 A 快照仍然过期。 • 6f 保存/审计异常：回滚；网络回执未知时先查当前档案，不把未知结果说成未保存，也不自动重放。 • 只读实例：可在授权范围读取现值，但预览写流程及最终保存被拒绝；普通查询不扩权。

SU-27　登记基础目录资料

表 B-2 SU-27　登记基础目录资料用例规约

标题	内容（SU-27）
用例名称	SU-27　登记基础目录资料
主执行者	当前激活 SYSADMIN 的技术维护人员。无外部模型/短信平台作为辅执行者。
涉众利益	运营人员希望新诊所和新牙医可供后续业务使用；牙医希望身份和联系资料准确且不被过度公开；原有患者/牙医不希望登记动作改写既有预约、治疗或账单；维护人员需要可核对的失败反馈和责任记录。

标题	内容（SU-27）
触发	技术维护人员依据已经人工核对的合成资料请求登记诊所、牙医或资格类别。
前置条件	会话有效且已激活技术身份；凭据、授权、编码唯一性和输入合法性由本用例检查，不提前假定全部成立。
基本路径	1. 技术维护人员提交目录类别、编码、基础字段和登记依据，请求核对。 2. 系统验证当前权限、字段范围和模型约束，核对现有编码；反馈拟登记内容及影响，尚不保存。 3. 技术维护人员核对目标和资料，提供自己的技术管理密码并明确请求保存。 4. 系统重新核验当前身份、工作上下文、确认期限、密码和唯一性；同步保存目录资料及审计。 5. 系统反馈稳定的业务对象和后续人工入口；账号授权、资格关联及出诊安排分别办理。
扩展路径	• 2a 字段缺失、隐藏字符、编码不合格式、未来出生日期、非法面积或邮箱：系统指出问题，不登记。 • 2b 已有相同编码或员工编号（含停用记录）：系统拒绝重复，不覆盖、不恢复，不凭同名自动合并。 • 3a 维护人员放弃：不保存。 • 4a 密码错误、未明确确认、撤权、旧上下文或过期令牌：不保存，要求重新核对。 • 4b 他人已登记同一编码：本次不覆盖，提示查询既有记录。 • 4c 同一成功操作重试：先核对当前权限与确认期限，再返回原结果；不重复保存。 • 4d 保存或审计失败：目录与审计一起回滚。回执未知时先查询原编码，不断言前次失败。
成功后置条件	新增一条所选目录记录和相应事件；没有自动新增账号、角色、出诊、预约或账单。
最低保证	失败不留下半次登记；既有资料和历史单据保持原值。只读实例不执行保存。
扩展路径	字段列表： • 诊所：clinic_code、name、postal_address、supervisor_name、phone、email、area_sqm。 • 牙医：employee_no、name、date_of_birth、home_address、phone、email。 • 资格类别：code、name。 • 控制字段：固定登记依据、操作者密码（不保存）、明确确认、受签名保护的当前上下文/操作编号/期限。
设计约束	本功能不提供既有身份信息纠错、目录编辑/删除/停用。新目录默认可用，仅表示当前基础记录，不等于完成入职认证；主管联络姓名也不构成账号授权。列表隐藏个人联系地址/出生日期，技术详情受限可读。本课程仅使用合成数据。

标题	内容（SU-27）
追踪	BR-D01/02/03/05/06；AT-D01/02/04/05/06/07/08；目录字段来自既有 registry 模型。实现范围及业务测试见第 5 章。

SU-28　维护牙医资格关联记录

表 B-3 SU-28　维护牙医资格关联记录用例规约

标题	内容（SU-28）
用例名称	SU-28　维护牙医资格关联记录
主执行者	当前技术维护人员。
涉众利益	运营人员希望准确记录牙医的多项资格类别；牙医希望误关联能够纠正且历史不被删除；患者希望不能以目录操作自动决定诊疗安全或撤销已有安排。
触发	维护人员请求新增关联、撤回误关联或恢复原关联。
前置条件	当前技术身份有效；牙医与资格类别存在。是否可关联、是否停用和是否重复由本用例核验。
基本路径	1. 技术维护人员指定牙医和资格类别，说明拟登记、撤回或恢复，并提交相应依据。 2. 系统核对当前记录及有效标志，反馈当前关联、拟进行动作和影响，生成状态预览；不保存。 3. 技术维护人员核对员工编号、资格类别和动作，提供技术密码并明确确认。 4. 系统再次核验权限、上下文、期限和关联快照；同步更新关联记录及审计。 5. 系统反馈该牙医的当前关联列表，不替维护人员办理账号或接诊变更。
扩展路径	• 2a 已有有效关联：拒绝重复登记。 • 2b 已有撤回记录：使用恢复依据，保留同一关联编号，不新建第二条关系。 • 2c 牙医或资格类别已停用：拒绝新增/恢复；撤回现有误关联仍可按本用例核对。 • 2d 关联不存在或已经撤回：拒绝再次撤回，不删除记录。 • 4a 预览后任一相关状态已变化：拒绝旧预览；即使值改回原值，审计游标改变仍使旧预览失效。 • 4b 密码、权限、签名、期限或只读模式不符：拒绝，不改变原关系。 • 4c 同一成功操作重复确认：返回原操作的关联对象，不撤销其后的合法变更。 • 4d 审计/保存失败：本次关系变化回滚；无法核对回执时反馈未知并指向查询入口。
成功后置条件	仅新增或改变所选 DentistQualification 当前有效标志，历史编号、原 notes 和原事件保留。

标题	内容（SU-28）
最低保证	不改变 Patient、UserAccount、RoleAssignment、AvailabilitySlot、Visit、治疗或 Invoice；不执行专业许可认证；不将缺失关联解释为无资格。
字段列表	dentist_id、qualification_id、attach/withdraw、依据类别、关联状态快照、操作编号、当前上下文及其修订、操作者密码和明确确认。
设计约束	模型没有资格有效期、核验机构、执业地点或医学适配规则。撤回“误关联”不同于撤销行政资格，也不同于安全封禁；账号封禁和业务交接仍使用各自受控流程。
追踪	BR-D01/03/04/05/06；AT-D03—08；实现范围及业务测试见第 5 章。

SU-29　调整未来空闲出诊时间

表 B-4 SU-29　调整未来空闲出诊时间用例规约

标题	内容（SU-29）
用例名称	SU-29　调整未来空闲出诊时间
主执行者	当前激活 FRONT_DESK 且已选择诊所的诊所前台。无辅执行者或外部 AI。
涉众利益	前台希望明确出诊安排和变更影响；患者希望既有预约或有效邀约不被暗中取消、改期；牙医希望历史出诊和接诊责任可核对；前台希望在同一岗位衔接协调与排班维护。
触发	前台依据已核对的计划提出时间调整。
前置条件	会话有效，当前工作身份为前台且已选店。是否授权、是否空闲、是否尚未开始以及是否冲突由本用例检查，不把它们全部预设为已满足。
基本路径	1. 前台指定本店原出诊，请求查询安排及相关业务影响。 2. 系统核对当前身份与范围，读取原时段、相关预约与邀约的必要事实，反馈时间、牙医、诊所、占用数和读取时点。 3. 前台提供新的开始、结束和固定类别的依据，请求预览变更。 4. 系统检查原记录及关联事实未在填写期间变化，原时段未开始且有效，没有阻止变更的业务，新时间在未来且不与同牙医其他有效出诊冲突；反馈新旧时间、历史保留方式及未发布草案影响。尚不保存。 5. 前台核对影响，明确要求保存。 6. 系统再次检查当前权限、上下文、确认期限、源对象与关联快照，并检查当下占用和时间条件。在同一事务中停用原时段、创建同店同牙医的新时段并记录两者关联及审计。 7. 系统反馈原记录及其替代记录入口，供前台核对已保存事实。

标题	内容（SU-29）
扩展	• 2a 对象不存在、诊所不符、账号/角色/范围失效：拒绝，不暴露患者资料。 • 2b 原时段已开始、已结束或已停用：拒绝该变更，保留历史。 • 2c 有 SCHEDULED、CHECKED_IN、COMPLETED 或 CLOSED_NO_TREATMENT 记录：拒绝；未闭合业务由前台协调，已完成业务不能为排班调整而取消。 • 2d 有 PENDING 且 expires_at 大于核验时点的邀约：拒绝，待患者决定或到期后重新核对。 • 2e 记录关联不一致或任一关联集合超过 1000 条：不以部分结果认定空闲，提示受控核对。 • 4a 开始不在未来、结束不晚于开始、包含秒/小数秒、新旧时间完全相同：指出问题，不生成可执行确认。 • 4b 相同牙医在其他有效时段有重叠（包括跨店）：拒绝，不透露其他诊所患者信息。 • 4c/6a 旧页面或旧快照：拒绝。即使相关事实后来又变回相同值，新增审计/关联记录仍使旧快照失效。 • 5a 前台放弃：不保存。 • 6b 预览之后有人预约或发布有效邀约：以本次锁定后事实为准，本次调整不执行。 • 6c 同一成功操作在有效期和当前权限内重复提交：返回原结果，不再创建替代时段；不恢复此后又被合法停用的替代记录。 • 6d 新时段并发冲突、保存或审计失败：回滚本次停用和新增，原有效安排保持。 • 6e 网络回执不确定：先查询原时段与维护记录，不推断原操作失败，不自动重试。
成功后置条件	原时段 is_active=False，但原编号、时间、诊所和牙医保持不变；新增同店同牙医的一条有效时段；维护事件将两者关联；未改动任何 Visit、WaitOffer、WaitRequest、Patient、Invoice 或账号授权记录。
最低保证	失败不留下“原时段已停用但替代时段缺失”的部分结果；历史记录不删除，已保存的既有业务不改变。重复请求不撤销先前成功结果。
字段列表	源出诊编号、新开始、新结束（北京时间、分钟精度）、固定依据类别、源快照令牌、预览确认令牌、当前工作上下文、操作编号、明确确认。
交互约束（不混入基本路径）	前台工作台→出诊安排→查看安排与影响→调整未来空闲时段→预览影响→确认出诊变更。大字模式、键盘及无脚本文本路径保留；新时间控件动态提示结束下限，但服务端始终复核；不会静默重写用户结束时间。

SU-30　停用未来空闲出诊

表 B-5 SU-30　停用未来空闲出诊用例规约

标题	内容（SU-30）
用例名称	SU-30　停用未来空闲出诊
主执行者	当前店前台。
涉众利益	前台需要停止提供某条未来机会；患者不希望预约被无声删除；审计与运营需要保留原安排依据。
触发/前置	前台提出停止某条原时段；有效会话、当前前台身份与诊所已选择。空闲性、有效性和授权由系统核验。
基本路径	1. 前台指定原出诊并请求停用影响预览。 2. 系统以与 SU-29 相同的权限、状态、未来时间、关联一致性与占用规则核对原记录。 3. 系统反馈原安排、停用影响和已核对的依据；尚不保存。 4. 前台明确要求保存。 5. 系统重新核验预览、当前授权与占用，在同一事务中将原记录 is_active 置为 False 并记录审计。 6. 系统反馈原记录当前状态和历史入口。
扩展	引用 SU-29 的授权、已开始/已停用、占用、旧页、上限、重复、失败和未知结果分支。停用不得携带新的开始/结束时间；不存在借停用动作更换牙医或诊所的分支。牙医资料已停用时，只要当前诊所授权仍有效且原出诊满足无占用/未开始条件，可以停用，但不能新建替代时段。
成功后置条件	只停用原出诊并新增审计。旧编号和全部关联历史保留，没有新增替代时段、预约或邀约。
最低保证	校验失败或审计失败不使部分操作生效，不取消任何正式预约，不自动回收邀约，不删除原记录。
字段	源出诊编号、固定依据类别、状态/确认令牌、当前上下文、操作编号、明确确认。无新时间字段。

SU-31　按出诊核对关联业务并定位协调入口

表 B-6 SU-31　按出诊核对关联业务并定位协调入口用例规约

标题	内容（SU-31）
用例名称	SU-31　按出诊核对关联业务并定位协调入口
主执行者	当前激活前台身份并选择了获授权诊所的前台人员。无辅执行者；不调用外部模型/通知平台。

标题	内容（SU-31）
涉众利益	前台希望准确定位一条出诊的关联承诺，不在全店列表反复搜索；主管希望得到可重新核对的出诊编号与事实，而不是未经验证的“已清空”；患者希望已有安排只按本人明确意思和原业务规则变更，个人资料不过度展开；牙医希望已到诊/完成记录不因排班清理被撤销；维护人员希望错误关联不会导致越权披露。
触发	前台依据已核对的人工协调需求，指定本店出诊编号或浏览有关出诊。
前置条件	已登录且激活前台、已选择诊所。目标属于当前诊所、授权仍有效和资料完整性由本用例验证，不能预设“一定有待处理记录”或“已经允许停用”。
基本路径	1. 前台提供查询范围或明确出诊编号，请求查阅关联业务。 2. 系统验证当前身份和诊所范围，反馈匹配的出诊及定位所需统计；列表不是维护批准。 3. 前台指定一条出诊，请求核对其关联预约和邀约。 4. 系统读取原计划及完整有界的关联事实，检查诊所/牙医/患者关联、已接受邀约与正式预约的一致性，并计算读取时点下的阻断说明。 5. 系统反馈原出诊、牙医、时间、业务编号、分状态解释、读取时点、规则版本与原有授权办理入口。 6. 前台在必要时另行发起原预约/邀约用例；本用例不代替患者作决定，也不办理任何取消、改期或接受。 7. 前台在原办理返回后请求重新核对；系统重新读取，不根据刚才点击的按钮推测结果。若当前未发现阻断，反馈“可由前台重新核对”，最终出诊维护仍另行核验。

标题	内容（SU-31）
扩展路径	• 2a/4a 当前角色错误、撤权、账号停用、诊所无权或上下文变化：拒绝，不借同一账号其他身份。 • 2b 查询参数无效：反馈字段错误，不退化成返回全店/全链资料；明确编号查询允许包含历史。 • 3a 目标不存在或属于他店：相同拒绝语义，不泄露该对象及患者详情。 • 4b 关联计数超每类 1000 条上限或检测到关系不一致：反馈需要受控核对；不展开可疑患者编号和深链，不用部分结果判断可维护。 • 4c 无关联业务：反馈当前未发现维护阻断；仍不是停用许可，查询后可出现新预约。 • 4d 已有预约或未过期待确认邀约：逐条核对；仅提供原流程，不批量办理。 • 4e 已到诊、治疗完成或无治疗关闭：作为受保护接诊说明，不提供快捷改期，不诱导为排班清空原记录。 • 4f 待确认邀约到期但未回收：按服务器时间说明已不再有效；不自动改变其存储状态。 • 4g 邀约已接受：核对直接关联预约及患者/时间一致性；不按旧确认截止将预约判作失效，不再计第二份保留。 • 4h 原出诊已开始或停用：反馈当前状态及历史，不提供维护批准或恢复入口。 • 4i 读取暂不可用：反馈本次结果未知，不推断前次写入失败，不自动重发。 • 6a 改期产生直接后继：原预约详情提供同患者同诊所的直接前后继和合法来源回跳，不能用任意 URL/外店编号绕过授权。 • 7a 查询后又有新预约或其他变化：以新读取事实更新；原维护命令还须再次核验。 • 全程只读实例：允许获授权 GET 查询；保留原业务写入限制，不因新页面开放额外 POST 例外。
成功后置条件	返回选定出诊在读取时点的受限关联投影及合法原业务入口；没有创建、更新、取消任何预约/邀约/候补/出诊/治疗/账单或授权，也没有发送通知或建立工单。
最低保证	无权或不完整查询不被当作“无待办”；读取失败不改变原记录、不自动重放业务命令；患者个人资料不因主管地位较高而扩大可见；结果仅代表本次读取，不保证后续仍空闲。
字段列表	输入为查询范围、出诊 ID、页号；输出为出诊 ID、诊所、牙医姓名及工号、原时间和状态、预约业务号/患者业务号、邀约与候补请求号、各自状态与起止/期限、关联预约 ID、完整计数、读取时点、规则版本及受控内部入口。新列表不读取投影姓名、电话、地址、主诉、过敏或治疗正文。
质量约束	窄屏和大字模式下主要动作可达；文字说明不能只依靠颜色；no-store 防止浏览器重用旧响应，但不承诺清除用户此前已看见内容。两类关系各分页 20 项；判断不得只依据当前页。

标题	内容（SU-31）
交互约束	前台工作台→出诊协调→按出诊编号核对。相关原详情带“返回出诊 #编号”；既有独立页面入口仍可用。主管仅获取聚合影响和告知前台的原出诊编号，本功能没有给主管创建前台入口。

SU-32　暂停出诊新增接收

表 B-7 SU-32　暂停出诊新增接收用例规约

标题	内容（SU-32）
用例名称	SU-32　暂停出诊新增接收
主执行者	当前激活 FRONT_DESK 且已选择获授权诊所的前台。无 AI 辅执行者。
涉众利益	前台希望减少协调期间新增负担；患者希望原预约/有效邀约不被暗中撤销；牙医希望原安排与治疗责任不被改变；前台希望看到当前真实接收状态。
触发	前台依据已核对的协调需求或接待能力复核，请求暂停一条出诊的新增接收。
前置	会话有效、已选择前台身份和诊所。目标有效性、权限、是否结束、当前状态及冲突由本用例检查。
基本路径	1. 前台指定本店出诊，请求查询接收状态及关联承诺概况。 2. 系统核验范围，读取原出诊、接收修订号、关联计数和历史游标，反馈目前状态。 3. 前台提交暂停依据，请求预览。 4. 系统核验状态一致，反馈拟暂停及保留已有预约/有效邀约的影响，尚不保存。 5. 前台核对并明确确认。 6. 系统重新核验当前授权、工作上下文、15 分钟确认期限、锁定后的状态摘要及是否尚未结束；同事务更新暂停标志、递增接收修订号并保存审计。 7. 系统反馈当前接收状态；前台另在自己的查询页面核对原承诺，按原流程办理。

标题	内容（SU-32）
扩展	• 2a 无权/跨店/旧上下文：拒绝，不展示患者资料。 • 4a 已停用、已结束或已经暂停：拒绝重复/无效操作，不取消任何记录。 • 4b 诊所/牙医资料已停用：仍可进一步暂停有效出诊新增，但不能恢复或创建新供给。 • 5a 放弃预览：没有业务写入。 • 6a 预览后出现预约、邀约、状态或审计变化：拒绝旧确认，要求重新核对。暂停→恢复同值仍有不同修订号。 • 6b 同一已成功操作的有效重放：先核验权限，再返回原操作及当前状态，不重新暂停，不撤销后续恢复。 • 6c 只读实例、保存或审计失败：不部分生效；不根据异常回执认定前一次也失败。 • 6d 新预约先获取源行锁：按当时状态先保存，该承诺保留；暂停确认需重核变化。暂停先完成：后到的新创建被拒绝。
成功后置	源出诊 booking_paused=true，intake_revision 递增，存在审计；is_active、原起止、牙医/诊所、Visit/WaitOffer/WaitRequest/Invoice 记录均不被本用例改写。
最低保证	失败不部分暂停；既有临床/财务/账号事实不改变；不生成通知或推断患者已被联系。
字段	slot_id、pause 依据枚举、当前上下文、源状态签名、操作编号、确认签名、明确确认。审计无原始患者资料。

SU-33　恢复出诊新增接收

表 B-8 SU-33　恢复出诊新增接收用例规约

标题	内容（SU-33）
用例名称	SU-33　恢复出诊新增接收
主执行者	当前店前台。
涉众利益	前台希望受控恢复供给；患者希望剩余机会真实且不会自动被登记；牙医希望仍按原排班和权限执行。
触发/前置	前台确认可以继续接收，指定已暂停、未结束的有效出诊。角色/范围同 SU-32。
基本路径	读取状态→提供恢复依据→预览→前台明确确认→系统重新核对有效牙医/诊所、资料一致性和快照→同事务清除暂停标志、递增修订并审计→反馈。
扩展	已停用、已结束、从未暂停、资料异常/超核对上限、牙医或诊所停用、旧签名/撤权/只读/审计失败均不恢复。重复已成功确认只返回原结果，不撤销后来的再次暂停。

标题	内容（SU-33）
成功后置	booking_paused=false、修订递增；可以提供新的剩余机会，但不自动创建预约、邀约、排程建议或恢复历史取消。
最低保证	恢复不延长旧邀约期限、不重开已停用历史出诊、不新增授权、不调用 AI。
字段（沿用 SU-32）	出诊编号、恢复依据、当前上下文与修订、状态签名、操作编号、确认签名及明确确认。

SU-34　发起与管理出诊协调任务

表 B-9 SU-34　发起与管理出诊协调任务用例规约

标题	内容（SU-34）
用例名称	SU-34　发起与管理出诊协调任务
主执行者	当前诊所前台；主管可提交协调交接需求。没有短信、外部 AI 等辅执行者。
涉众利益	主管希望协调计划有明确记录且不重复派出；前台希望目标、来源出诊和责任边界清楚；患者与牙医希望任务不偷偷改变服务承诺；维护人员希望保留撤销、交接和复核历史。
触发	前台对既有出诊提出时间调整或停用的协调需求。
前置条件	前台会话及当前诊所已选择；授权、源状态、暂停标志和重复任务由系统核验，而非全部假定成立。
联系责任	发起、受理和记录办理进度须填写未来的下次跟进期限；列表及工作台提示逾期。原历史空值显示未填写，不补造历史；主管退回后需由前台重新明确责任。
基本路径	1. 前台指定原出诊，提交协调目标及固定类别依据，请求预览。 2. 系统核验当前角色/诊所、源出诊尚未开始且有效、已明确暂停新增、关联资料完整且没有另一未结束任务，反馈拟创建任务。已有预约或有效邀约不阻止发起，但必须保留。 3. 前台明确确认。 4. 系统在锁定源出诊后重新核验状态、授权、确认期限和当前事实，同事务创建待受理任务与审计。 5. 系统反馈任务编号；任务不会自动受理或触发任何患者业务。

标题	内容（SU-34）
扩展	• 2a 原出诊未暂停：提示先通过 SU-32 办理，不隐式暂停。 • 2b 源已开始/停用、存在关联异常、超过完整上限：不创建普通任务，交由受控流程处理。 • 2c 已有未结束任务：提示查询原任务，不以新编号绕过。 • 3a 放弃预览：不创建。 • 4a 旧上下文、摘要变化、过期/篡改、撤权、只读模式：不写入。 • 4b 并发重复发起：源行锁与部分唯一约束保护一条活动任务；失败不覆盖原任务。 • 4c 相同成功确认重放：重新核验当前权限后返回原任务当前状态，不重开或重复创建。 • 4d 保存/审计异常：本次同事务回滚；回执未知先按原出诊查任务。 • 管理分支：主管可对处理中/待复核任务说明退回依据，将其重置为待受理并清除当前受理/提交标记；旧办理事件保留。不能代另一个账号受理。 • 撤销分支：主管可撤销未结束任务，保留历史，不暂停/恢复出诊、不取消患者业务。源已失效时仍可核对并撤销任务，但不能借此宣称正常维护完成。
成功后置条件	一条待受理任务存在；或一次明确的退回/撤销及相应事件已保存。既有源出诊、预约、邀约、临床与财务事实不改变。
最低保证	失败不留半次任务变更；原记录、原承诺和暂停标志保持；旧成功请求不撤销后续合法状态。
字段	下次跟进期限；source slot ID；目的 DEACTIVATE/REPLACE；固定依据；签名状态/确认；当前上下文；操作编号；明确确认。没有任意受理人 ID、患者资料或自由文本。
通知协作规则	成功任务变化、审计和 NotificationOutbox 同一事务保存；不向患者发送信息，派发失败不重新执行任务。

SU-35　受理并记录出诊协调办理

表 B-10 SU-35　受理并记录出诊协调办理用例规约

标题	内容（SU-35）
用例名称	SU-35　受理并记录出诊协调办理
主执行者	当前诊所前台。
涉众利益	前台希望明确谁负责当前跟进，能够必要交接；患者希望自身意思仍通过原业务流程确认；主管希望区分联络声明和已保存业务事实。
触发	前台选择待受理任务，或继续本人已受理任务。

标题	内容（SU-35）
基本路径	1. 前台查询本店任务，选择准确原出诊。 2. 系统核对任务尚未受理，反馈由当前账号受理的影响。 3. 前台明确确认；系统再次核对任务修订并保存本人受理责任及审计。 4. 前台通过 SU-31 定位关联记录，另在原预约/邀约用例办理；任务服务不代办这些动作。 5. 前台指定本出诊的一条预约/邀约，选择尝试联络、等待患者决定、转原流程办理等有限声明，请求预览并明确确认。需要主管协助可以不指定个人对象。 6. 系统核对当前受理人、对象属于该出诊、快照及期限，保存声明事件并推进任务修订，不改变预约状态。 7. 前台认为可提交时发起复核请求；系统重新核对完整有界关联无阻断、源仍未来有效且暂停，再经明确确认将任务转为待主管复核并记录当时的业务事实摘要。
扩展	· 别的前台已受理：不能覆盖；只允许当前受理人记录、退回或提交。 • 无法继续：受理人可明确退回待受理队列；账号停用/撤权后不得自行继续，主管仍可按 SU-34 退回任务，其他合法前台自行受理。 • 声明对象无关/不存在，或关联异常/超限：不附加声明；错误反馈不透露另一患者存在与否。 • 声明类别不是患者同意或办理成功证明：系统不据此清除实际阻断。 • 有受保护预约/接诊或有效邀约：不能提交复核。旧邀约到期后未回收不再占位，但仍保留历史；接受后的预约按真实预约事实核对。 • 原出诊恢复接收/开始/停用：不能提交普通维护复核，主管需再核对或转其他流程。 • 旧页、ABA、并发受理、重复确认、只读、审计异常：遵循签名/修订/锁/事务规则，不产生第二受理人或半次状态。
成功后置条件	当前受理人明确；或有一条附明确对象的操作者声明；或任务转为待复核且提交人/时点/摘要一致。上述不等于患者已同意，也不证明某次原业务已经成功。
最低保证	失败不改变责任；不自动处置预约/邀约、不通知患者，不开放其他角色权限。
字段	下次跟进期限；任务/出诊 ID；操作依据枚举；声明对象类别与记录 ID（不得填姓名电话）；状态/确认令牌；操作编号；当前上下文与明确确认。
通知协作规则	成功任务变化、审计和 NotificationOutbox 同一事务保存；不向患者发送信息，派发失败不重新执行任务。
联系期限	受理及进度记录同时核对未来跟进期限；期限仅用于待办提醒，不改变预约时间、患者同意或任何治疗资金事实。

SU-36　复核出诊协调结果

表 B-11 SU-36　复核出诊协调结果用例规约

标题	内容（SU-36）
用例名称	SU-36　复核出诊协调结果
主执行者	当前诊所主管，必须与本次提交复核的前台为不同账号。
涉众利益	主管希望根据真实结果而非勾选进度判断；前台希望结果可追踪；患者希望已有承诺和临床记录不为结案被错误删除；系统维护人员希望失败可以恢复且不自批。
基本路径	1. 主管查询待复核任务，核对原出诊、目标、受理人和提交时点。 2. 系统核对独立账号、当前源状态和完整有界关联；确认原出诊仍未来有效且暂停，没有保护业务/有效邀约/异常/截断，且相关事实摘要仍与前台提交时一致。 3. 系统反馈本次可通过的依据，明确不自动维护出诊。 4. 主管明确确认。 5. 系统重新锁定、核验状态/权限/快照/时间条件，同事务将任务标为协调核对通过并保存独立复核人、时点和审计。 6. 系统提供回到原主管出诊的入口；SU-29/30 维护或 SU-33 恢复由主管另行独立办理并重验。
扩展	· 未由前台提交或同账号切身份自批：拒绝。 • 提交后关联记录、接收修订或源维护历史变化：拒绝通过，主管退回重新核对；即使又变回同样状态也不能复活旧结果。 • 查到受保护接诊或源已开始：不得为结案虚假取消、爽约或删除，转专门受控流程。 • 条件不满足：主管按 SU-34 退回或撤销；不能跳过检查强制通过。 • 保存/审计失败：任务仍为原状态；重复成功确认不反复结案或取消后续合法维护。
成功后置条件	协调任务结束，保留复核责任与历史，不新增预约、不改邀约、不改出诊接收标志。
最低保证	未满足真实条件不得写成功标记；任务结束不是对以后状态的永久保证，也不是停诊指令或临床许可。
字段	任务／源出诊编号、复核依据、提交事实摘要、状态与确认令牌、操作编号、当前上下文和明确确认。通过前后都须检查主管与提交人不是同一账号。
通知协作规则	成功任务变化、审计和 NotificationOutbox 同一事务保存；不向患者发送信息，派发失败不重新执行任务。

SU-37　查阅本人任务消息并标记已读

表 B-12 SU-37　查阅本人任务消息并标记已读用例规约

标题	内容（SU-37）
用例名称	SU-37　查阅本人任务消息并标记已读
主执行者	当前本店前台或主管。无外部消息服务、AI 或患者作为辅执行者。
涉众利益	前台希望知道新协调任务与退回；主管希望知道受理、声明和提交复核；患者希望通知不泄露个人/临床数据，不暗含其同意；原业务各方希望浏览通知不修改服务承诺。
触发	执行者查询站内收件箱，或对一条消息明确请求标记已读。
前置条件	有有效会话且激活相应身份和诊所。权限、消息归属、授权是否撤回由系统检查，不预设合法。
基本路径	1. 执行者提交消息范围及页码，请求查阅本人当前工作范围的消息。 2. 系统核验账号、当前身份、诊所及原始收件授权与当前授权，反馈有界分页消息。 3. 系统区分事件发生时状态、派发时点、当前查询任务状态及已读标记，反馈原任务查询入口。 4. 执行者需要时另行请求对指定本人消息标记已读。 5. 系统重新核验当前权限、工作上下文和归属，保存首次已读时间，并反馈该标记不构成受理/同意/完成。
扩展	2a 没有符合条件消息：反馈空结果，但不认定没有任务；2b 查询失败：反馈未知并保留原任务入口；2c 其他患者或岗位未纳入本版消息：不扩大角色；3a 任务有后续变化：以当前任务页为准；4a 用户只浏览：不写已读；5a 旧上下文/撤权/其他账号消息/其他店：拒绝；5b 重复标记：保留第一次时间；5c 只读实例：不保存标记；5d 保存失败：不伪称成功，不重做原任务。
成功后置	只读查询不改消息及业务；明确标记仅改变本人该条消息 read_at。最低保证：任务、出诊、Visit、WaitOffer、治疗、Invoice 保持原值，无自动受理或患者同意。
字段	mode(unread/all)、page、message_id、工作上下文令牌；查询返回 task_id、slot_id、动作标题、历史状态/修订、当前状态/修订、发生/派发/首次标记时点。无姓名、电话、病例、自由文本或外部 URL。

SU-38　核对本店通知派发并请求重试

表 B-13 SU-38　核对本店通知派发并请求重试用例规约

标题	内容（SU-38）
用例名称	SU-38　核对本店通知派发并请求重试

标题	内容（SU-38）
主执行者	当前本店主管；后台 worker 是内部实现机制，不是主管身份的替代者。
涉众利益	主管希望发现等待或失败，不因通知失败误判任务失败；维护人员需要受控重试和不泄露敏感数据的错误信息；其他使用者不希望重试重复生成消息或业务动作。
触发	主管查询当前店通知处理情况，必要时重排失败事件。
前置条件	有效主管工作上下文，具体事件权限、状态和轮次由系统检查。
基本路径	1. 主管请求本店派发情况。 2. 系统反馈待派发、已生成、无符合条件收件人、失败状态及发生/处理时间；不暴露其他人的个人消息或明细收件名单。 3. 主管对一条失败事件核对原因，明确请求只重试通知。 4. 系统重新核验当前诊所、权限、只读策略和重试轮次，将原事件重排并保存审计。 5. 后台另行按原收件范围及当前授权有界重试，主管以后查询实际结果。
扩展	2a 暂时读取失败：结果未知，不自动重发；3a 空收件或失效授权：不通过重试创造新权限/新收件人；4a 已处理/已经重排/旧轮次：拒绝第二次重置；4b 其他店、前台身份、旧页面、未确认或只读：拒绝；4c 审计失败：回滚重排；5a 后台未运行：仍 PENDING，不虚构成功；5b 失败：退避到最多 5 次后 FAILED；5c 部分原授权失效：跳过并记录聚合数量，不向新授权补发。
成功后置	仅通知处理记录与审计变化。最低保证：重试不重新创建任务、取消/改期预约、接受邀约或释放资源；此前成功的消息行不重复。
字段	event_id、expected_round、明确确认及工作上下文令牌。事件和收件快照不可在本入口修改。

附录 C 扩展业务用例规约

本附录补充 SU-39—140，覆盖电话接待、统一资源、取消改进、财务设备、患者关系、专业协作、连续诊疗及微信账号协同。每项分别列明岗位、输入、正常与异常路径、最低保证及验收目标。

SU-39　登记电话预约接待与联系结果

表 C-1 SU-39　登记电话预约接待与联系结果用例规约

标题	内容（SU-39）
用例名称	SU-39　登记电话预约接待与联系结果
执行者／触发	当前诊所前台；患者提出电话咨询。
实现状态	已实现：独立接待、追加沟通、责任联系、完整建档核对与唯一成约关联。
前置条件	当前诊所前台有有效授权；咨询可以先保留待核实联络，正式成约前须完整建档。
主要输入	来电者与患者关系、待核实联络、服务及日期／医师偏好、责任人及联系期限、每次沟通结果。
基本路径	1）登记来电与待核实资料，保存首次沟通；按业务编号核对老患者，不按电话合并。 2）核对服务、医师、时间、诊室椅位及必要设备，提供不占位的候选。 3）多次沟通均追加历史，待联系或待回复安排有效负责人和期限；失效时明确交接。 4）正式预约前完成患者建档，复述安排并取得同意，原子保存预约、占用与接待关联。 5）无合适安排则明确转候补或记录未成约原因；原候补成功时关联同一预约，成约事实保留。
扩展路径	未建档、未同意、旧预览或资源被占：不产生部分预约，返回核实和协商。 无资源、拒绝或联系未果：保留原因、责任及期限；不能自动取消其他安排。 接待成约后的取消和改期：打开原预约办理，不将接待改回未成约。
成功结果	可追踪接待结果、责任人和最终预约；咨询状态与预约状态分别可查。
最低保证	未确认不产生预约、收费或候补承诺；失败保留已保存咨询。
业务规则	联系电话不是身份凭证；专业判断由医护负责；接待记录不可用来绕过预约占用规则。
验收目标	AT-B39-1：新老患者、多次联系、完整建档、唯一成约及重试。 AT-B39-2：候补原结果关联、联系责任交接、拒绝及失联。

SU-40　患者自助改期

表 C-2 SU-40　患者自助改期用例规约

标题	内容（SU-40）
用例名称	SU-40　患者自助改期
执行者／触发	本人绑定且当前激活患者身份的患者；请求调整未开始预约。
实现状态	已实现：网站和原生小程序支持普通时段改期及本人有效邀约替换；微信平台实际运行另验收。
前置条件	本人有效档案和已预约、尚未开始的原预约；所有权、时间、状态及目标资源均由系统核对。
主要输入	原预约、日期和医师偏好、候选资源组合或本人邀约、改期原因及明确确认。
基本路径	1）患者读取本人待就诊清单，进入原预约，核对当前状态、原服务及原承诺。 2）按日期和医师查询本店同一服务的可行组合，或选择本人同店同服务的有效候补邀约；查询不占位。 3）系统展示原新医师、起止时间、时长及资源，患者填写原因并明确确认。普通候选按当前服务时长，保留邀约按原承诺时长。 4）系统重新核对当前授权、原预约版本、排班及资源，在同一事务释放原占用、保存原已改期事实、建立唯一后继和确认回执；使用邀约时一并接受邀约并关联同一成约结果。 5）返回当前保存结果；原新预约可以互查，待就诊和历史分开。后继另行取消时进入真正取消的原因跟进。
扩展路径	资源被抢占、设备停用、配置变化、旧预览或撤权：返回重新核对与人工协助，事务失败不丢失原约。 原预约已到诊、取消、爽约、完成、已改期或已经开始：不再创建后继，显示当前状态及合法查询入口。 邀约过期、已撤回、其他患者或不同服务：不能借邀约改期；有效保留仍按原承诺和当前物理资源核验。 有效确认期内相同成功确认重复或断网重试：重新核对当前权限后返回原保存结果及当前状态，不产生第二次业务效果。 没有合适时段：保留原约，提示候补现状与原诊所联系方式；系统不自动接受邀约或撤回其他候补。 网站与小程序共用本人预约和邀约。接受邀约须明确选择新增预约或替换指定原约，不由客户端自动推断。
成功结果	原预约保留为已改期，存在唯一正式后继和确认回执；原资源释放，新资源有效占用，候补接受指向同一结果。
最低保证	失败不丢失原约、不留下部分占用；患者仅能操作本人本店同服务，不改写原治疗、账单或资金。

标题	内容（SU-40）
业务规则	未来十四天内选择本店同服务；医师或时间变化必须由患者明确确认。普通候选采用当前服务时长，有效邀约保留原时长；历史接待及取消跟进的原关联不改写，展示合法直接后继。改期不计为真正取消，不自动生成治疗或资金。 确认页十五分钟有效；过期先查看已保存结果，再决定是否重新办理。
验收目标	AT-B40-1：两患者、前台与患者并发争用同一椅位或设备，仅保留一个有效结果。 AT-B40-2：冲突、旧页面、越权、撤权及重复确认保持正确原新关系；自身原占用不会误排除可行替代。 AT-B40-3：本人有效邀约原子转为唯一后继，接待关联同一成功结果；原接受事实保留，后继取消进入原因跟进。 AT-B40-4：五店浏览器、窄屏键盘、接诊与结算、三十分钟患者负载及独立加密恢复分别核验。

SU-41　分析预约取消时段并跟进改进

表 C-3 SU-41　分析预约取消时段并跟进改进用例规约

标题	内容（SU-41）
用例名称	SU-41　分析预约取消时段并跟进改进
执行者／触发	当前诊所主管；总部选择授权诊所查看汇总。
实现状态	已实现：本店星期×开始时段聚合、明确分母与缺失、原因及提前量汇总；主管及总部按授权访问。
前置条件	有效经营查询身份和诊所范围。
主要输入	期间、诊所、星期、预约开始时段、观察时点。
基本路径	1）选择本店及完整观察期间，总部先明确选择一家授权诊所。 2）查看星期×开始时段的到诊、患者取消、诊所取消、爽约、待核实和改期前身。 3）核对患者取消率与整体取消率的不同分母，查看样本不足或状态不完整提示。 4）按已核实分类及明确取消事件查看原因和提前量，缺失保持未知。 5）为需调查时段建立改进措施，由责任人执行并独立复核。
扩展路径	分母为零：显示无法计算，不显示零取消率。 D 不足 30 或完整性不足 95%：不进入优先调查排行。 授权诊所不匹配：拒绝访问；不展示患者身份或临床文字。
成功结果	原数量、分子分母、完整性和观察时点可核对；可进入措施办理，不能以排行断言因果。
最低保证	分析不改预约或泄露身份，不自动取消、处罚或超额预约。
业务规则	D=A+P+N；诊所取消与改期单列；合成结果不代表真实取消规律。 原取消说明保留，原因核实由 SU-55 办理；措施执行与复核由 SU-56 办理。
验收目标	AT-B41-1：A6/P2/C1/N1/U3/R5 得 D9、22.22%、11.11%、30.00%及 76.92%，不排行。 AT-B41-2：充分样本、边界、跨午夜、未来及多治疗明细不放大计数；跨店拒绝。

SU-42　维护本店收付款渠道账户

表 C-4 SU-42　维护本店收付款渠道账户用例规约

标题	内容（SU-42）
用例名称	SU-42　维护本店收付款渠道账户
执行者／触发	财务；新增或停用渠道。
实现状态	已实现。
前置条件	有效财务授权和当前目标范围。
主要输入	稳定账户代码、名称、方式和启停状态。
基本路径	1）选择授权诊所。 2）填写渠道方式及稳定代码。 3）预览核对后明确确认。 4）保存账户及历史，供新资金申请选用。
扩展路径	代码重复或跨店：拒绝。 停用账户：不再接受新使用，历史仍可查及对账。
成功结果	本店账户清晰可用且历史不被删除。
最低保证	失败不改变既有资金和匹配。
业务规则	方式包括现金、卡、转账、电子钱包及其他；不保存银行卡密码等支付凭据。
验收目标	AT-B42-1：新建、停用后拒绝新用；旧资金和流水仍可核对。

SU-43　提出账单收款申请

表 C-5 SU-43　提出账单收款申请用例规约

标题	内容（SU-43）
用例名称	SU-43　提出账单收款申请
执行者／触发	本店前台；患者支付全部或部分费用。
实现状态	已实现。
前置条件	有效账单及前台当前店权限；有可用渠道。
主要输入	金额、业务日、渠道、参考编号和申请依据。
基本路径	1）核对当前账单、已记账收退款和剩余应收。 2）录入本次金额与凭据，允许分次付款。 3）预览核对来源及金额后确认申请。 4）保存待审记录并交财务审核，显示当前办理状态。
扩展路径	超额或来源版本变化：拒绝，重新核对。 重复确认：返回既有申请。 联系或收款事实尚未明确：不以草稿记账。
成功结果	独立且有来源的待审收款，原应收和现金未被提前改变。
最低保证	申请失败不形成部分账务；预览不收款。
业务规则	独立财务审核后才形成已记账款项；账单不等于现金。
验收目标	AT-B43-1：两次部分收款与余额独立核算一致；超额拒绝。

SU-44　提出账单退款申请

表 C-6 SU-44　提出账单退款申请用例规约

标题	内容（SU-44）
用例名称	SU-44　提出账单退款申请
执行者／触发	本店前台；需要退还已收款项。
实现状态	已实现。
前置条件	原账单有可退已记账余额，具备当前店权限。
主要输入	退款金额、业务日、原因、渠道和参考编号。
基本路径	1）核对当前账单与已收已退。 2）说明退款依据并录入渠道证据。 3）预览后确认待审申请。 4）由不同财务账号核对并决定。
扩展路径	超过可退余额或原事实变化：拒绝。 只有账单更正而无可退余额：不自动退款。 回执不明：先查原申请，再决定后续处理。
成功结果	有依据的待审退款，审核和记账结果可查。
最低保证	失败不冲减实收，不删除原收款。
业务规则	退款、账单更正与临床更正分别处理；禁止盲目重复提交。
验收目标	AT-B44-1：部分退款、超额、自审、并发退款及重复确认核对。

SU-45　独立审核收退款及设备资金

表 C-7 SU-45　独立审核收退款及设备资金用例规约

标题	内容（SU-45）
用例名称	SU-45　独立审核收退款及设备资金
执行者／触发	不同账号的财务人员；待审申请进入队列。
实现状态	已实现。
前置条件	申请待审；经办和审核账号不同，双方授权仍有效。
主要输入	目标申请、通过或退回、审核理由。
基本路径	1）核对来源、当前金额与证据。 2）检查账单或设备事实及已记账、待审情况。 3）预览审核决定并明确确认。 4）重新核验版本和授权，原子保存决定及资金事实。
扩展路径	同账号换身份：拒绝自审。 经办撤权、来源变化或并发已审：不能沿用旧页通过。 退回：保留理由与原申请，不记账。
成功结果	通过后产生唯一已记账结果，或明确退回。
最低保证	失败不记账或改写原金额。
业务规则	不把审核通过当作外部真实支付已自动执行。
验收目标	AT-B45-1：自审、撤权、旧页和双人并发审核只保留合法一次效果。

SU-46　补充或更正资金凭据

表 C-8 SU-46　补充或更正资金凭据用例规约

标题	内容（SU-46）
用例名称	SU-46　补充或更正资金凭据
执行者／触发	账单前台／设备主管经办；不同财务账号复核。
实现状态	已实现。
前置条件	存在可处理资金及当前范围；不改变原金额。
主要输入	渠道账户、参考编号、补充或更正理由。
基本路径	1）读取原资金及当前凭据；缺失则明确未提供。 2）提出新证据版本。 3）不同财务账号核对补充或更正并确认。 4）追加版本；涉及已有匹配时使其失效并保留历史。
扩展路径	旧页或授权失效：拒绝。 试图修改金额或直接删旧凭据：不允许。
成功结果	证据有版本，原资金与历史决定仍可解释。
最低保证	失败不覆盖原凭据或现金事实。
业务规则	不为历史无证据记录伪造参考编号。
验收目标	AT-B46-1：历史补证、更正后匹配失效、同账号审核及旧证据确认拒绝。

SU-47　导入收付款渠道流水

表 C-9 SU-47　导入收付款渠道流水用例规约

标题	内容（SU-47）
用例名称	SU-47　导入收付款渠道流水
执行者／触发	当前店主管；取得合成 CSV 对账单。
实现状态	已实现。
前置条件	有目标店及账户权限；账户属于该店。
主要输入	CSV 原字节及选择账户；v1 六列。
基本路径	1）上传 UTF-8 文件。 2）服务器保留预览并校验列、日期、方向、正数金额及币种。 3）展示无效、重复与冲突结果。 4）主管确认绑定原预览及摘要。 5）保存有效新流水、原始字节和解析信息；精确重复跳过。
扩展路径	超过 2MiB 或 1,000 行、格式错或冲突：整批不接受新流水。 跨上传重复按账户和交易号识别；不能信任隐藏字段改写上传。
成功结果	可追溯且不重复的渠道流水。
最低保证	导入不改变应收、现金、账单或临床事实。
业务规则	交易号以账户为范围；原文件随数据库备份保留。
验收目标	AT-B47-1：重叠、精确重复、冲突交易号、错误 CSV 和过期预览。

SU-48　提交与独立复核逐笔对账

表 C-10 SU-48　提交与独立复核逐笔对账用例规约

标题	内容（SU-48）
用例名称	SU-48　提交与独立复核逐笔对账
执行者／触发	本店主管提议；不同财务账号复核。
实现状态	已实现。
前置条件	同店已接受流水和已记账资金；证据当前有效。
主要输入	目标流水、资金记录及复核决定。
基本路径	1）查看建议及未匹配差异。 2）逐项核对店、账户、币种、方向、金额和凭据参考号。 3）主管明确提交一对一提议。 4）不同财务账号复核并确认，重新检查授权和证据。 5）保存匹配决定和历史；差异继续可见。
扩展路径	待审资金、方向金额等不符：拒绝。 流水或资金已占用：拒绝重复匹配。 凭据更正或经办撤权：旧提议不能通过。
成功结果	唯一有效的一对一匹配，或说明差异。
最低保证	匹配不能记账、改账、拼凑余额或掩盖手续费差异。
业务规则	组合结算、费用和拆分列为例外；需人工后续设计。
验收目标	AT-B48-1：六条件、并发复核、重用流水、证据更正及独立审核。

SU-49　完成账内日结与交接复核

表 C-11 SU-49　完成账内日结与交接复核用例规约

标题	内容（SU-49）
用例名称	SU-49　完成账内日结与交接复核
执行者／触发	本店主管经办；不同财务账号审核。
实现状态	已实现。
前置条件	业务日期有效；当前店及财务权限有效。
主要输入	四类声明总额、凭据说明及交接理由。
基本路径	1）取业务日已记账四类资金事实。 2）分别填写收款、退款、设备支出和冲回总额。 3）预览差异并提交日结。 4）不同财务账号核对当前事实后通过或退回。 5）并列展示账内交接和渠道对账状态。
扩展路径	存在金额差异或后续资金变更：阻止旧版本通过并要求重核。 次日渠道入账：对账可待处理，不改原资金业务日。
成功结果	可追溯的独立日结版本及差异。
最低保证	日结不生成资金，也不强行完成渠道对账。
业务规则	四类毛额分别核对，不仅比净额。
验收目标	AT-B49-1：四类非零、迟到资金、旧页、独立复核和次日结算。

SU-50　登记设备资产及状态变更

表 C-12 SU-50　登记设备资产及状态变更用例规约

标题	内容（SU-50）
用例名称	SU-50　登记设备资产及状态变更
执行者／触发	当前店主管；新增、投用、送修或退役设备。
实现状态	已实现。
前置条件	本店设备管理权限；来源和状态有效。
主要输入	设备编码、名称、序列资料、日期、费用及变更依据。
基本路径	1）核对是否已有资产和当前状态。 2）录入登记或允许的状态变化。 3）预览确认后保存资产事件。 4）查阅历史，并在送修后交接维修工单。
扩展路径	重复标识或不允许状态：拒绝。 存在未完成维护：按业务规则先处理，不直接覆盖。
成功结果	本店资产及追加事件可查。
最低保证	不改其他店，不删除既有历史或自动付款。
业务规则	设备状态不等于预约日历，诊疗影响仍需明确协调。
验收目标	AT-B50-1：登记、送修、历史保留、跨店拒绝及重复提交。

SU-51　分派并办理设备维修工单

表 C-13 SU-51　分派并办理设备维修工单用例规约

标题	内容（SU-51）
用例名称	SU-51　分派并办理设备维修工单
执行者／触发	本店主管创建；指定主管负责人执行。
实现状态	已实现。
前置条件	设备已送修且来源有效，无重复未完成工单。
主要输入	故障说明、负责人、期限、完成日期、费用和维修说明。
基本路径	1）关联设备送修事件并指定负责人和期限。 2）负责人开始办理；必要时明确改派。 3）记录完成说明、费用及下次保养时间。 4）确认已经核对排班影响，提交独立验收。
扩展路径	负责人失效：改派后继续。 维修未完成：不提交恢复使用。 工单取消不自动恢复设备或患者安排。
成功结果	维修责任、处理历史和待验收结果可查。
最低保证	失败不恢复设备、不关闭预约、不自动支出。
业务规则	费用未知不当作零，零费用须明确确认。
验收目标	AT-B51-1：分派、改派、失效负责人、未知费用及提交退回。

SU-52　独立验收设备维修并协调恢复

表 C-14 SU-52　独立验收设备维修并协调恢复用例规约

标题	内容（SU-52）
用例名称	SU-52　独立验收设备维修并协调恢复
执行者／触发	不同账号的本店主管；维修报告待验收。
实现状态	已实现；资源日历自动影响识别待 SU-54 扩展。
前置条件	工单可验收；验收人与负责人及提交人不同。
主要输入	通过／退回、依据和排班影响核对。
基本路径	1）核对维修结果、费用、日期和设备来源。 2）核对出诊影响与需继续办理的协调事项。 3）预览通过或退回并明确确认。 4）通过则记录维修事件与验收；退回则交负责人继续。 5）相关预约与接收控制通过各自流程另行办理。
扩展路径	同账号验收、来源变更或旧报告：拒绝。 仍有待协调事项：明确责任，不以声明代替患者同意。
成功结果	有独立依据的验收结果，费用可供后续资金申请。
最低保证	不自动给患者改期、不自动付款或放行已有业务阻断。
业务规则	维修完成、验收、付款及恢复新预约分别表达。
验收目标	AT-B52-1：独立账号、过期来源、退回重提及预约事实不变。

SU-53　办理设备支出与资金冲回

表 C-15 SU-53　办理设备支出与资金冲回用例规约

标题	内容（SU-53）
用例名称	SU-53　办理设备支出与资金冲回
执行者／触发	本店主管申请；不同财务账号审核。
实现状态	已实现。
前置条件	有可用设备费用来源，或待冲回已记账支出。
主要输入	来源事件、金额、业务日、渠道凭据和依据。
基本路径	1）核对资产或维修费用及现有资金情况。 2）提出有来源的设备支出，或基于原支出提出冲回。 3）预览后保存待审。 4）不同财务账号审核并保存唯一记账决定。 5）费用更正与资金冲回分别核对并保留历史。
扩展路径	重复费用申请、超额、旧来源或自审：拒绝。 维修记录更正不自动冲回已记账支出。
成功结果	设备费用与真实资金有明确来源关联。
最低保证	不删原支出，不让资产事件直接代办资金。
业务规则	设备支出及冲回分别计入四类毛额。
验收目标	AT-B53-1：支出、冲回、费用更正、独立审核及重复申请核对。

SU-54　核对科室与诊疗资源并协调不可用安排

表 C-16 SU-54　核对科室与诊疗资源并协调不可用安排用例规约

标题	内容（SU-54）
用例名称	SU-54　核对科室与诊疗资源并协调不可用安排
执行者／触发	本店前台、主管；预约或设备不可用需要协调。
实现状态	已实现：电话、网站、前台、改期及候补统一核对诊疗资源。
前置条件	已确认本店服务资源规则，有权查看可用性。
主要输入	服务类别、预期时长、科室、医师、房间／椅位和必要设备。
基本路径	1）按服务时长、科室开放及接收医师查询可行的诊室椅位和必要设备组合。 2）核对患者与医师冲突、有效暂占、设备状态和临时停用；查询不占位。 3）复述安排并取得同意，确认时在统一事务重检并保存预约、资源方案及占用。 4）设备送修或停用列出原承诺影响，前台明确联系责任；同店同医师同时间可确认兼容替换。 5）到诊核查设备和实际使用，仍被前一患者占用时进入协调；维修恢复由另一主管验收。
扩展路径	同椅位或共享设备竞争：只一方成功，失败不部分占用。 患者未答复或拒绝改期：保留原约和待办；取消需明确发起方和原因。 治疗中故障：医护人工处置并留痕，不自动搬迁、顺延或改治疗状态。
成功结果	预约与适配资源一致；变更有责任人和明确结果。
最低保证	失败保留原预约，不能突破安全占用或自动替代患者选择。
业务规则	资格记录不等于自动执业认证；多渠道共享同一资源规则。
验收目标	AT-B54-1：同房双椅并行、共享设备争用、服务时长、关闭和维修。 AT-B54-2：跨入口并发、送修竞争、原约保护、兼容替换及到诊占用复核。

SU-55　核实取消原因并跟进患者选择

表 C-17 SU-55　核实取消原因并跟进患者选择用例规约

标题	内容（SU-55）
用例名称	SU-55　核实取消原因并跟进患者选择
执行者／触发	当前诊所前台；取消后需核对原因或联系结果。
实现状态	已实现：预览后明确确认，保留每次办理历史。
前置条件	原预约已取消；前台具有当前店有效权限；责任人属于本店前台。
主要输入	核实分类、联系人、联系结果、期限、依据；已另约时提供真实预约编号。
基本路径	1）进入取消待办，核对原发起方和取消说明，不覆盖原文。 2）按实际联系结果选择原因、责任人和联系状态；待联系或待回复填写下次期限。 3）患者接受另约时进入正式预约流程，成功后回到跟进页关联编号。 4）预览全部联系结果后明确确认，保存当前版本及办理历史。 5）按待办期限继续办理；核实变化时追加新版本，保留既有依据。
扩展路径	未联系或未提供原因：保持未提供，不依据关键词自动定责。 另约编号属于其他患者、诊所或无效状态：拒绝关联并继续核对。 原责任人授权失效或页面过期：重新分配或重开预览，不绕过授权。
成功结果	可知道谁联系、何时继续、患者实际选择及另约凭据；原预约仍保持取消。
最低保证	失败不部分写入；重复确认返回已完成结果；不更改原预约、治疗、账单及资金。
业务规则	只有当前店前台办理个案；记录联系不等于短信或微信送达。主管和总部不取得患者联系文字。
验收目标	AT-B55-1：五店联系待办、原因修订、正式另约与历史一致；比率分母不被修改。 AT-B55-2：旧预览、授权撤销、错店另约和并发重复确认拒绝或返回同一结果。

SU-56　安排预约改进措施并独立复核

表 C-18 SU-56　安排预约改进措施并独立复核用例规约

标题	内容（SU-56）
用例名称	SU-56　安排预约改进措施并独立复核
执行者／触发	主管建立和复核，授权负责人实际执行；另一账号负责复核。
实现状态	已实现：预览后明确确认，保留每次办理历史。
前置条件	已选择本店星期及时段；完整原窗口已结束；执行人授权有效。
主要输入	改进类型、计划、执行负责人、期限、完整原窗口；提交后提供执行依据及后续窗口。
基本路径	1）主管依据时段问题建立措施，核对原窗口数量、分母及限制后确认保存。 2）负责人开始执行，按约定联系、协调或核实，记录实际执行依据。 3）负责人提交待复核；另一主管核对责任、执行记录及后续完整窗口。 4）确认后续窗口不早于最近开始日且已完整结束，选择样本不足、不可比或变化待观察。 5）复核后保存比较快照与依据；需补充则退回，责任失效则明确重新分配。
扩展路径	执行前或当日未结束窗口：拒绝复核，不提前宣称效果。 执行人与复核人为同一账号：拒绝；切换岗位不能自审。 样本不足：保留计数和不足结论；不选择已核对变化。 重新分配或终止：保存责任和原因历史，不修改原预约。
成功结果	计划、责任期限、实际执行及独立评价可追溯；当前措施未满观察期保持待复核。
最低保证	失败不部分写入；重复确认返回已完成结果；不更改原预约、治疗、账单及资金。
业务规则	待开始→执行中→待复核→已复核；退回、重新分配及终止使用明确路径。统计变化不等于措施因果作用。
验收目标	AT-B56-1：执行提交、另一主管复核、退回、授权失效重分配及终止均保留历史。 AT-B56-2：自审、并发重复、统计变化、执行前窗口及未结束窗口被核验。

SU-57　维护本店预约服务与诊疗资源目录

表 C-19 SU-57　维护本店预约服务与诊疗资源目录用例规约

标题	内容（SU-57）
用例名称	SU-57　维护本店预约服务与诊疗资源目录
执行者／触发	本店主管；需要准备或调整服务与资源配置。
实现状态	已实现：预览确认维护，保留办理记录及原承诺。
前置条件	有效本店主管工作台，牙椅及必要设备已有本店资产登记。
主要输入	科室和开放时间、诊室、预约服务及时长、接收医师、必要设备数量、固定／共享位置、临时停用及核实依据。
基本路径	1）开始本店资源核对，暂停新增成约与邀约并保留旧承诺。 2）配置科室、开放区间、诊室、服务时长与医师适配；牙椅复用原资产台账。 3）配置固定或共享设备，核对同店位置与必要设备要求，预览后明确确认。 4）逐项核实现有预约和有效邀约的资源方案，不补造原来源与历史。 5）确认启用条件；日后调整只影响新候选，旧方案保留；停用进入影响协调。
扩展路径	外店关联、非法时长或不合适牙椅位置：拒绝，返回目录核实。 有未核实承诺或未完成影响协调：不能启用，原记录保留。 目录并发变化或旧预览：重新核对；重复确认不重复配置。
成功结果	本店服务与资源可用于统一预约，配置责任、启用条件及历史引用可核对。
最低保证	不直接创建治疗、账单或资金，不覆盖原预约、不删除历史资产。
业务规则	15 至 240 分钟、15 分钟步长；整段占用；固定设备服务所属诊室，共享设备仅本店；独占诊室配置一个椅位。
验收目标	AT-B57-1：同店配置、时长、开放、固定／共享关系和停用。 AT-B57-2：旧承诺逐项映射、启用重检、撤权、过期预览及重复确认。

SU-58　查阅日周排班并衔接预约或调班

表 C-20 SU-58　查阅日周排班并衔接预约或调班用例规约

标题	内容（SU-58）
用例名称	SU-58　查阅日周排班并衔接预约或调班
执行者／触发	当前诊所前台；需要核对服务安排和剩余机会。
实现状态	已实现：日周视图及授权办理入口。
前置条件	有效前台工作身份并已选择本店。
主要输入	日期、日或周、可选本店医师与预约服务。
基本路径	1）选择日期与查看方式，系统按北京时间定位本日或从周一开始的一周。 2）查看本店出诊和分页范围，区分正式预约、有效邀约、到期邀约与剩余计划空档。 3）选择服务核对完整时长及首个可行诊室、椅位和设备组合；查询不保留资源。 4）按需要进入原预约、出诊维护、候补排班或调班任务，确认页重新核验授权与冲突。
扩展路径	无本页出诊：切换日期、医师或页码，不能据此断言全店无供给。 暂停新增、科室关闭、医师不适配或设备维修：显示状态，不能据计划空档直接成约。 上一患者仍在诊：显示现场协调提示，预约和到诊仍再次核验实际占用。 撤权或跨店筛选：拒绝；不提供其他店患者身份或临床内容。
成功结果	前台能定位可行服务机会及受影响承诺，并进入准确的原办理流程。
最低保证	只读查询不创建预约、资源占用、治疗、账单或资金；接受邀约不被重复计作两份承诺。
业务规则	星期从周一开始；最多 28 条出诊分页；按具体服务完整时长查询，计划空档与实际使用分别展示。
验收目标	AT-B58-1：日周边界、医师及本店过滤、跨日出诊、分页和到期邀约。 AT-B58-2：15／45／60 分钟、维修停用、实际在诊超时、键盘及 390px 大字布局。 AT-B58-3：七角色隔离、重复确认、并发、无逐行查库及查询无业务副作用。

SU-59　维护并发布患者服务说明

表 C-21 SU-59　维护并发布患者服务说明用例规约

标题	内容（SU-59）
用例名称	SU-59　维护并发布患者服务说明
执行者／触发	当前诊所主管；患者阅读公开内容。
实现状态	已实现：本店草稿、预览、明确发布及双端服务选约；真实临床能力须另行核实。
前置条件	本店资源目录已配置，主管当前身份及诊所授权有效；公开前接诊配置及内容完整。
主要输入	对应预约服务、分类、适用需求、包含内容、限制、准备事项、费用方式与金额、公开选择。
基本路径	1）选择本店既有预约服务，填写患者可读的说明；模板仅作为草稿。 2）核对服务范围、接收医师、时长与费用；预览患者阅读效果。 3）明确选择公开，预览并确认保存；公开目录仅展示内容完整且接诊配置有效的服务。 4）患者在网站或小程序了解内容，选择同一服务并查询时段；正式预约仍经统一资源确认。 5）主管按原流程调整或下架，保留操作历史；已有预约仍按原授权办理。
扩展路径	草稿、不完整或停用：不作为可新预约的公开服务。 未知费用：保留待评估与空金额；明确零元不与缺失混用。 查询后服务变化或下架：旧预览不能新成约，成功回执重放仍返回原结果。 儿童代办：前台核验关系及授权后，代约人可在有效期内选择患者办理；阅读说明本身不授予权限。
成功结果	本店已核对的患者说明与真实预约目录一致，两个渠道使用同一公开服务。
最低保证	发布不新增临床权限、不占位、不创建治疗、账单或资金；失败保留原记录。
业务规则	每项服务至多一份说明；本店主管可维护，前台继续负责排班。公开不表示临床资格已认证，也不保证某时段空闲。
验收目标	AT-B59-1：本店发布、外店拒绝、草稿预览、内容完整性、未知与零元费用。 AT-B59-2：网站与小程序选约、登录续接、下架旧页、既有预约改期及重复确认。

SU-60　受理患者关系并关联账号

表 C-22 SU-60　受理患者关系并关联账号用例规约

标题	内容（SU-60）
用例名称	SU-60　受理患者关系并关联账号
执行者／触发	本店前台
实现状态	已实现；基于课程合成资料验证。
前置条件	患者已建档，前台处于当前诊所。
主要输入	患者编号、关联人、关系、可选账号和受理说明。
基本路径	1）核对本店患者，登记关联人与关系。 2）账号缺失时保留待核验，可由技术人员先创建独立账号。 3）人工核对账号归属后预览并确认关联；受理事件保留。
扩展路径	外店、无效患者或不存在账号：不能办理。 同一患者与账号已有办理中关系：继续原单。 相同手机号：仍独立核对，不自动合并。
成功结果	待核验关系与受理历史；尚未产生代约权。
最低保证	失败不留下部分预约或授权效果，已保存的历史和原承诺保留。
业务规则	联系人和普通亲属关系不是访问授权。
验收目标	AT-C11-60：正常办理、撤权、旧预览、重复确认、跨店及恢复核对。

SU-61　核验关系并授予预约代办

表 C-23 SU-61　核验关系并授予预约代办用例规约

标题	内容（SU-61）
用例名称	SU-61　核验关系并授予预约代办
执行者／触发	获本店明确核验职责的前台
实现状态	已实现；基于课程合成资料验证。
前置条件	待核验或已暂停关系；代约账号已人工核对。
主要输入	核验方式、内部依据编号、说明、截止时间和明确确认。
基本路径	1）复述患者、关联人、账号和本店范围。 2）核对关系及委托依据，填写有效期。 3）预览并明确确认；关系状态与授权在同一事务保存。 4）保留核验人员、时间及原始决定。
扩展路径	无核验职责或职责已撤销：拒绝。 联系人核验：保存关系但不生成授权。 有效期已过或关系版本已变：重新核对。
成功结果	可在有效期内办理指定患者本店预约事项。
最低保证	失败不留下部分预约或授权效果，已保存的历史和原承诺保留。
业务规则	预约委托不包含病历、账单、支付或临床知情同意权。
验收目标	AT-C11-61：正常办理、撤权、旧预览、重复确认、跨店及恢复核对。

SU-62　切换患者并办理预约事项

表 C-24 SU-62　切换患者并办理预约事项用例规约

标题	内容（SU-62）
用例名称	SU-62　切换患者并办理预约事项
执行者／触发	患者本人或有效代约人
实现状态	已实现；基于课程合成资料验证。
前置条件	账号已登录，至少一个有效本人或代约入口。
主要输入	本人或授权患者选择，预约、改期、取消或候补决定。
基本路径	1）选择就诊人，页面显示姓名和办理身份。 2）查阅所选患者授权范围内的预约及候补。 3）核对服务、医师、起止时间或候补意向。 4）明确确认后共用原预约资源事务并返回办理结果。
扩展路径	切换后旧表单、迟到响应：失效并重新核对。 授权暂停或到期：联系前台，原预约保留。 资源被占或重复提交：返回冲突或原成功结果。
成功结果	所选患者的唯一有效办理结果，可在网站和小程序查询。
最低保证	失败不留下部分预约或授权效果，已保存的历史和原承诺保留。
业务规则	实际操作者与就诊人分别保留；同一患者不同操作者共享资源冲突检查。
验收目标	AT-C11-62：正常办理、撤权、旧预览、重复确认、跨店及恢复核对。

SU-63　暂停或撤销预约代办并协调原约

表 C-25 SU-63　暂停或撤销预约代办并协调原约用例规约

标题	内容（SU-63）
用例名称	SU-63　暂停或撤销预约代办并协调原约
执行者／触发	本店前台
实现状态	已实现；基于课程合成资料验证。
前置条件	存在已核验或已暂停关系。
主要输入	暂停或撤销决定、原因与明确确认。
基本路径	1）核对当前关系、授权及历史。 2）预览并确认暂停或撤销，追加决定事件。 3）停止新的代办确认，保留原约和候补。 4）前台按既有预约与候补入口继续联系处理。
扩展路径	已完成决定的重试：返回当前记录。 暂停后需恢复：重新核验并产生新版本。 旧预览或已撤销关系：不得恢复效力。
成功结果	授权失效且业务历史连续；原承诺未被隐式取消。
最低保证	失败不留下部分预约或授权效果，已保存的历史和原承诺保留。
业务规则	前台取消或改期仍须单独明确办理，不以撤权代替患者决定。
验收目标	AT-C11-63：正常办理、撤权、旧预览、重复确认、跨店及恢复核对。

SU-64　申请并独立审核专业操作范围

表 C-26 SU-64　申请并独立审核专业操作范围用例规约

标题	内容（SU-64）
用例名称	SU-64　申请并独立审核专业操作范围
执行者／触发	本店主管及受机构委任的专业审核医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料验证。
前置条件	有效医师账号和本店服务适配，审核职责有明确机构依据及期限。
主要输入	医师、服务、资质来源机构与编号、证据期限、操作期限及查阅／记录／转诊范围。
基本路径	1）主管核对原始资质证据并整理限定申请。 2）预览后确认提交，等待专业审核。 3）另一名受委任医师核对来源、期限和动作，批准或拒绝。 4）需要暂停、恢复或撤销时另行说明并明确确认，保留全部决定。
扩展路径	申请对象或整理人切换身份自审：拒绝。 职责撤回、资质到期或当前页面状态变化：重新核对。 重复确认：返回原申请或当前决定，不新增第二项效果。
成功结果	限定专业范围及可追溯的独立决定。
最低保证	失败不留下部分授权或披露结果，原预约、诊疗及财务历史保留。
业务规则	目录资质和机构审核职责不自动授予病历、处方、财务审核或临床文书复制权限。
验收目标	AT-AUTH-64：正常交接、撤权、旧预览、并发、跨店与历史保留核对。

SU-65　启用专业控制并办理授权失效交接

表 C-27 SU-65　启用专业控制并办理授权失效交接用例规约

标题	内容（SU-65）
用例名称	SU-65　启用专业控制并办理授权失效交接
执行者／触发	本店受委任专业审核医师及技术管理人员
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料验证。
前置条件	本店原有未来和在诊预约逐项核对专业范围。
主要输入	启用依据、授权调整或离岗停用依据及明确确认。
基本路径	1）核对本店原承诺所需的医师、服务和日期。 2）明确启用后，接诊与查阅持续核验当前账号、专业动作和有效期。 3）人员离岗时通过受控账号治理停止访问及旧会话。 4）保留原预约、诊疗署名和结算历史，另行安排业务交接。
扩展路径	原承诺尚无有效专业范围：先补齐或协调，不能直接启用。 授权到期或撤回：拒绝新临床操作，不自动取消预约。 安全封禁后恢复：先重置凭据，再明确启用，原会话不恢复。
成功结果	临床操作受持续授权控制，原有业务事实可追溯。
最低保证	失败不留下部分授权或披露结果，原预约、诊疗及财务历史保留。
业务规则	专业失效不等于预约取消或临床事实撤销，技术人员不能代替专业审核。
验收目标	AT-AUTH-65：正常交接、撤权、旧预览、并发、跨店与历史保留核对。

SU-66　发起并接收限定跨店转诊

表 C-28 SU-66　发起并接收限定跨店转诊用例规约

标题	内容（SU-66）
用例名称	SU-66　发起并接收限定跨店转诊
执行者／触发	原负责医师、接收店身份核验前台及指定接收医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料验证。
前置条件	原负责医师具有本次服务转诊范围，接收医师有接收店相应查阅范围。
主要输入	原就诊、可选发布版本、接收店和医师、独立披露同意依据、目的与查阅期限。
基本路径	1）原医师核对患者同意，预览并确认限定转诊。 2）接收店获明确职责的前台核对现有患者完整编号。 3）身份相符后，指定医师明确接收限定范围。 4）接收医师查阅选定版本，再根据实际情况另行安排后续诊疗。
扩展路径	身份编号不一致：登记待澄清，不合并档案。 未核对身份、非指定医师或过期专业范围：拒绝接收或查阅。 草稿、其他患者或其他就诊记录：不能作为披露版本。 重复或并发确认：保存一次决定，旧预览不能覆盖撤回。
成功结果	保留指定人、范围、期限及各岗位决定的转诊记录。
最低保证	失败不留下部分授权或披露结果，原预约、诊疗及财务历史保留。
业务规则	转诊不授予全连锁搜索，不产生预约、实际治疗、账单或收退款。
验收目标	AT-AUTH-66：正常交接、撤权、旧预览、并发、跨店与历史保留核对。

SU-67　核对并终止本人转诊披露

表 C-29 SU-67　核对并终止本人转诊披露用例规约

标题	内容（SU-67）
用例名称	SU-67　核对并终止本人转诊披露
执行者／触发	患者本人、原负责医师或转出店主管
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料验证。
前置条件	存在本人或本店有权终止的转诊事项。
主要输入	明确的终止决定及办理依据。
基本路径	1）在网站或小程序核对本人转诊接收店、指定医师及截止时间。 2）预览本次撤回或终止范围。 3）明确确认后停止后续查阅。 4）保留办理历史，原预约及原诊疗记录继续按各自流程管理。
扩展路径	预约代约人：不能进入临床披露控制。 切换患者后旧预览：重新核对。 重复确认或网络重试：返回当前结果，不恢复原授权。
成功结果	撤回未接收转诊，或撤销已接收转诊的后续查阅。
最低保证	失败不留下部分授权或披露结果，原预约、诊疗及财务历史保留。
业务规则	停止后续查阅不能收回已经合法送达的信息；不以撤权代替取消或更改预约。
验收目标	AT-AUTH-67：正常交接、撤权、旧预览、并发、跨店与历史保留核对。

SU-68　补充与核对本人健康自述

表 C-30 SU-68　补充与核对本人健康自述用例规约

标题	内容（SU-68）
用例名称	SU-68　补充与核对本人健康自述
执行者／触发	患者本人及本次负责医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	本人账号已绑定有效患者；医师面谈须实际到诊并具有本店本服务记录范围。
主要输入	既往健康、目前用药及过敏的自述状态和说明，当前来源版号及明确确认。
基本路径	1）患者通过网站或小程序核对当前就诊人。 2）区分已有情况、目前无已知和仍未知，明确提交新的自述版本。 3）医师在本次实际面谈中另存所取得的自述来源。 4）后续检查引用具体自述版本，分别保留核对结论及差异。
扩展路径	预约代办人：拒绝临床自述。 其他店面谈：不进入本店可核对列表。 旧页或重复请求：比较最新来源后继续，原历史不被覆盖。
成功结果	有来源、作者及前版的自述，未知事项继续可见。
最低保证	失败不留下部分确认结果，已保存草稿及原患者、诊疗和财务历史保留。
业务规则	自述不等于专业核验，不自动改变已复核过敏、治疗或资金事实。
验收目标	AT-CLINICAL-68：来源、未知、并发、重试、撤权、跨店及历史核对。

SU-69　记录本次检查与牙位观察

表 C-31 SU-69　记录本次检查与牙位观察用例规约

标题	内容（SU-69）
用例名称	SU-69　记录本次检查与牙位观察
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	患者已实际到诊，医师对当前诊所、服务和记录动作具有有效专业范围。
主要输入	主诉、检查说明、自述来源、核对结论、差异、牙列、牙位牙面及观察说明。
基本路径	1）核对实际就诊人与本次负责关系，开始唯一检查记录。 2）填写主诉和检查，选择具体自述及核对结论。 3）以牙位图或键盘选框录入恒牙、乳牙或混合牙列观察。 4）分次保存服务器草稿，逐条核对未确认观察。
扩展路径	未到诊、过期范围或其他医师：不能建立检查。 非法牙位、牙面或重复位置：提示修正，保留本页填写。 两页冲突：比较当前已保存草稿，再保留本页文字明确继续。
成功结果	有正确就诊关联及当前版号的服务器检查草稿。
最低保证	失败不留下部分确认结果，已保存草稿及原患者、诊疗和财务历史保留。
业务规则	未记录部位不推断为正常；牙位观察不等同于已实施治疗或收费。
验收目标	AT-CLINICAL-69：来源、未知、并发、重试、撤权、跨店及历史核对。

SU-70　确认检查版本与追加更正

表 C-32 SU-70　确认检查版本与追加更正用例规约

标题	内容（SU-70）
用例名称	SU-70　确认检查版本与追加更正
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	本次有已保存草稿，来源及患者专业范围可重新核对。
主要输入	服务器预览、明确确认；更正时填写依据。
基本路径	1）预览服务器保存的文字、牙位和具体自述来源。 2）核对患者、观察发生时间、未知和差异后确认。 3）需要更正时基于原版本建立新草稿并填写原因。 4）重新预览后追加新版本，原版本、作者及前版关系继续保留。
扩展路径	预览后新增自述或草稿变化：保留草稿并重新核对。 重复确认：返回已保存进度，不新增第二个版本。 误建更正草稿：说明依据并明确放弃，原版本不变。
成功结果	可按原版本阅读的检查历史及带依据的新更正版本。
最低保证	失败不留下部分确认结果，已保存草稿及原患者、诊疗和财务历史保留。
业务规则	检查更正不重写已发布结算；结构化记录可作为限定转诊来源，披露仍遵守独立同意和接收规则。
验收目标	AT-CLINICAL-70：来源、未知、并发、重试、撤权、跨店及历史核对。

SU-71　通过检查工作台完成接诊衔接

表 C-33 SU-71　通过检查工作台完成接诊衔接用例规约

标题	内容（SU-71）
用例名称	SU-71　通过检查工作台完成接诊衔接
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	有效医师身份及当前患者、诊所、服务查阅范围。
主要输入	活动、草稿、已确认及历史列表，具体就诊编号。
基本路径	1）查看本人的授权负责清单及检查进度。 2）进入对应患者实际检查，完成来源核对与确认。 3）返回接诊页面复核过敏及实际治疗。 4）按实际治疗核对并结束接诊，结算与资金操作继续独立办理。
扩展路径	检查草稿未确认或有新增自述待核对：提示处理入口并阻止直接结束。 前台、财务、主管、总部、技术或患者身份访问临床工作台：拒绝。 范围撤回或跨店探测：停止新查阅，原署名与历史保留。
成功结果	检查、实际治疗和结算各自完整，下一操作明确。
最低保证	失败不留下部分确认结果，已保存草稿及原患者、诊疗和财务历史保留。
业务规则	清单不扩大跨店病历搜索；工作台显示及敏感查阅事件不产生临床或资金决定。
验收目标	AT-CLINICAL-71：来源、未知、并发、重试、撤权、跨店及历史核对。

SU-72　建立与修订跨次治疗方案

表 C-34 SU-72　建立与修订跨次治疗方案用例规约

标题	内容（SU-72）
用例名称	SU-72　建立与修订跨次治疗方案
执行者／触发	负责医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	本次有确认检查及本店本服务记录范围。
主要输入	方案摘要、步骤、位置、估算、互斥组、计费时点与加工依赖。具体步骤的目的、风险、选择、麻醉、材料、费用、后续注意及沟通说明。
基本路径	1）基于当前检查建立工作草稿。 2）讨论目标及可选步骤，未知费用保持空缺。 3）按具体步骤保存治疗说明，未完成可暂存；勾选准备完成时核对前七项及当前依据。 4）预览后明确确认具体方案版本。 5）后续改变另建版本，保留原步骤沿革及发布时目录定义。
扩展路径	目录或检查在预览后变化：重新核对。 双页冲突、撤权或跨店：拒绝覆盖并提供返回入口。 步骤、摘要、检查或目录变化：重新复核说明；未完成文字不对患者公开。
成功结果	可按确切版本查阅的方案与工作历史。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	方案估算不产生治疗或账单；旧本人决定不自动适用新版。具体说明随发布版本冻结，修订保留原版；准备说明不代表患者已经同意。
验收目标	AT-CONTINUITY-72：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。 AT-DISCLOSURE-72：草稿隐藏、准确来源、步骤变更、双页并发、旧预览及版本恢复。

SU-73　核对具体方案步骤的本人决定

表 C-35 SU-73　核对具体方案步骤的本人决定用例规约

标题	内容（SU-73）
用例名称	SU-73　核对具体方案步骤的本人决定
执行者／触发	患者本人或手工记录讨论的负责医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	网站和小程序须为有效本人；医师须有具体服务范围。
主要输入	认可、暂缓或不选择，具体步骤版本与讨论说明。
基本路径	1）读取本人已经发布的方案。 2）查阅医师已准备的对应步骤说明，可切换历史；缺失时明确尚未提供。 3）选择具体版本步骤及本人表态。 4）核对预览并明确提交。 5）刷新当前进度，保留所有旧决定。
扩展路径	互斥步骤同时认可：拒绝第二个选择。 患者切换或响应丢失：清除旧主体资料，原提交可同次核实。 当前说明尚未准备：显示待完善，不展示部分草稿，不补造已告知或本人同意。
成功结果	可追溯来源、账号及版本的本人决定。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	代约权限不含临床决定；讨论决定不等于治疗完成或合格知情同意签署。查看说明不新增决定；预约代办不能查看本人临床说明。
验收目标	AT-CONTINUITY-73：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。 AT-DISCLOSURE-73：网站与小程序准确版本一致，原版保留，其他患者及代约人被拒绝。

SU-74　登记实际执行与唯一开单来源

表 C-36 SU-74　登记实际执行与唯一开单来源用例规约

标题	内容（SU-74）
用例名称	SU-74　登记实际执行与唯一开单来源
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	实际到诊、确认检查、具体服务权限及必要准备已满足。
主要输入	实际项目、数量、位置、发生时间、阶段、计费及差异依据。
基本路径	1）核对当前已认可步骤或明确计划外依据。 2）检查加工件周期及确切步骤就绪。 3）预览实际执行和本次开单金额，明确确认。 4）依实际治疗关闭接诊并发布结算，保留原收费来源与快照。
扩展路径	旧预览、重复确认或并发执行：重新核对或返回原结果。 未发布误录：说明依据撤回，原执行及快照保留。
成功结果	唯一实际执行与至多一个原始收费行；阶段不收费仍记已治疗。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	估算和本人表态不收费；已发布执行不能由本入口作废，审核账单副本不新增执行。
验收目标	AT-CONTINUITY-74：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。

SU-75　明确后续要求并关联正式预约

表 C-37 SU-75　明确后续要求并关联正式预约用例规约

标题	内容（SU-75）
用例名称	SU-75　明确后续要求并关联正式预约
执行者／触发	负责医师、当前店前台
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	医师有已确认检查及目标服务范围；前台有本店预约权限。
主要输入	服务、日期窗口、临床目标、完成标准、安排说明及已有预约。
基本路径	1）医师明确后续目标和完成标准。 2）前台核对患者与统一资源时段并正式成约。 3）明确关联同患者同店同服务预约。 4）沿原改期后继显示当前结果，未完成目标继续安排。
扩展路径	原预约取消或部分治疗关闭：保留临床目标并继续协调。 窗口或资源不符：重新协商，不自动造约。
成功结果	有原检查依据和原预约关联的后续要求。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	关联预约不代表复诊完成，前台不查阅临床目标及计划估价。
验收目标	AT-CONTINUITY-75：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。

SU-76　承接复诊责任与联系跟进

表 C-38 SU-76　承接复诊责任与联系跟进用例规约

标题	内容（SU-76）
用例名称	SU-76　承接复诊责任与联系跟进
执行者／触发	当前店前台
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	医师已明确后续完成标准。
主要输入	责任期限、实际联系结果及安排需要的说明。
基本路径	1）明确认领责任和下次内部期限。 2）记录联系、未接通或内部协调。 3）本人暂不继续时转医师核对。 4）原责任人失效可明确接续，经核对后明确恢复协调。
扩展路径	非责任人、撤权或跨店：不得代替原责任人写入。 本人暂不继续：不自动再次联系，不自动取消预约。
成功结果	有责任、期限和追加沟通历史的随访工作。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	内部期限不是患者承诺，也不触发真实电话或短信。
验收目标	AT-CONTINUITY-76：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。

SU-77　核对随访目标实际完成

表 C-39 SU-77　核对随访目标实际完成用例规约

标题	内容（SU-77）
用例名称	SU-77　核对随访目标实际完成
执行者／触发	当前责任前台
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	明确关联的后续就诊已关闭并达到医师定义的目标。
主要输入	具体实际完成依据及核对说明。
基本路径	1）查看原要求、建议窗口及原预约后继。 2）选择已关闭实际检查或指定步骤完成依据。 3）核对患者、诊所、服务及实际时间。 4）明确结束责任，保留迟于建议窗口等事实。
扩展路径	只有预约、到诊、草稿或部分治疗：不得完成。 原指示被医师撤回：按撤回事实另行结束，不能记成完成。
成功结果	带实际证据的完成或明确撤回结果。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	不改原建议日期，不把联络或物理返回当成临床完成。
验收目标	AT-CONTINUITY-77：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。

SU-78　登记加工要求与手工送返

表 C-40 SU-78　登记加工要求与手工送返用例规约

标题	内容（SU-78）
用例名称	SU-78　登记加工要求与手工送返
执行者／触发	负责医师、当前店责任前台
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	当前已接受步骤明确需要加工件，医师有对应服务范围。
主要输入	加工类别、临床要求、原需要日期、加工方、交接凭据及期限。
基本路径	1）医师从确认检查登记具体步骤加工要求。 2）前台认领协调责任和期限。 3）手工登记实际送出、返回及凭据。 4）延误照实登记新获悉日期，原日期及预约保留。
扩展路径	责任人失效：明确交接并留历史。 延误或原约不合适：进入原资源改期流程，不静默取消。
成功结果	可核对周期及责任的加工流转历史。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	手工登记不是供应方回执，前台不读取临床规格及验收详情。
验收目标	AT-CONTINUITY-78：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。

SU-79　临床验收、返工与加工件就绪

表 C-41 SU-79　临床验收、返工与加工件就绪用例规约

标题	内容（SU-79）
用例名称	SU-79　临床验收、返工与加工件就绪
执行者／触发	具有具体服务记录范围的医师
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	加工件已实际返回，目标为当前明确步骤。
主要输入	验收周期、具体版本步骤、实际验收时间、结果及返工说明。
基本路径	1）核对物理周期及当前具体步骤。 2）分别记录临床验收通过或明确返工。 3）返工经下一次送返周期重新验收。 4）换版复用重新核对，全部有效请求满足后允许实际执行。
扩展路径	只有返回、旧周期或旧版本：不能作为当前就绪。 缺少历史依赖或实际时间早于验收：重新核对。
成功结果	有原检查、版本、周期及医师依据的就绪或返工结果。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	返回不等于适配，撤回请求不取消步骤依赖，验收本身不产生收费。
验收目标	AT-CONTINUITY-79：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。

SU-80　查看复诊与加工协同汇总

表 C-42 SU-80　查看复诊与加工协同汇总用例规约

标题	内容（SU-80）
用例名称	SU-80　查看复诊与加工协同汇总
执行者／触发	当前店主管、总部
实现状态	已实现；以明确标注的合成资料核对软件流程。
前置条件	相应管理范围有效。
主要输入	状态、未承接及逾期筛选。
基本路径	1）主管核对当前诊所的责任和状态数量。 2）总部查看授权范围汇总。 3）区分复诊未完成、本人暂不继续和加工待验收。 4）根据汇总交由对应岗位办理，不能代替临床或财务决定。
扩展路径	其他岗位或跨店探测：拒绝越权明细。 空数据：明确为零，不补造联系或临床结果。
成功结果	可解释统计范围与状态含义的管理投影。
最低保证	失败不留下部分业务效果，已保存草稿及原患者、预约、诊疗和财务历史保留。
业务规则	汇总不包含患者身份、联系文字、临床目标、加工规格和验收详情。
验收目标	AT-CONTINUITY-80：具体版本、责任、准备、实际完成、重试、并发、撤权及历史核对。

SU-81　发现附近门店并延续预约选择

表 C-43 SU-81　发现附近门店并延续预约选择用例规约

标题	内容（SU-81）
用例名称	SU-81　发现附近门店并延续预约选择
执行者／触发	访客、患者或有权预约代办人
实现状态	已实现；软件流程采用明确合成资料核对，平台运行另行验收。
前置条件	存在明确发布的有效门店或服务；浏览不要求登录。
主要输入	手动城市、区域或名称，主动定位选择，明确门店及服务。
基本路径	1）浏览已发布门店及营业、电话和详细入口。 2）手动筛选，或主动授权后由近到远排序。 3）选定明确服务，再按需登录患者通道。 4）选择合法就诊人，继续原服务候选及明确预约确认。
扩展路径	拒绝定位或缺少坐标：继续手动选择，不显示伪造距离。 服务撤回、提示过期、撤权或跨店：重新核对，不替换为其他服务。 合成电话及地址：说明课程资料，不执行真实拨号或导航。
成功结果	保留明确门店和服务选择，后续预约仍由统一规则确认。
最低保证	浏览、定位、登录和患者选择均不制造预约、患者、治疗或资金记录。
业务规则	公开只读字段与私有工作台分开；用户精确位置只在客户端排序；营业状态与资源余位分别表达。
验收目标	AT-DISC-01—06：访客、定位拒绝、排序、登录延续、撤回、患者切换、窄屏大字与键盘。

SU-82　维护并发布本店公开资料

表 C-44 SU-82　维护并发布本店公开资料用例规约

标题	内容（SU-82）
用例名称	SU-82　维护并发布本店公开资料
执行者／触发	当前店主管
实现状态	已实现；正常预览确认与数据库版本核对。
前置条件	有效主管工作上下文及当前诊所授权；发布前已有科室开放安排。
主要输入	展示名、行政区、地址入口、公开电话、两种坐标及来源、发布状态。
基本路径	1）查看本店当前资料与版本。 2）输入公开字段并预览营业来源和影响。 3）核对后明确确认，追加发布版本。 4）公开撤回时隐藏新服务入口，保留原约、有效邀约及历史。
扩展路径	跨店、撤权或只读实例：拒绝写入。 旧预览或同时确认：核对当前版本后继续；重复同次提交返回原结果。 实际停诊或搬迁：前台明确协调原承诺，不由公开文字改写预约。
成功结果	当前公开资料与不可覆盖的操作者版本记录。
最低保证	失败不留下部分资料确认；业务诊所身份、单据及原承诺保持。
业务规则	一店一份当前资料；版本及操作编号唯一；开放日历复用原表，历史缺失不补造。
验收目标	AT-DIRECTORY-01—08：字段、营业来源、并发、重复、撤权、历史和 SQL 约束。

SU-83　建立并管理患者渠道账号

表 C-45 SU-83　建立并管理患者渠道账号用例规约

标题	内容（SU-83）
用例名称	SU-83　建立并管理患者渠道账号
执行者／触发	患者渠道使用者
实现状态	已实现；真实认证接口及合成流程分开配置，真实平台验收尚未完成。
前置条件	存在有效本地登录凭证；绑定旧账号时还须核对原密码。
主要输入	一次凭证、明确同意；可选原账号及密码。
基本路径	1）明确同意本地授权替身，核对有效登录凭证。 2）首次建立没有患者及员工授权的账号，或明确绑定原患者渠道账号。 3）查看账号与办理状态，核对同一身份后设置可用密码。 4）解除绑定须核对密码，保留原账号和业务历史。
扩展路径	过期、已用、错用途或未知凭证：重新签发，不接受客户端自报身份。 安全停用账号或错误原密码：不绑定、不激活患者。 本人关系暂停：仅办理原关联复核，不取得原患者业务权。
成功结果	可识别的患者渠道账号与追加的绑定或解除事件。
最低保证	登录与解绑不创建患者、预约、治疗、资金或员工岗位。
业务规则	身份来源、账号、患者与岗位分离；凭证仅消费一次；解绑不删除历史。
验收目标	AT-ACCOUNT-01：首次、原账号绑定、重放、过期、恢复与通道隔离。

SU-84　登记有来源的账号联络号码

表 C-46 SU-84　登记有来源的账号联络号码用例规约

标题	内容（SU-84）
用例名称	SU-84　登记有来源的账号联络号码
执行者／触发	患者渠道使用者
实现状态	已实现；真实认证接口及合成流程分开配置，真实平台验收尚未完成。
前置条件	当前本人账号上下文，存在专属手机替身凭证。
主要输入	手机凭证及明确确认。
基本路径	1）查看账号当前联络来源。 2）明确同意后提交绑定当前账号的手机替身凭证。 3）保存联络号码、来源、核对时间和版本。 4）换号追加事件，患者原档案和本人关系保持。
扩展路径	错用途、过期、已用或属于另一账号：不保存。 家人共用号码：分别记录，不合并账号或档案。 没有手机授权：仍可浏览及申请人工核验。
成功结果	账号联络号码显示本地模拟来源和时间。
最低保证	号码变化不授予患者或代约权限，不改写原患者联络资料。
业务规则	号码不是患者身份主键；合成号码不冒充真实手机核验。
验收目标	AT-ACCOUNT-02：来源、当前账号、共享号码、换号及拒绝后继续。

SU-85　申请本人建档或原档案复核

表 C-47 SU-85　申请本人建档或原档案复核用例规约

标题	内容（SU-85）
用例名称	SU-85　申请本人建档或原档案复核
执行者／触发	待关联本人档案的患者渠道使用者
实现状态	已实现；本地合成流程核对，真实微信平台及身份能力另行验收。
前置条件	有效账号与明确门店；没有有效本人关联，或原本人关联待复核。
主要输入	必要患者资料、新档或旧档意向及可选原患者编号。
基本路径	1）选择明确门店，新患者填写完整必要资料，旧患者提供核验线索。 2）预览资料和本次申请，不自动检索或合并患者。 3）明确提交后查看原申请状态，待补充时修改同一申请。 4）原关联暂停时只申请同一原档案复核；需要结束时明确撤回。
扩展路径	重复或断网重试：核对同次唯一结果。 已有办理中申请：继续原申请，不另建并行申请。 旧预览、已有关联或试图改绑：刷新核对，不生成新档。
成功结果	属于当前账号、明确门店和版本的申请及历史。
最低保证	申请及补充本身不创建患者、预约、病历或账单，不披露其他患者。
业务规则	一个账号至多一件待办申请；恢复只能针对同一原档案；终态保留。
验收目标	AT-ENROLL-01：新档、旧档、补充、撤回、重试、并发及原关联恢复申请。

SU-86　独立核验并开通本人档案

表 C-48 SU-86　独立核验并开通本人档案用例规约

标题	内容（SU-86）
用例名称	SU-86　独立核验并开通本人档案
执行者／触发	本店具有本人核验职责的前台，申请人
实现状态	已实现；本地合成流程核对，真实微信平台及身份能力另行验收。
前置条件	有效当前诊所及核验职责；审核账号不同于申请人。
主要输入	申请版本、决定、核验方式、内部依据；旧档明确患者编号。
基本路径	1）在本店待办中核对申请、本人和账号，区分新档与旧档。 2）旧档明确选择可见的同一患者；需要补充或不通过时说明结果。 3）预览决定并明确确认，新档原子创建完整档案及本人关联，旧档不改资料。 4）恢复时启用原关联行并保留历史；申请人刷新后明确进入原患者服务。
扩展路径	跨店、撤权、自己审核或安全停用：不批准。 档案或申请已变化、并发绑定冲突：重新核对，不部分写入。 重复确认：返回原成功结果，原关联暂停时不能另建或改绑。
成功结果	明确批准、待补充或不通过的决定；批准引用原患者并保留独立依据。
最低保证	不制造治疗或资金事实，未批准不授予患者权，原患者与历史不被覆盖。
业务规则	当前店核验、不同账号、完整建档及唯一关联；显式激活与原预约授权分开。
验收目标	AT-ENROLL-02：独立审核、七岗位、跨店、撤权、事务唯一、新档完整、同一行恢复及预约衔接。

SU-87　导入口腔支付目录并独立发布

表 C-49 SU-87　导入口腔支付目录并独立发布用例规约

标题	内容（SU-87）
用例名称	SU-87　导入口腔支付目录并独立发布
执行者／触发	两名不同财务账号
实现状态	已实现；课程合成资料基础，真实联网另行验收。
前置条件	当前全链财务工作区，存在已核对来源的服务端目录包。
主要输入	目录版本选择、明确确认和独立核对依据。
基本路径	1）预览地区、通知、生效日、原始摘要和缺失统计。 2）明确导入原始字节、规范记录及对应项目，保留待核对状态。 3）另一财务账号查阅原件和项目，预览决定后确认启用或未通过。 4）需要停用时记录依据，保留原版本和所有决定。 5）未通过或停用后明确重新提交核对，关联前次审阅，不修改原政策版本和原决定。
扩展路径	相同来源已存在：打开原目录，不重复导入。 原始文件或规范包摘要变化：整批不保存。 自己复核、授权失效或旧预览：不启用。 原表分类、比例或单位为空：原样保留，不补造规则。
成功结果	有原件和项目来源的地区目录及独立决定。
最低保证	不改变诊疗、原收费、患者资格或资金；失败不留下部分目录。
业务规则	普通导入同来源唯一；再次核对明确关联最新已结束审阅；目录内编码唯一、不同账号独立复核，原件与决定保留。
验收目标	AT-INS-POLICY：原件字节、202 编码、重复、缺失、权限、重试、并发和停用。

SU-88　准备本店模拟医保安排

表 C-50 SU-88　准备本店模拟医保安排用例规约

标题	内容（SU-88）
用例名称	SU-88　准备本店模拟医保安排
执行者／触发	本店主管、独立财务
实现状态	已实现；课程合成资料基础，真实联网另行验收。
前置条件	已核对启用的目录，主管进入授权诊所。
主要输入	目录、有效起止日期、合成依据和财务决定。
基本路径	1）主管核对本店及目录地区、生效日期。 2）预览并确认准备课程模拟安排，等待财务核对。 3）不同财务账号核对有效期与当前重叠安排，再明确决定。 4）需要停止新用途时明确停用，历史安排继续可查。
扩展路径	早于政策生效、截止早于开始：重新填写。 日期重叠：核对旧安排并明确处理，不自动覆盖。 目录停用、提交人撤权或跨店：不确认新安排。
成功结果	本店有明确有效期、来源及独立依据的课程安排。
最低保证	不声明真实定点资格，不生成患者、收费或结算；旧安排不被覆盖。
业务规则	已确认安排同店日期不重叠；目录生效与安排有效分别核验。
验收目标	AT-INS-CLINIC：日期、地区、并发重叠、跨店、撤权及停用后原历史。

SU-89　核对收费项目与医保目录适配

表 C-51 SU-89　核对收费项目与医保目录适配用例规约

标题	内容（SU-89）
用例名称	SU-89　核对收费项目与医保目录适配
执行者／触发	本店主管、独立财务
实现状态	已实现；课程合成资料基础，真实联网另行验收。
前置条件	原收费目录在用，地区政策目录已核对启用。
主要输入	原项目、明确目录项目、单位数量换算及适配依据。
基本路径	1）逐项核对原收费项目和目录项目的含义与单位。 2）记录每个原收费单位对应的目录数量，预览后提交。 3）财务独立核对来源、单位、数量、当前收费定义及已启用映射。 4）原收费定义变化或映射失效时明确停用并另行核对，保留旧版。
扩展路径	单位或支付规则缺失：继续待核对，不能启用。 同店该收费项目已有映射：先核对并停用旧映射。 预览后收费单位或目录状态变化：重新核对。 目录不支付：明确自费分类，不生成基金承担。
成功结果	本店收费项目到明确政策项目的已核对适配或未通过记录。
最低保证	不模糊合并名称，不改价格、实际治疗数量和旧账单。
业务规则	换算为正数、最多四位小数；本店同一收费项目至多一个启用映射；独立确认。
验收目标	AT-INS-MAP：源表缺项、单位变化、正数量、重复、版本与独立复核。

SU-90　登记并接续患者模拟待遇核对

表 C-52 SU-90　登记并接续患者模拟待遇核对用例规约

标题	内容（SU-90）
用例名称	SU-90　登记并接续患者模拟待遇核对
执行者／触发	本店前台
实现状态	已实现；课程合成资料基础，真实联网另行验收。
前置条件	当前店可见且在用的患者档案，不以手机号或位置匹配患者。
主要输入	合成参保地、类型、核对结果、有效期、SIM 依据及说明。
基本路径	1）从原患者档案核对本店就诊人。 2）分别登记参保地、类型、有效期和本次模拟结果。 3）预览后明确确认，追加版本并保留原核对。 4）后续结果变化时比较当前版本再追加，核对门店安排、地区与日期是否适用。
扩展路径	参保地或类型未知：保留待核实，不能认证待遇。 跨店、撤权、旧预览或版本竞争：不覆盖原结果。 同次重复确认：返回同一版本。 地区不符、过期或门店无安排：保留资料与明确待办，不承诺报销。
成功结果	属于明确患者和本店的追加待遇版本及适用性提示。
最低保证	不另建患者，不授予本人或代约权限，不产生治疗、账单和资金。
业务规则	最新未知不回退旧已核实结果；前版必须为同一患者同一店；合成来源明确。
验收目标	AT-INS-ELIGIBILITY：参保地与定位分离、未知、有效期、跨店、版本链、并发和重试。

SU-91　办理模拟结算与查询原请求

表 C-53 SU-91　办理模拟结算与查询原请求用例规约

标题	内容（SU-91）
用例名称	SU-91　办理模拟结算与查询原请求
执行者／触发	本店前台，财务可查询原请求
实现状态	已实现；本地合成流程，真实机构联网另行验收。
前置条件	当前岗位及诊所授权有效；原患者、实际费用和必要来源可核对。
主要输入	原账单、逐行分担、模拟方式及办理依据。
基本路径	1）核对确切发布版本、实际接诊日、目录适配及最新待遇。 2）逐行预览现金责任、个人账户和基金，明确确认唯一请求。 3）处理中或回复未知时查询同一请求，取得原保留结果。 4）由不同财务账号继续分担复核。
扩展路径	来源失效、费用变化或待审现金：重新核对原流程。 无映射、缺失单位或支付规则：保留自付例外。 同次重试：返回原请求当前进度；未终结请求不重复申报。
成功结果	有原实际费用、唯一编号和逐行结果的模拟申报。
最低保证	失败不留下部分业务；原费用、现金、来源和决定历史保留，不补造资金或权限。
业务规则	逐行分担相加等于原费用；未知结果不视为支付。
验收目标	AT-INS-SETTLE：实际版本、逐行金额、最新待遇、丢失回复、重复与并发。

SU-92　独立核对模拟医保分担

表 C-54 SU-92　独立核对模拟医保分担用例规约

标题	内容（SU-92）
用例名称	SU-92　独立核对模拟医保分担
执行者／触发	与原前台账号不同的财务
实现状态	已实现；本地合成流程，真实机构联网另行验收。
前置条件	当前岗位及诊所授权有效；原患者、实际费用和必要来源可核对。
主要输入	原申报、原模拟结果、明确通过或未通过及依据。
基本路径	1）查看原费用和原编号返回结果。 2）重新核对来源、授权、各行分担及现金进度。 3）预览并确认独立决定。 4）通过后按原现金流程办理患者待缴或待退金额。
扩展路径	自己复核或旧预览：不能通过。 来源或原办理人授权失效：记录未通过并处置原受理请求。 复核未通过不等于外部撤销，不能换编号重复申报。
成功结果	保留独立决定，并在通过时明确患者现金责任及非现金承担。
最低保证	失败不留下部分业务；原费用、现金、来源和决定历史保留，不补造资金或权限。
业务规则	原收入与现金不改写；待审、未知或未通过不产生抵扣。
验收目标	AT-INS-REVIEW：独立账号、撤权、先付款后分担、部分付款及现金冲突。

SU-93　核对基金银行到账与退回凭据

表 C-55 SU-93　核对基金银行到账与退回凭据用例规约

标题	内容（SU-93）
用例名称	SU-93　核对基金银行到账与退回凭据
执行者／触发	两名不同财务账号
实现状态	已实现；本地合成流程，真实机构联网另行验收。
前置条件	当前岗位及诊所授权有效；原患者、实际费用和必要来源可核对。
主要输入	已导入本店银行流水、用途和独立核对依据。
基本路径	1）从保留的银行流水核对诊所、币种、方向、金额和用途。 2）预览并确认基金到账或退回凭据，保留活动用途。 3）另一财务账号明确核对通过或未通过。 4）通过后进入逐笔分配，未通过保留历史并释放用途。
扩展路径	同一流水已用于现金匹配或基金：返回原用途。 方向、银行方式或币种不符：不能办理。 原办理人撤权：不能通过，可明确退回。
成功结果	有原流水和不同账号核对的基金银行凭据。
最低保证	失败不留下部分业务；原费用、现金、来源和决定历史保留，不补造资金或权限。
业务规则	现金匹配与基金用途排他；凭据通过不自动清偿申报。
验收目标	AT-FUND-EVIDENCE：原流水唯一使用、方向、独立决定、升级来源及并发。

SU-94　逐笔分配基金到账或退回

表 C-56 SU-94　逐笔分配基金到账或退回用例规约

标题	内容（SU-94）
用例名称	SU-94　逐笔分配基金到账或退回
执行者／触发	两名不同财务账号
实现状态	已实现；本地合成流程，真实机构联网另行验收。
前置条件	当前岗位及诊所授权有效；原患者、实际费用和必要来源可核对。
主要输入	已核对银行凭据、同店申报、逐笔正金额及依据。
基本路径	1）核对银行可用金额及每笔申报剩余应收或已收到净额。 2）选择同店同币种申报，逐笔预览本次金额。 3）确认一批分配并预留额度。 4）另一财务账号独立核对后确认核销或退回本次分配。
扩展路径	银行或申报额度不足、待审占用：核对原进度。 申报未通过、跨店或撤销中新增到账：不分配。 退回超过已核对净到账：不能通过。 同次重试、并发或旧预览：只保留一个合法效果。
成功结果	原银行凭据到具体申报的独立分配与退回历史。
最低保证	失败不留下部分业务；原费用、现金、来源和决定历史保留，不补造资金或权限。
业务规则	待审计入预留；不借用未知到账，不改变原收入及患者现金。
验收目标	AT-FUND-ALLOCATE：批量、部分分配、额度、返还、同流水及跨流水竞争。

SU-95　跟进基金差额并调整责任

表 C-57 SU-95　跟进基金差额并调整责任用例规约

标题	内容（SU-95）
用例名称	SU-95　跟进基金差额并调整责任
执行者／触发	财务
实现状态	已实现；本地合成流程，真实机构联网另行验收。
前置条件	当前岗位及诊所授权有效；原患者、实际费用和必要来源可核对。
主要输入	原申报、事项类型、已知金额或未知、责任人、期限及依据。
基本路径	1）登记未到账、少到账、扣减或用途待核实事项。 2）指定有效财务责任人和未来联系期限。 3）记录联系结果，必要时明确重分配责任及期限。 4）有明确依据后结束跟进，保留全部历史。
扩展路径	金额未知：保留空值，不补零。 责任人失效或已逾期：由现任财务明确调整。 旧预览或已经结束：查阅原结果，需要再次跟进时新建事项。
成功结果	可按责任与期限查询的跟进事项和追加沟通历史。
最低保证	失败不留下部分业务；原费用、现金、来源和决定历史保留，不补造资金或权限。
业务规则	结束跟进不核销金额，不转嫁患者欠款。
验收目标	AT-FUND-FOLLOWUP：未知、期限、失效责任人、重分配、结束及金额不变。

SU-96　撤销原结算并核对基金退回

表 C-58 SU-96　撤销原结算并核对基金退回用例规约

标题	内容（SU-96）
用例名称	SU-96　撤销原结算并核对基金退回
执行者／触发	本店前台或财务发起，另一财务账号复核
实现状态	已实现；本地合成流程，真实机构联网另行验收。
前置条件	当前岗位及诊所授权有效；原患者、实际费用和必要来源可核对。
主要输入	原已知受理结果、撤销依据、原撤销编号和资金退回依据。
基本路径	1）查询并核对原结算结果，先处理待审现金及分配。 2）预览并确认唯一撤销，原已通过分担继续保留。 3）处理中或回复未知时查询原撤销编号。 4）已到账基金按出账凭据逐笔退回，由另一财务核对。 5）独立确认原撤销及基金净到账归零，终结原分担；患者现金另行办理。
扩展路径	原结算未知：先查原编号。 部分退回或待审分配：保留撤销进度。 自己复核、撤权或旧预览：不确认。 复核未通过：继续原撤销，不生成第二个编号。
成功结果	有原结果和独立资金依据的结算撤销历史。
最低保证	失败不留下部分业务；原费用、现金、来源和决定历史保留，不补造资金或权限。
业务规则	不作废实际费用；不自动退款；未通过分担在撤销中也不产生抵扣。
验收目标	AT-INS-REVERSE：未知查询、部分退回、独立复核、现金保持、并发和历史不可改。

SU-97　以微信身份登录小程序

表 C-59 SU-97　以微信身份登录小程序用例规约

标题	内容（SU-97）
用例名称	SU-97　以微信身份登录小程序
执行者／触发	患者账号使用者
实现状态	代码与隔离流程已实现；真实平台验收尚未完成。
前置条件	患者通道已开通对应认证方式；平台条件和当前账号状态有效。
主要输入	主动确认、wx.login 一次性 code。
基本路径	1）匿名浏览门店后选择微信快捷登录。 2）服务端向微信换码并核对应用与身份。 3）已有绑定登录原账号；首次建立无密码账号。 4）继续原服务意向，再按原流程核验本人档案。
扩展路径	平台错误或 code 过期：保留匿名状态并提示重试。 账号停用：联系门店，不能新建账号绕过。 取消授权：不建立登录会话。
成功结果	同一微信在同一应用映射到唯一 ADC 账号。
最低保证	失败不登录错误账号，不改变病历、代约权限、预约和财务；已有账号及凭据历史保留。
业务规则	不强制手机号，不接收自报 OpenID，不创建患者档案或员工岗位。
验收目标	AT-WX1-LOGIN：首次、重复、退出后和不同微信的账号归属。

SU-98　扫码确认网站登录

表 C-60 SU-98　扫码确认网站登录用例规约

标题	内容（SU-98）
用例名称	SU-98　扫码确认网站登录
执行者／触发	电脑使用者与同一账号的微信使用者
实现状态	代码与隔离流程已实现；真实平台验收尚未完成。
前置条件	患者通道已开通对应认证方式；平台条件和当前账号状态有效。
主要输入	网站随机票据、原浏览器私有凭据、新微信 code 与明确同意。
基本路径	1）电脑显示三分钟小程序登录码。 2）微信扫码显示目标网站及期限。 3）明确确认时重新取得 code 并核对当前绑定身份。 4）原浏览器查询状态后通过独立提交领取登录。
扩展路径	拒绝、过期或刷新：旧票据不能领取。 不同浏览器、解绑、停用、密码或会话变化：重新发起。 重复及并发确认：原票据只产生一次有效领取。
成功结果	原浏览器登录手机确认的同一 ADC 账号。
最低保证	失败不登录错误账号，不改变病历、代约权限、预约和财务；已有账号及凭据历史保留。
业务规则	状态查询不登录；仅短信或密码会话不能批准；票据无病历授权。
验收目标	AT-WX1-QR：原浏览器、独立同意、期限、撤销及真实 PostgreSQL 并发。

SU-99　使用手机验证码注册或登录

表 C-61 SU-99　使用手机验证码注册或登录用例规约

标题	内容（SU-99）
用例名称	SU-99　使用手机验证码注册或登录
执行者／触发	患者账号使用者
实现状态	代码与隔离流程已实现；真实平台验收尚未完成。
前置条件	患者通道已开通对应认证方式；平台条件和当前账号状态有效。
主要输入	手机号、用途、服务端挑战、短信验证码与明确同意。
基本路径	1）填写号码并独立申请验证码。 2）平台生成短信，ADC 保留会话绑定挑战。 3）输入实际收到的验证码并核验。 4）已有登录身份进入原账号，首次只建立账号。
扩展路径	错误、过期、重放或会话变化：不能登录。 额度未确认、号码未约定或上限已到：不调用平台。 发送失败：提示失败，不使用演示码替代。
成功结果	登录属于已核验号码的账号，不合并患者。
最低保证	失败不登录错误账号，不改变病历、代约权限、预约和财务；已有账号及凭据历史保留。
业务规则	平台核验结果不直接作为 ADC 会话；验证码不在真实页面显示。
验收目标	AT-WX1-SMS：真实接收另验；隔离测试核对挑战、次数与账号事实。

SU-100　将当前微信关联到原账号

表 C-62 SU-100　将当前微信关联到原账号用例规约

标题	内容（SU-100）
用例名称	SU-100　将当前微信关联到原账号
执行者／触发	已有患者账号使用者
实现状态	代码与隔离流程已实现；真实平台验收尚未完成。
前置条件	患者通道已开通对应认证方式；平台条件和当前账号状态有效。
主要输入	有效原密码或先前短信登录会话、微信 code 与明确同意。
基本路径	1）选择关联原账号，使用原密码登录或先完成手机号登录。 2）主动确认将当前微信绑定到此账号。 3）服务端换码并锁定身份与账号重新核对归属。 4）保留原本人、家人授权及预约，以同一账号继续。
扩展路径	微信已属于其他账号：拒绝并引导使用原账号。 原密码错误、旧会话或停用：不关联。 重复绑定：保留同一结果，不复制患者档案。
成功结果	原账号新增明确归属的微信凭据。
最低保证	失败不登录错误账号，不改变病历、代约权限、预约和财务；已有账号及凭据历史保留。
业务规则	不按号码、姓名或微信昵称自动合并；关联不扩大权限。
验收目标	AT-WX1-LINK：原账号、冲突归属、撤权及未新增病历。

SU-101　核验并换绑账号手机号码

表 C-63 SU-101　核验并换绑账号手机号码用例规约

标题	内容（SU-101）
用例名称	SU-101　核验并换绑账号手机号码
执行者／触发	当前患者账号使用者
实现状态	代码与隔离流程已实现；真实平台验收尚未完成。
前置条件	患者通道已开通对应认证方式；平台条件和当前账号状态有效。
主要输入	目标号码、绑定用途挑战、验证码与当前账号凭据。
基本路径	1）在我的账号输入目标号码并同意发送。 2）平台核验绑定用途和当前会话。 3）确认号码未属于其他账号，替换当前登录号码。 4）原 SMS 登录身份解除归属，保留变更事件。
扩展路径	目标号码属于其他账号：拒绝，不覆盖。 旧挑战、登录用途或其他会话：不换绑。 网络结果未知：查询当前账号，避免反复发送。
成功结果	新号码登录原账号，原患者联络档案不被改写。
最低保证	失败不登录错误账号，不改变病历、代约权限、预约和财务；已有账号及凭据历史保留。
业务规则	手机号与患者联络字段独立；绑定历史保留，旧 SMS 身份不再登录原账号。
验收目标	AT-WX1-PHONE：绑定、换绑、号码冲突、重放和原业务保持。

SU-102　完善并提交本人医师介绍

表 C-64 SU-102　完善并提交本人医师介绍用例规约

标题	内容（SU-102）
用例名称	SU-102　完善并提交本人医师介绍
执行者／触发	医师
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	职称申报、方向、简介、经历来源、从业时间、语言及头像。
基本路径	1）编辑本人草稿并保存。 2）核对本次内容与图片。 3）明确提交不可变版本，交门店审核。
扩展路径	草稿被更新：重新读取。 来源或图片不符：保留原发布。
成功结果	形成本人可追踪的提交版本。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	草稿和提交不直接覆盖公开版本。
验收目标	P1-PROFILE-01：草稿、重复提交、撤权和图片归属。

SU-103　审核发布或退回本店医师介绍

表 C-65 SU-103　审核发布或退回本店医师介绍用例规约

标题	内容（SU-103）
用例名称	SU-103　审核发布或退回本店医师介绍
执行者／触发	门店主管
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	任职关系、医师确切提交版本及审核意见。
基本路径	1）查看本店医师提交和内部来源。 2）明确发布、退回或撤回。 3）核对版本并确认，保留决定。
扩展路径	新提交使旧预览失效：重核版本。 本人变换角色申请自审：拒绝。
成功结果	本店采用明确版本，旧展示及决定留存。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	各店独立采用；公开审核不授予专业资格。
验收目标	P1-PROFILE-02：退回、撤回、跨店及自审拒绝。

SU-104　维护常驻轮诊及结束任职

表 C-66 SU-104　维护常驻轮诊及结束任职用例规约

标题	内容（SU-104）
用例名称	SU-104　维护常驻轮诊及结束任职
执行者／触发	主管、前台
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	医师、门店、种类、有效期和原承诺。
基本路径	1）登记统一医师的接诊关系。 2）核对原出诊、预约与邀约后启用控制。 3）结束时列出原承诺，由前台协调。
扩展路径	原承诺不在有效范围：先核对，不能静默启用。 已有患者预约：保留原约，不能自动取消。
成功结果	新出诊及成约受有效任职约束，历史保持。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	前台排班与专业授权仍独立；撤回介绍不结束任职。
验收目标	P1-ROSTER：多店、结束与成约并发、原约保护。

SU-105　完善并发布门店画像

表 C-67 SU-105　完善并发布门店画像用例规约

标题	内容（SU-105）
用例名称	SU-105　完善并发布门店画像
执行者／触发	本店主管
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	特色、简介、交通、停车、无障碍、费用说明及最多三图。
基本路径	1）维护门店草稿并核对图片。 2）提交明确版本并发布。 3）读取营业、服务、设备与医保的现有配置。
扩展路径	资料未核实：保留未知。 新草稿尚未发布：患者仍见旧版。
成功结果	提供一致且可追踪的门店公开资料。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	电话地址各呈现一次；资料不替代真实机构资格。
验收目标	P1-CLINIC：同店维护、历史、公开字段与恢复。

SU-106　先选门店并比较团队

表 C-68 SU-106　先选门店并比较团队用例规约

标题	内容（SU-106）
用例名称	SU-106　先选门店并比较团队
执行者／触发	匿名患者、患者账号使用者
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	城市、区域、服务、线上预约条件或主动定位。
基本路径	1）筛选门店并按已授权位置由近到远查看。 2）查看特色、团队、近期出诊和交通条件。 3）选择门店、医师及实际服务。
扩展路径	拒绝定位：继续城市筛选。 无合适时间：明确选其他医师、同城门店或候补。
成功结果	形成清晰的服务与医师意向。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	浏览不占资源、不访问病历。
验收目标	P1-DISCOVERY：二十店筛选、两端投影及窄屏。 P15：二十店基础能力矩阵、两端同筛选及日期恢复；小程序真实工具操作单独留证。

SU-107　先选医师并核对接诊门店

表 C-69 SU-107　先选医师并核对接诊门店用例规约

标题	内容（SU-107）
用例名称	SU-107　先选医师并核对接诊门店
执行者／触发	匿名患者、患者账号使用者
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	医师方向、简介、语言及接诊日期。
基本路径	1）查看医师目录与详情。 2）核对各任职门店的服务和日期。 3）明确选择同一医师在某店的服务。
扩展路径	任职已结束或介绍撤回：刷新并另选。 多个门店：不默认替患者决定门店。
成功结果	保留明确医师和门店的预约意向。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	统一身份不重复计为多个医师；资格来源未核验不显示认证。
验收目标	P1-DOCTOR：轮诊身份、适配服务与失效选择。 P15：二十店基础能力矩阵、两端同筛选及日期恢复；小程序真实工具操作单独留证。

SU-108　在登录及患者切换后继续选医

表 C-70 SU-108　在登录及患者切换后继续选医用例规约

标题	内容（SU-108）
用例名称	SU-108　在登录及患者切换后继续选医
执行者／触发	患者本人、已核验代约人
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	登录前医师服务意向、账号会话及就诊人。
基本路径	1）完成患者通道登录。 2）选择本人或有本店有效权限的就诊人；儿童服务需前台已核验的监护关系。 3）重核医师、服务、出诊及物理资源后明确预约。
扩展路径	切换就诊人：重新核对授权和确认。 无资源或撤权：保留原事实，返回可继续办理的选择。
成功结果	形成唯一授权预约，可继续原改期及候补合同。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	意向不是授权，旧预览不绕过患者或资源检查。 一般预约委托不等于儿童监护授权。
验收目标	P1-HANDOFF：登录延续、改期、候补、代约及重复确认。 P15：二十店基础能力矩阵、两端同筛选及日期恢复；小程序真实工具操作单独留证。

SU-109　登记月度直接及公共成本

表 C-71 SU-109　登记月度直接及公共成本用例规约

标题	内容（SU-109）
用例名称	SU-109　登记月度直接及公共成本
执行者／触发	门店主管、总部财务
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	年月、类别、金额、归属、来源编号及依据。
基本路径	1）选择本店或总部期间。 2）核对直接归属医师或公共成本。 3）引用原维修来源或登记其他来源并提交。
扩展路径	设备采购冒充维修、重复来源或跨店：拒绝。 缺失费用：保留待核算，不能自动为零。
成功结果	形成待独立复核成本，不产生付款。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	原季度成本不自动导入，来源更正走修订。
验收目标	P1-COST-01：来源唯一、采购区分与无资金副作用。

SU-110　独立复核成本及核对完整性

表 C-72 SU-110　独立复核成本及核对完整性用例规约

标题	内容（SU-110）
用例名称	SU-110　独立复核成本及核对完整性
执行者／触发	财务、另一总部财务
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	待审成本、独立依据和各类完整／零费用结论。
基本路径	1）核对来源、金额、期间及提交人。 2）确认或退回，保留独立决定。 3）逐类别确认完整或确实为零。
扩展路径	提交人自行换角色审核：拒绝。 待审、新成本或来源变化：完整性待重核。
成功结果	可区分已确认部分、缺失与明确零费用。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	全部类别完整且无待审和来源差异才给出利润。
验收目标	P1-COST-02：独立复核、缺失零值、撤权及并发。

SU-111　按月分摊公共成本并留存经营报告

表 C-73 SU-111　按月分摊公共成本并留存经营报告用例规约

标题	内容（SU-111）
用例名称	SU-111　按月分摊公共成本并留存经营报告
执行者／触发	财务；主管、医师与总部按范围查看
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	当前账单、出诊分钟、已确认成本和完整性。
基本路径	1）按诊疗完成期计算产值，资金业务日计算回款。 2）按工时分摊公共成本并守恒分币尾差。 3）核对范围和差异后确认报告版本。
扩展路径	无工时：保留门店未分摊。 来源变化或不完整：先补充核对，不确认正式利润。
成功结果	保留可独立重算的月报及医师分摊依据。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	净回款不等于现金余额，管理贡献不自动发工资或报税。
验收目标	P1-MONTH：跨月、多版本、零收入、零工时和尾差。

SU-112　修订费用并比较月报历史

表 C-74 SU-112　修订费用并比较月报历史用例规约

标题	内容（SU-112）
用例名称	SU-112　修订费用并比较月报历史
执行者／触发	主管、独立财务
实现状态	已实现；课程合成业务验证与真实运营资格分别评价。
前置条件	当前账号、岗位和门店授权有效；对应服务及资源已按职责配置。
主要输入	原成本或设备费用来源、新金额与更正依据。
基本路径	1）保留原成本并提交修订引用。 2）独立复核后重新核对类别完整性。 3）形成新月报并查看与旧版差异。
扩展路径	同一来源跨月或并发重用：仅一份有效结果。 旧月报预览：刷新来源后再确认。
成功结果	当前核算采用已确认新版本，原报告和资金仍保留。
最低保证	失败保留原发布、原预约、诊疗及资金事实；重试不产生第二次业务效果。
业务规则	更正不覆写金额、不制造平衡资金、不自动重算旧报告。
验收目标	P1-REVISION：设备来源修订、旧报保留、并发重复。

SU-113　核对本人结算单与历史版本

表 C-75 SU-113　核对本人结算单与历史版本用例规约

标题	内容（SU-113）
用例名称	SU-113　核对本人结算单与历史版本
执行者／触发	患者本人
实现状态	已实现，按渠道分别验收
前置条件	有效患者通道及本人档案权限；该次就诊已发布结算单。
主要输入	本人预约、结算单编号及需要查看的发布版本。
基本路径	1）从就诊详情打开本人结算单。 2）核对诊疗发布版本、收费项目、数量、单价与原版本金额。 3）查看已记账收款、退款合计及净额，逐笔核对业务日期、记账时间和状态。 4）按页查看全部已记账收退款；切换历史收费版本时保留当前资金口径提示。
扩展路径	尚未开单：说明尚未形成结算单，不显示为免费或已付款。 非本人、代约或权限撤销：拒绝读取并清除旧页面。 历史版本：明确其金额与当前资金余额适用版本不同。 没有已记账条目：显示零总额与空态；待审请求单列提示，不计入总额或明细。
成功结果	患者获得可追踪的已发布项目、版本金额及当前资金情况。
最低保证	只读查询不产生收费、退款、治疗或新增病历权限。
业务规则	网站和小程序共用发布及余额口径；待审资金不计入已收款；代约权限不能查看本人账单。
验收目标	P15-INVOICE：本人、跨患者、代约、撤权、历史版本、已记账与待审资金分别验证。 FIN-READ：验证收退款分列、分页总额守恒、待审拒绝排除、字段白名单、日期、历史版本及翻页撤权。

SU-114　整理完整初诊病历

表 C-76 SU-114　整理完整初诊病历用例规约

标题	内容（SU-114）
用例名称	SU-114　整理完整初诊病历
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现，课程合成场景验证
前置条件	已实际到诊，有当前诊所、服务和操作的有效专业范围；既往资料须另经查阅授权。
主要输入	当前就诊、准确来源、正文与办理依据；当前工作身份和版本。
基本路径	1）核对患者、诊所、主诉、病史及检查来源。 2）记录诊断、辅助检查来源、离诊医嘱和复诊建议。 3）引用原实际处置并保存文书草稿。
扩展路径	缺项可继续保存草稿，预览时提示具体待完善事项。 无治疗保留检查和建议，不生成项目或金额。
成功结果	形成可追踪的本次办理结果，准确文书和原资源／金额按各自规则保持。
最低保证	失败不产生部分确认；保存草稿与已确认历史继续保留，不扩张其他岗位权限。
业务规则	完整文书不代替原检查和实际执行；未知继续未知。
验收目标	C31-A01—A08：初复诊、准确来源、并发重试、版本与撤权。 C31-A19—A21：正常周转和原资金事实保持；具体证据见对应验证记录。

SU-115　整理复诊病历与既往变化

表 C-77 SU-115　整理复诊病历与既往变化用例规约

标题	内容（SU-115）
用例名称	SU-115　整理复诊病历与既往变化
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现，课程合成场景验证
前置条件	已实际到诊，有当前诊所、服务和操作的有效专业范围；既往资料须另经查阅授权。
主要输入	当前就诊、准确来源、正文与办理依据；当前工作身份和版本。
基本路径	1）核对本次负责就诊和已授权既往文书。 2）选择既往准确版本，说明本次症状、检查和判断变化。 3）院外或纸质资料另记来源，保存复诊草稿。
扩展路径	跨患者、跨店或无专业范围的来源拒绝。 既往版本未选时须说明院外／纸质依据，不自动照抄结论。
成功结果	形成可追踪的本次办理结果，准确文书和原资源／金额按各自规则保持。
最低保证	失败不产生部分确认；保存草稿与已确认历史继续保留，不扩张其他岗位权限。
业务规则	既往来源不授予新的病历权限，同一就诊不能引用自己作为既往就诊。
验收目标	C31-A01—A08：初复诊、准确来源、并发重试、版本与撤权。 C31-A19—A21：正常周转和原资金事实保持；具体证据见对应验证记录。

SU-116　由负责医师确认完整文书

表 C-78 SU-116　由负责医师确认完整文书用例规约

标题	内容（SU-116）
用例名称	SU-116　由负责医师确认完整文书
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现，课程合成场景验证
前置条件	已实际到诊，有当前诊所、服务和操作的有效专业范围；既往资料须另经查阅授权。
主要输入	当前就诊、准确来源、正文与办理依据；当前工作身份和版本。
基本路径	1）按原流程结束实际接诊。 2）预览完整内容、准确临床来源和确认凭据。 3）明确确认后保存作者、服务端时间及准确版本。
扩展路径	草稿、授权或来源变化时返回核对，原草稿保留。 重复确认返回原结果，并发不同确认只产生一个新版本。
成功结果	形成可追踪的本次办理结果，准确文书和原资源／金额按各自规则保持。
最低保证	失败不产生部分确认；保存草稿与已确认历史继续保留，不扩张其他岗位权限。
业务规则	账号确认与纸质原件引用分别记录，不宣称可靠电子签名或归档。
验收目标	C31-A01—A08：初复诊、准确来源、并发重试、版本与撤权。 C31-A19—A21：正常周转和原资金事实保持；具体证据见对应验证记录。

SU-117　比较病历文书历史

表 C-79 SU-117　比较病历文书历史用例规约

标题	内容（SU-117）
用例名称	SU-117　比较病历文书历史
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现，课程合成场景验证
前置条件	已实际到诊，有当前诊所、服务和操作的有效专业范围；既往资料须另经查阅授权。
主要输入	当前就诊、准确来源、正文与办理依据；当前工作身份和版本。
基本路径	1）打开本人有权查阅的本次文书历史。 2）选择两个确认版本比较正文和来源差异。 3）核对更正依据、医师及实际确认时间。
扩展路径	其他患者、其他就诊或不存在的版本不能比较。 历史只读，不能从对比页改写原文。
成功结果	形成可追踪的本次办理结果，准确文书和原资源／金额按各自规则保持。
最低保证	失败不产生部分确认；保存草稿与已确认历史继续保留，不扩张其他岗位权限。
业务规则	历史页面不跟随当前目录重绘；来源编号与 SQL 外键分别说明。
验收目标	C31-A01—A08：初复诊、准确来源、并发重试、版本与撤权。 C31-A19—A21：正常周转和原资金事实保持；具体证据见对应验证记录。

SU-118　追加更正未归档文书

表 C-80 SU-118　追加更正未归档文书用例规约

标题	内容（SU-118）
用例名称	SU-118　追加更正未归档文书
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现，课程合成场景验证
前置条件	已实际到诊，有当前诊所、服务和操作的有效专业范围；既往资料须另经查阅授权。
主要输入	当前就诊、准确来源、正文与办理依据；当前工作身份和版本。
基本路径	1）基于当前确认版本说明更正依据。 2）建立新草稿并核对变化，原确认文书保持可读。 3）重新预览确认，生成前版链接及新版本。
扩展路径	已有草稿继续办理，不再建立并行更正链。 明确放弃草稿保留依据，不删除旧确认文书。
成功结果	形成可追踪的本次办理结果，准确文书和原资源／金额按各自规则保持。
最低保证	失败不产生部分确认；保存草稿与已确认历史继续保留，不扩张其他岗位权限。
业务规则	只追加，不覆盖；改诊断文字不自动改账，费用问题走原财务独立复核。
验收目标	C31-A01—A08：初复诊、准确来源、并发重试、版本与撤权。 C31-A19—A21：正常周转和原资金事实保持；具体证据见对应验证记录。

SU-119　跟进文书待办与迟记

表 C-81 SU-119　跟进文书待办与迟记用例规约

标题	内容（SU-119）
用例名称	SU-119　跟进文书待办与迟记
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现，课程合成场景验证
前置条件	已实际到诊，有当前诊所、服务和操作的有效专业范围；既往资料须另经查阅授权。
主要输入	当前就诊、准确来源、正文与办理依据；当前工作身份和版本。
基本路径	1）从本人工作台查看待完善、待确认和超期。 2）核对责任、原办理期限及下次办理时间。 3）记录进展与下一期限；超期确认须说明迟记原因。
扩展路径	跟进调整不消除原期限，不自动确认。 责任授权失效不能冒名办理，交机构核对接续。
成功结果	形成可追踪的本次办理结果，准确文书和原资源／金额按各自规则保持。
最低保证	失败不产生部分确认；保存草稿与已确认历史继续保留，不扩张其他岗位权限。
业务规则	期限是课程工作台目标，不等于法定归档期限；不阻断原接诊、椅位释放和结算。
验收目标	C31-A01—A08：初复诊、准确来源、并发重试、版本与撤权。 C31-A19—A21：正常周转和原资金事实保持；具体证据见对应验证记录。

SU-120　打印准确病历文书版本

表 C-82 SU-120　打印准确病历文书版本用例规约

标题	内容（SU-120）
用例名称	SU-120　打印准确病历文书版本
执行者／触发	本次负责医师
实现状态	已实现，课程合成场景验证
前置条件	已实际到诊，有当前诊所、服务和操作的有效专业范围；既往资料须另经查阅授权。
主要输入	当前就诊、准确来源、正文与办理依据；当前工作身份和版本。
基本路径	1）核对本次负责病例的查阅授权。 2）选择已确认准确版本，展示当时身份、正文、来源与确认凭据。 3）使用浏览器打印并保留所选版本标识。
扩展路径	无确认文书时不能打印为确认结果。 越权和不存在版本拒绝，不提供公开下载链接。
成功结果	形成可追踪的本次办理结果，准确文书和原资源／金额按各自规则保持。
最低保证	失败不产生部分确认；保存草稿与已确认历史继续保留，不扩张其他岗位权限。
业务规则	打印展示不等于机构批准副本，不绘制印章或伪造可靠签名。
验收目标	C31-A01—A08：初复诊、准确来源、并发重试、版本与撤权。 C31-A19—A21：正常周转和原资金事实保持；具体证据见对应验证记录。

SU-121　医师确认具体医疗告知

表 C-83 SU-121　医师确认具体医疗告知用例规约

标题	内容（SU-121）
用例名称	SU-121　医师确认具体医疗告知
执行者／触发	负责医师
实现状态	已实现，课程合成业务规则验证；微信工具及真机结果单列
前置条件	当前工作身份有效；本人有当前访问权，医师具本病例及服务的专业操作范围。
主要输入	当前负责病例、准确检查与已认可方案步骤、身份核对依据及完整治疗说明。
基本路径	1）核对本人身份及理解表达条件，不按微信或年龄自动认定。 2）核对具体步骤、牙位、检查和八项说明，预览后确认告知版本。 3）重新告知说明原因，保留原说明和决定。
扩展路径	检查、方案或依据已变化：先复核说明。 未成年或需要代理：转适格代理核验，不能借预约授权。
成功结果	形成可追溯的准确版本告知、沟通或决定，既有业务事实保留。
最低保证	预览不写入；失败不留下部分决定，原预约、治疗和资金不受自动改写。
业务规则	认可方案与医疗同意分离；账号、纸质原件与可靠电子签名分别核验。新增医疗代理与完整开治控制不由本用例推定。
验收目标	AT-MC-121：tests/test_medical_consent.py 核对准确版本、权限、历史及并发；软件测试不替代专业验收。

SU-122　患者提问与医师答复

表 C-84 SU-122　患者提问与医师答复用例规约

标题	内容（SU-122）
用例名称	SU-122　患者提问与医师答复
执行者／触发	患者本人及负责医师
实现状态	已实现，课程合成业务规则验证；微信工具及真机结果单列
前置条件	当前工作身份有效；本人有当前访问权，医师具本病例及服务的专业操作范围。
主要输入	准确告知版本、具体问题和医师答复。
基本路径	1）患者针对具体告知版本提出问题，进入负责医师待办。 2）医师核对原问题后明确答复，保留问题与答复关联。 3）患者阅读后重新决定，答复本身不代表本人同意。
扩展路径	尚有未答复问题：阻止新增同意。 换版不删除未回答问题，问题不能被重复覆盖。
成功结果	形成可追溯的准确版本告知、沟通或决定，既有业务事实保留。
最低保证	预览不写入；失败不留下部分决定，原预约、治疗和资金不受自动改写。
业务规则	认可方案与医疗同意分离；账号、纸质原件与可靠电子签名分别核验。新增医疗代理与完整开治控制不由本用例推定。
验收目标	AT-MC-122：tests/test_medical_consent.py 核对准确版本、权限、历史及并发；软件测试不替代专业验收。

SU-123　本人明确医疗决定

表 C-85 SU-123　本人明确医疗决定用例规约

标题	内容（SU-123）
用例名称	SU-123　本人明确医疗决定
执行者／触发	患者本人
实现状态	已实现，课程合成业务规则验证；微信工具及真机结果单列
前置条件	当前工作身份有效；本人有当前访问权，医师具本病例及服务的专业操作范围。
主要输入	已告知准确版本、本人的同意／拒绝／暂缓及原因。
基本路径	1）阅读具体治疗说明，核对版本、患者与具体步骤。 2）选择同意、拒绝或暂缓，预览并明确确认。 3）保存准确版本决定及本人账号来源，两端显示相同历史。
扩展路径	同意前检查、方案、本人资料或专业范围变化：重新核对。 撤权、跨患者、代约或旧预览：拒绝写入，保留已有事实。
成功结果	形成可追溯的准确版本告知、沟通或决定，既有业务事实保留。
最低保证	预览不写入；失败不留下部分决定，原预约、治疗和资金不受自动改写。
业务规则	认可方案与医疗同意分离；账号、纸质原件与可靠电子签名分别核验。新增医疗代理与完整开治控制不由本用例推定。
验收目标	AT-MC-123：tests/test_medical_consent.py 核对准确版本、权限、历史及并发；软件测试不替代专业验收。

SU-124　登记本人纸质原件决定

表 C-86 SU-124　登记本人纸质原件决定用例规约

标题	内容（SU-124）
用例名称	SU-124　登记本人纸质原件决定
执行者／触发	负责医师
实现状态	已实现，课程合成业务规则验证；微信工具及真机结果单列
前置条件	当前工作身份有效；本人有当前访问权，医师具本病例及服务的专业操作范围。
主要输入	本人纸质原件、准确告知版本、原件编号及实际时间。
基本路径	1）核对本人原件与本份告知一致，不将登记人当作签署人。 2）录入原件参考、实际时间和决定，预览后确认。 3）分别保留纸质来源、登记账号、实际时间及服务器登记时间。
扩展路径	缺原件编号、实际时间在未来或早于该份告知：拒绝当前登记并核对原始材料。 医师不能以普通账号操作伪装成患者本人点击。
成功结果	形成可追溯的准确版本告知、沟通或决定，既有业务事实保留。
最低保证	预览不写入；失败不留下部分决定，原预约、治疗和资金不受自动改写。
业务规则	认可方案与医疗同意分离；账号、纸质原件与可靠电子签名分别核验。新增医疗代理与完整开治控制不由本用例推定。
验收目标	AT-MC-124：tests/test_medical_consent.py 核对准确版本、权限、历史及并发；软件测试不替代专业验收。

SU-125　撤回同意与重新告知

表 C-87 SU-125　撤回同意与重新告知用例规约

标题	内容（SU-125）
用例名称	SU-125　撤回同意与重新告知
执行者／触发	患者本人及负责医师
实现状态	已实现，课程合成业务规则验证；微信工具及真机结果单列
前置条件	当前工作身份有效；本人有当前访问权，医师具本病例及服务的专业操作范围。
主要输入	原准确同意版本、撤回原因或重新告知依据。
基本路径	1）本人明确撤回原告知版本未实施部分的同意。 2）保留原同意和撤回事件，已发生治疗与资金不被回滚。 3）医师重新告知时建立新版本，原决定不自动适用于新版。
扩展路径	无原同意不能撤回；仅有预约代办不能代签。 拒绝或暂缓后改变决定：经重新告知再作新决定，不能覆盖原版。
成功结果	形成可追溯的准确版本告知、沟通或决定，既有业务事实保留。
最低保证	预览不写入；失败不留下部分决定，原预约、治疗和资金不受自动改写。
业务规则	认可方案与医疗同意分离；账号、纸质原件与可靠电子签名分别核验。新增医疗代理与完整开治控制不由本用例推定。
验收目标	AT-MC-125：tests/test_medical_consent.py 核对准确版本、权限、历史及并发；软件测试不替代专业验收。

SU-126　核对医疗代理资料

表 C-88 SU-126　核对医疗代理资料用例规约

标题	内容（SU-126）
用例名称	SU-126　核对医疗代理资料
执行者／触发	本店专项核验前台
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	患者与代理账号、材料及原件编号、适用情形、方案步骤、期限。
基本路径	1）受理独立医疗代理办理单，不沿用预约授权。 2）按原件核对身份材料并提交负责医师。 3）保留核验责任与办理历史，待医师明确确认。
扩展路径	无专项职责或跨店：拒绝办理。 材料不足：退回后追加新版本，不覆盖原件依据。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-126：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-127　确认医疗代理适用性

表 C-89 SU-127　确认医疗代理适用性用例规约

标题	内容（SU-127）
用例名称	SU-127　确认医疗代理适用性
执行者／触发	负责医师及独立专业审核医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	已核对材料、本方案及步骤、具体适用原因与期限。
基本路径	1）核对本次代理适用性、具体步骤与有效期限。 2）疑难或冲突转另一名具有既有职责的审核医师。 3）明确生效、退回或不通过，保留责任来源。
扩展路径	代理人、材料整理人与核验人不能自审。 多个有效代理重叠或本人意见变化：进入明确核对，不按最后提交覆盖。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-127：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-128　代理核对方案选择

表 C-90 SU-128　代理核对方案选择用例规约

标题	内容（SU-128）
用例名称	SU-128　代理核对方案选择
执行者／触发	已核验医疗代理
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	明确患者、授权版本、当前方案与指定步骤。
基本路径	1）选择具有医疗权限的就诊人。 2）阅读指定步骤并认可、拒绝或暂缓方案选择。 3）确认真实代理来源，医疗同意仍另行办理。
扩展路径	只有代约权限不能读取临床方案。 本人已有明确拒绝或授权失效：停止代理办理并交医师核对。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-128：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-129　代理医疗问答与明确决定

表 C-91 SU-129　代理医疗问答与明确决定用例规约

标题	内容（SU-129）
用例名称	SU-129　代理医疗问答与明确决定
执行者／触发	医疗代理及负责医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	准确告知版本、代理依据及本步骤问题或决定。
基本路径	1）医师核对当前医疗代理并发布准确版本告知。 2）代理提问，医师答复后再由代理明确决定。 3）保存患者、实际决定人及准确代理依据。
扩展路径	未答疑问阻止新增同意；答复不代替决定。 换版、跨患者、撤权或过期：拒绝不适用办理，原历史保留。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-129：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-130　修订暂停或撤销医疗授权

表 C-92 SU-130　修订暂停或撤销医疗授权用例规约

标题	内容（SU-130）
用例名称	SU-130　修订暂停或撤销医疗授权
执行者／触发	前台、医师及本人相关账号
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	原办理单、原因、需要核对的新材料或明确撤销意见。
基本路径	1）明确暂停或撤销并停止新增临床访问及办理。 2）退回或暂停后追加新材料版本。 3）分别核对原决定与新授权，保留历史并提示重新选择就诊人。
扩展路径	旧预览或重复确认不产生第二次业务效果。 到期在读取时识别，不倒写授权历史或回滚实际治疗。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-130：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-131　发布临床规则与启用控制

表 C-93 SU-131　发布临床规则与启用控制用例规约

标题	内容（SU-131）
用例名称	SU-131　发布临床规则与启用控制
执行者／触发	本店专业审核医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	实际项目、具体同意或沟通要求、机构依据及版本。
基本路径	1）逐项核对在用项目要求并发布规则。 2）未知项目明确为需进一步专业判断。 3）完成目录核对后明确启用，旧规则保持可读。
扩展路径	未具既有职责不能发布。 旧规则预览遇新版本须重新核对，不按收费名称或金额推定。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-131：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-132　治疗前核对与实际执行

表 C-94 SU-132　治疗前核对与实际执行用例规约

标题	内容（SU-132）
用例名称	SU-132　治疗前核对与实际执行
执行者／触发	负责医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	患者、项目牙位、检查方案、告知决定、代理、疑问、专业与资源依据。
基本路径	1）核对当前事实并明确保存独立开治依据。 2）真实实施后登记实际项目，确认时再核验准确依据。 3）实际事实与原收费来源各保存一次，不通过核对生成收费。
扩展路径	撤回、未答疑问、资料或资源变化：给出原因并重新核对。 已启用店的直接旧入口不能绕过；其他未变化步骤不机械重签。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-132：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-133　已发生治疗补记与独立复核

表 C-95 SU-133　已发生治疗补记与独立复核用例规约

标题	内容（SU-133）
用例名称	SU-133　已发生治疗补记与独立复核
执行者／触发	负责医师及另一名专业审核医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务规则验证；专业及平台验收单列
前置条件	当前账号及岗位有效；办理对象属于核验诊所、患者及具体服务范围。
主要输入	真实发生时间、实际项目、缺失事前依据及补记原因。
基本路径	1）如实保存已发生治疗及资料缺口，不引用虚构开治记录。 2）另一名具职责与读取范围医师核对实际事实和后续安排。 3）保留独立复核结论、原缺口及唯一收费来源。
扩展路径	本人不能复核自己的补记。 补记不倒签，复核不能把历史缺口改成事前已通过。
成功结果	形成独立、准确、可追溯的办理事实，原预约、治疗及资金保持原有事实。
最低保证	预览不写入业务事实；失败不留下部分结果，旧版本和已保存事实继续保留。
业务规则	材料核验、临床适用性、方案选择、医疗决定和实际执行分别承担责任；账号确认和可靠电子签名分别验收。
验收目标	AT-MP-133：tests/test_medical_proxy_preflight.py 验证权限、历史、并发及实际接口；官方工具与手机结果另列。

SU-134　提交准确归档清单

表 C-96 SU-134　提交准确归档清单用例规约

标题	内容（SU-134）
用例名称	SU-134　提交准确归档清单
执行者／触发	负责医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务验证；机构制度与可靠签署分别验收
前置条件	当前工作身份、诊所及具体业务范围有效；临床内容由获准医师办理。
主要输入	本次已结束接诊、确认文书、收费版本、指定审核人及依据。
基本路径	1）核对本次文书、真实临床来源及完整性。 2）选择准确收费版本和独立医务审核人。 3）预览服务器清单后明确提交。
扩展路径	未付清费用不阻止合格归档。 有必要缺项或旧预览失效：给出责任与继续入口。
成功结果	保留准确、独立且可追溯的归档办理事实，原临床版本、治疗和资金保持。
最低保证	预览不发布文件；失败无部分结果，原清单、原包和历史继续保留。
业务规则	文书确认、独立归档批准、固定文件生成、付款结清和副本交付分别表达；资料保全不表示完整归档。
验收目标	AT-AR-134：tests/test_medical_archives.py 核对授权、准确版本、独立性、历史、失败和并发；浏览器及恢复证据另列。

SU-135　独立医务审核归档

表 C-97 SU-135　独立医务审核归档用例规约

标题	内容（SU-135）
用例名称	SU-135　独立医务审核归档
执行者／触发	指定独立医务审核医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务验证；机构制度与可靠签署分别验收
前置条件	当前工作身份、诊所及具体业务范围有效；临床内容由获准医师办理。
主要输入	冻结文书清单、资料完整性及具体审核意见。
基本路径	1）核对本店专项职责与具体服务范围。 2）阅读准确文书及来源，选择通过、退回或不通过。 3）明确确认并保留独立账号、职责和意见。
扩展路径	本人及本次负责医师不得自审。 主管、前台、技术或跨店职责不能替代医务审核。
成功结果	保留准确、独立且可追溯的归档办理事实，原临床版本、治疗和资金保持。
最低保证	预览不发布文件；失败无部分结果，原清单、原包和历史继续保留。
业务规则	文书确认、独立归档批准、固定文件生成、付款结清和副本交付分别表达；资料保全不表示完整归档。
验收目标	AT-AR-135：tests/test_medical_archives.py 核对授权、准确版本、独立性、历史、失败和并发；浏览器及恢复证据另列。

SU-136　生成固定包与处理异常

表 C-98 SU-136　生成固定包与处理异常用例规约

标题	内容（SU-136）
用例名称	SU-136　生成固定包与处理异常
执行者／触发	后台处理组件及负责医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务验证；机构制度与可靠签署分别验收
前置条件	当前工作身份、诊所及具体业务范围有效；临床内容由获准医师办理。
主要输入	已独立通过的准确来源、原包及当前职责。
基本路径	1）从获准快照生成固定 PDF 和来源清单。 2）锁内重核来源和适用职责后原子发布。 3）生成失败保留原任务，负责医师核对后明确重试。
扩展路径	来源或职责变化：旧申请不发布，重新核对提交。 重复处理不产生第二份文件或归档回执。
成功结果	保留准确、独立且可追溯的归档办理事实，原临床版本、治疗和资金保持。
最低保证	预览不发布文件；失败无部分结果，原清单、原包和历史继续保留。
业务规则	文书确认、独立归档批准、固定文件生成、付款结清和副本交付分别表达；资料保全不表示完整归档。
验收目标	AT-AR-136：tests/test_medical_archives.py 核对授权、准确版本、独立性、历史、失败和并发；浏览器及恢复证据另列。

SU-137　保全缺项病历资料

表 C-99 SU-137　保全缺项病历资料用例规约

标题	内容（SU-137）
用例名称	SU-137　保全缺项病历资料
执行者／触发	负责医师及独立医务审核医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务验证；机构制度与可靠签署分别验收
前置条件	当前工作身份、诊所及具体业务范围有效；临床内容由获准医师办理。
主要输入	实际现有资料、未确认草稿、缺失依据及处置原因。
基本路径	1）列明缺失材料和责任。 2）明确选择仅资料保全并独立审核。 3）固定保留现有资料和缺项，不标为完整归档。
扩展路径	医务复核不把历史缺口改成事前通过。 资料保全不阻断后续如实完善原临床资料。
成功结果	保留准确、独立且可追溯的归档办理事实，原临床版本、治疗和资金保持。
最低保证	预览不发布文件；失败无部分结果，原清单、原包和历史继续保留。
业务规则	文书确认、独立归档批准、固定文件生成、付款结清和副本交付分别表达；资料保全不表示完整归档。
验收目标	AT-AR-137：tests/test_medical_archives.py 核对授权、准确版本、独立性、历史、失败和并发；浏览器及恢复证据另列。

SU-138　审批归档后准确补正

表 C-100 SU-138　审批归档后准确补正用例规约

标题	内容（SU-138）
用例名称	SU-138　审批归档后准确补正
执行者／触发	负责医师及另一名医务审核医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务验证；机构制度与可靠签署分别验收
前置条件	当前工作身份、诊所及具体业务范围有效；临床内容由获准医师办理。
主要输入	原完整包、准确更正草稿、差异原因及实际来源。
基本路径	1）负责医师保存准确文书或检查草稿。 2）比较更正前后内容并提交独立审核。 3）另一名医师只批准准确内容，不代改临床记录。
扩展路径	草稿或来源变化须重新核对批准。 无完整归档包时沿用原临床更正流程。
成功结果	保留准确、独立且可追溯的归档办理事实，原临床版本、治疗和资金保持。
最低保证	预览不发布文件；失败无部分结果，原清单、原包和历史继续保留。
业务规则	文书确认、独立归档批准、固定文件生成、付款结清和副本交付分别表达；资料保全不表示完整归档。
验收目标	AT-AR-138：tests/test_medical_archives.py 核对授权、准确版本、独立性、历史、失败和并发；浏览器及恢复证据另列。

SU-139　追加临床版本与补充归档

表 C-101 SU-139　追加临床版本与补充归档用例规约

标题	内容（SU-139）
用例名称	SU-139　追加临床版本与补充归档
执行者／触发	负责医师及独立医务审核医师
实现状态	已实现，课程合成软件业务验证；机构制度与可靠签署分别验收
前置条件	当前工作身份、诊所及具体业务范围有效；临床内容由获准医师办理。
主要输入	有效准确补正批准、原文书和临床来源。
基本路径	1）负责医师通过原临床入口预览并确认追加版本。 2）确认时重检批准、来源和权限，引用唯一补正结果。 3）另行提交补充归档包，保留原包及所有审核。
扩展路径	旧入口不能绕过已归档补正批准。 后续新就诊、费用更正和真实医疗撤回仍保留原模块事实。
成功结果	保留准确、独立且可追溯的归档办理事实，原临床版本、治疗和资金保持。
最低保证	预览不发布文件；失败无部分结果，原清单、原包和历史继续保留。
业务规则	文书确认、独立归档批准、固定文件生成、付款结清和副本交付分别表达；资料保全不表示完整归档。
验收目标	AT-AR-139：tests/test_medical_archives.py 核对授权、准确版本、独立性、历史、失败和并发；浏览器及恢复证据另列。

SU-140　协调归档责任与汇总

表 C-102 SU-140　协调归档责任与汇总用例规约

标题	内容（SU-140）
用例名称	SU-140　协调归档责任与汇总
执行者／触发	前台、主管及总部
实现状态	已实现，课程合成软件业务验证；机构制度与可靠签署分别验收
前置条件	当前工作身份、诊所及具体业务范围有效；临床内容由获准医师办理。
主要输入	当前授权诊所的业务编号、状态、责任及办理期限。
基本路径	1）前台核对本店责任与期限，联系相关责任医师。 2）主管和总部查看各自范围的汇总。 3）通过明确入口继续原医务待办。
扩展路径	不展示临床正文、问答、资金凭据或固定文件。 调整后续办理进度不消除原责任期限。
成功结果	保留准确、独立且可追溯的归档办理事实，原临床版本、治疗和资金保持。
最低保证	预览不发布文件；失败无部分结果，原清单、原包和历史继续保留。
业务规则	文书确认、独立归档批准、固定文件生成、付款结清和副本交付分别表达；资料保全不表示完整归档。
验收目标	AT-AR-140：tests/test_medical_archives.py 核对授权、准确版本、独立性、历史、失败和并发；浏览器及恢复证据另列。